รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการการศึกษาสถานการณ์การจัดบริการดูแลระยะยาวในชุมชนของไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอย่างรอบด้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์และคณะ
หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการการศึกษาสถานการณ์การจัดบริการดูแลระยะยาวในชุมชนของไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอย่างรอบด้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

มีนาคม 2569

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการการศึกษาสถานการณ์การจัดบริการดูแลระยะยาวในชุมชนของไทย
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอย่างรอบด้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2569
จำนวนการพิมพ์ 30 เล่ม
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาสถานการณ์การจัดบริการดูแลระยะยาวในชุมชนของไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอย่างรอบด้าน.-- กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2569.

265 หน้า.

1. ผู้สูงอายุ -- การดูแล. 2. ผู้สูงอายุ -- การดูแลระยะยาว. I. สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์. II. ชื่อเรื่อง.

613.0438
ISBN 978-616-622-114-5

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

พิมพ์ที่ บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จำกัด
เลขที่ 3 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายนามคณะผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หัวหน้าโครงการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล	นักวิจัยอิสระ
อาจารย์ นายแพทย์ปวินท์ ศรีวิเชียร	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ เอี่ยงธนรัตน์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาจารย์ นายแพทย์ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายแพทย์พีรสิชฌ์ สิทธิรัตน์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายแพทย์ภรัณยู โอสถธนากร	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายเทพพิทักษ์ เข็มลา	นักวิจัยอิสระ
นายพิวัฒน์ ศุภวิทยา	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายปุญญพัฒน์ พันธ์นาค	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวจิณณ์ รัชโน	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายณัฐพัชร์ พรหมมานันท์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวสกุลฎลา ไตรโกมล	ผู้ประสานงานโครงการวิจัย
นางสาวสุพัตรา สำราญจิตร์	ผู้ประสานงานโครงการวิจัย
นางสาวสิริญา ยงเพชร	ผู้ประสานงานโครงการวิจัย

คำนำ

รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง “โครงการการศึกษาสถานการณ์การจัดบริการดูแลระยะยาวในชุมชนของประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอย่างรอบด้าน” จัดทำขึ้นภายใต้ความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ความต้องการระบบการดูแลระยะยาวมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้ม ตลอดจนประเมินปัจจัยความสำเร็จและข้อจำกัดของการจัดบริการดูแลระยะยาวในชุมชนของประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากฐานข้อมูลระดับประเทศและการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายพื้นที่ เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมและสะท้อนสภาพความเป็นจริงอย่างรอบด้าน

คณะผู้วิจัยมุ่งหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน พัฒนา และยกระดับระบบการดูแลระยะยาวในชุมชนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชากรสูงอายุได้อย่างเหมาะสม

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้วิจัยคาดหวังอย่างยิ่งให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวที่มีความครอบคลุม เป็นธรรม และยั่งยืน โดยมุ่งคุ้มครองประชาชนทุกกลุ่มให้เข้าถึงบริการที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม ลดภาระของครัวเรือน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม

คณะผู้วิจัย
มีนาคม 2569

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนทุนสำหรับการดำเนินโครงการ ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงผลการศึกษาเข้าสู่เวทีนโยบาย อันเป็นกลไกสำคัญในการทำให้มั่นใจได้ว่าผลการศึกษาจะได้รับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสาธารณสุข และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 ภูมิภาค ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูล เข้าร่วมการสัมภาษณ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเปิดกว้าง ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้การศึกษาครั้งนี้สามารถสะท้อนภาพการดำเนินงานจริงได้อย่างรอบด้าน และเป็นตัวอย่างของการนำข้อมูลเชิงประจักษ์จากพื้นที่มาใช้ประกอบการเสนอเชิงนโยบาย

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะอันทรงคุณค่า ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการศึกษา ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานวิจัยฉบับนี้

ขอขอบคุณผู้ประสานงานโครงการวิจัยและทีมงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบ จนทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากรายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบให้แก่สังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ส่วนข้อบกพร่องหรือความคลาดเคลื่อนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คณะผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

คณะผู้วิจัย

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร 1

บทคัดย่อ 13

Abstract 15

บทที่ 1 บทนำ 19

ที่มาและความสำคัญ 19

วัตถุประสงค์ 21

ระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป 21

บทที่ 2 สังคมผู้สูงอายุและการดูแลระยะยาว 23

สถานการณ์โลกและประเทศไทยด้านผู้สูงอายุ 24

วิวัฒนาการและกรอบแนวคิดสากลเกี่ยวกับระบบการดูแลระยะยาว 32

1) การอภิบาลระบบ (Governance) 37

2) การเงินการคลังที่ยั่งยืน (Sustainable Financing) 39

3) ระบบข้อมูล การติดตาม และการประเมินผล (Information, monitoring and evaluation systems) 45

4) กำลังคน (Workforce) 48

5) การส่งมอบบริการ (Service Delivery) 51

6) นวัตกรรมและการวิจัย (Innovation and Research) 56

บทสรุป 57

บทที่ 3 ระบบการดูแลระยะยาวในประเทศต่าง ๆ 59

ภาพรวมระบบการดูแลระยะยาว 60

พัฒนาการของระบบการดูแลระยะยาวและสถาบันทางสังคม 69

สวีเดน (35) 70

เดนมาร์ก (36) 72

สหราชอาณาจักร (37) 75

เยอรมนี (38) 77

เนเธอร์แลนด์ 80

สหรัฐอเมริกา (46) 83

ระบบการดูแลระยะยาวในประเทศเอเชีย 85
ญี่ปุ่น 85
เกาหลีใต้ 87
ไต้หวัน 88
กรอบการประเมินระบบการดูแลระยะยาวในต่างประเทศ 89
บทที่ 4 แนวคิดและหลักการของระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย 93
การพิจารณาองค์ประกอบของระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย 94
การอภิบาลระบบ 94
การเงินการคลัง 112
กำลังคน 125
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 143
ผลลัพธ์ของระบบการดูแลระยะยาวในช่วงที่ผ่านมา 148
การประเมินระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา 149
การประเมิน SWOT 150
การประเมินภายใต้โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long term care) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 151
การประเมินภายใต้โครงการประเมินและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 155
การประเมินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 163
การประเมินโครงการและปัจจัยขับเคลื่อนเชิงระบบของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 165
บทที่ 5 การวิเคราะห์การเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวของประชากรไทย 167
ระเบียบวิธี 168
ฐานข้อมูลและการคัดเข้าชุดข้อมูล 168
นิยามตัวแปรและผลลัพธ์ 169
การวิเคราะห์ทางสถิติ 169
สถานการณ์ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 170
สถานการณ์ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 175

การใช้บริการของผู้ป่วยที่อยู่ในระบบกองทุนการดูแลระยะยาว..... 178
สรุปข้อค้นพบสำคัญ..... 181
บทที่ 6 ผลการประเมินการดำเนินการของระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน 183
ระเบียบวิธี..... 184
ผลการศึกษาจากข้อค้นพบในพื้นที่และบทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์..... 188
มิติที่ 1 กำลังคนและพลวัตตลาดแรงงาน (Workforce & Labor Dynamics)..... 188
มิติที่ 2 การเงินการคลังและการจัดหาทรัพยากร (Financing & Resource Procurement).....215
มิติที่ 3 ระบบสารสนเทศและตัวชี้วัด (Information Systems & Data Governance).....231
มิติที่ 4 การจัดบริการและรอยต่อการดูแล (Service Delivery & Transition of Care).....250
มิติที่ 5 การอภิบาล และภาวะผู้นำ (Governance & Leadership).....265
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย..... 281
ภาพรวมและสถานการณ์ระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ..... 282
ช่องว่างระหว่างการออกแบบและการดำเนินงาน (Design-Implementation Gap)..... 282
แนวทางแก้ไขปัญหาช่องว่างการดำเนินงาน..... 284
จุดเด่นและข้อจำกัดของรายงาน..... 285
จุดเด่นของรายงาน 285
ข้อจำกัดของรายงาน 285
การศึกษาในอนาคต..... 285
เอกสารอ้างอิง.....289

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 1 พัฒนาการของอายุขัยประชากรโลกและภูมิภาคต่าง ๆ.....24
รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงและพยากรณ์ของอัตราส่วนการพึ่งพิงของผู้สูงอายุ ระหว่างปี 1950 ถึง 2100.....26
รูปที่ 3 การเพิ่มขึ้นของช่วงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในภาพรวมของโลก 27
รูปที่ 4 การเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดการยืดอายุ (Life extension) ที่มีช่วงภาวะเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นและแนวคิดการบีบอัดความเจ็บป่วย (Compression of morbidity).....28
รูปที่ 5 กลไกการเงินการคลังของกองทุนการดูแลระยะยาวในประเทศญี่ปุ่น.....29
รูปที่ 6 สถานการณ์ผู้สูงอายุในไทย 30
รูปที่ 7 กลไกการเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิต (functional ability) ในผู้สูงอายุ 34
รูปที่ 8 กรอบแนวคิดการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการต่อเนื่องขององค์การอนามัยโลก 36
รูปที่ 9 รายจ่ายภาครัฐด้าน LTC ค.ศ. 2015–2017 (ไม่รวมสหรัฐอเมริกา) 42
รูปที่ 10 รายจ่ายเฉลี่ยต่อประชากรสำหรับ LTC.....43
รูปที่ 11 รายจ่ายภาครัฐด้าน LTC เมื่อเทียบกับ GDP (%).....43
รูปที่ 12 วิธีการจัดหาเงินทุนภาครัฐสำหรับ LTC 44
รูปที่ 13 กลไกการจ่ายชดเชยสำหรับ LTC.....45
รูปที่ 14 Health Labor Market Framework for Universal Coverage 50
รูปที่ 15 โครงสร้างลำดับชั้นสำหรับการดูแลระยะยาวตามกรอบ DESDE-LTC 54
รูปที่ 16 การปฏิรูประบบหลักประกันการดูแลระยะยาวในเนเธอร์แลนด์.....82
รูปที่ 17 แผนภาพการพัฒนาการจัดการบริการ LTC สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง.....113
รูปที่ 18 ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการ LTC ที่ สปสช. จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567.....115
รูปที่ 19 กรอบการการจ่ายเงินเพื่อจัดบริการ LTC ที่จ่ายให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567.....116
รูปที่ 20 แสดงค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง 119
รูปที่ 21 แผนภาพสรุประบบกำลังคนด้านสุขภาพของระบบบริการระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง.....129

รูปที่ 22 การแสดงจำนวนยอด CM และ CG ในแต่ละปี.....138
รูปที่ 23 การแสดงอัตราส่วน CG:CM ในแต่ละปี.....138
รูปที่ 24 การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
แบ่งตามผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ 143
รูปที่ 25 จำนวนผู้สูงอายุจำแนกตามระดับความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน (ADL)
และพื้นที่ที่อยู่อาศัยระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2567 171
รูปที่ 26 แหล่งรายได้หลักและขนาดของรายได้ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2567 173
รูปที่ 27 ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง.....176
รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยที่เบิกจ่ายในกองทุนการดูแลระยะยาว.....180
รูปที่ 29 ความสัมพันธ์ของความครอบคลุมและการเปลี่ยนแปลงของจำนวนวันนอน
และ AdjRW 181

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับการประเมินระบบการดูแลระยะยาวที่ใช้ในต่างประเทศ....90
ตารางที่ 2 หน่วยงานและบทบาทในระบบการดูแลผู้สูงอายุ 95
ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำหรับการดูแลระยะยาวที่บ้าน.....117
ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการดูแลระยะยาวที่บ้าน 118
ตารางที่ 5 ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของไทย
ในปี พ.ศ. 2560 - 2590.....120
ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านอุปกรณ์ของผู้ป่วยระยะท้าย 121
ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านวัสดุสิ้นเปลืองของผู้ป่วยระยะท้าย 122
ตารางที่ 8 การประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน.....123
ตารางที่ 9 ค่าใช้จ่ายด้านบริการสำหรับประชากรในชนบทและเขตเมือง.....125
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบการอบรมและโครงสร้างบุคลากรระหว่าง CG
ที่ทำงานแบบ Community-based และ In facility-based 132
ตารางที่ 11 ข้อมูล CM และ CG ผู้ปฏิบัติงานระหว่างปี 2564 ถึง 2567.....137
ตารางที่ 12 สถิติ CM CG และผู้ใช้งานระบบ LTC แบ่งตามเขตสุขภาพปี 2567 139
ตารางที่ 13 รายละเอียดและหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในระบบการดูแล
ระยะยาวของประเทศไทย 145
ตารางที่ 14 ผลการดำเนินการการดูแลระยะยาวจากสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย.. 149
ตารางที่ 15 SWOT Analysis ของการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว.....150
ตารางที่ 16 สรุประเบียบวิธีวิจัยของการประเมินแผนการวิจัยในโครงการฯ.....152
ตารางที่ 17 จุดเด่นของแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาว
สำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงฉบับที่ 1.....156
ตารางที่ 18 สรุปโอกาสและข้อจำกัดของแผนยุทธศาสตร์ LTC.....157
ตารางที่ 19 สรุปการประเมินความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดทั้ง 6 ยุทธศาสตร์.....158
ตารางที่ 20 สรุปการปรับปรุงเกณฑ์จำแนกกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง 161
ตารางที่ 21 สรุปทางเลือกนโยบายด้านการเงินการคลังในการสนับสนุนจากรัฐ.....161
ตารางที่ 22 สรุปผลการประเมินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น.....164

ตารางที่ 23 สรุปผลการประเมินโครงการและปัจจัยขับเคลื่อนเชิงระบบของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 166
ตารางที่ 24 ลักษณะประชากรของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2567.....172
ตารางที่ 25 การเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2567...174
ตารางที่ 26 ลักษณะประชากรของผู้ดูแลหลักในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2567.....177
ตารางที่ 27 จำนวนผู้มีภาวะพึ่งพิงจำแนกตามกลุ่มของแต่ละพื้นที่ในสี่จังหวัด 186

บทสรุปผู้บริหาร

1. บริบทและสถานการณ์ภาพรวม

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด” (Super-Aged Society) อย่างเต็มรูปแบบภายในปี พ.ศ. 2574 สถานการณ์ดังกล่าวนำไปสู่ความจำเป็นเร่งด่วนในการขยายขอบเขตและปฏิรูประบบการดูแลระยะยาว (Long-Term Care: LTC) ให้บูรณาการครอบคลุมทั้งมิติของการรักษาพยาบาล (Medical care) และสวัสดิการสังคม (Social welfare) เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ เป้าหมายสำคัญของระบบไม่ได้มีไว้เพื่อดูแลผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อคุ้มครอง “ประชากรวัยแรงงาน (Sandwich Generation)” ไม่ให้ต้องหลุดออกจากระบบเศรษฐกิจเพื่อมาเป็นผู้ดูแลเต็มเวลา ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อฐานภาษีและความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศ

ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เสนอให้ระบบ LTC ยึดเป้าหมายหลักในการรักษาระดับ “ศักยภาพในการดำรงชีวิต” (Functional Ability) โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) เพื่อออกแบบเป้าหมายการดูแลและการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนี้

1) กลุ่มติดสังคม (Active / ADL ≥ 12): เป้าหมายเชิงป้องกันสมรรถนะ (Preventive LTC)

- ทิศทางการดูแล: มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันความเสื่อมถอย โดยอาศัยกลไกชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็นหลัก
- เป้าหมายตาม Functional Ability: ชะลอการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง (Delay Dependency) และรักษาสถานการณ์พึ่งพาตนเองให้นานที่สุดชะลอภาวะสมองเสื่อม ผ่านการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และการปรับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันการหกล้ม

2) กลุ่มติดบ้าน (Home-bound / ADL 5-11): เป้าหมายเชิงฟื้นฟูและพยุงสมรรถนะ (Intermediate & Supportive Care)

- ทิศทางการดูแล: ผสมผสานบริการฟื้นฟูทางการแพทย์ระยะกลาง (Intermediate Care) เข้ากับการสนับสนุนทางสังคมระดับครัวเรือน
- เป้าหมายตาม Functional Ability: ป้องกันไม่ให้สมรรถนะถดถอยลงไปสู่กลุ่มติดเตียง (Prevent Decline) และพยายามฟื้นฟูความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันระดับกลาง (Mid-loss ADLs เช่น การลุกเดิน การเข้าห้องน้ำ) ให้กลับมาอิสระ สำหรับกลุ่มนี้ การมีระบบสนับสนุนทางสังคมที่เข้มแข็ง เช่น ศูนย์รับฝากดูแลกลางวัน (Social Daycare) หรือการจัดหาผู้ดูแล (CG) เพื่อแบ่งเบาภาระ จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยคืนเวลาให้ประชากรวัยแรงงานสามารถกลับไปประกอบอาชีพและรักษาเสถียรภาพทางการเงินของครอบครัวไว้ได้

3) กลุ่มติดเตียง (Bed-bound / ADL 0-4): เป้าหมายเชิงรักษาเสถียรภาพและชีวาภิบาล (Intensive & Palliative Care)

- ทิศทางการดูแล: จำเป็นต้องอาศัยการดูแลทางการแพทย์ที่ซับซ้อน ควบคู่กับการจัดหาผู้ดูแลมืออาชีพ (Professional Caregivers) แบบเต็มเวลา และครอบคลุมไปถึงการดูแลระยะท้าย (Palliative Care)
- เป้าหมายตาม Functional Ability: รักษาความมั่นคงทางร่างกาย (Physical Stability) มุ่งเน้นความปลอดภัยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและมีต้นทุนสูง (เช่น การเกิดแผลกดทับ ภาวะทุพโภชนาการ หรือการติดเชื้อรุนแรง) ควบคู่กับการบรรเทาความเจ็บปวด และปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตตามเจตจำนง (End-of-life care)

โดยสรุป การออกแบบระบบ LTC โดยตั้งเป้าหมายตาม “ระดับศักยภาพในการดำรงชีวิต (Functional Ability)” ทั้ง 3 กลุ่ม นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็นการสร้าง “ระบบนิเวศเศรษฐกิจการดูแล” (Care Economy) ที่จะช่วยปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณระดับประเทศ

การนำฐานข้อมูลการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติมาวิเคราะห์ ช่วยให้มองเห็นข้อจำกัดที่ซ่อนอยู่ใต้ตัวเลขสถิติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบ LTC ของไทยมีความเกี่ยวโยงอย่างลึกซึ้งกับประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมระดับมหภาค ดังนี้

1) ช่องว่างทางการเงินและข้อจำกัดของสวัสดิการรัฐ

- จากข้อค้นพบ: ผู้สูงอายุมีรายได้ค่อนข้างต่ำ (อ้างอิงผลสำรวจประชากรสูงอายุ (สสช.) ปี 2567) ร้อยละ 60 มีรายได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี หรือไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน และแหล่งรายได้หลักโดยรวมมาจากครอบครัว/การโอนในครัวเรือน ขณะที่การพึ่งพาบำเหน็จ/บำนาญ/กองทุนเป็นแหล่งรายได้หลักมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำ (ประมาณ 6 - 8%)
- ตีความได้ว่า: โครงสร้างรายได้ดังกล่าวสะท้อนว่า ความมั่นคงทางรายได้หลังเกษียณของผู้สูงอายุไทยยังพึ่งพาครัวเรือนเป็นหลัก มากกว่ากลไกทางการเงินแบบสถาบัน (บำนาญ/กองทุน) ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายและการจัดบริการดูแลระยะยาว (LTC) มีแนวโน้มถูกผลักไปอยู่ที่ครอบครัว โดยเฉพาะครัวเรือนเปราะบาง จึงชี้ให้เห็นความจำเป็นของนโยบายที่ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง (Out-of-Pocket Payment) และเพิ่มการคุ้มครองทางสังคมที่เข้าถึงได้จริง ควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรการดูแลตามระดับความจำเป็นของผู้มีภาวะพึ่งพิง

2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคและภาระของผู้ดูแลในครอบครัว

- จากข้อค้นพบ: ผู้ดูแลหลักร้อยละ 91 - 94 คือ “คนในครอบครัว” (รับภาระหนักที่สุดคือบุตรหญิงและคู่สมรสวัย 56 - 58 ปี) โดยร้อยละ 9 - 11 ต้องลาออกจากงานมาดูแลเฉลี่ยนาน 3 - 4 ปี และมีถึงร้อยละ 18 - 19 ที่ต้องดูแลมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- ตีความได้ว่า: การพึ่งพาทุนทางสังคม (Social Capital) โดยให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแลหลัก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระดับมหภาค การที่ประชากรวัยแรงงานร้อยละ 10 ต้องออกจากระบบเศรษฐกิจ ถือเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและฐานภาษี นอกจากนี้ การที่จำนวนครึ่งหนึ่งของผู้ดูแลมีอายุ 56 - 58 ปีขึ้นไป สะท้อนแนวโน้ม “ผู้สูงวัยดูแลผู้สูงวัย”

(Aging Caregivers) การรับภาระดูแลที่หนักและต่อเนื่องยาวนานเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟ (Caregiver Burnout) ซึ่งอาจส่งผลกระทบย้อนกลับ ทำให้ผู้ที่อยู่ในการดูแลต้องกลับเข้าโรงพยาบาลขาดการดูแลอย่างเหมาะสม

3) ความเสี่ยงแฝงทางคลินิกจากข้อจำกัดด้านทักษะการดูแล

- จากข้อค้นพบ: ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และผู้ดูแลหลักในครอบครัวร้อยละ 83 - 84 ไม่เคยผ่านการอบรมทักษะการดูแลใด ๆ
- ตีความได้ว่า: ข้อจำกัดดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน (เช่น แผลกดทับ การติดเชื้อ) จนต้องเข้าโรงพยาบาลซ้ำ จึงควรเร่งให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะของญาติผู้ดูแล และการสนับสนุนโดยพยาบาลผู้จัดการการดูแล (CM) และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (CG)

4) ความคุ้มค่าของการลงทุนในระบบการดูแลระยะยาว

- จากข้อค้นพบ: พื้นที่ที่มีความครอบคลุมของการจัดบริการ LTC ไม่สัมพันธ์กับการลดระยะเวลาวันนอนโรงพยาบาล และการลดความรุนแรงของโรค
- ตีความได้ว่า: การลงทุนระบบดูแลระยะยาวยังไม่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

3. การวิเคราะห์กลไกเชิงประจักษ์และข้อจำกัดเชิงโครงสร้างจากการลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงคุณภาพจากเสียงสะท้อนหน้างานจริงของผู้บริหารท้องถิ่น พยาบาลผู้จัดการการดูแล (CM) และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (CG) ในพื้นที่ศึกษา 4 จังหวัด 4 ภูมิภาค (จ.เพชรบูรณ์ - ภาคเหนือ / จ.ลพบุรี - ภาคกลาง / จ.ขอนแก่น - ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / จ.สตูล - ภาคใต้) รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของส่วนกลางคณะผู้วิจัยพบว่า แม้จะมีโครงสร้างนโยบายที่ชัดเจน แต่ระบบยังคงเผชิญ “ช่องว่างระหว่างการออกแบบระบบกับการปฏิบัติจริง” (Design-Implementation Gap) โดยสามารถอดรหัสข้อจำกัดเชิงโครงสร้างได้ใน 5 มิติ ดังนี้

1) กำลังคนและพลวัตตลาดแรงงาน (Workforce & Labor Dynamics)

- เจตจำนงและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้: ระบบถูกออกแบบโดยคาดหวังให้มีการใช้กำลังคนในชุมชน หรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (CG) ที่ผ่านการอบรม เป็นผู้ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยมีพยาบาลผู้จัดการการดูแล (CM) เป็นผู้บริหารจัดการและประเมินแผนการดูแล
- สถานการณ์หน้างานจริง: ขีดจำกัดของ “ใจรัก” และ “ทุนทางสังคมเชิงเสียสละ”: ในปัจจุบันระบบ LTC ขับเคลื่อนด้วย “ทุนทางสังคมเชิงเสียสละ” (Sacrificial Social Capital) และความผูกพันในชุมชนเป็นหลัก ผู้ดูแล (CG) ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้วย “ใจรัก” และ “จิตอาสา” โดยยอมรับค่าตอบแทนที่จำกัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาระงานจริง ทำให้บุคลากรหลายรายต้องใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการจัดหาสิ่งของจำเป็นเพื่อผู้ป่วย ในขณะเดียวกัน พยาบาลผู้จัดการการดูแล (CM) ก็ต้องทำงานด้วยความเสียสละเช่นกัน โดยแบกรับทั้งงานคลินิกและงานบริหารจัดการเอกสารที่ซับซ้อนจนเกิดภาวะงานล้นมือและเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟ (Burnout)
- ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างและแนวโน้มอนาคต (The Limits of Volunteerism & The Wage Gap): แม้ความเสียสละจะเป็นรากฐานที่ช่วยพยุงระบบในระยะเริ่มต้นได้ดี แต่ในระยะยาว การพึ่งพา “ใจรัก” เพียงอย่างเดียวถือเป็นความเสี่ยงและข้อจำกัดเชิงระบบ กลุ่ม CG สะท้อนความเห็นอย่างชัดเจนว่า หากจะยกระดับงานบริบาลให้เป็น “อาชีพ” ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้จริง ค่าตอบแทนขั้นต่ำควรอยู่ในช่วง 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน ไม่ใช่อัตรา 5,000 - 6,000 บาทต่อเดือนในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงพอที่จะดึงดูดประชากรวัยแรงงานให้มาทำหน้าที่นี้ได้อย่างยั่งยืน และยังก่อให้เกิดสภาวะสมองไหล (Brain Drain) ที่ CG ผู้ผ่านการอบรมจากรัฐบางส่วน ตัดสินใจย้ายไปทำงานในสถานดูแลเอกชน (Nursing Home) หรือโรงพยาบาลเอกชนที่มีค่าตอบแทนวิชาชีพสูงกว่าถึง 20,000 - 25,000 บาทต่อเดือน

2) การเงินการคลังและการจัดหาทรัพยากร (Financing & Resource Procurement)

- เจตจำนงและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้: รัฐสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบเหมาจ่ายรายหัว (Capitation) เข้าสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) เพื่อกระจายอำนาจให้พื้นที่สามารถบริหารจัดการจัดซื้อบริการและวัสดุทางการแพทย์ได้ตามความเหมาะสม

- สถานการณ์หน้างานจริงและผลกระทบ: งบประมาณที่ได้รับจำกัดอยู่เฉพาะด้านสาธารณสุข งบประมาณที่โอนเข้าพื้นที่ 6,000 บาท/คน/ปี นั้น พบว่าบางพื้นที่ใช้งบประมาณกว่าร้อยละ 70 - 80 ไปกับวัสดุสิ้นเปลืองพื้นฐาน เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง เช่น เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม หรือเครื่องผลิตออกซิเจน ทำให้ชุมชนต้องระดมทุนภาคประชาชน (เช่น การทำผ้าป่า) เพื่อจัดซื้อกายอุปกรณ์มาเป็นทรัพย์สินส่วนกลางให้ผู้ป่วยหมุนเวียนกันยืมใช้ ในขณะที่บางพื้นที่พบว่างบดังกล่าวหมดไปกับค่าตอบแทน CG (50 บาท/ชั่วโมง) ในการดูแลตามเกณฑ์ที่กำหนดของ สปสช. เป็นหลัก
- ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง: การบริหารงบประมาณในระดับพื้นที่ยังติดขัดจากข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่
    - ความจำกัดของงบประมาณ ส่วนใหญ่ต้องใช้จ่ายค่าตอบแทนการทำงานรายชั่วโมงของ CG หรือบางแห่งใช้ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองดังกล่าวข้างต้นเป็นหลัก
    - การจัดสรรงบประมาณของ สปสช. ตามรายหัวเท่ากันหมด ไม่สอดคล้องกับภาวะความจำเป็นของผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องการการดูแลแตกต่างกัน และ
    - ความกังวลต่อการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ แม้โครงการนี้มีมาร่วมทศวรรษแต่พบว่าหลายพื้นที่เพิ่งมีการดำเนินการอย่างจริงจังในระยะสองสามปีหลังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่การเงินกังวลต่อการถูกตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำให้การตัดสินใจอนุมัติงบประมาณยึดติดกับความรัดกุมตามระเบียบพัสดุเป็นหลัก

3) ระบบสารสนเทศและตัวชี้วัด (Information Systems & Data Governance)

- เจตจำนงและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้: ระบบถูกออกแบบโดยมุ่งหวังให้มีการใช้ระบบสารสนเทศส่วนกลางเป็นฐานข้อมูลหลักที่บูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ
- สถานการณ์หน้างานจริงและผลกระทบ: ในการปฏิบัติงานจริง ผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญกับภาระการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนจากความหลากหลายของระบบสารสนเทศที่

ไม่เชื่อมโยงกัน (Fragmented Systems) พยาบาลผู้จัดการการดูแล (CM) จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยรายเดียวกันลงในหลายแพลตฟอร์ม (เช่น ระบบ 3C ของกรมอนามัย, ระบบ LTC ของ สปสช., โปรแกรม HOSxP ของโรงพยาบาล, Smart COC และ สอน.บัดดี้) ทำให้สูญเสียเวลาอันมีค่าในการดูแลผู้ป่วยหน้างาน นอกจากนี้ ข้อมูลในระบบทางการมักถูกนำไปใช้เพื่อ เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบฯเป็นหลัก ในขณะที่ข้อมูลทางคลินิกที่มีนัยสำคัญต่อการรักษาจริง (เช่น ภาพถ่ายความก้าวหน้าของแผลกดทับ ระดับน้ำตาลที่เปลี่ยนแปลงกะทันหัน หรือสภาพแวดล้อมที่บ้าน) กลับถูกรายงานและปรึกษากันผ่านช่องทางสื่อสารส่วนตัว เช่น กลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งทำให้ข้อมูลวิกฤตเหล่านี้ไม่ถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบระเบียนสุขภาพแห่งชาติ (HIS) ระบบจึงสูญเสียโอกาสในการรับรู้ผลลัพธ์ของการดูแลกลุ่มเป้าหมายตลอดสิบปีที่ผ่านมา

- ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง: ระบบสารสนเทศในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การประเมินเชิงกระบวนการและปริมาณกิจกรรม (Process-oriented Indicators) หรือการตรวจสอบว่าลงเยี่ยมครบจำนวนครั้งและทำ Care Plan ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อการเบิกจ่ายเงินเป็นหลัก แต่ยังขาดข้อมูลที่จะเป็นตัวชี้วัดด้านคุณภาพที่มีความไวพอจะประเมิน “ความเร็วของการเสื่อมถอย” หรือสะท้อนผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยอันบ่งชี้คุณภาพของการดูแล

4) การจัดบริการและรอยต่อการดูแล (Service Delivery & Transition of Care)

- เจตจำนงและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้: ระบบมุ่งหวังให้เกิดการส่งมอบบริการที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) การดูแลระยะยาว (LTC) ไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย (Palliative Care)
- สถานการณ์หน้างานจริงและผลกระทบ: ในระดับพื้นที่ที่มีความพร้อม พบว่ามีการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่ออุดช่องว่างของระบบ เช่น การจัดตั้ง ศูนย์รับฝากดูแลกลางวัน (Social Daycare) ซึ่งเกิดจากการระดมทุนในชุมชนเพื่อรับฝากผู้ป่วยในเวลากลางวัน ช่วยบรรเทาภาระของญาติมิให้เกิดภาวะความเครียดสะสมหรือหมดไฟ (Caregiver Burnout) รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) เพื่อจัดการความปวดให้ผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน อย่างไรก็ตาม

ในภาพรวมยังพบข้อจำกัดในระยะรอยต่อของการดูแล (Transition of Care) ซึ่งเกิดจาก “กับดักการจัดบริการเชิงกิจกรรมที่แข็งตัว” (Activity-based Checklist Trap) ส่งผลให้เกิดการบริการแบบตายตัวแม้อาการผู้ป่วยเป็นพลวัต เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะรอยต่อที่สำคัญ เช่น ผู้ป่วย LTC ที่จู่ ๆ มีอาการทรุดลงเฉียบพลัน (เช่น เริ่มเกิดแผลกดทับ มีภาวะสับสน หรือน้ำหนักลดรวดเร็ว) ระบบกลับขาดความยืดหยุ่นในการปรับระดับความเข้มข้นของการดูแล ผู้ปฏิบัติงาน (CG) มักต้องทำตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในเช็คลิสต์เพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย ทำให้สัญญาณเตือนภัยทางคลินิกถูกมองข้าม ผู้ป่วยจำนวนมากจึงสูญเสียโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพ และมักจบลงด้วยการเกิดภาวะแทรกซ้อนจนต้องถูกส่งตัวกลับเข้าสู่โรงพยาบาลซ้ำ (Readmission) โดยไม่จำเป็น

- ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง: รอยต่อของการดูแลที่ขาดประสิทธิภาพ มีรากฐานมาจากข้อจำกัดเชิงโครงสร้างหลายประการ ได้แก่
    - การออกแบบกลไกจ่ายที่แยกส่วนของ สปสช. เนื่องจาก สปสช. มีรูปแบบเงื่อนไข วิธีการจ่ายบริหารจัดการกองทุน และระบบสารสนเทศแยกย่อยสำหรับบริการแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน เช่น IMC, LTC, Palliative care ทำให้เกิดข้อจำกัดสำหรับพื้นที่คนหน้างานในการจัดบริการแบบไร้รอยต่อ
    - การออกแบบตัวชี้วัดและกลไกการจ่ายเงินแบบเส้นตรง (Linear Design & Process-Oriented KPIs): ระบบผูกติดการประเมินผลและการจ่ายงบประมาณไว้กับ “ปริมาณกิจกรรม” (เช่น ทำ Care Plan ครบหรือไม่ ลงเยี่ยมครบจำนวนครั้งหรือไม่) มากกว่าการวัด “ผลลัพธ์ทางคลินิก” (เช่น ความเร็วของการเสื่อมถอยลดลง หรือรักษาความสามารถในการเดินไว้ได้) ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน มุ่งเน้นความถูกต้องทางเอกสารเพื่อการเบิกจ่าย มากกว่าการเฝ้าระวังและปรับแผนเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
    - ความแข็งตัวของรอบงบประมาณของพื้นที่: การประชุมของอนุกรรมการ LTC ของพื้นที่เพื่ออนุมัติ Care Plan และงบประมาณมักกระทำเป็นรอบ เช่น รายไตรมาส หรือบางแห่งรายปี ทำให้ระบบขาดความยืดหยุ่นและไม่สามารถตอบสนองต่อจังหวะชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นพลวัตได้ทันท่วงที เช่น กรณีมีเคสใหม่แต่ยังไม่ถึงรอบของการประชุมทำให้ขาดการดูแลที่เหมาะสม หรือเมื่อเกิด

ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องการทรัพยากรเพิ่มขึ้นฉับพลัน

- ขาดโครงสร้างการสนับสนุนระบบการดูแลในระดับอำเภอ: การดูแลระยะยาวในชุมชนในปัจจุบันบริหารจัดการแยกกันเป็นอิสระในแต่ละตำบล การบูรณาการเชื่อมโยงการจัดบริการร่วมกันระหว่างตำบลและอำเภอยังมีจำกัดโดยเฉพาะระหว่าง รพ.สต. และโรงพยาบาลชุมชนในเรื่องนี้ กล่าวคือ ขาดคนที่ทำหน้าที่เป็น system manger ขณะเดียวกันก็ยังขาดศูนย์ดูแลกลางวัน (Daycare) หรือศูนย์ดูแลชั่วคราว (Respite care) เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ดูแลหลักในครอบครัวได้มีเวลาพักผ่อนส่วนตัวหรือจัดการธุระ

5) การอภิบาล และภาวะผู้นำ (Governance & Leadership)

- เจตจำนงและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้: ระบบการดูแลระยะยาวถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการและอภิบาลระบบสุขภาพและสังคมในระดับพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จ
- สถานการณ์หน้างานจริงและผลกระทบ: ในการปฏิบัติงานจริง ความสำเร็จและประสิทธิภาพของกองทุน LTC ระดับพื้นที่มักขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และศักยภาพส่วนบุคคลของผู้บริหารท้องถิ่น (Individual Leadership Dependency) ร่วมกับความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณสุขกับท้องถิ่นเป็นสำคัญ ในพื้นที่ที่ผู้นำมีความเข้าใจและให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง การขับเคลื่อนงานจะเกิดการบูรณาการทรัพยากรอย่างไร้รอยต่อ เช่น การพิจารณาอนุมัติงบประมาณสมทบเพิ่มเติม หรือการจัดสรรยานพาหนะของเทศบาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้ป่วย ในทางกลับกัน หากพื้นที่ใดขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหาร หรืออยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านผู้นำ การดำเนินงานมักขาดความต่อเนื่องและอาจเกิดความชะงักงัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบยังคงพึ่งพาตัวบุคคลมากกว่าความเข้มแข็งของระบบเชิงสถาบัน
- ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง: นอกเหนือจากความท้าทายด้านความยั่งยืนของผู้นำแล้ว ระบบการอภิบาลยังเผชิญกับข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่สำคัญ ได้แก่
- โครงสร้างการอภิบาลระบบที่แยกส่วนของส่วนกลาง: คณะกรรมการผู้สูงอายุ

แห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 24 คนจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้าทายต่อการบูรณาการแนวคิด กฎระเบียบ งบประมาณ และการทำงานร่วมกัน สิบปีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏหลักฐานการรับรู้ผลลัพธ์ของการดำเนินยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการบางคณะประชุมกันเพียงปีละครั้ง

- ข้อจำกัดด้านศักยภาพของท้องถิ่นในการจัดการ: แม้ระบบจะมอบอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ แต่ อปท. หลายแห่ง (โดยเฉพาะขนาดเล็กและขนาดกลาง) ยังขาดความพร้อมด้านโครงสร้างบุคลากร บางแห่งไม่มีกองสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม่ได้มาจากสายวิชาชีพด้านสุขภาพ (Non-health background) ส่งผลให้ท้องถิ่นมีขีดจำกัดในการทำความเข้าใจและประเมินความต้องการเมื่อต้องเผชิญกับ “ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนสูง” (เช่น ผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ผู้ป่วยสมองเสื่อม หรือผู้ป่วยระยะประคับประคอง) แม้ท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่มีความเหมาะสมในการบูรณาการดำเนินงานด้านนี้ แต่ก็มักตอบสนองได้เพียงงานธุรการ หรือการจัดซื้อวัสดุพื้นฐาน ขาดองค์ความและทักษะที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรให้สอดรับกับพลวัตความซับซ้อนของโรคและภาวะพึ่งพิงได้อย่างทันท่วงที
- ช่องว่างของการกำกับดูแลทางคลินิก (Clinical Governance Gap) หลังการถ่ายโอน: นโยบายการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แม้จะช่วยเพิ่มความเป็นอิสระด้านการบริหารจัดการงบประมาณและอัตรากำลังในบางพื้นที่ แต่ในระดับการปฏิบัติการทางคลินิกกลับก่อให้เกิดช่องว่างในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาการบูรณาการระบบฐานข้อมูลที่ถูกตัดขาดจากกัน (เช่น การกำหนดให้เปลี่ยนระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเดิม) ตลอดจนความท้าทายในการประสานงานดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และนักกายภาพบำบัด ซึ่งมีข้อจำกัดและอุปสรรคเพิ่มขึ้นจากการอยู่คนละสังกัดกระทรวงและระเบียบการบริหารที่แตกต่างกัน

4. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

1) การทลายกับดักงบประมาณแยกส่วนและระบบอภิบาลที่แยกส่วนและตามสถานการณ์ไม่ทัน: เสนอให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการเปลี่ยนผ่านจากระบบที่พึ่งพา “ตัวบุคคล” ไปสู่การยกระดับสู่ “ธรรมาภิบาลเชิงสถาบัน” (Institutional Governance) ผ่านการสร้างระบบสารสนเทศที่บูรณาการฐานข้อมูลทุกหน่วยงานรัฐและเอกชน และสามารถประมวลผลให้ติดตามสถานการณ์ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงหน้างานเพื่อจัดสรรทรัพยากรโดยอัตโนมัติได้ตรงตามความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายแต่ละรายอย่างเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ควรอาศัย “แผนการดูแลแบบบูรณาการ” (Integrated Care Plan) ซึ่งทำหน้าที่เป็น “จุดคานงัด” (Leverage Point) ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เอื้อให้ “ผู้จัดการระบบ” (System Manager) และ “ผู้จัดการการดูแล” (CM) สามารถเอื้ออำนวย เพื่อให้เกิด “การดูแลที่ไร้รอยต่อ” (Seamless Care) อย่างเป็นมาตรฐานและยั่งยืน

2) การสร้างพันธมิตรและหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Building Partnerships for Care Financing): เสนอให้กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กองทุนผู้พิการ และกองทุนผู้สูงอายุ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการแสวงหา “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” เพื่อดึงทุกภาคส่วนมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหา “วิกฤตการล้มละลายทางการเงินของครัวเรือนเปราะบาง” ผ่านการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ด้วย “พันธบัตรร่วมทุนทางสังคม” (Social Impact Bond) พร้อมกระตุ้นกลไก “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน” (PPP: Public-Private Partnership) และสนับสนุนการจัดตั้ง “พื้นที่ทดลองนวัตกรรมสังคม” (Social Innovation Sandbox) ที่มีกลไกทางการเงินสนับสนุน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ให้เข้ามาร่วมจัดบริการ “การดูแลชั่วคราว” (Respite Care) เพื่อช่วยพยุงระบบนิเวศของครอบครัวและป้องกันภาวะหมดไฟของผู้ดูแล ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือการสร้าง “ความยั่งยืนทางการคลัง” (Fiscal Sustainability) และผลักดัน “เศรษฐกิจการดูแล” (Care Economy) ให้เป็นฟันเฟืองที่ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ร่วมกัน

3) การทลายกับดักระบบอาสาสมัครที่ไร้ทิศทางความก้าวหน้า (Break the Volunteerism Trap): เสนอให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ “ความเป็นมืออาชีพ” (Professionalization) โดยมุ่งเน้นการจัดจ้าง

ผู้ดูแลแบบเต็มเวลา (full-time CG) ผู้จัดการการดูแล (CM) ให้เป็น “ตำแหน่งเฉพาะทาง” (Dedicated Focus Role) ที่แยกออกจากภารกิจอื่น หรือมีระบบ “เงินรางวัลจูงใจตามผลงาน” (Performance-based Incentive) ที่สูงเพียงพอ พร้อมยกระดับขีดความสามารถของท้องถิ่นผ่านกลไก “ผู้จัดการระบบระดับอำเภอ/จังหวัด” (System Manager) ที่มีทักษะเข้มข้นในด้าน “การวิเคราะห์ข้อมูล” (Data Analytics) เพื่อทำหน้าที่วางแผนเชิงกลยุทธ์ออกแบบชุดบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนในพื้นที่ (Locally Responsive Needs) โดยมี “ค่าตอบแทนผู้จัดการการดูแลที่ชัดเจน” (Clear CM Remuneration) และ “ค่าจ้างที่เพียงพอต่อค่าครองชีพจริง” (Living Wage) เป็นฐานรากสำคัญในการสร้างระบบที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ ข้อเสนอทั้งหมดมุ่งเน้นการทลายกับดักเชิงโครงสร้างผ่านธรรมาภิบาลเชิงสถาบันที่มั่นคง โดยมีหัวใจสำคัญคือการยกระดับ “ระบบข้อมูล” จากภาระงานเอกสารสู่ “เครื่องมือทางปัญญา” ในการวิเคราะห์เพื่อจัดสรรทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง พร้อมระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (Living Wage) และจูงใจตามผลสัมฤทธิ์

บทคัดย่อ

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2574 ทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-Term Care: LTC) เพื่อคุ้มครองทั้งผู้สูงอายุและประชากรวัยแรงงาน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้ม ศึกษาปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในชุมชนของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน

การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-methods) แบบคู่ขนาน โดยส่วนของการวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิระดับประเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ควบคู่กับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่เก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มจากผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ใน 4 ภูมิภาคและผู้บริหารระดับนโยบาย

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ

สถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนถึงปัญหาความเปราะบางทางเศรษฐกิจและภาระของครอบครัวอย่างรุนแรง พบว่าผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำและพึ่งพาเงินจากครอบครัวเป็นหลัก ภาระการดูแลร้อยละ 91 - 94 ตกอยู่กับคนในครอบครัว (โดยเฉพาะสตรีและคู่สมรสที่เข้าสู่วัยสูงอายุเช่นกัน) ซึ่งกว่าร้อยละ 83 - 84 ไม่เคยผ่านการอบรมทักษะการดูแลใด ๆ นอกจากนี้ ประชากรวัยแรงงานถึงร้อยละ 9 - 11 ต้องลาออกจากงานเพื่อมาเป็นผู้ดูแลเต็มเวลา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจมหภาค ในด้านความคุ้มค่า พบว่าการลงทุนและระดับความครอบคลุมของบริการ LTC ในปัจจุบันยังไม่สัมพันธ์กับการลดระยะเวลาวันนอนโรงพยาบาลหรือการลดความรุนแรงของโรค

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ

การดำเนินงานในพื้นที่จริงต้องเผชิญกับ “ช่องว่างระหว่างการออกแบบระบบกับการปฏิบัติจริง” (Design-Implementation Gap) ใน 5 มิติหลัก ได้แก่

- **กำลังคน:** ระบบขับเคลื่อนด้วย “ทุนทางสังคมเชิงเสียสละ” โดยพึ่งพาอาสาสมัครที่ได้รับค่าตอบแทนต่ำจนเกิดภาวะสมองไหลไปสู่ภาคเอกชน และทำให้บุคลากรเผชิญภาวะหมดไฟ (Burnout)
- **การเงินการคลัง:** งบเหมาจ่าย 6,000 บาท/คน/ปี มักหมดไปกับวัสดุสิ้นเปลือง (เช่น ผ้าอ้อม) ไม่เพียงพอต่อการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ราคาสูง อีกทั้งยังขาดความยืดหยุ่นเนื่องจากข้อกังวลด้านการตรวจสอบ
- **ระบบข้อมูล:** มีความซ้ำซ้อนและกระจัดกระจาย โดยมุ่งเน้นการบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย (Process-oriented) มากกว่าการใช้ข้อมูลทางคลินิกเพื่อติดตามผลลัพธ์ทางสุขภาพ
- **การจัดบริการและรอยต่อการดูแล:** บริการในพื้นที่มีความแข็งตัวตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ไม่ยืดหยุ่นตามพลวัตอาการของผู้ป่วย ขาดการบูรณาการระบบในระดับอำเภอ และขาดโครงสร้างสนับสนุน เช่น ศูนย์รับฝากดูแลกลางวัน (Daycare)
- **การอภิบาล:** ความสำเร็จในแต่ละพื้นที่ยังคงพึ่งพาวิสัยทัศน์และการสนับสนุนจากผู้นำท้องถิ่นส่วนบุคคล (Individual Leadership) มากกว่าความเข้มแข็งของกลไกเชิงสถาบัน

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

รัฐควรทลาย “กับดักระบบอาสาสมัคร” โดยยกระดับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (CG) และพยาบาลผู้จัดการการดูแล (CM) สู่ความเป็นมืออาชีพด้วยระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (Living Wage) และจูงใจตามผลงาน ควรมีการจัดตั้ง “ผู้จัดการระบบระดับอำเภอ” (System Manager) เพื่อเชื่อมรอยต่อการทำงาน พร้อมทั้งปฏิรูประบบข้อมูลให้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ (Data Analytics) สำหรับการจัดสรรทรัพยากร นอกจากนี้ ควรดึงภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบของความร่วมมือรัฐ - เอกชน (PPP) หรือพันธบัตรร่วมทุนทางสังคม (Social Impact Bond) เพื่อสร้างระบบนิเวศ “เศรษฐกิจการดูแล” (Care Economy) ที่ปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว

Abstract

Thailand will fully enter a Super-Aged Society by 2031, creating an urgent need to develop a Long-Term Care (LTC) system that protects both the elderly and the working-age population. Therefore, this study aims to review the current situation, analyze trends, investigate success factors and barriers, and synthesize policy recommendations to develop a sustainable community-based long-term care system in Thailand.

This study employed a concurrent mixed-methods research design. The quantitative component analyzed national secondary databases from the National Statistical Office and the National Health Security Office (NHSO). Concurrently, the qualitative component collected data through in-depth interviews and focus groups with local practitioners across four regions and national policy executives.

Quantitative Findings

The current situation reflects severe economic vulnerability and family burden. Most Thai older adults have low incomes and rely primarily on financial support from their families. The caregiving burden heavily falls on family members (91 - 94%), particularly women and aging spouses, with 83 - 84% having never received any formal caregiving training. Furthermore, 9 - 11% of the working-age population had to quit their jobs to become full-time caregivers, directly impacting the macroeconomy. Regarding cost-effectiveness, the current investment and coverage of LTC services do not correlate with a reduction in hospital length of stay or disease severity.

Qualitative Findings

On-the-ground implementation faces a "Design-Implementation Gap" across five key dimensions:

- **Workforce:** The system is driven by "sacrificial social capital," relying heavily on underpaid volunteers. This leads to a brain drain to the private sector and severe burnout among personnel.
- **Financing:** The capitation budget of 6,000 THB/person/year is often exhausted on basic consumables (e.g., adult diapers) and is insufficient for high-cost medical equipment. Moreover, budget utilization lacks flexibility due to strict state auditing concerns.
- **Information Systems:** Data systems are fragmented and redundant, focusing primarily on recording process-oriented indicators for budget reimbursement rather than utilizing clinical data to monitor patient health outcomes.
- **Service Delivery and Transition of Care:** Local services are rigid and tied to quantitative KPIs, lacking the flexibility to adapt to patients' dynamic conditions. There is a lack of system integration at the district level and insufficient support structures, such as social daycare centers.
- **Governance:** Success in each local area depends heavily on the individual leadership and vision of local executives rather than the strength of institutional mechanisms.

Policy Recommendations

The government should break the “volunteerism trap” by professionalizing Caregivers (CG) and Care Managers (CM) through fair compensation (Living Wage) and performance-based incentives. A “System Manager” role at the district level should be established to bridge care transitions. Information systems must be reformed into data analytics tools for targeted resource allocation. Additionally, the government should attract alternative investments through Public-Private Partnerships (PPP) or Social Impact Bonds to build a “Care Economy” ecosystem that safeguards the country’s long-term economic and social stability.

บทที่ 1
บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

การดูแลระยะยาว (Long Term Care; LTC) เป็นบริการเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องมีผู้ช่วยดูแล เนื่องจากภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุ ความพิการต่าง ๆ หรืออาจเกิดจากภาวะถดถอยของการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายตามความชราภาพของร่างกาย ทั้งนี้บริการดูแลระยะยาวไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจากแพทย์โดยตรง เน้นการให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง มีคุณภาพชีวิตที่ดี (1)

การดูแลระยะยาวสามารถจัดได้ทั้งที่บ้านหรือในศูนย์รับดูแลผู้ป่วย เช่น nursing home หรือ daycare center โดยการดูแลที่บ้านนั้นส่วนใหญ่อาศัยระบบแบบไม่เป็นทางการ โดยสมาชิกในครอบครัว (informal caregivers) หรือ การดูแลแบบเป็นทางการ (formal caregivers) โดยการจ้างงานผู้ดูแลทั้งเต็มและบางเวลามาช่วยดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (2) อย่างไรก็ตามการดูแลทั้งสองแบบนำมาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจของครอบครัว คือ ขาดรายได้ที่เหมาะสม ถ้าเลือกให้สมาชิกครอบครัวต้องออกจากงานมาดูแลแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อคนดูแลในระยะยาวเมื่อผู้ที่ตนดูแลจากโลกนี้ไป หรือ มีรายจ่ายเมื่อจ้างผู้ดูแลเป็นประจำ ซึ่งคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นบาทต่อเดือน ขณะเดียวกันจากการเปลี่ยนแปลง

เชิงโครงสร้างประชากร ขนาดครอบครัวที่เล็กลง การเคลื่อนย้ายของวัยแรงงาน ทำให้ศักยภาพของครัวเรือนในการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงถดถอยลงทำให้มีข่าวภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงถูกลูกหลานทอดทิ้งขาดคนดูแล

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีความจำเป็นที่ภาครัฐต้องเข้ามาแสดงบทบาทในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ศักยภาพไม่เพียงพอ ในการจัดเตรียมสถานบริการหรือระบบบริการให้มี caregivers ไว้รองรับให้เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เพราะผู้มีภาวะพึ่งพิงอาจไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่ไม่สามารถให้การดูแลที่บ้านต่อไปได้ ผู้ที่มีความต้องการการดูแลระยะยาวจึงเป็นปัญหาระดับชาติ ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาในระดับครัวเรือนอีกต่อไป

ในการนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้พัฒนาและดำเนินการระบบการดูแลระยะยาวในชุมชนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยแนวคิดหลักคือให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในชุมชน โดยความร่วมมือของภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัว เพื่อให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและพักอาศัยอยู่ที่บ้านตนเอง ท้องถิ่นเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โดยมีผู้จัดการการดูแล (care manager, CM) และผู้ช่วยเหลือดูแล (caregiver, CG) ที่ผ่านการอบรมให้การดูแล ทั้งนี้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 6,000 บาท/คน/ปีตั้งแต่เริ่มดำเนินการและเพิ่งเพิ่มเป็น 10,442 บาท/คน/ปีในปีงบประมาณ 2567 (3) การดำเนินการที่ผ่านมาก็ประสบกับปัญหาอุปสรรคหลายประการ ตั้งแต่เรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว รวมถึงอำนาจในการใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการสนับสนุนการดำเนินงาน งบประมาณที่จำกัดรวมถึงความหลากหลายในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยเหลือดูแล การบริหารจัดการกำลังคนในระบบการดูแลระยะยาว รวมถึงระบบข้อมูลและการติดตามกำกับคุณภาพการให้บริการและผลลัพธ์ต่อผู้มีภาวะพึ่งพิงและครอบครัวที่ยังไม่ชัดเจน (4 - 6)

จากการดำเนินการจัดระบบการดูแลระยะยาวในชุมชนมาเกือบครบทศวรรษ จึงเห็นสมควรต้องมีการศึกษาสถานการณ์การจัดบริการดูแลระยะยาวในชุมชนของไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอย่างรอบด้านว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด เช่นความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย คุณภาพบริการ ผลลัพธ์และผลกระทบต่อผู้มีภาวะพึ่งพิงและครอบครัว รวมถึงมีปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคอะไรที่ทำให้ อปท. บางแห่งไม่มีการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานการณ์การจัดบริการดูแลระยะยาวในชุมชนของไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
2. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การมีภาวะพึ่งพิงของประชากรไทยและการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวในชุมชนในช่วงที่ผ่านมา
3. เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดบริการดูแลระยะยาวในชุมชน
4. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายและช่องว่างประเด็นการวิจัยในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน

ระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป

การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed-methods research design) ในลักษณะการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบคู่ขนาน (concurrent design) ตามแนวคิดของ Creswell and Clark (2011) เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในบริบทประเทศไทย โดยอาศัยทั้งการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ฐานข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น การสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย ฐานข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงบริการและการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และกลไกการดำเนินงานของระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามจะดำเนินการในพื้นที่ตัวอย่างจาก 4 ภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมบริบทการจัดบริการที่หลากหลาย ทั้งในมิติของรูปแบบการบริหารจัดการ การทำงานของผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และลักษณะพื้นที่เมืองและชนบท

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังดำเนินการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากฐานข้อมูลวิชาการและเอกสารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษา โดยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะถูกนำมาประกอบกันเพื่อประเมินสถานการณ์และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทยต่อไป

บทที่ 2
สังคมผู้สูงอายุและการดูแลระยะยาว

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา โครงสร้างประชากรโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ อันเป็นผลจากความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจสังคม รวมถึงทางการแพทย์ เทคโนโลยี และการพัฒนาระบบสาธารณสุข ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของการพัฒนาในระดับโลก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้มีเพียงมิติของความสำเร็จ หากยังเป็นสัญญาณเตือนถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างต่อระบบสุขภาพ ระบบสวัสดิการสังคม และระบบเศรษฐกิจการคลังของแต่ละประเทศ ที่จำเป็นต้องปรับตัวและรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

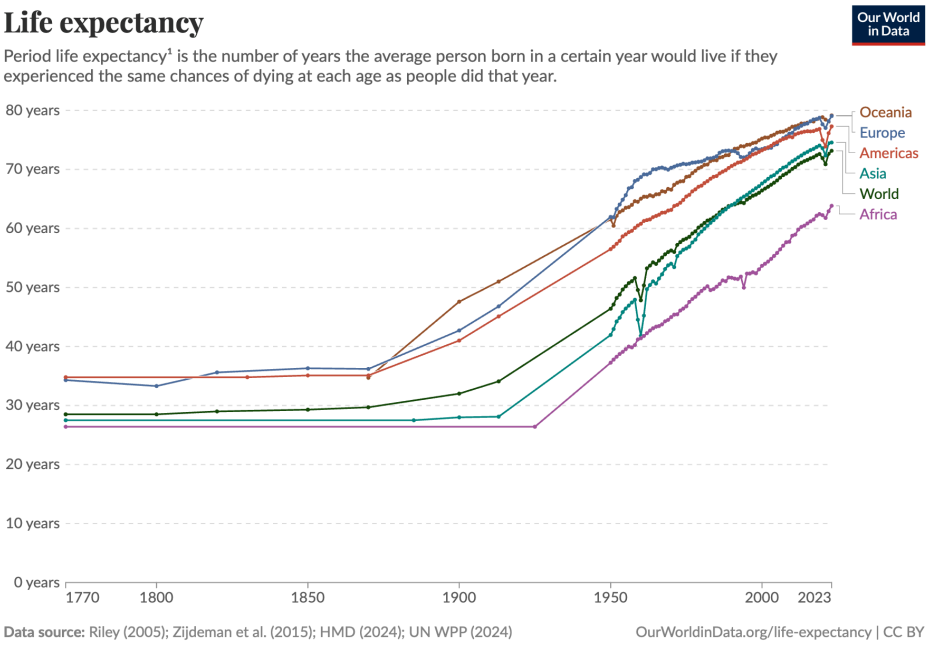
เพื่อปูพื้นฐานสู่การทำความเข้าใจระบบสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย บทนี้จึงมุ่งวางกรอบเชิงแนวคิดและเชิงสถานการณ์เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุและมโนทัศน์หลักของระบบการดูแลระยะยาว โดยเริ่มจากการทบทวนสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุทั้งในระดับโลกและประเทศไทย วิเคราะห์พลวัตของอายุขัย ช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดี และอัตราส่วนการพึ่งพิง ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

จากนั้นจะอธิบายพัฒนาการของระบบการดูแลระยะยาวในระดับนานาชาติ ตั้งแต่รูปแบบการดูแลในสถานบริการ (institutional care) ไปสู่แนวคิดการดูแลในชุมชน (community-based care) และการดูแลแบบบูรณาการต่อเนื่อง (integrated continuum of care) พร้อมทั้งนำเสนอกรอบองค์ประกอบหลักของระบบการดูแลระยะยาวตามข้อเสนอ

ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งครอบคลุมมิติด้านการอภิบาล การเงินการคลัง ระบบข้อมูล กำลังคน และการส่งมอบบริการ เพื่อเป็นฐานในการวิเคราะห์ระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทยในส่วนถัดไป

สถานการณ์โลกและประเทศไทยด้านผู้สูงอายุ

ความก้าวหน้าด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม การสาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการแพทย์นั้นนำมาสู่การยืดอายุขัย (Life expectancy) ของมนุษยชาติอย่างมีนัยสำคัญ ย้อนกลับไปช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 นั้น อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกอยู่ที่ประมาณ 30 ปีเท่านั้น ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อายุขัยของประชากรเพิ่มขึ้นมาเป็น 46 ปี และข้อมูลล่าสุดจากองค์การสหประชาชาติประมาณการณ์อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกในปี ค.ศ. 2023 อยู่ที่ 73 ปี (7) แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเพียง 150 ปีนั้น มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นกว่าเดิมเกือบ 2.4 เท่า (รูปที่ 1) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษย์



รูปที่ 1 พัฒนาการของอายุขัยประชากรโลกและภูมิภาคต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม การที่ประชากรโลกมีอายุยืนยาวขึ้นย่อมนำมาซึ่งความท้าทายต่อระบบสุขภาพทั่วโลกควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ เห็นได้ว่าปัจจุบันหลายประเทศมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและลักษณะพลวัตของประชากรนี้เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างก้าวกระโดด ในปี ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปทั่วโลกมีมากกว่าจำนวนเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี และมีแนวโน้มว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยจากการพยากรณ์ระหว่างปี 2015 ถึง 2050 สัดส่วนประชากรโลกที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะเพิ่มจากประมาณ 12% เป็นเกือบ 22% ของประชากรทั้งหมด (8) ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) มีการให้นิยามของระดับความรุนแรงของสังคมผู้สูงอายุตามสัดส่วนของประชากรสูงอายุในแต่ละปีไว้ 3 ระดับ (9) ได้แก่

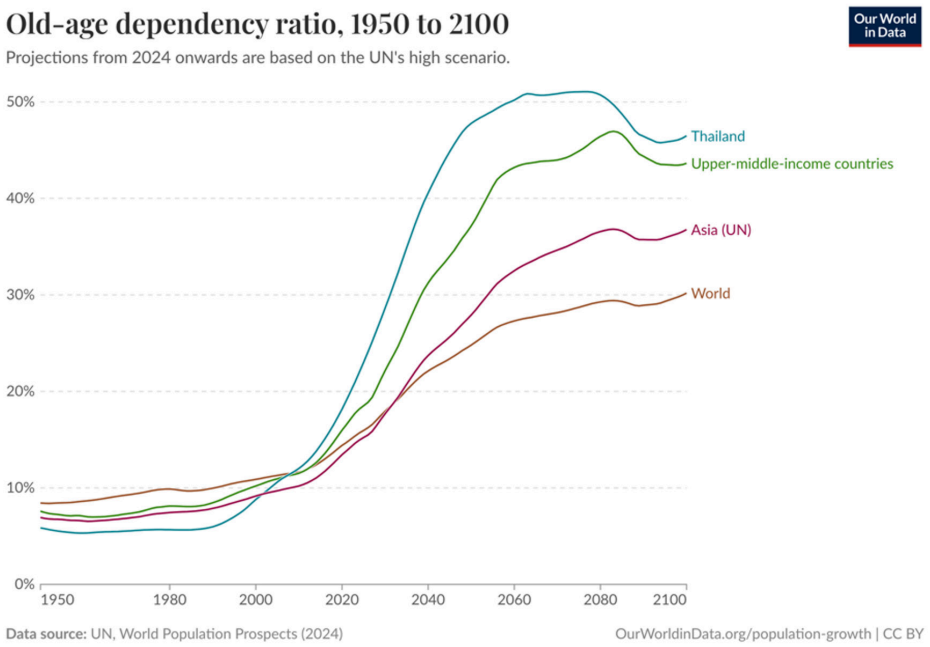
1. ระดับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) หมายถึง ประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ หรืออายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศในบริบทของประเทศกำลังพัฒนา

2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายถึง ประเทศที่มีประชากรอายุ 65 เพิ่มเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ หรืออายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศในบริบทของประเทศกำลังพัฒนา

3. ระดับสังคมผู้สูงอายุระดับสูงยอด (Super-aged Society หรือ Hyper-aged Society) หมายถึง ประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ขึ้นไป มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรืออายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศในบริบทของประเทศกำลังพัฒนา

หากพิจารณาในมุมมองทางเศรษฐกิจและการคลังของประเทศนั้น ความกังวลที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับอัตราส่วนการพึ่งพิงของผู้สูงอายุ (Old-age dependency ratio) ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย กล่าวคือ อัตราส่วนการพึ่งพิงนั้นแสดงให้เห็นสัดส่วนประชากรสูงอายุเทียบกับประชากรวัยทำงาน ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมที่กลุ่มวัยทำงานต้องแบกรับในการดูแลผู้สูงวัยในสังคม ในระดับโลกอัตราส่วนการพึ่งพิงนี้กำลังปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมเพียงร้อยละ 11 ในปี ค.ศ. 2000

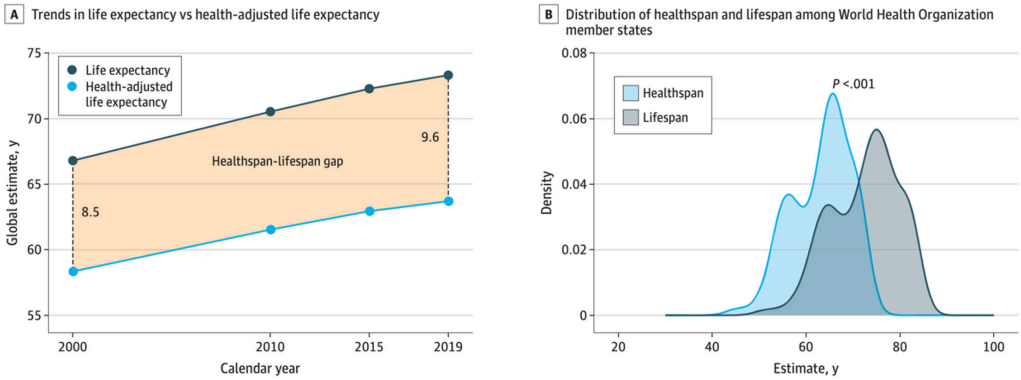
เพิ่มเป็นร้อยละ 16 ในปี ค.ศ. 2024 กล่าวคือ จากเดิมมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 11 คนต่อประชากรวัยทำงาน 100 คนในปี ค.ศ. 2000 เพิ่มขึ้นมาเป็น 16 คนต่อประชากรวัยทำงาน 100 คนในปี ค.ศ. 2004 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นราวร้อยละ 24 ภายในปี ค.ศ.2050 นั่นคือภายในปี 2050 ทั่วโลกจะมีผู้สูงอายุโดยเฉลี่ย 1 คนต่อประชากรวัยทำงานไม่ถึง 5 คน (10) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของการจัดการด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ และการจัดบริการสวัสดิการสังคมที่จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้



รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงและพยากรณ์ของอัตราส่วนการพึ่งพิงของผู้สูงอายุ ระหว่างปี 1950 ถึง 2100

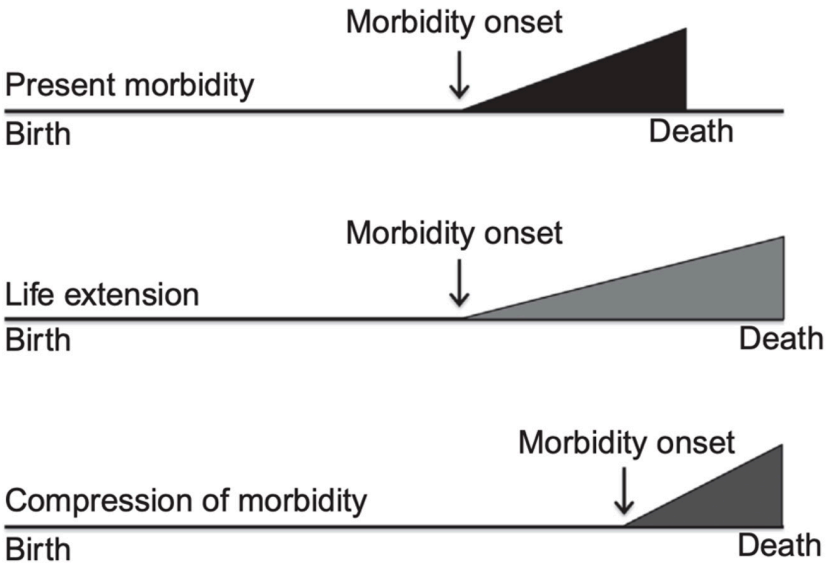
และหากพิจารณาในระบบสุขภาพ พบว่า แม้มนุษย์โดยเฉลี่ยจะมีอายุยืนยาวมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าช่วงเวลาทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นนั้นจะปราศจากปัญหาสุขภาพอย่างสิ้นเชิง แนวคิดเรื่อง “ช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดี (Health-span)” ถูกพูดถึงมากขึ้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าคนเรามีช่วงชีวิตที่ปราศจากความเจ็บป่วยหรือความพิการนานเพียงใดเมื่อเทียบกับอายุขัยรวมทั้งหมด (11) จากการวิเคราะห์ข้อมูลอายุขัยภาพรวมเทียบกับอายุขัยที่มีสุขภาพดี (Health-adjusted

life expectancy, HALE) นั้นชี้ว่า การเพิ่มอายุขัยไม่ได้มาควบคู่กับการมีสุขภาพที่ดีในบั้นปลายชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือ ในช่วงตั้งแต่ ค.ศ. 2000 – 2019 นั้น ผู้คนมีขัยเพิ่มมากขึ้น ทว่ากลับมีช่วงชีวิตที่มีปัญหาสุขภาพเพิ่มมากขึ้นจาก 8.5 ปีเป็น 9.6 ปี ซึ่งปัญหาสุขภาพนั้นมักมาจากโรคเรื้อรังหรือภาวะพึ่งพิงทางสุขภาพต่าง ๆ ในช่วงปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิต (12)



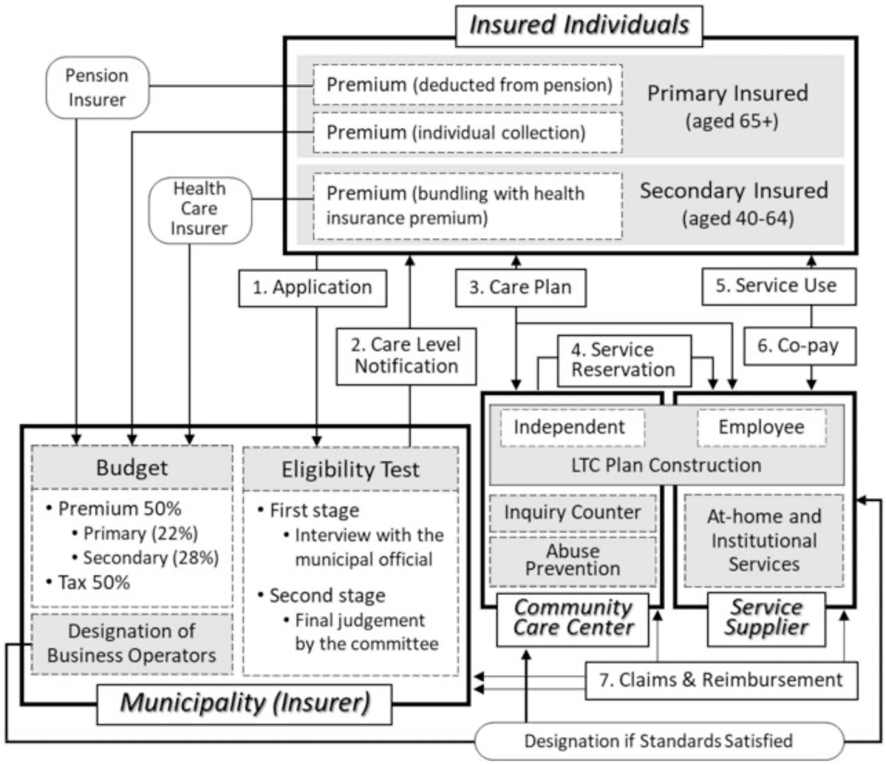
รูปที่ 3 การเพิ่มขึ้นของช่วงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในภาพรวมของโลก (Garmany & Terzic. 2024)

ทว่าในทางกลับกัน มีนักวิชาการบางกลุ่มได้เสนอแนวคิดเชิงบวกเกี่ยวกับแนวคิด “การบีบอัดความเจ็บป่วย (Compression of morbidity)” โดยคาดหวังว่าพัฒนาการทางการแพทย์และเทคโนโลยีอาจช่วยลดระยะเวลาที่ผู้สูงอายุต้องทุกข์ทรมานกับภาวะเจ็บป่วย กล่าวคือพยายามทำให้มนุษย์แก่ช้าลงและมีช่วงชีวิตที่สุขภาพดียาวนานขึ้น (13) (รูปที่ 4) อย่างไรก็ดี หลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบันยังไม่ชัดเจนว่าสังคมโลกกำลังเดินไปสู่ทิศทางดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกชี้ว่า สัดส่วนช่วงชีวิตที่คนเรามีสุขภาพดียังคงใกล้เคียงเดิมเมื่อเทียบกับอดีต ซึ่งหมายความว่าปีที่เพิ่มขึ้นในอายุขัยนั้นโดยมากยังคงเป็นช่วงเวลาที่สุขภาพถดถอยหรือมีโรคประจำตัวรุมเร้าอยู่ดี หากผู้คนสามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้นโดยที่สุขภาพดีควบคู่กันไปและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ผู้สูงอายุเหล่านั้นก็จะยังสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคุณค่าได้ไม่ต่างจากคนวัยหนุ่มสาวมากนัก แต่หากปีที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้นเต็มไปด้วยการเสื่อมถอยทางร่างกายและจิตใจ ก็จะส่งผลเชิงลบต่อทั้งคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเองและภาระต่อสังคมโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ (8)



รูปที่ 4 การเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดการยืดอายุ (Life extension) ที่มีช่วงภาวะเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นและแนวคิดการบีบอัดความเจ็บป่วย (Compression of morbidity) (Fries, 2016)

แม้วิกฤตประชากรสูงวัยจะเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก แต่ภาพรวมสถานการณ์ในแต่ละประเทศกลับมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางประชากร นโยบายทางเศรษฐกิจ และลักษณะทางสังคมของแต่ละประเทศ ในอดีตนั้น กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยเริ่มขึ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหรือมีรายได้สูงก่อน (High income countries: HICs) เช่น ในยุโรปตะวันตก อเมริกาเหนือ รวมถึงญี่ปุ่น เป็นต้น ประเทศเหล่านี้ผ่านยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางประชากรไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดช่วงศตวรรษที่ 20 และได้นำมาตรการต่าง ๆ มารองรับสังคมสูงวัยล่วงหน้าหลายทศวรรษ ไม่ว่าจะเป็นระบบบำนาญของรัฐ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีประชากรสูงอายุมากกว่าร้อย 30 และถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก ซึ่งญี่ปุ่นได้เริ่มเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970s - 1980s และได้พัฒนาระบบสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งกองทุนการดูแลระยะยาวแยกออกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน ค.ศ. 2000 (14) ทำให้ประเทศสามารถรับมือกับสังคมสูงวัยได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ

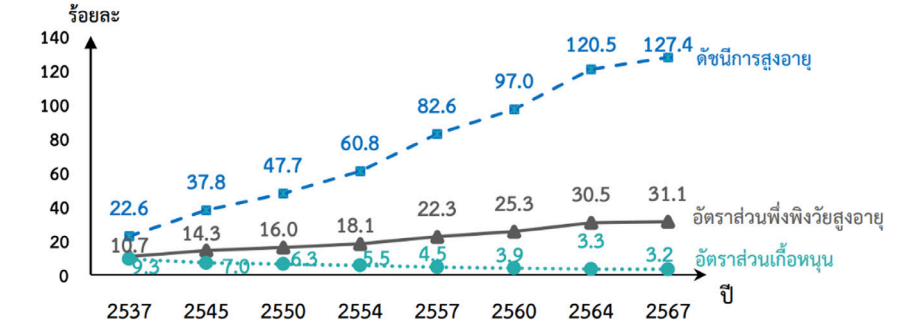


รูปที่ 5 กลไกการเงินการคลังของกองทุนการดูแลระยะยาวในประเทศญี่ปุ่น
(Fu & Noguchi, 2019)

ในทางกลับกัน ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่ง (Low- and middle-income countries: LMICs) กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ทศวรรษนี้ โดยที่หลายประเทศยังมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบสวัสดิการที่ไม่เต็มที่นัก สหประชาชาติประมาณการณ์ว่า ภายในปี 2050 ประชากรสูงอายุของโลกกว่าร้อยละ 80 จะอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง (8) กล่าวได้ว่าสังคมสูงวัยในอนาคตจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มประเทศร่ำรวย หากแต่จะเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากรในประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมาก โดยที่ในอดีตประเทศที่พัฒนาแล้วบางแห่งใช้เวลากว่า 50 - 100 ปี ในการเพิ่มสัดส่วนผู้สูงอายุจากระดับร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 14 ของประชากร แต่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างจีนหรือไทยอาจใช้เวลาไม่ถึง 25 ปีในการเปลี่ยน

ผ่านสู่ระดับเดียวกัน จึงเกิดปรากฏการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญบางรายเรียกว่า “แก่ก่อนรวย” (15) ซึ่งหมายถึงการที่ประเทศมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นมากทั้งที่รายได้ประชาชาติหรือทรัพยากรของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์จำกัด ส่งผลให้การจัดบริการสวัสดิการและระบบดูแลผู้สูงอายุเผชิญข้อจำกัดและแรงกดดันสูงมาก

ประเทศไทยเองก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้น พบว่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเพียงร้อยละ 6.8 ในปี พ.ศ. 2537 เป็นร้อยละ 20.0 ในปี พ.ศ. 2567 (16) ซึ่งเกินเกณฑ์ที่นิยามว่า “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (aged society)” ไว้แล้ว นอกจากนี้ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุชาวไทยยังได้แซงหน้าประชากรที่อายุต่ำกว่า 15 ปีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 และอัตราส่วนการพึ่งพิงของไทยอยู่ที่ร้อยละ 30 ในปัจจุบัน ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวส่งสัญญาณว่าฐานประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานของไทยกำลังหดตัวลง ขณะที่สัดส่วนผู้สูงวัยเพิ่มสูงขึ้นและจะยังเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้ และจะนำมาซึ่งภาวะขาดแคลนแรงงานและผลิตภาพทางเศรษฐกิจที่ถดถอยลง หากไม่สามารถปรับตัวด้วยนโยบายเพิ่มผลิตภาพแรงงานหรือเพิ่มแรงงานจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ทันเวลา



หมายหตุ: ดัชนีการสูงอายุ คำนวณจากจำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี 100 คน
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ คำนวณจากจำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรอายุ 15 – 59 ปี 100 คน
อัตราส่วนเกื้อหนุน คำนวณจากจำนวนประชากรอายุ 15 – 59 ปี เทียบกับประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป

รูปที่ 6 สถานการณ์ผู้สูงอายุในไทย
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2024)

นอกเหนือจากประเด็นด้านโครงสร้างจำนวนประชากรแล้ว สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยยังมีมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจที่ท้าทายควบคู่กัน จากการศึกษาดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index, MPI) พบว่า มีผู้สูงอายุไทยที่อยู่ในภาวะยากจนถึงร้อยละ 18 และมีผู้สูงอายุเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มีเงินออม ขณะที่ระบบบำเหน็จ/บำนาญภาคบังคับนั้นปัจจุบันครอบคลุมเพียงข้าราชการหรือลูกจ้างประจำภาครัฐ ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องพึ่งพิงรายได้จากบุตรหลานหรือเบี้ยยังชีพจากรัฐเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยอาจประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสุขภาพในบั้นปลายชีวิต หากไม่มีหลักประกันที่เข้มแข็งพอ (17) นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินสำหรับวัยเกษียณ และมีแนวโน้มจะมีรายได้ไม่พอเพียงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งทำให้รัฐจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลประชากรกลุ่มนี้ในอนาคต

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทย กล่าวคือ มีขนาดเล็กลงและกระจายตัวมากขึ้น และก้าวเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้นนั้น ทำให้การพึ่งพิงการดูแลจากบุตรหลานยากลำบากกว่าเดิม ในขณะที่ความต้องการบริการด้านสุขภาพและการดูแลระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อประชากรสูงวัยมีจำนวนมากขึ้น ภาครัฐไทยจึงมีบทบาทสำคัญในการวางแผนรองรับสังคมสูงวัย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมโรคเรื้อรังและภาวะผู้สูงอายุ การส่งเสริมการออมและระบบบำเหน็จบำนาญที่ยั่งยืน ตลอดจนการสนับสนุนให้ภาคเอกชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมหรือโครงข่ายการดูแลผู้สูงวัยในระยะยาวต่อไป

โดยสรุป การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันส่งผลให้ภาพรวมของปัญหาทางสุขภาพที่ต้องการการดูแลรักษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านจำนวนและความซับซ้อนของโรคที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภาวะพึ่งพิง หรือความเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวมิได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวโยงกับโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การหดตัวของขนาดครอบครัว การย้ายถิ่นของแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งล้วนส่งผลให้กลไกการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอ่อนแอลง

ดังนั้น “การดูแลระยะยาว” (Long-Term Care) จึงเป็นแนวคิดสำคัญที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ซับซ้อนเหล่านี้ โดยมิได้หมายถึงเพียงการรักษาพยาบาลทางกายเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนด้านจิตสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการสร้าง

ระบบบริการที่ต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวจึงกลายเป็นวาระสำคัญของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่ต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ระบบการดูแลระยะยาวที่มีคุณภาพและยั่งยืนยังคงเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่นักวิชาการและผู้กำหนดนโยบาย เนื่องจากต้องอาศัยทรัพยากรจำนวนมาก การบูรณาการระหว่างภาคส่วน และความเข้าใจในบริบทของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม ท่ามกลางข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและสังคม การแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรมจึงยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในส่วนถัดไปของบทนี้

วิวัฒนาการและกรอบแนวคิดสากลเกี่ยวกับระบบการดูแลระยะยาว

ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคกลาง การดูแลผู้สูงอายุยากไร้ในชุมชนนั้นถูกจัดขึ้นในลักษณะการกุศลภายใต้การจัดตั้งบ้านพักสงเคราะห์ (Almshouse) โดยบ้านพักนี้ไม่เพียงแต่ให้ที่อยู่กับผู้สูงอายุเท่านั้น ทว่า เป็นบ้านพักสำหรับคนจนในสังคมทุกช่วงอายุและมีความยึดโยงกับความเชื่อทางศาสนา ในยุโรปมีการกระจายของบ้านพักสงเคราะห์ในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 และเริ่มมีในอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 17 ทว่าบ้านพักสงเคราะห์นี้จะเน้นให้การดูแลทางสังคมเป็นหลัก อาทิ การให้ที่อยู่อาศัย อาหาร และการประกอบอาชีพ ทว่าการให้บริการทางสุขภาพนั้นยังคงเน้นหนักไปที่บริการในโรงพยาบาล (18)

จนมาถึงต้นศตวรรษที่ 19 ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากไร้ที่ไม่มีครอบครัวคอยดูแล หลายครั้งกลายเป็นภาระของโรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์ เนื่องจากไม่มีระบบรองรับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน จึงกำเนิดเป็น “Benevolent ladies” ซึ่งเป็นสมาคมการกุศลที่รวบรวมพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถให้บริการทางสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยหรือภายในชุมชนได้ กลายเป็นบริการทางสุขภาพในชุมชน (Community-based healthcare) แรก ๆ ที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันตก และเริ่มแพร่หลายมากขึ้นและได้รับการบรรจุเข้าไปในหลักประกันสุขภาพในต้นศตวรรษที่ 20 (19) ถึงแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีการพูดถึงการดูแลระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

การดูแลระยะยาวเริ่มมีรูปธรรมชัดเจนขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม (Social Security Act)[1] ในปี ค.ศ. 1935 ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลาง

วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ (Great Depression, 1929–1939) ภายใต้รัฐบาล Franklin D. Roosevelt และแนวคิดเศรษฐกิจแบบเคนส์ (Keynesian economics) ที่มุ่งให้รัฐเข้ามาดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายภาครัฐ พระราชบัญญัตินี้ได้จัดตั้งโครงการ Old Age Assistance (OAA) เพื่อให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ยากจน (20) แต่กฎหมายกำหนดว่าผู้รับสิทธิจะไม่ได้รับเงินหากอาศัยอยู่ในบ้านพักสงเคราะห์ของรัฐ (หรือ Almshouse เดิม) จึงทำให้เกิดการขยายตัวของบ้านพักผู้สูงอายุเอกชน (Old-age homes) และต่อมาพัฒนาเป็น Nursing homes ในช่วงทศวรรษ 1940 - 1950 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการดูแลระยะยาวในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่นั้น

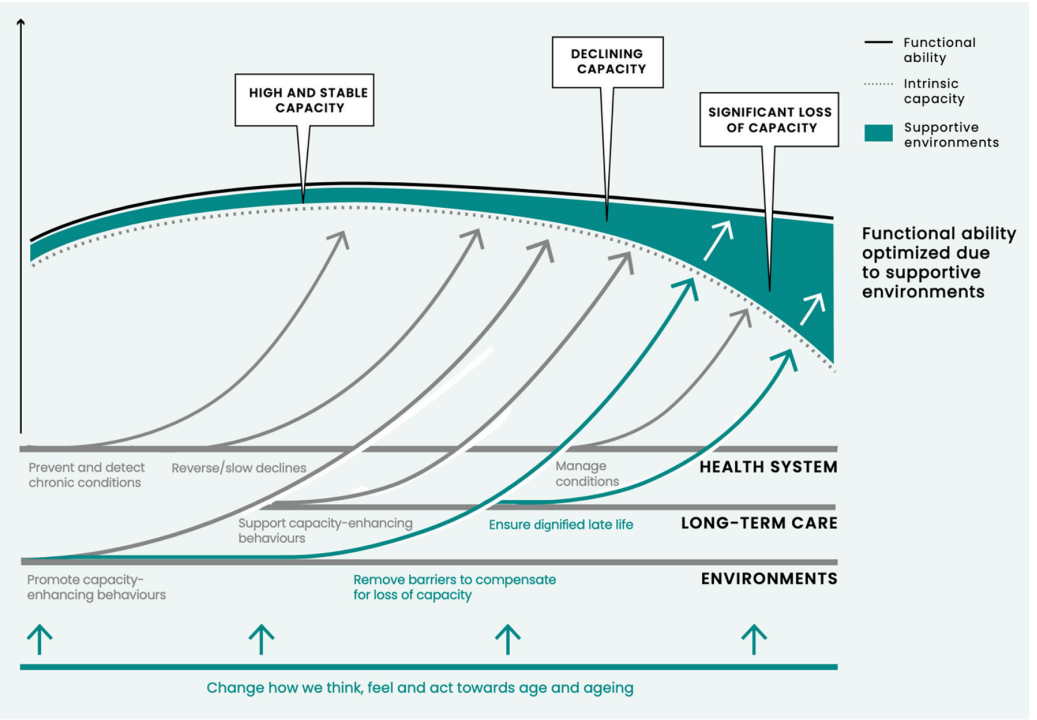
ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 การปรับแก้พระราชบัญญัติประกันสังคม ซึ่งก่อกำเนิด Medicare และ Medicaid และได้ตอกย้ำบทบาทของรัฐในระบบการดูแลสุขภาพและการดูแลระยะยาว โดย Medicaid กลายเป็นผู้จ่ายค่าบริการหลักสำหรับการดูแลในหน่วยบริการ (Institutional long-term care) และเป็นแรงผลักสำคัญให้บริการ Nursing home ขยายตัวอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ (21) นับตั้งแต่นั้น “การดูแลผู้สูงอายุ” ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐในการสร้างสมดุลระหว่างความยั่งยืนทางการคลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในบริบทของสังคมที่เข้าสู่ความเป็นผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ

การเกิดขึ้นของระบบการดูแลระยะยาวในสหรัฐอเมริกาจึงเป็นต้นกำเนิดในเกิดการพัฒนาระบบบริการในประเทศอื่น ๆ ในช่วงระยะต่อมา ตั้งแต่การพัฒนารัฐสวัสดิการในประเทศต่าง ๆ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (22) หรือการยอมรับแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นสังคมผู้สูงอายุและการดูแลระยะยาวในกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) (23) ตลอดจนการเคลื่อนเข้าสู่กรอบแนวคิดการให้บริการการดูแลระยะยาวในชุมชน (Community-based long term care) แทนการให้บริการการดูแลระยะยาวในหน่วยบริการ ซึ่งพบว่ามีต้นทุนต่ำกว่าในประเทศพัฒนาแล้ว (21) ทำให้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวกลายเป็นกรอบแนวคิดใน

[1] คำว่า “Act” ในที่นี้หมายถึงกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ตราโดยรัฐสภาสหรัฐ (Congress) และได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดี ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติในระบบกฎหมายไทยในแง่ของศักดิ์และผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม คำว่า “พระราชบัญญัติ” ที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นเพียงคำแปลเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจระดับของกฎหมาย มิได้แปลตามโครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศนั้น ๆ

ระดับสากลและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรนานาชาติอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ พัฒนาการของระบบการดูแลระยะยาวในแต่ละประเทศจะกล่าวในบทถัดไป

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) จึงได้ผลักดันให้เกิดระบบ “การดูแลระยะยาวแบบบูรณาการต่อเนื่อง (Integrated continuum of long-term care)” ขึ้นในประเทศต่าง ๆ โดยกำหนดสิ่งที่ระบบสุขภาพและสังคมต้องจัดให้มี (Social provisioning process) เพื่อทำให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการดำรงชีวิต (functional ability) มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละช่วงเวลา หรือในแง่หนึ่งคือการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่สุขภาพดี (Healthy ageing) นั่นเอง (24) (รูปที่ 7)



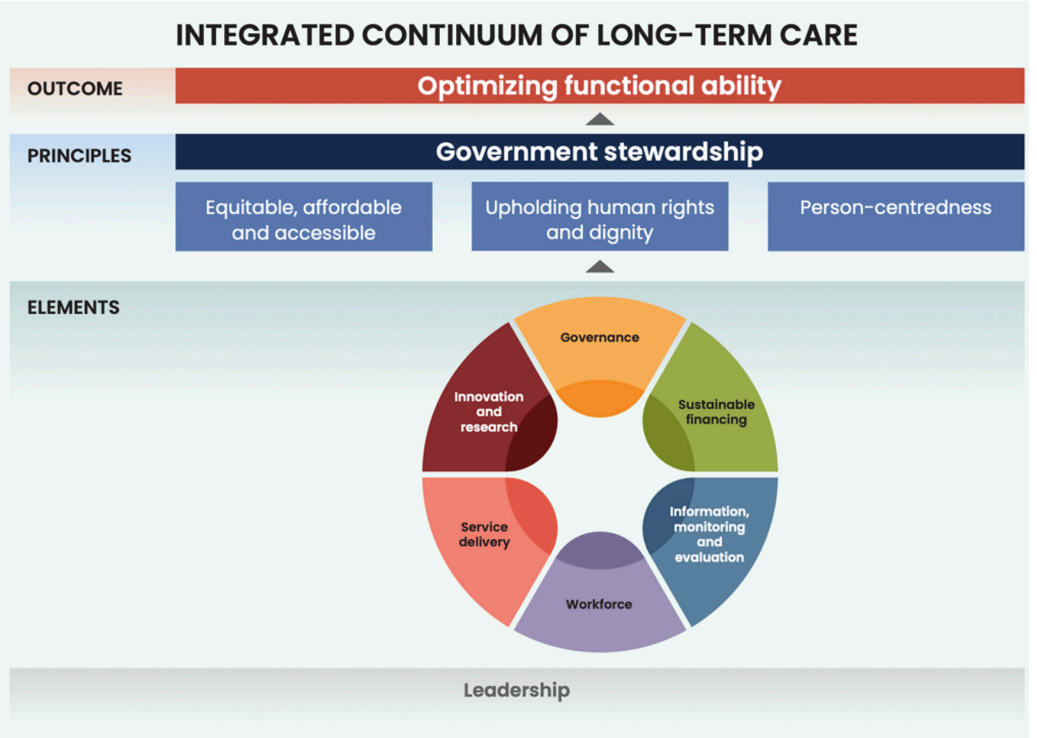
รูปที่ 7 กลไกการเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิต (functional ability) ในผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ระบบบริการการดูแลระยะยาวจะต้องมีลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้

- **เป็นบริการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนพิจารณาถึงคุณค่าและความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก** โดยระบบการดูแลระยะยาวนั้นควรจัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและคุณค่าที่ผู้รับบริการแต่ละคนต้องการ โดยต้องมีการให้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้ผู้รับบริการและ/หรือผู้ดูแลสามารถร่วมตัดสินใจในการรับบริการได้ นอกจากนี้ผู้รับบริการและ/หรือผู้ดูแลยังมีเสรีภาพในการจินตนาการถึงความเป็นอยู่ที่ดี ความหมายและศักดิ์ศรีของชีวิต และชีวิตที่ดี ถึงแม้ว่าจะผู้รับบริการจะมีการเสื่อมถอยของศักยภาพทางร่างกายแล้ว หรือมีความเสี่ยงจะสูญเสียศักยภาพในอนาคต
- **มุ่งหวังเพิ่มศักยภาพในการทำหน้าที่ของร่างกายและจิตใจให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละช่วงวัย** การดูแลระยะยาวนั้นจะต้องให้บริการเพื่อชดเชยความเสื่อมของสมรรถภาพทางกายและความต้องการพื้นฐานในชีวิต ทั้งนี้ ยังต้องสนับสนุนกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ได้เรียนรู้ ได้เติบโต และได้ตัดสินใจในกระบวนการต่าง ๆ ในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่
- **เป็นบริการที่ให้ในชุมชน (Community-based)** การดูแลระยะยาวจะต้องส่งมอบบริการที่สนับสนุนกิจกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับบริการจะสามารถใช้ชีวิตในสถานที่ที่พวกเขาเลือกได้ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนรอบข้าง
- **เป็นบริการที่บูรณาการและเชื่อมโยงกันตลอดสายใยการให้บริการ** การดูแลระยะยาวนั้นประกอบด้วยบริการย่อย ๆ หลายประเด็น ได้แก่ บริการส่งเสริมและป้องกันโรค บริการรักษา บริการฟื้นฟูและกายภาพบำบัด บริการดูแลประคับประคอง ตลอดจนบริการช่วยเหลือทางสังคม ซึ่งแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ บริการทั้งหมดจะต้องส่งมอบโดยไม่มีรอยต่อตลอดสายใยการให้บริการผ่านการบูรณาการระหว่างหลายภาคส่วน
- **ไม่ละเลยบริการที่เป็นการเสริมพลัง (Empower) และศักยภาพด้านอื่น ๆ ของผู้สูงอายุ** การดูแลระยะยาวไม่ใช่การดูแลเพื่อทดแทนการเสื่อมถอย ทว่า เป็นการ

ดูแลเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

- **มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ดูและและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับบริการระยะยาว** การดูแลระยะยาวนั้นจะส่งเสริมบริการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการเสื่อมถอยของผู้สูงอายุและการเจ็บป่วยนั้นจะไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อผู้ดูแลและครอบครัว ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และการเงิน



รูปที่ 8 กรอบแนวคิดการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการต่อเนื่องขององค์การอนามัยโลก

และเพื่อให้ระบบบริการการดูแลระยะยาวสามารถส่งมอบบริการตามลักษณะที่พึงประสงค์ได้นั้น องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบบริการสุขภาพก็จะต้องมีลักษณะบางประการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริการจะสามารถบูรณาการได้และตอบสนองความต้องการทางสุขภาพและความต้องการด้านสังคมของผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) การอภิบาลระบบ (Governance)

การอภิบาลระบบคือการทำให้กรอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ดำเนินคู่กับการกำกับติดตาม ควบคุม และออกแบบระบบ ระบบดูแลระยะยาวเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง หลายระดับการปกครอง และผู้ให้บริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคไม่แสวงหาผลกำไร ดังนั้น ระบบจึงต้องการกลไกประสานงานที่เข้มแข็งและกำหนดบทบาทของชุมชนอย่างเป็นทางการ โดยการอภิบาลระบบประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- **โครงสร้างการอภิบาลระบบ (Governance structure):** ในหลายประเทศ ระบบการดูแลระยะยาวคาบเกี่ยวระหว่างกระทรวงหลักอย่างน้อยสองกระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคม (Social affairs) ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการแยกส่วนและความซับซ้อนของการดำเนินนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณ การกำกับและติดตามผล มาตรฐานข้อมูล และกลไกการบริหารจัดการ การอภิบาลระบบที่ดีจึงเป็นการออกแบบการอภิบาลระบบที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการจัดตั้งหน่วยงานประสานงานพหุภาคีที่มีอำนาจหน้าที่ชัดเจนทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงและสื่อสารระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคส่วนที่เป็นงานสาธารณสุข และภาคส่วนอื่น ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม ตลอดจนทำงานประสานกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในกรณีศึกษาจากหลายประเทศ กลไกนี้จะช่วยให้การจัดบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น และยกระดับคุณภาพโดยรวม
- **กฎหมายว่าด้วยการดูแลระยะยาว (Long-term care legislation):** การตรากฎหมายระดับชาติเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในอนาคต โดยกลไกเชิงกฎหมายจะทำหน้าที่วางโครงสร้างการอภิบาลระบบ สร้างความยั่งยืนด้านการคลัง เกิดการวางแผนพัฒนากำลังคน และจัดตั้งระบบเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพผ่านตัวชี้วัดมาตรฐาน นอกจากนี้ กฎหมายที่มีคุณภาพต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย ได้แก่ ผู้ให้บริการ องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานรับรองคุณภาพบริการ ตลอดจนผู้สูงอายุและผู้ดูแลซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง โดยกฎหมายควรคุ้มครองทั้งการบริการระยะยาว รวมไปถึงบริการทางสังคมที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุและผู้ดูแล

- **ยุทธศาสตร์/แผนระดับชาติด้านการดูแลระยะยาว (Long-term care strategy):** ภายใต้กรอบกฎหมาย แต่ละรัฐควรจัดทำยุทธศาสตร์ แผน หรือกรอบนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ในรัฐสภา โดยแผนระดับชาตินี้ควรกำหนดหลักการ เป้าประสงค์ และมาตรการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถเป็นแผนเฉพาะด้านหรือจะบูรณาการอยู่ในนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้ เช่น บูรณาการเข้ากับสวัสดิการบำนาญผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดี แผนดังกล่าวจะอาศัยการบูรณาการหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันตั้งแต่ขั้นตอนการร่างแผนในตอนต้น
- **กลไกความรับผิดชอบ (Accountability mechanisms):** ความรับผิดชอบในที่นี้หมายถึง การที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตกลงไว้ได้หรือไม่ ซึ่งความรับผิดชอบนี้หมายถึงทุกภาคส่วนในระบบจะต้องมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน ซึ่งต้องมีกลไกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
    - ความโปร่งใสในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร
    - การติดตามประสิทธิผลของหน่วยงาน บริการ และกระบวนการ เช่น การประเมินผลลัพธ์นโยบาย
    - การสร้างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ครอบครัว ผู้ดูแล ภาคประชาสังคม และผู้ให้บริการระดับพื้นที่ในการกำหนดนโยบายและพัฒนาบริการ
    - การติดตามการดำเนินการของระบบการดูแลระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ
    - การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
    - การดำเนินมาตรการเพื่อกำกับเชิงกฎหมายและการดำเนินการ
    - การผูกกลไกการคลังเข้ากับตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และ
    - การรายงานผลการปฏิบัติงานสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานอิสระเพื่อให้สังคมสามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างโปร่งใส

2) การเงินการคลังที่ยั่งยืน (Sustainable Financing)

การสนับสนุนการคลังสำหรับการดูแลระยะยาวในประชากรสูงอายุที่มีการเสื่อมถอยทางร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายทางการคลังในรัฐบาลทั่วโลก ทว่า ถึงแม้การดูแลระยะยาวที่บูรณาการและตอบสนองปัญหาของผู้สูงอายุได้รอบด้านจะใช้งบประมาณในการลงทุนสูง ส่วนหนึ่งที่อาจเป็นผลตอบแทนได้นั้นจะอยู่ในรูปแบบของการที่ผู้ดูแลและครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสร้างผลิตภาพให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้นได้ และมากกว่านั้นระบบการดูแลที่มีคุณภาพก็อาจลดค่าใช้จ่ายทางสุขภาพในส่วนอื่น ๆ ได้เช่นกัน อาทิ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นหรือการเจ็บป่วยจากภาวะแทรกซ้อน ดังนั้น การดำเนินนโยบายการคลังสำหรับการดูแลระยะยาวจึงควรประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

- **กลไกการเงินการคลัง (Financing mechanism):** การออกแบบกลไกการเงินการคลังเพื่อการดูแลระยะยาวนั้นมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งหลักประกันภาครัฐ (public financing) หรือการใช้กองทุนประกันเอกชน แต่ไม่ว่าเลือกแบบใด กลไกการเงินการคลังจำเป็นต้องมีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจนและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อความสามารถในการระดมทุนและการใช้จ่ายที่โปร่งใส ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแล โดยตามอุดมคติแล้วนั้น รัฐควรสร้างสมดุลของการให้บริการโดยภาครัฐและภาคเอกชน ควบคู่กับกลไกการระดมทรัพยากรแบบกระจายความเสี่ยง (risk pooling) ที่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นจะด้วยการเก็บภาษีหรือการทำประกันแบบรวมกองทุน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ กลไกการเงินการคลังควรสนับสนุนเพื่อให้การดูแลแบบบูรณาการระหว่างภาคสุขภาพและภาคประชาสังคมที่ครอบคลุมบริการที่ตามความจำเป็นของผู้สูงอายุด้วย
- **การใช้จ่าย (Expenditure):** การใช้จ่ายต้องตั้งอยู่บนหลักการที่คำนึงถึงอนาคต (forward-looking) เช่น การมุ่งเน้นสิทธิประโยชน์ไปยังกลุ่มโรค/การเจ็บป่วยที่มีความต้องการสูง การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยออกค่าอยู่กิน (board and lodging) ในสถานดูแล การส่งเสริมการดูแลที่บ้านและชุมชนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางการคลัง การส่งเสริมนโยบายสูงอายุอย่างมีสุขภาวะ (healthy ageing) การป้องกันและชะลอภาวะถดถอย และการป้องกันโรค การใช้บริการที่ไร้ร้อยต่อระหว่างระบบการดูแลระยะยาวและระบบสุขภาพอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

ของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แต่ละประเทศควรทำความเข้าใจภาพรวมและรายละเอียดของกลไกการเงินการคลังและรูปแบบลักษณะการใช้จ่ายภายในประเทศอย่างละเอียด ทั้งตามมิติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยบริการ (บ้าน ชุมชน และสถานดูแล) และมิติสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) เมื่อเทียบกับความต้องการด้านสุขภาพและสังคมในประเด็นอื่น ๆ เพื่อชี้ให้เห็นช่องว่างและความจำเป็นในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม

- **แรงจูงใจสำหรับการให้บริการดูแลระยะยาว (Incentives for provision of long-term care services):** การออกแบบแรงจูงใจผู้ให้บริการที่เหมาะสมจะช่วยขยายการเข้าถึงบริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินชดเชยตามผลลัพธ์ (outcome-based financing) และตามผลงาน (pay-for-performance) สำหรับทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรับประกันคุณภาพบริการ การให้เงินโอน (cash transfer) สำหรับผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุชั่วคราว (respite care) ตลอดจนมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อให้สถานประกอบการพิจารณาวันลาเพิ่มเติมให้แก่ผู้ดูแลที่ต้องกลับไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ต่อเนื่องโดยไม่กระทบสุขภาวะของตนเอง นอกจากนี้ การออกแบบประกันที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk-adjusted schemes) ยังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการให้ความสำคัญกับกลุ่มประชากรที่ได้ประโยชน์สูงจากการดูแลแบบบูรณาการและเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เช่น ผู้มีโรคเรื้อรังและกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ
- **ความครอบคลุมประชากร (Population coverage):** แต่ละประเทศจำเป็นต้องระบุจำนวนและลักษณะประชากรที่ต้องการการดูแลระยะยาว พร้อมกำหนดเกณฑ์อย่างเป็นธรรมและชัดเจน ซึ่งต้องครอบคลุมทั้งมิติการเจ็บป่วยและมิติทางสังคมเศรษฐกิจ บางประเทศอาจพิจารณาการจัดบริการสุขภาพที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในหน่วยบริการควบคู่ไปกับการประเมินสถานะทางเศรษฐกิจสำหรับการจัดบริการทางสังคมอื่น ๆ วิธีการนี้จะช่วยให้รัฐบาลสามารถเลือกสนับสนุนครัวเรือนที่มีฐานะยากจนด้วยงบประมาณที่สูงกว่าได้ อย่างไรก็ดี วิธีดังกล่าวอาจก่อภาระต่อผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะปานกลาง ซึ่งเสี่ยงต่อภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวที่สูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ
- **ความครอบคลุมบริการ (Service coverage):** ความครอบคลุมบริการนั้นจะต้องพิจารณาในกรอบที่กว้างกว่าการดูแลในหน่วยบริการ ซึ่งต้องพิจารณาทั้งมิติของ

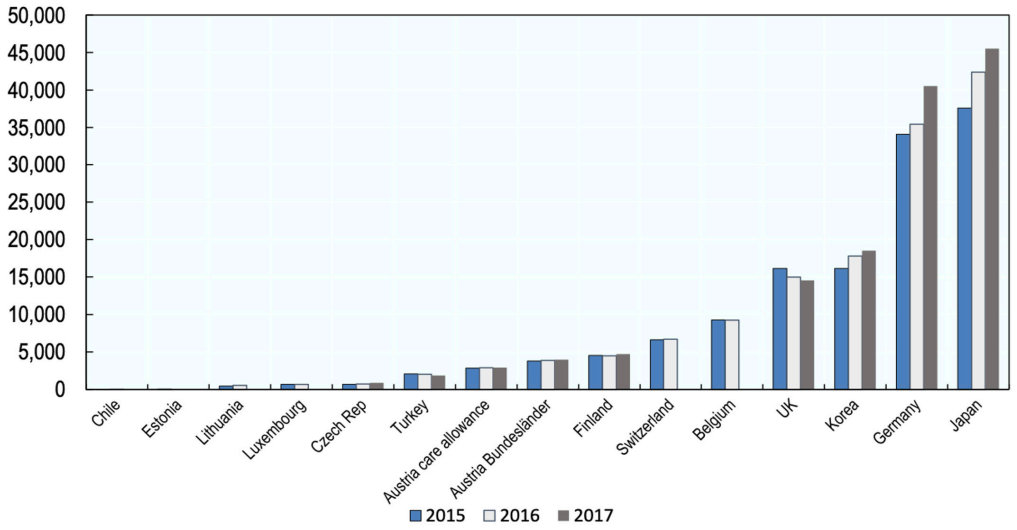
ประเภทบริการ เช่น การให้เงินสงเคราะห์ การให้บริการในชุมชน การให้บริการในศูนย์ดูแลระหว่างวัน และการดูแลในบ้านพักคนชรา ประกอบกับการพิจารณาความเข้มข้นของบริการ กล่าวคือ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งระดับความเข้มข้นนี้ควรพิจารณาจากประสิทธิผลของของแต่ละรูปแบบและระดับความต้องการของแต่ละบุคคล และที่สำคัญที่สุด ความครอบคลุมนี้จะต้องครอบคลุมความต้องการของผู้ดูแลด้วย ในประเทศที่มีบริการทางสุขภาพและบริการทางสังคมอยู่แล้วนั้น รัฐบาลควรวิเคราะห์ว่าที่ผ่านมา งบประมาณถูกใช้ไปกับบริการใดและปริมาณเท่าใด ซึ่งในกรณีที่พบว่ามีประชากรเพียงส่วนน้อยที่ได้รับความครอบคลุมอย่างเพียงพอและครัวเรือนยังต้องรับผิดชอบค่าดูแลเองเพื่อให้เข้าถึงบริการ รัฐบาลก็ควรปรับปรุงระบบในภาพรวมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจนมีความเสี่ยงต่อความยากจนในอนาคต ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงมิติของผู้สูงอายุส่วนบุคคล แต่หมายรวมถึงมิติครัวเรือนที่พิจารณาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและผู้ดูแลเข้าไปด้วย

รายงานของ OECD ปี 2563 (25) ระบุว่าหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญแรงกดดันด้านการจัดบริการ LTC จากการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงอายุ สัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น คอสตาริกา คาดว่าภายในปี 2593 ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึงสามเท่า ขณะที่เอสโตเนีย สาธารณรัฐเช็ก และชิลีคาดว่าในช่วงปี 2583 - 2593 ผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนราวหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมด แนวโน้มดังกล่าวยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อพิจารณาปัจจัยเสริม ได้แก่ การลดลงของบทบาทการดูแลโดยครอบครัว ความชุกของภาวะสมองเสื่อมที่สูงขึ้น และจำนวนผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ “ความต้องการบริการ LTC” เร่งตัวเข้าสู่ระดับสูงสุดครั้งใหม่

ภาระค่าใช้จ่ายด้าน LTC เพิ่มขึ้นทั้งจากอัตราการเรียกร้องสิทธิประโยชน์และความถี่ในการใช้บริการทำให้เสถียรภาพทางการคลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งรับมือ หลายประเทศดำเนินการประเมินเชิงนโยบายเพื่อจัดวางบทบาทระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่น กำหนดสมดุลระหว่างภาครัฐกับเอกชน และบูรณาการระบบสุขภาพเข้ากับระบบสวัสดิการอย่างไร้รอยต่อ เช่น สหราชอาณาจักรกำลังจัดทำเอกสารเชิงนโยบาย (Green Paper) เพื่อปฏิรูประบบ LTC คอสตาริกาให้สัตยาบันนโยบายความยั่งยืนทางเศรษฐกิจด้านประกันสุขภาพ ตุรกีถกเถียงการบรรจุ LTC ในระบบประกันสังคม และเยอรมนีได้จัดตั้งกองทุนสำรองดูแล LTC มาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งล้วนสะท้อนความพยายามออกแบบฐานะการคลังให้รองรับความต้องการในระยะยาว

ควบคู่กับประเด็นการเงินการคลัง หลายประเทศติดตามคุณภาพและความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ ออสเตรียพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลที่บ้านมีความพึงพอใจในระดับสูง ชิลีซึ่งเริ่มระบบสนับสนุนและการดูแลในระดับชาติมีรายงานจากธนาคารโลก (2560) ว่าครัวเรือนส่วนใหญ่พึงพอใจ และประชาชนญี่ปุ่นราวร้อยละ 60 เห็นว่าระบบ LTC ของประเทศตอบโจทย์ความต้องการของตน ข้อค้นพบเหล่านี้ยืนยันว่า “การคงไว้ซึ่งคุณภาพบริการ” ต้องเดินหน้าไปพร้อมกับ “การควบคุมค่าใช้จ่าย” เพื่อให้ระบบมีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของสาธารณะ

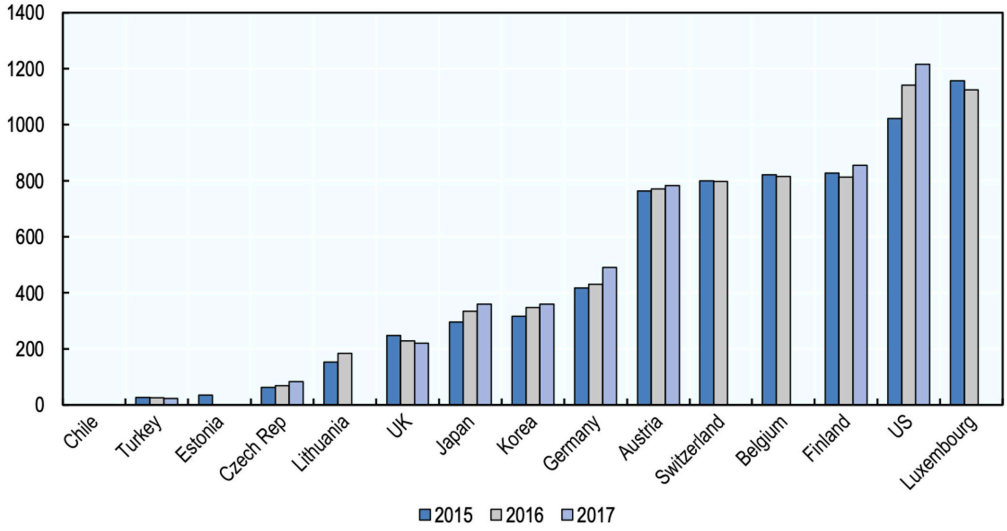
ข้อมูล OECD ช่วงปี 2015–2017 ชี้ว่าในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นและเยอรมนีเพิ่มการจัดสรรงบประมาณด้าน LTC อย่างต่อเนื่องดังรูปที่ 9



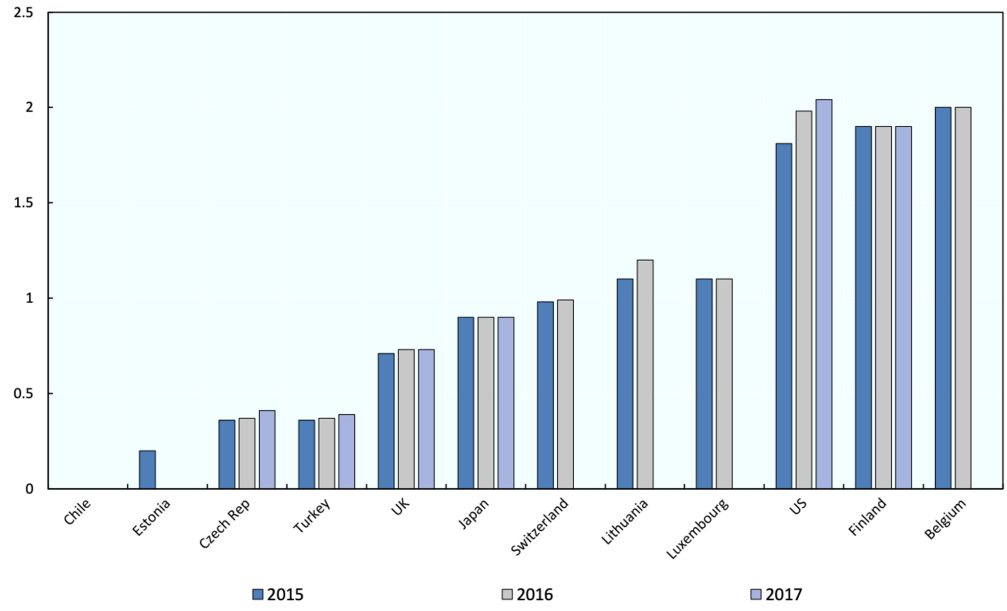
รูปที่ 9 รายจ่ายภาครัฐด้าน LTC ค.ศ. 2015–2017 (ไม่รวมสหรัฐอเมริกา)
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

โดยกรณีของเยอรมนีเชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบ LTC ครั้งสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว หากพิจารณารายหัว สหรัฐอเมริกาและลักเซมเบิร์กใช้งบประมาณต่อประชากรสูงกว่าประเทศอื่น สะท้อนการลงทุนต่อคนในระดับเข้มข้น ส่วนในเชิงสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) สหรัฐอเมริกาใช้งบประมาณด้าน LTC สูงที่สุดในปี 2017 ดังรูปที่ 10 และ 11 ที่ร้อยละ 2.04 ของ GDP ขณะที่ในปี 2015 - 2016 เบลเยียมใช้งบประมาณ

ด้านนี้ราวร้อยละ 2 ของ GDP ต่อเนื่องสองปี แสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ แม้บริบทเศรษฐกิจและประชากรแตกต่างกัน



รูปที่ 10 รายจ่ายเฉลี่ยต่อประชากรสำหรับ LTC (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐต่อคน)



รูปที่ 11 รายจ่ายภาครัฐด้าน LTC เมื่อเทียบกับ GDP (%)

ด้านแหล่งรายได้ ประเทศส่วนใหญ่พึ่งพางบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็มีตัวอย่างการระดมเงินแบบผสม อาทิ การจัดสรรจากทั้งรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการใช้กองทุนสหภาพยุโรปหรือทุนเอกชนต่างชาติ เพื่อเสริมความยืดหยุ่นทางการคลังสำหรับบริการ LTC ดังรูปที่ 12

Taxation	State budget allocation	Income-based contribution	Other
Belgium	Austria	Chile	Czech Rep
Czech Rep	Czech Rep	Costa Rica	Estonia
Estonia	Costa Rica	Czech Rep	Lithuania
Israel	Estonia	Estonia	
Japan	Hungary	Germany	
Luxembourg	Israel	Japan	
US	Japan	Korea	
	Luxembourg	Luxembourg	
	Russia	US	
	Turkey		
	US		

Note: In Austria there is no specific taxation for the financing of LTC. In Czech Republic, it is financed by state, regional and municipal governments. Lithuania uses central government budget, municipal budgets, EU structural funds, foreign foundations, sponsorship, social services organisation and family.
Source: OECD Questionnaire.

รูปที่ 12 วิธีการจัดหาเงินทุนภาครัฐสำหรับ LTC

ด้านกลไกการจ่ายเงิน ภาครัฐมักใช้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ (1) การจ่ายตรงจากผู้รับประกันไปยังผู้ให้บริการ (2) การจ่ายตามบริการ (Fee-for-Service) และ (3) การจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว (Capitation) ดังรูปที่ 13 โดยหลายประเทศออกแบบ “การร่วมจ่าย” ของผู้รับบริการเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ออสเตรียจัดเก็บค่าบริการดูแลเคลื่อนที่ เอสโตเนียให้ประชาชนจ่ายบางส่วนด้วยตนเอง และสาธารณรัฐเช็กปรับระดับเงินสงเคราะห์ตามระดับพึ่งพิง นอกจากนี้ เกือบทุกประเทศ (ยกเว้นลักเซมเบิร์ก) พิจารณารายได้จากบำนาญและสินทรัพย์ของผู้รับบริการในการคำนวณภาระร่วมจ่าย เช่น ญี่ปุ่นกำหนดสัดส่วนร่วมจ่ายตามรายได้สุทธิ และลิทัวเนียกำหนดเพดานไม่ให้จัดเก็บเกินร้อยละ 80 ของรายได้

Direct payment from insurer to service provider	Fee-for-service	Other
Austria	Austria	Belgium
Belgium	Czech Rep	Chile
Costa Rica	Lithuania	Estonia
Czech Republic	Luxembourg	Korea
Germany	UK	Russia
Hungary		Switzerland
Japan		Turkey
Lithuania		
Russia		
Switzerland		
UK		
US		

Note: In Austria there is no specific taxation for the financing of LTC. Belgium uses an allowance for elderly and Flemish Social Protection. The Czech Republic and Estonia use state, regional and municipal funding.
Source: OECD questionnaire.

รูปที่ 13 กลไกการจ่ายชดเชยสำหรับ LTC

โดยสรุป ระบบ LTC ทั่วโลกกำลังเผชิญแรงกดดันจากโครงสร้างประชากรสูงอายุที่ทวีความเข้มข้น ภายใต้ข้อจำกัดทางการคลังที่ต้องบริหารอย่างรอบคอบ หลักฐานเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นว่าการออกแบบระบบที่ “บูรณาการบริการสุขภาพกับสวัสดิการสังคม” การกำหนด “กลไกการเงินการคลังที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน” และการธำรง “คุณภาพบริการควบคู่การคุมต้นทุน” เป็นเงื่อนไขหลักของความสำเร็จ ทั้งนี้ การปรับระดับการร่วมจ่ายตามความสามารถในการจ่าย การกำหนดสิทธิประโยชน์ตามระดับพึ่งพิง การเฝ้าระวังความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเป็นระยะ ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อให้ระบบ LTC สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

3) ระบบข้อมูล การติดตาม และการประเมินผล (Information, monitoring and evaluation systems)

การขาดระบบข้อมูลและการติดตามผลการดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละประเทศนั้นมักเกิดจากการแยกส่วนของระบบการอภิบาลและระบบการเงินการคลัง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนานโยบาย โดยเฉพาะการระบุประชากรที่มีความต้องการ ดังนั้น กระบวนการการสร้าง จัดการ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ตลอดจนการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานจากระบบฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั้น จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ได้อย่างมีนัยสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ โดยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการออกแบบระบบการดูแลระยะยาวนั้นประกอบด้วย

- **สถานะสุขภาพและความต้องการ (Health status and needs)** ได้แก่
    - ข้อมูลระดับประชากร เช่น อายุขัยของประชากรในปัจจุบันและอายุขัยที่คาดการณ์ในอนาคต พลวัตประชากรที่เกิดจากอัตราการเกิดและการย้ายถิ่น ปริมาณและแนวโน้มของประชากรที่มีภาวะพึ่งพา สาเหตุของการเกิดโรคร่วม และระดับสุขภาวะมวลรวม
    - ผลการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุที่จัดทำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหมายรวมถึงผลลัพธ์จากการดูแลระยะยาวด้วย
    - ผลการประเมินสุขภาพและสุขภาวะของผู้ดูแล ประกอบด้วยความถี่ ความเข้มข้นและระยะเวลาที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละช่วงเวลา ความเครียดและภาระที่เกิดขึ้นกับผู้ดูแล ปัญหาสุขภาพของผู้ดูแล ตลอดจนเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมและโอกาสที่ผู้ดูแลได้พักช่วงจากการดูแล
- **ความครอบคลุมของบริการ (Service Coverage)** ได้แก่
    - จำนวนประชากรที่ได้รับการดูแลระยะยาวทั้งในมิติของประเภทหน่วยบริการ เช่น การดูแลในหน่วยบริการ การดูแลในชุมชน และมิติของรูปแบบการสนับสนุนทางการเงินการคลัง เช่น การดูแลโดยหน่วยบริการภาครัฐและภาคเอกชน หรือการดูแลโดยองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งอย่างหลังนี้มักไม่ปรากฏในฐานข้อมูลกลางในหลายประเทศ
    - ระยะเวลารอคอย ความพึงพอใจ ตลอดจนอุบัติการณ์การเกิดภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถป้องกันได้
- **การคุ้มครองความเสี่ยง (Risk protection)** ได้แก่
    - การประเมินความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง (unmet needs) โดยเปรียบเทียบความต้องการการดูแลระยะยาวในภาพรวมกับปริมาณผู้สูงอายุที่ได้รับบริการในแต่ละประเภทของหน่วยบริการ

- การประเมินเศรษฐานะของผู้สูงอายุและครอบครัวทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยขนาดครอบครัวและลักษณะที่อยู่อาศัย รายได้ครัวเรือน และอัตราความยากจน
- การประเมินพฤติกรรมทางสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
- ข้อมูลความพร้อมบริการการดูแลระยะยาวในระดับประเทศ
- การประเมินภาระงานและความเครียดของผู้ดูแล ซึ่งมักส่งผลต่อการเกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและการนอนโรงพยาบาล

- **กำลังคน (Workforce)** ได้แก่ จำนวนและลักษณะประชากรของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแล ประกอบด้วย อัตราส่วนต่อผู้สูงอายุ เพศ ภูมิลำเนา และสวัสดิการและความคุ้มครองสังคมที่มี ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพและบทบาทจำเพาะ ตลอดจนจำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
- **การติดตาม (Monitoring)** มิติที่ควรมีการกำกับและติดตามสำหรับการดูแลระยะยาวนั้น ประกอบด้วย
  - มิติประสิทธิผล เช่น ผลลัพธ์บริการทั้งด้านสุขภาพและด้านสังคม
  - มิติประสิทธิภาพ เช่น การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสูงสุดต่องบประมาณ
  - มิติการเข้าถึง ทั้งในประเด็นด้านภูมิศาสตร์ ตลอดจนการเข้าถึงบริการของประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
  - มิติความทันเวลา
  - มิติการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เช่น ความพึงพอใจของผู้ป่วย การมีส่วนของผู้ป่วยในการตัดสินใจทางคลินิก
  - มิติความปลอดภัย เช่น การลดลงของภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้
  - มิติความเป็นธรรม เช่น การพิจารณาว่าผู้ป่วยที่มีความต้องการใกล้เคียงกันนั้นได้รับบริการที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่หรือไม่

4) กำลังคน (Workforce)

ในแต่ละประเทศทั่วโลกกำหนดบุคลากรในการดูแลระยะยาวที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดี ในหลายประเทศนั้นการดูแลระยะยาวยังพึ่งพาการดูแลโดยผู้ดูแลในครอบครัวสูง ขณะที่ค่าตอบแทน ลักษณะงาน และจำนวนวิชาชีพที่ผ่านการอบรมยังคงเป็นข้อจำกัดเรื้อรังในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว นอกจากนี้ ในหลายประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางนั้นพบว่าแรงงานข้ามชาติเป็นแรงงานหลักในการดูแลระยะยาวในครัวเรือน และการจ้างงานในลักษณะชั่วคราวนั้นยิ่งเป็นการทำให้เกิดความเปราะบางในกลุ่มแรงงานดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้น การจัดการด้านกำลังคนในการดูแลระยะยาวนั้นจึงยังเป็นช่องว่างสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องจัดการด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้

- **การทำความเข้าใจกำลังคนที่มีอยู่ (Understanding the existing workforce):** การวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการเข้าใจสถานการณ์กำลังคนในปัจจุบัน ทั้งกำลังคนด้านสุขภาพและกำลังคนสำหรับบริการทางสังคม ผู้กำหนดนโยบายจะต้องเห็นทั้งปริมาณกำลังคน อัตราส่วนของบุคลากร (care workers) ต่อผู้ดูแลในครอบครัว (carers) การกระจายตัวของบุคลากร ลักษณะทักษะที่ใช้ในการดูแล รูปแบบการศึกษาและการอบรม ระบบกำหนดมาตรฐาน การหมุนเวียนของบุคลากร สภาพการทำงานและภาระงาน และปริมาณค่าตอบแทน ถึงแม้จะไม่มีสูตรสำเร็จในการออกแบบทีมสำหรับการดูแลระยะยาวในทุกประเทศ แต่ในอุดมคติแล้วนั้นทีมบริการจะต้องมีลักษณะของสหวิชาชีพทั้งด้านสุขภาพและด้านสังคม โดยการจัดทีมผู้ดูแลต้องตั้งอยู่บนความต้องการในระดับประเทศหรือระดับพื้นที่

  สำหรับบริบทที่การดูแลระยะยาวส่วนใหญ่เป็นการดูแลในสถานบริการนั้น ควรมีข้อมูลที่แม่นยำของบุคลากรและผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำของบุคลากรต่อผู้สูงอายุเพื่อประกันคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงความพึงพอใจและการคงอยู่ของบุคลากร สัดส่วนดังกล่าวควรคำนึงถึงจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล ประกอบกับระดับความต้องการที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีความต้องการสูงควรได้รับการดูแลจากบุคลากรที่มีทักษะสูงกว่าในสัดส่วนที่เหมาะสม

- **การเสริมสมรรถนะและความเป็นวิชาชีพ (Capacity-building and professionalization of the workforce):** แต่ละประเทศควรดำเนินนโยบาย

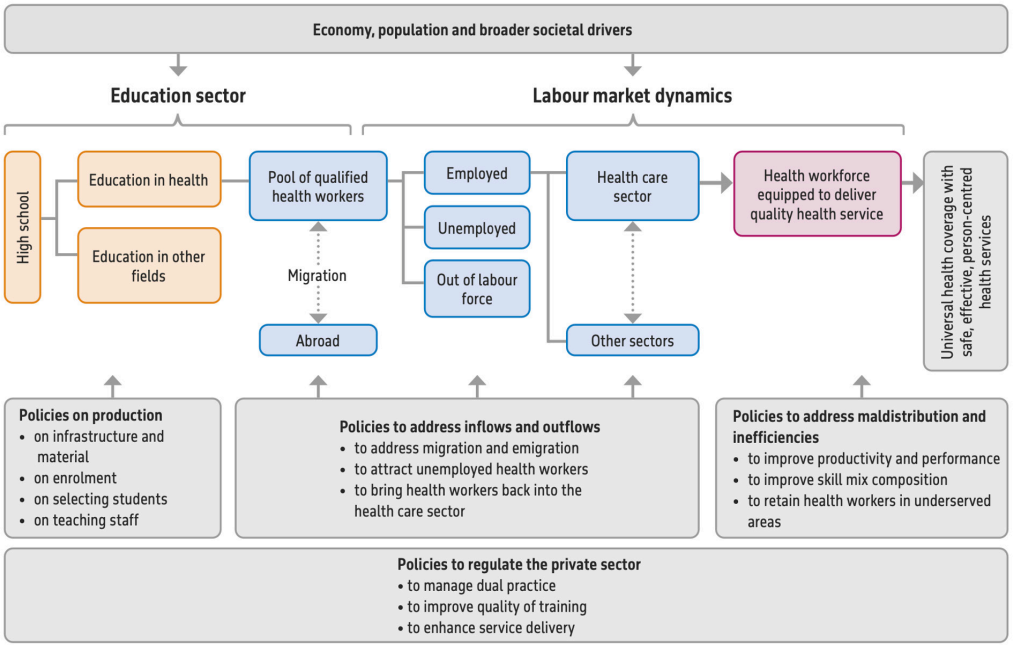
เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความเป็นวิชาชีพของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลระยะยาว บุคลากรควรผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านการดูแลระยะยาว และได้รับการประเมินอย่างสม่ำเสมอ ประกอบด้วยหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ประจำปี และการอบรมทักษะใหม่ที่จำเป็น โดยการพัฒนาศักยภาพควรอิงตามหลักสูตรที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based curriculum) และขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพระหว่างพื้นที่ และการฝึกอบรมควรยึดความต้องการหลักของผู้สูงอายุและช่องว่างความรู้ที่ยังมีอยู่จากการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ท้ายที่สุด แต่ละประเทศควรวางนโยบายในการทำให้บุคลากรและสายงานด้านการดูแลระยะยาวมีลักษณะความเป็นวิชาชีพผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยเฉพาะบุคลากรที่ให้การดูแลในสถานพยาบาลและบุคลากรที่ให้การดูแลที่บ้าน

- **อัตราการหมุนเวียนและการรักษาบุคลากรในการทำงาน (Staff turnover and retention):** รัฐบาลควรมีการตัดสินใจในระดับประเทศสำหรับกลไกการจูงใจบุคลากร เช่น การทำให้บุคลากรเป็นวิชาชีพ การเพิ่มค่าตอบแทน และมาตรการอื่น ๆ ตามหลักการแล้วนั้น ค่าตอบแทนของบุคลากรที่ให้การดูแลระยะยาวควรเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ (เช่น มาตรฐานสภาการพยาบาล) ประกอบกับการสร้างความพึงพอใจให้บุคลากรโดยการรับรองคุณวุฒิ ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีสวัสดิการรองรับเพื่อลดภาพลักษณ์เชิงลบของการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาทักษะจำเพาะในการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละบริบทของบริการ (เช่น การดูแลในสถานพยาบาลหรือการดูแลที่บ้านอาจต้องการทักษะที่แตกต่างกัน) ทั้งนี้ ต้องมีการกำกับและติดตามตัวชี้วัดคุณภาพอย่างเป็นระบบ
- **การสนับสนุนผู้ดูแลในครอบครัว (Support for family carers):** ผู้ดูแลในครอบครัวถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบการดูแลระยะยาว โดยผู้ที่กำลังจะเข้าสู่บทบาทผู้ดูแลในครอบครัว หรือแม้กระทั่งในละแวกเพื่อนบ้าน ควรได้รับการประเมินทักษะอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมด้านการดูแลระยะยาวและการดูแลตนเอง เช่น การช่วยเหลือกันเองในกลุ่มผู้ดูแล ตลอดจนการช่วยเหลือด้านจิตวิทยาและการช่วยเหลือทางการเงิน ทั้งนี้ การฝึกอบรมทักษะนั้นต้องมีขอบเขตกว้างกว่าเพียงทักษะทางกายภาพพื้นฐาน แต่หมายถึงทักษะเชิงจริยธรรมและการเสริมสร้าง

ความเห็นอกเห็นใจด้วย โดยควรจัดให้เหมาะกับความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ดูแลเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ รัฐบาลควรกำหนดรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับแรงงานที่เป็นผู้ดูแลในครอบครัว และให้แรงจูงใจแก่นายจ้างสำหรับการสนับสนุนแรงงานกลุ่มดังกล่าว การสนับสนุนนี้ควรครอบคลุมไปจนถึงช่วงหลังการเสียชีวิตของผู้ป่วยเพื่อเยียวยาผู้ดูแลและการเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ อาจมีการวิเคราะห์กำลังคนด้วยกรอบแนวคิดที่ Health labour market framework for universal health coverage ขององค์การอนามัยโลก ดังรูปที่ 14 ซึ่งได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพราะเป็นกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงปริมาณทรัพยากรมนุษย์เข้ากับการฝึกอบรม การจ้างงาน การกระจายตัว และการบริบาลทรัพยากรมนุษย์ ผ่านระบบการศึกษา พลวัติของตลาดแรงงาน และบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกับบุคลากรที่เป็นวิชาชีพ เช่น พยาบาล แพทย์ นักกายภาพบำบัด รวมไปถึงบุคลากรที่ไม่ได้เป็นวิชาชีพ เช่น ผู้ดูแล (Caregiver, CG) ในบริบทของไทย



รูปที่ 14 Health Labor Market Framework for Universal Coverage

โดยในกรอบแนวคิดมีการกล่าวถึงนโยบายซึ่งเป็นส่วนประกอบของนโยบายทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่

1. การผลิตกำลังคน ซึ่งกล่าวถึงกำลังในการผลิตและทักษะของกำลังคน
2. การไหลเข้า - ออกของบุคลากรในระบบ เช่น การย้ายภาคส่วนการทำงานระหว่างรัฐและเอกชน
3. การกระจายตัวและประสิทธิภาพการทำงานของกำลังคน
4. การกำกับดูแลการทำงานของกำลังคนนอกเหนือจากภาครัฐ (26)

ซึ่งกรอบแนวคิดนี้จะนำไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านกำลังคนในระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทยในบทต่อไป

5) การส่งมอบบริการ (Service Delivery)

อุปสรรคหลักของการส่งมอบบริการการดูแลระยะยาวคือการแยกส่วนกันระหว่างบริการทางสุขภาพและบริการทางสังคม ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการบริการทั้งสองประเภท ความแตกต่างของบริการทั้งสองประเภทนั้นทำให้เกิดความท้าทายในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตบริการ การออกกฎหมายรับรอง การฝึกอบรม และการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนบุคลากรในส่วนของบริการทั้งสองประเภทมักมีมุมมองถึงคุณค่าของบริการและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ระบบบริการที่ดีจึงต้องกำหนดขอบเขตบริการ บริบท และกรอบคุณภาพที่ชัดเจน โดยยึดผลจากการประเมินความต้องการของผู้ป่วยเป็นฐานและกำหนดให้มีระบบการกำกับติดตามคุณภาพที่เหมาะสม โดยการออกแบบรูปแบบการส่งมอบบริการนั้นควรประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- **การกำหนดบริการขั้นต่ำ (Minimal services defined):** การกำหนดบริการนั้นควรพิจารณาตามเส้นทางการดูแล ได้แก่ การสร้างเสริมและป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การดูแลประคับประคอง และการดูแลหลังการเสียชีวิต ตลอดจนมิติการดูแลอื่น ๆ อาทิ การช่วยเหลือกิจวัตรส่วนบุคคล การดูแลตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม ทั้งนี้ ควรระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เช่น ผู้สูงอายุที่มีความต้องการทางสุขภาพและสังคมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังหรือผู้สูงอายุที่มีผู้ร่วมอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนประเมินจากลักษณะของผู้ดูแลด้วย อาทิ

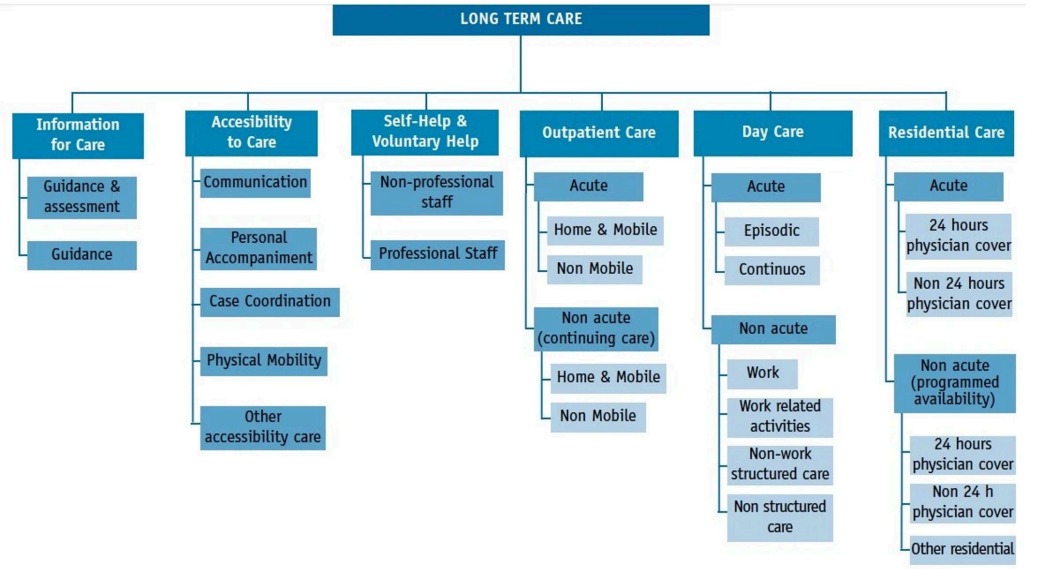
ยังทำงานอยู่หรือเกษียณแล้ว มีอายุมากหรือน้อย อยู่ร่วมบ้านกันหรืออยู่ห่างไกลกัน เมื่อพิจารณาความต้องการดังกล่าวแล้วนั้น จึงจะสามารถออกแบบบริการที่พึงจัดได้ ประกอบด้วยแผนการดูแลรายบุคคลที่ออกแบบร่วมกันระหว่างผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้ให้บริการ ทั้งนี้ บริการจะต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีและมีความยืดหยุ่นตลอดเส้นทางการดูแล

- **บริบทการให้บริการดูแลระยะยาว (Settings for long-term care provision):** การดูแลระยะยาวนั้นเกิดขึ้นได้ในหลายบริบท ซึ่งผู้สูงอายุนั้นสามารถเลือกสถานที่ที่ตนเองต้องการอยู่อาศัยได้ และสถานที่นั้นควรสนับสนุนให้เกิดสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุด้วย ดังนั้น ผู้กำหนดนโยบายควรนิยามและทำแผนที่เพื่อแสดงสถานบริการที่สามารถให้บริการการดูแลระยะยาวได้และสนับสนุนให้เกิดความครอบคลุมทั้งในพื้นที่ชนบทและชุมชนเมือง เพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรณีของเมืองใหญ่นั้นควรมีการกำกับให้เกิดกระจายบริการที่ไม่กระจุกเพียงใจกลางเมืองหรือเฉพาะย่านที่มีความเจริญเท่านั้น และควรต้องจัดให้มีระบบการให้บริการที่บ้านหรือในชุมชน เช่น การมีทีมบุคลากรเยี่ยมบ้าน การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ อนึ่ง แต่ละประเทศควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนไปพร้อมกันเพื่อให้สามารถรองรับการดูแลในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะการเดินทาง การโทรคมนาคม และการเข้าถึงบริการช่วยเหลือต่าง ๆ
- **เส้นทางการดูแลแบบบูรณาการและการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Integrated care and person-centred care pathways):** ไม่ว่าบริการจะเกิดขึ้นที่ใด จะต้องมีการประสานงานและบูรณาการอย่างเข้มแข็งระหว่างหน่วยบริการและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อคงไว้ซึ่งสมรรถนะทางร่างกายของผู้สูงอายุ ในขณะที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม สิ่งนี้จะสามารถทำได้โดยการสร้างเส้นทางการดูแลแบบบูรณาการที่เชื่อมการดูแลสุขภาพ การดูแลส่วนบุคคล และการสนับสนุนทางสังคมเข้าด้วยกัน โดยมีแนวทางหรือมาตรฐานทางคลินิกที่ชัดเจนและมีระบบข้อมูลที่เชื่อมบริการในทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน
- **กำหนดเกณฑ์สิทธิ (Eligibility criteria defined):** แผนหรือนโยบายการดูแลระยะยาวควรกำหนดให้ชัดว่าใครมีสิทธิได้รับบริการใดและเมื่อใด โดยยึดตามลักษณะความพิการ ความต้องการทางสุขภาพ สถานะการพึ่งพิง รวมถึงเศรษฐานะ ซึ่งปัจจัย

เหล่านี้ควรพิจารณาเป็นเกณฑ์การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ โดยใช้ระเบียบวิธีประเมินความต้องการสำหรับทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแล ทั้งนี้ เกณฑ์เหล่านี้ควรสอดคล้องไปด้วยกันทั้งประเทศเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่และเพื่อจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม และเมื่อผู้ป่วยได้รับการรับรองสิทธิแล้ว ควรเริ่มบริการทันทีและโปร่งใสต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ลดการพึ่งพาการรักษาด้วยยาและเพิ่มการดูแลที่ไม่ใช้ยาเป็นหลักในการดูแลระยะยาว

- **การประกันคุณภาพ (Quality assurance):** เพื่อให้เกิด “คุณภาพ” อย่างสม่ำเสมอ จำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานคุณภาพให้ครอบคลุมทุกบริบทของการให้บริการ โดยติดตามด้วยเกณฑ์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์การอนามัยโลกสำหรับการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ อันประกอบด้วย
    - ความมีประสิทธิผล (effective) จากการดูแลตามความต้องการและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์สุขภาพและสังคมที่ดีขึ้นแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล
    - ความมีประสิทธิภาพ (efficient) จากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและหลีกเลี่ยงบริการที่สิ้นเปลือง
    - การเข้าถึงได้ (accessible) ตามความเหมาะสมด้านภูมิศาสตร์ โดยประชาชนจะต้องเข้าถึงบริการโดยบุคลากรที่มีทักษะ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และทรัพยากรที่สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคล
    - ความทันเวลา (timely) จากการลดความล่าช้าในการรับบริการตามความจำเป็น
    - การยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient-centred) โดยต้องเคารพคุณค่า ความชื่นชอบ ความปรารถนา และวัฒนธรรมของแต่ละปัจเจก ทั้งนี้ ควรมีการให้ข้อมูลสำหรับทางเลือกบริการที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
    - การยอมรับบริการ (acceptable) บริการที่ส่งมอบจะต้องผ่านเป็นไปตามเกณฑ์และเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล
    - ความปลอดภัย (safe) จากการป้องกันและลดเหตุไม่พึงประสงค์จากการดูแล รวมถึงการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
    - ความเป็นธรรม (equitable) จากการรับประกันคุณภาพไม่ให้แปรผันด้วยลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ เชื้อชาติ ที่ตั้ง หรือเศรษฐานะ

ตัวอย่างการวางกรอบแผนเพื่อจัดบริการการดูแลระยะยาว Description and Evaluation of Services and DirectoriEs for Long-Term Care (DESDE-LTC) ดังรูปที่ 15 ที่มีการประยุกต์ใช้แพร่หลายในกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป มีการนิยาม Basic stable input of care (BSIC) และ Main type of care (MTC) แล้วจัดเข้าเป็นประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงกับการเข้ารหัสในกิจกรรมการให้บริการ และนำไปสู่การจัดเก็บเข้าฐานข้อมูลของแต่ละประเทศได้ (27)



รูปที่ 15 โครงสร้างลำดับชั้นสำหรับการดูแลระยะยาวตามกรอบ DESDE-LTC

มุมมองการคิดอีกจำพวกหนึ่งของการดูแลระยะยาว คือสถานที่ที่ใช้ในการดูแล โดยแบ่งออกเป็น การดูแลในสถานบำบัด (Institutional Care) การดูแลที่บ้าน (Home-Based Care) และการดูแลในชุมชน (Community-Based Care) เนื่องด้วยการดูแลระยะยาวนั้นมีรากฐานมาจากการดูแลที่บ้านโดยครอบครัว หรือชุมชนตั้งแต่สมัยโบราณ จากนั้นจึงมีการพัฒนาโมเดลของศูนย์ผู้สูงอายุหรือเนิร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) เพิ่มมากขึ้น (28) ตามความต้องการของสังคมและกฎหมายสวัสดิการ และการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเภทของการดูแลยังคงมีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการของผู้ที่ควรได้รับการดูแลระยะยาว

สำหรับในประเทศไทยให้นิยามการดูแลระยะยาง (Long Term Care) ว่าเป็นการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และได้มีการเปรียบเทียบทางเลือกการออกแบบระบบบริการ ระหว่างการบริการที่มีฐานในโรงพยาบาล (Hospital Based) และการบริการที่มีฐานในชุมชน (Community Based) โดยมีข้อสรุปว่า ควรใช้การบริการที่มีฐานในชุมชนเป็นหลักภายใต้การสนับสนุนทางวิชาการและบริการจากการบริการที่มีฐานในโรงพยาบาล (29) เนื่องด้วยความสามารถในการบูรณาการกับภาคสังคม และความได้เปรียบด้านภาระทางการเงินของการบริการที่มีฐานในชุมชนเป็นหลัก

โดยหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิผล และความคุ้มค่าเปรียบเทียบระหว่าง การดูแลในสถานบำบัด การดูแลที่บ้าน และการดูแลในชุมชน ว่าแบบใดสามารถสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีกว่ากัน บางการศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เช่น Blackburn J, 2014 (30) ทำการศึกษา matched retrospective cohort study ในสหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบ nursing home residents กับ community-dwelling home health recipients พบว่า 77.7% ของผู้ใช้บริการ Home Health รอดชีวิต เทียบกับ 76.2% ของผู้ใช้บริการ Nursing Home ($p < .001$) รวมถึงผู้ใช้บริการ Home Health เข้าโรงพยาบาลมากกว่า 0.2 เข้าแผนกฉุกเฉินมากกว่า 0.1 ส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลแบบเฉียบพลันไม่แตกต่าง แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวของ Medicaid สูงกว่า $4,582 ในผู้ใช้บริการ Nursing Home แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานในระดับ Systematic Review และ Meta Analysis แล้วยังพบความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูง (Heterogeneity) จึงไม่สามารถชี้ให้ชัดเจนถึงความเหนือกว่าของการดูแลประเภทใดประเภทหนึ่ง บางหลักฐานทำให้พอสามารถกล่าวได้ว่าการสร้างการดูแลแบบ Community-Based นั้นช่วยสนับสนุนการดูแลที่บ้านได้จริง เมื่อเทียบกับการให้ดูแลที่บ้านกันเอง หรืออาจแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์แนวคิด Integrated Care เท่านั้น

ดังนั้น การเลือกรูปแบบการดูแลควรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน รวมถึงความต้องการของผู้ป่วย ความพร้อมของครอบครัว ทรัพยากรที่มีอยู่ และระบบสุขภาพท้องถิ่น และการพัฒนาระบบ Long-Term Care ในอนาคตควรเน้นไปที่การดูแลแบบต่อเนื่อง (continuum of care) ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาระบบที่รวมการดูแลทุกระดับเข้าด้วยกัน (integrated care) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพในทุกช่วงของชีวิต เช่น การศึกษา systematic review and meta-analysis โดย Yu Y et al, 2024 ที่วิเคราะห์จากการดูแลผู้สูงอายุกว่า 2,942,069 คน จาก 10 ประเทศทั่วโลก

แสดงให้ประโยชน์ของการใช้ Home-Based และ Community-Based services ในผู้สูงอายุที่อายุมาก หรือมีความบกพร่องทางสติปัญญา (Cognitive Impairment) โดยพบอัตราการใช้การส่งอาหารผู้ป่วย (Meals on Wheels) ในกลุ่มที่อายุ 85 ปีขึ้นไป (31 - 33)

6) นวัตกรรมและการวิจัย (Innovation and Research)

ท้ายที่สุดแล้ว ในโลกปัจจุบัน นวัตกรรมและการวิจัยจะเป็นตัวขับเคลื่อนการขยายบริการการดูแลระยะยาวให้มีความเป็นธรรม ยั่งยืน และมีประสิทธิผล โดยการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยนั้นควรยึดตามลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้สูงอายุเอง

ในบริบทของแต่ละประเทศ รัฐบาลควรมียุทธศาสตร์ของตนเองในการเร่งพัฒนาและทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมและสมรรถนะด้านดิจิทัลของประชาชน ทั้งนี้ควรส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนอื่น ๆ และภาคประชาสังคม เพื่อลดต้นทุนการคิดค้นและเพิ่มระดับการนำผลงานไปใช้งานจริง และยุทธศาสตร์นี้จะต้องครอบคลุมการนำนวัตกรรมมาช่วยสื่อสารภายในทีมผู้ดูแล และการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนวัตกรรมและการวิจัยที่จำเป็น มีดังต่อไปนี้

- **สุขภาพดิจิทัล (Digital health)** พบว่าการใช้งานเทคโนโลยีในหมู่ผู้สูงอายุยังมีอยู่น้อยโดยเฉพาะในบริบทที่มีทรัพยากรจำกัด ทว่า เทคโนโลยีดิจิทัลนี้สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การจัดยากินเอง การกระตุ้นสมรรถนะทางสมอง การช่วยให้ผู้สูงอายุเชื่อมต่อกับสังคม รวมถึงการสนับสนุนการฝึกอบรมผู้ดูแล ทั้งนี้ ภาครัฐสามารถอำนวยความสะดวกด้านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ผ่านการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ด้านดิจิทัลให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลไปพร้อม ๆ กัน
- **เทคโนโลยีช่วยเหลือ (Assistive products)** เทคโนโลยีช่วยเหลือนั้นหมายความถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการรักษาและเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายของผู้สูงอายุซึ่งส่งผลให้ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุดีขึ้น และยังใช้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้อาจมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางตรงของระบบสุขภาพ เช่น การลดการนอนโรงพยาบาล หรือการลดการใช้สวัสดิการของรัฐ ทั้งนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์ควร

มุ่งเน้นการชดเชยการสูญเสียสมรรถนะทางร่างกายของผู้ป่วย โดยควรจัดหาอย่างเป็นธรรมแก่ประชากรที่มีความต้องการดูแลระยะยาวทุกคน

- **การวิจัย** ลำดับความสำคัญด้านการวิจัยควรถูกกำหนดบนฐานข้อมูลที่แสดงถึงผลการดำเนินงานในปัจจุบันของระบบดูแลระยะยาวในแต่ละบริบท และสอดคล้องแผนการวิจัยในระดับนานาชาติและระดับประเทศ อนึ่ง กระบวนการกำหนดโจทย์วิจัยนั้นควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ให้บริการทางสุขภาพและสังคม ตลอดจนผู้สูงอายุและผู้ดูแล โดยพิจารณาจัดสรรเงินทุนให้เพียงพอเพื่อบรรลุเป้าหมายการวิจัย และต้องมีการทบทวนและปรับปรุงโจทย์วิจัยเป็นระยะ เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์และความต้องการในปัจจุบัน

บทสรุป

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุถือเป็นหนึ่งในพลวัตทางสังคมที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของอายุขัยจะสะท้อนความสำเร็จด้านสาธารณสุขและการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ในอีกด้านหนึ่ง การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุและอัตราส่วนการพึ่งพิงได้สร้างแรงกดดันต่อระบบสุขภาพ ระบบสวัสดิการสังคม และระบบการคลังของรัฐอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังเผชิญภาวะ “แก่ก่อนรวย” ซึ่งต้องรับมือกับสังคมสูงวัยท่ามกลางข้อจำกัดด้านทรัพยากร

สำหรับประเทศไทย การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ขณะที่โครงสร้างครอบครัว ขนาดครัวเรือน และรูปแบบการพึ่งพิงทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ภาวะโรคเรื้อรัง ภาวะพึ่งพิง และช่วงชีวิตที่มีปัญหาสุขภาพในบั้นปลายชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริการดูแลระยะยาวขยายตัวทั้งในเชิงปริมาณและความซับซ้อน ปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าการดูแลผู้สูงอายุไม่อาจจำกัดอยู่เพียงการรักษาพยาบาลเชิงเฉียบพลัน แต่จำเป็นต้องอาศัยระบบการดูแลระยะยาวที่บูรณาการ ครอบคลุม และยั่งยืน

การทบทวนพัฒนาการของระบบการดูแลระยะยาวในระดับนานาชาติสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากการดูแลในสถานบริการไปสู่การดูแลในชุมชน และการพัฒนากรอบการดูแลแบบบูรณาการต่อเนื่องที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ภายใต้กรอบแนวคิดขององค์การ

อนามัยโลก ระบบการดูแลระยะยาวที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การอภิบาลระบบที่ชัดเจนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม การเงินการคลังที่ยั่งยืน ระบบข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย กำลังคนที่เพียงพอและมีคุณภาพ การส่งมอบบริการที่บูรณาการและต่อเนื่อง และการส่งเสริมนวัตกรรมและการวิจัย

อย่างไรก็ตาม การมีกรอบแนวคิดเชิงอุดมคติไม่เพียงพอ หากขาดการประเมินสถานการณ์จริงของประเทศอย่างรอบด้าน บทนี้จึงชี้ให้เห็นทั้งแรงขับเชิงประชากร ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และกรอบเชิงระบบที่จำเป็นต่อการพัฒนาการดูแลระยะยาวในประเทศไทย อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในบทถัดไป ซึ่งจะมุ่งประเมินพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนสถานการณ์การจัดบริการดูแลระยะยาวของไทย ทั้งในมิติความครอบคลุม คุณภาพ ความเป็นธรรม และความยั่งยืน เพื่อระบุช่องว่างเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาในอนาคตอย่างเป็นระบบต่อไป

บทที่ 3
ระบบการดูแลระยะยาว ในประเทศต่าง ๆ

สำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นความท้าทายระดับสากลที่แต่ละประเทศจำเป็นต้องออกแบบระบบรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เห็นภาพรวมของพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในประเทศต่าง ๆ ที่สามารถออกแบบระบบได้ดี ในบทนี้ คณะผู้วิจัยจะนำเสนอภาพรวมของระบบการดูแลระยะยาวโดยอ้างอิงจากรายงานการศึกษาของประเทศกลุ่ม OECD ซึ่งได้ทำการจำแนกประเทศต่าง ๆ ตามมิติด้านการเข้าถึงบริการ ลักษณะการบูรณาการระหว่างมิติสุขภาพและมิติทางสังคม ตลอดจนกลไกการเงินการคลังสำหรับการคุ้มครองทางสังคม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเชิงสถาบันทางสังคมที่ส่งผลต่อการออกแบบระบบสวัสดิการที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริบท

เนื้อหาในบทนี้จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์การจัดกลุ่มระบบการดูแลระยะยาวออกเป็น 4 รูปแบบหลัก ตั้งแต่กลุ่มที่เน้นรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าไปจนถึงกลุ่มที่เน้นการดูแลโดยครอบครัวเป็นหลัก จากนั้นจะลงลึกถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจทั้งในฝั่งตะวันตก เช่น สวีเดนและเดนมาร์ก ซึ่งเป็นต้นแบบของสวัสดิการถ้วนหน้า และประเทศที่ใช้ระบบประกันสังคมอย่างเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ รวมถึงบทเรียนสำคัญจากประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ที่มีรากฐานวัฒนธรรมใกล้เคียงกับไทย โดยเป้าหมายสำคัญของบทนี้คือการทำความเข้าใจว่าความสำเร็จของระบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประกาศสิทธิทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนภาครัฐ ความชัดเจนของการอภิบาลระบบ และการกำหนด

บทบาทที่เหมาะสมของครอบครัว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับบริบทของประเทศไทยในลำดับถัดไป

ภาพรวมระบบการดูแลระยะยาว

รายงานการศึกษารูปแบบของบริการการดูแลระยะยาวในประเทศกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) ได้จัดจำแนกประเทศต่าง ๆ ตามการเข้าถึงบริการ การมีบริการที่เป็นทางการ (formal care) สัดส่วนของค่าใช้จ่ายภาครัฐและกลไกการเงินการคลังสำหรับการปกป้องทางสังคม (social protection) ลักษณะการบูรณาการระหว่างมิติด้านสุขภาพกับมิติด้านสังคม ลักษณะการกระจายอำนาจในระบบการดูแลระยะยาว สัดส่วนของการให้บริการจากส่วนภาครัฐและภาคเอกชน การบูรณาการระหว่างระบบการดูแลระยะยาวและการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ตลอดจนการประเมินคุณภาพของบริการการดูแลระยะยาว ทั้งนี้ การจัดจำแนกทั้ง 4 ประเภทนั้นสามารถสะท้อนลักษณะเชิงสถาบันทางสังคมที่ส่งผลต่อการออกแบบระบบสวัสดิการทางสังคมเพื่อรองรับผู้สูงอายุ โดยสามารถวิเคราะห์กลุ่มประเทศสมาชิกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (34)

กลุ่มที่ 1 ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส และสวีเดน

เป็นกลุ่มประเทศที่มีการสนับสนุนการเงินการคลังภาครัฐแกระบบบริการดูแลระยะยาวสูงสุด มีการจัดบริการดูแลแบบทางการภาครัฐสูงรวมถึงให้การสนับสนุนผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการสูง มีคุณภาพระดับสูง มีความเป็นเอกภาพแม้ว่าจะเป็นระบบที่กระจายอำนาจ

ประเทศในกลุ่มที่ 1 มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในด้านระดับความครอบคลุมของบริการดูแลระยะยาวแบบเป็นทางการ (formal LTC) เมื่อเทียบกับทุกกลุ่มอื่น โดยในครึ่งหนึ่งของประเทศในกลุ่มนี้ ผู้สูงอายุที่มีความต้องการการดูแลมากกว่าร้อยละ 50 สามารถเข้าถึงบริการแบบเป็นทางการได้ มีเพียงสวีเดนเท่านั้นที่มีระดับความครอบคลุมต่ำกว่า 25% ซึ่งใกล้เคียงกับระดับของกลุ่มที่ 3 และ 4 มากกว่า ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนว่าในกลุ่มนี้ การดูแลระยะยาวได้รับการบรรจุเป็นองค์ประกอบหลักของรัฐสวัสดิการอย่างชัดเจน

แม้ว่าระบบจะมีความครอบคลุมสูง แต่การเข้าถึงสิทธิยังคงอยู่ภายใต้กลไกการประเมินความจำเป็น (needs-testing) อย่างแพร่หลาย โดยในหลายประเทศ ระดับการสนับสนุนจากภาครัฐจะเพิ่มขึ้นตามความรุนแรงของความต้องการการดูแล ในขณะเดียวกัน กลไกการพิจารณาฐานะทางเศรษฐกิจ (means-testing) ก็ถูกใช้ในเกือบทุกประเทศ ยกเว้นเดนมาร์กที่ไม่ใช้กลไกดังกล่าว ลักษณะสิทธิประโยชน์นั้นมีความหลากหลาย โดยบางประเทศ เช่น ออสเตรียและฝรั่งเศสจะพึ่งพาเงินสนับสนุน (in-cash benefits) ในสัดส่วนสูง ขณะที่ประเทศอื่น ๆ เน้นการจัดบริการโดยตรง (in-kind benefits) เป็นหลัก สะท้อนการออกแบบระบบที่ผสมผสานความยืดหยุ่นกับกระบวนคัดกรองประชาชนที่มีความจำเป็น

ในเชิงทรัพยากร กลุ่มนี้มีจำนวนเตียงในสถานดูแลระยะยาวต่อประชากรผู้สูงอายุสูงกว่ากลุ่มอื่นโดยเฉลี่ย แม้บางประเทศ เช่น เดนมาร์ก จะมีจำนวนเตียงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนจำนวนบุคลากรดูแลต่อประชากรผู้สูงอายุโดยเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ 2 เล็กน้อย เนื่องจากจำนวนบุคลากรในบางประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ เช่น เดนมาร์กและฟินแลนด์ ระดับบุคลากรกลับอยู่ในระดับสูงและใกล้เคียงกับกลุ่มที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างภายในกลุ่มเอง

ในมิติของครอบครัว สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจากสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับกลุ่มที่ 2 และ 4 แม้บางประเทศ เช่น ฝรั่งเศสและสวีเดน จะมีอัตราการดูแลแบบไม่เป็นทางการต่ำกว่าค่าเฉลี่ย แต่โดยรวมแล้ว ประเทศในกลุ่มนี้ล้วนมีมาตรการเชิงนโยบายอย่างน้อยสองรูปแบบที่สนับสนุนผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือ การลางานเพื่อกลับไปดูแล หรือการจัดหน่วยบริการชั่วคราว (respite care) เพื่อบรรเทาภาระผู้ดูแล สะท้อนการวางตำแหน่งของครอบครัวในฐานะ “ส่วนหนึ่งของระบบ” มากกว่าการเป็นภาระที่ถูกละเลย

ด้านการเงิน กลุ่มนี้มีระดับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากภาครัฐสูงที่สุด โดยในทุกประเทศยกเว้นฝรั่งเศส ภาครัฐครอบคลุมค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่มีความต้องการรุนแรงอย่างน้อยร้อยละ 80 ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนต้องรับผิดชอบเองอยู่ในระดับต่ำ และความเสี่ยงต่อความยากจนจากค่าใช้จ่ายด้านการดูแลระยะยาวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ความเอื้อเฟื้อเช่นนี้เป็นลักษณะสำคัญที่ทำให้ระบบในกลุ่มนี้มีระดับการหลุดพ้นจากกลไกตลาด (decommodification) สูง กล่าวคือ การเข้าถึงการดูแลไม่ผูกพันโดยตรงกับความสามารถในการจ่ายของปัจเจกบุคคล

ในเชิงการอภิบาลระบบ ระบบกฎหมายด้านการดูแลระยะยาวในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเอกภาพ กล่าวคือ มีการบูรณาการทั้งมิติสุขภาพและมิติทางสังคมเข้าด้วยกัน และมีการกระจายอำนาจด้านการจัดบริการไปยังท้องถิ่น ขณะที่โครงสร้างผู้ให้บริการพึ่งพาภาครัฐเป็นหลัก โดยผู้ให้บริการภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าในเกือบทุกประเทศ ยกเว้นเบลเยียมที่มีสัดส่วนต่ำกว่าชัดเจน การบูรณาการระหว่างการดูแลระยะยาวกับโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิมีอยู่ในทุกประเทศ แม้บางประเทศจะบูรณาการกับเพียงหนึ่งในสองระบบเท่านั้น

ในด้านคุณภาพ ประเทศในกลุ่มนี้มีกรอบการประกันคุณภาพและระบบรับรองมาตรฐาน (accreditation) ครอบคลุมทั้งบริการในสถานดูแลและบริการที่บ้านเกือบทั้งหมด คุณวุฒิขั้นต่ำของบุคลากรอยู่ในระดับสูงกว่ากลุ่มที่ 2 และ 3 อย่างชัดเจน แม้ว่าบางประเทศจะไม่กำหนดสัดส่วนบุคลากรต่อผู้รับบริการอย่างตายตัว เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นท่ามกลางภาวะขาดแคลนแรงงาน แต่โดยภาพรวม ระบบในกลุ่มนี้สามารถรักษาผลลัพธ์ด้านคุณภาพในระดับสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น

โดยสรุป กลุ่มที่ 1 สะท้อนรูปแบบของรัฐสวัสดิการที่ยกระดับการดูแลระยะยาวเป็นภารกิจสาธารณะอย่างชัดเจน ทั้งในด้านความครอบคลุม ความเอื้อเฟื้อทางการเงิน การบูรณาการเชิงสถาบัน และการกำกับคุณภาพ แม้จะยังคงใช้กลไกคัดกรองความจำเป็นและฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ แต่ระดับการสนับสนุนจากรัฐทำให้ความเสี่ยงจากภาวะพึ่งพิงถูกทำให้เป็นความรับผิดชอบร่วมของสังคมในระดับสูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกกลุ่มอื่น

กลุ่มที่ 2 เยอรมนี ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอร์แลนด์ สโลวีเนีย และสหราชอาณาจักร

เป็นกลุ่มประเทศมีการสนับสนุนการเงินการคลังภาครัฐแก่ระบบการดูแลระยะยาวในระดับสูง ระบบมีการรวมศูนย์ พึ่งพาผู้ให้บริการภาคเอกชนเป็นหลัก และไม่ค่อยใช้ระบบการพิจารณารายได้

ประเทศในกลุ่มที่ 2 มีลักษณะโดดเด่นในเชิงการออกแบบสิทธิ กล่าวคือ การเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวถูกกำกับด้วยกลไกการพิจารณาความจำเป็นและฐานะทางเศรษฐกิจน้อยกว่ากลุ่มที่ 1 และ 3 อย่างชัดเจน หลายประเทศในกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้ระบบการพิจารณารายได้เลยในกรณีทั่วไป และไม่มีประเทศใดใช้กลไกดังกล่าวอย่างครอบคลุมทุกกรณี ส่งผลให้โดยภาพรวม

กลุ่มนี้มีระดับการคัดกรองรายได้ต่ำกว่ากลุ่มอื่น และมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ 4 ในมิตินี้

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแนวโน้มสู่ความครอบคลุมถ้วนหน้าในเชิงหลักการ การสนับสนุนจากภาครัฐที่พิจารณาจากสัดส่วนงบประมาณภาครัฐที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายการดูแลระยะยาวทั้งหมดนั้นไม่ได้สูงเท่ากลุ่มที่ 1 ในทุกประเทศ มีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ ด้วยข้อจำกัดนั้น ทำให้ระดับความครอบคลุมของผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลของภาครัฐอยู่เพียงประมาณหนึ่งในสามโดยเฉลี่ย ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังสูงกว่ากลุ่มที่ 3 และ 4

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาภาระที่ตกอยู่กับครัวเรือนนั้น จะพบว่าถึงแม้จะมีเกณฑ์การคัดกรองที่หลวมกว่า แต่เนื่องจากการสนับสนุนจากภาครัฐน้อยกว่า ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนต้องรับผิดชอบเองและความเสี่ยงต่อความยากจนของผู้รับบริการยังสูงกว่ากลุ่มที่ 1 เล็กน้อย ความแตกต่างภายในกลุ่มมีความชัดเจน โดยบางประเทศครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุที่มีความต้องการรุนแรง ขณะที่บางประเทศครอบคลุมเพียงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่า ความเหลื่อมล้ำนี้สะท้อนผ่านระดับค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนต้องรับผิดชอบและความเสี่ยงต่อความยากจนที่แตกต่างกันระหว่างประเทศ

ในด้านทรัพยากร กลุ่มที่ 2 มีความพร้อมของบริการอย่างเป็นทางการในระดับสูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกกลุ่ม จำนวนเตียงในสถานดูแลระยะยาวต่อประชากรผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูงสุด และจำนวนบุคลากรดูแลต่อประชากรผู้สูงอายุก็สูงที่สุดเช่นกัน แม้จะมีบางประเทศที่มีระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม แต่โดยรวมแล้ว โครงสร้างทรัพยากรของกลุ่มนี้สะท้อนความสามารถเชิงระบบที่แข็งแรง แต่ที่น่าสนใจ คือ ถึงแม้ในกลุ่มนี้จะมีทรัพยากรจำนวนมาก อัตราการดูแลแบบไม่เป็นทางการในกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในระดับที่สูงไม่ต่างจากกลุ่มที่ 1 โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุที่มีความต้องการการดูแลได้รับการดูแลจากสมาชิกในครัวเรือน ยกเว้นบางประเทศเท่านั้นที่มีระดับต่ำกว่า

ถึงตรงนี้ อาจพิจารณาได้ว่า ในประเทศที่อาจไม่ได้เข้มงวดต่อการคัดเข้าผู้ป่วยที่มีจำเป็น แต่เมื่อมีการสนับสนุนจากภาครัฐน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การเข้าถึงของประชาชนก็ลดลงไปโดยปริยาย โดยไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์จากทางภาครัฐ การหันไปพึ่งตลาดและพึ่งครอบครัวนั้นเป็นอีกทิศทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนที่มีความจำเป็นเข้าถึงบริการได้ แต่ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายครัวเรือนสูงขึ้นหรืออัตราการพึ่งพิงในครอบครัวมากขึ้นตามมา อย่างไรก็ตาม ในประเทศกลุ่มนี้

ยังสามารถเห็นมาตรการการสนับสนุนเชิงนโยบายสำหรับผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการในทุกประเทศ ซึ่งยังเป็นกลไกการสนับสนุนสถาบันทางสังคมที่คอยพยุงระบบอยู่สะท้อนการยอมรับบทบาทของครอบครัวควบคู่กับระบบบริการที่เป็นทางการ แม้ว่าลักษณะของการสนับสนุนจะแตกต่างกันไป

ในเชิงการอภิบาลระบบ ประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้มีกฎหมายที่เป็นเอกภาพ และมีรูปแบบการอภิบาลแบบรวมศูนย์อำนาจมากกว่ากลุ่มที่ 1 อย่างไรก็ดี ในกลุ่มที่ 2 นี้ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่ 1 ที่พึ่งพาภาครัฐเป็นหลัก แม้หลายประเทศจะบูรณาการระบบการดูแลระยะยาวเข้ากับหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาล แต่บางประเทศยังมีข้อจำกัดด้านการประสานงาน และตระหนักถึงความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างมิติสุขภาพและมิติทางสังคม

ในด้านคุณภาพ กลุ่มที่ 2 ใช้เครื่องมือกำกับมาตรฐาน เช่น การกำหนดสัดส่วนบุคลากรต่อผู้รับบริการ ระบบรับรองมาตรฐาน (accreditation) และกรอบประกันคุณภาพอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดด้านคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรดูแลอยู่ในระดับต่ำกว่ากลุ่มอื่น และผลลัพธ์ด้านคุณภาพโดยเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ 1 และ 3 แม้จะมีโครงสร้างกำกับดูแลอยู่ก็ตาม แสดงถึงความสำคัญของวุฒิการศึกษาที่อาจส่งผลต่อมาตรวัดด้านคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ

โดยสรุป กลุ่มที่ 2 สะท้อนระบบที่มีทรัพยากรเชิงโครงสร้างสูงและการออกแบบสิทธิที่ค่อนข้างเปิดกว้าง แต่มีการสนับสนุนงบประมาณในภาครัฐที่น้อย ดังนั้นระบบยังต้องพึ่งพาภาคเอกชนและสถาบันครบครัวเป็นหลัก ความเสี่ยงจากภาวะพึ่งพิงจึงถูกทำให้เป็นสาธารณะในระดับหนึ่ง แต่ยังมีภาระที่ตกอยู่กับปัจเจกและครัวเรือนมากกว่ากลุ่มแรก ระบบในกลุ่มนี้จึงอาจถูกมองว่าเป็น “กึ่งถ้วนหน้าเชิงโครงสร้าง แต่กึ่งตลาดเชิงการจัดบริการ” ซึ่งแตกต่างจากลักษณะรัฐสวัสดิการแบบเต็มรูปแบบในกลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มที่ 3 แคนาดา เอสโตเนีย ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย และสหรัฐอเมริกา

ประเทศในกลุ่มนี้กระจายอำนาจกลไกการอภิบาลระบบการดูแลระยะยาว เข้มงวดกับการประเมินความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลและการประเมินรายได้ ขณะเดียวกันระบบบริการดูแลระยะยาวภาครัฐมีจำกัด

ประเทศในกลุ่มที่ 3 มีลักษณะโดดเด่นคือการใช้กลไกการพิจารณาความจำเป็นและการพิจารณาฐานะทางเศรษฐกิจอย่างแพร่หลายและเข้มข้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระดับความครอบคลุมของบริการดูแลระยะยาวแบบเป็นทางการ ในประเทศส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้ การสนับสนุนจากภาครัฐจะเพิ่มขึ้นตามระดับความรุนแรงของความต้องการการดูแล อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงสิทธิยังถูกกำกับด้วยเงื่อนไขทางรายได้ในหลายประเทศ ทำให้โดยภาพรวมแล้ว มีผู้สูงอายุที่มีความต้องการการดูแลได้รับบริการแบบเป็นทางการในสัดส่วนต่ำกว่า 30% ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยสำคัญ

แม้รูปแบบสิทธิประโยชน์จะยังคงมีลักษณะผสมผสานระหว่างการให้บริการและการให้เงินสนับสนุน แต่การให้บริการโดยตรงมีความแพร่หลายมากกว่า โครงสร้างทรัพยากรด้านเตียงและบุคลากรดูแลต่อประชากรผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และมีความแตกต่างระหว่างประเทศภายในกลุ่มอย่างชัดเจน บางประเทศมีจำนวนบุคลากรใกล้เคียงกับกลุ่มที่ 1 ขณะที่บางประเทศมีระดับทรัพยากรต่ำมาก สะท้อนความไม่สม่ำเสมอของทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบภายในกลุ่มเดียวกัน

สิ่งที่น่าสังเกตคือ แม้ระบบในกลุ่มนี้จะมีความครอบคลุมต่ำ แต่ระดับการพึ่งพาการดูแลแบบไม่เป็นทางการกลับไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น กล่าวคือ หลายประเทศในกลุ่มนี้มีอัตราการดูแลโดยครอบครัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอื่น และมีมาตรการสนับสนุนผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการเพียงหนึ่งหรือสองรูปแบบเท่านั้น สะท้อนว่าระบบไม่ได้พัฒนา “กลไกทดแทน” ผ่านครอบครัวอย่างเต็มที่ เมื่อรัฐจำกัดการสนับสนุน ขณะที่การสนับสนุนครอบครัวก็ไม่เข้มแข็ง ผลที่เกิดขึ้นคือความเสี่ยงอาจตกอยู่กับปัจเจกบุคคลมากกว่าถูกกระจายผ่านเครือข่ายสังคม

ในด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ กลุ่มที่ 3 อยู่ในระดับปานกลางโดยเฉลี่ย แต่ความแตกต่างภายในกลุ่มสูงมาก บางประเทศสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในสัดส่วนใกล้เคียงกับกลุ่มที่ 1 ขณะที่บางประเทศสนับสนุนเพียงประมาณหนึ่งในห้าของต้นทุนทั้งหมด ความแตกต่างนี้สะท้อนผ่านภาระค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนต้องรับผิดชอบเองและความเสี่ยงต่อความยากจนของผู้รับบริการ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วสูงกว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 อย่างชัดเจน มีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่สามารถจำกัดความเสี่ยงต่อความยากจนของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเชิงการอภิบาลระบบ ประเทศในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่มีกรอบกฎหมายที่บูรณาการมิติสุขภาพและสังคมเข้าไว้ในระบบเดียวกัน ทว่ามีรูปแบบการอภิบาลที่กระจายอำนาจไปยังระดับท้องถิ่นเป็นหลัก ระดับการแยกส่วนระหว่างบริการสุขภาพและบริการสังคมค่อนข้างชัดเจนมากกว่าสองกลุ่มแรก อย่างไรก็ดี หลายประเทศมีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด ทั้งในรูปแบบการกำหนดสัดส่วนบุคลากรต่อผู้รับบริการ การวางกรอบประกันคุณภาพ และการกำหนดคุณวุฒิขั้นต่ำของบุคลากรดูแล ส่งผลให้ผลลัพธ์ด้านคุณภาพของบริการในบางประเทศอยู่ในระดับใกล้เคียงกับกลุ่มที่มีความครอบคลุมสูงกว่า

ดังนั้น กลุ่มที่ 3 จึงสะท้อนลักษณะของระบบที่มี “การกำกับเชิงคุณภาพค่อนข้างเข้มแข็ง แต่การคุ้มครองเชิงปริมาณยังจำกัด” กล่าวคือ มีความพยายามรักษามาตรฐานการดูแล แต่การเข้าถึงสิทธิถูกจำกัดด้วยกลไกคัดกรองและทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ ระบบในกลุ่มนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับสวัสดิการแบบเก็บตก (residual welfare model) ซึ่งรัฐเข้ามาแทรกแซงเมื่อความจำเป็นชัดเจนและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ความเสี่ยงจากภาวะพึ่งพิงในวัยชราจึงยังคงถูกทำให้เป็นภาระของปัจเจกบุคคลในระดับสูง แม้จะมีโครงสร้างคุณภาพรองรับอยู่บางส่วนก็ตาม

กลุ่มที่ 4 เช็กเกีย โครเอเชีย กรีซ ลิทัวเนีย สเปน โปแลนด์ โปรตุเกส และสาธารณรัฐสโลวัค

เป็นกลุ่มประเทศที่มีการสนับสนุนการเงินการคลังภาครัฐแก่ระบบบริการดูแลระยะยาวต่ำที่สุด ทำให้ความครอบคลุมการได้รับบริการแบบภาคทางการอยู่ในระดับต่ำ ระบบมีการแยกส่วนและมีคุณภาพต่ำ

ประเทศในกลุ่มที่ 4 มีลักษณะสำคัญคือ แม้จะใช้กลไกการพิจารณาฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย แต่ระดับความครอบคลุมของบริการดูแลระยะยาวแบบเป็นทางการกลับอยู่ในระดับต่ำที่สุดในบรรดาทั้งสี่กลุ่ม โดยเฉลี่ยมีผู้สูงอายุที่มีความต้องการการดูแลเพียงประมาณร้อยละ 20 เท่านั้นที่ได้รับบริการแบบเป็นทางการ และมีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีอัตราความครอบคลุมเกินร้อยละ 30 ลักษณะดังกล่าวสะท้อนว่าการไม่ใช้กลไกคัดกรองรายได้อย่างเข้มงวดมิได้แปลว่าระบบจะมีความครอบคลุมสูง หากแต่ข้อจำกัดเชิงทรัพยากรและโครงสร้างบริการมีบทบาทกำหนดระดับการเข้าถึงอย่างชัดเจนมากกว่า

รูปแบบสิทธิประโยชน์มีความหลากหลาย โดยบางประเทศพึ่งพาการให้เงินเป็นหลัก ขณะที่บางประเทศจัดบริการโดยตรงเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ไม่ว่ารูปแบบใด ระดับการสนับสนุนจากภาครัฐต่อค่าใช้จ่ายรวมของการดูแลอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น แม้บางประเทศจะเพิ่มการสนับสนุนตามระดับความรุนแรงของความต้องการ แต่โดยรวมแล้ว ภาครัฐครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพียงสัดส่วนจำกัด โดยในหลายประเทศครอบคลุมไม่ถึงหนึ่งในสี่ของต้นทุนทั้งหมด สำหรับผู้สูงอายุที่มีความต้องการรุนแรงและมีรายได้ระดับกลาง ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนต้องรับผิดชอบเองอยู่ในระดับสูง และการลดความเสี่ยงต่อความยากจนจากค่าใช้จ่ายด้านการดูแลระยะยาวทำได้อย่างจำกัด

ข้อจำกัดด้านทรัพยากรเป็นอีกลักษณะเด่นของกลุ่มนี้ จำนวนเตียงในสถานดูแลระยะยาวต่อประชากรผู้สูงอายุอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มในหลายประเทศ และจำนวนบุคลากรดูแลต่อประชากรผู้สูงอายุอยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับทั้งสี่กลุ่ม ด้วยกำลังระบบที่จำกัดเช่นนี้ ภาระการดูแลจึงถูกผลักกลับไปสู่ครอบครัวในระดับสูง โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุที่มีความต้องการการดูแลได้รับการดูแลจากสมาชิกในครัวเรือน และในหลายประเทศอัตราดังกล่าวสูงเกินร้อยละ 60

อย่างไรก็ตาม ความพึ่งพาครอบครัวในระดับสูงนี้ไม่ได้มาพร้อมกับมาตรการสนับสนุนเชิงนโยบายที่เข้มแข็ง ประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้มีนโยบายสนับสนุนผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการเพียงหนึ่งมาตรการ หรือไม่มีเลย ยกเว้นบางประเทศที่มีชุดมาตรการสนับสนุนครบถ้วนกว่า ความไม่สมดุลระหว่างการพึ่งพาครอบครัวและการสนับสนุนเชิงสถาบันดังกล่าว สะท้อนลักษณะของระบบที่ “ทำให้การดูแลเป็นเรื่องของครอบครัวโดยปริยาย” มากกว่าจะเป็นผลจากการออกแบบเชิงนโยบายอย่างตั้งใจ

ในกลไกการอภิบาลระบบ ระบบในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่มีกรอบกฎหมายที่บูรณาการมิติสุขภาพและสังคมเข้าไว้ด้วยกัน และมีระดับการบูรณาการกับระบบบริการสุขภาพโดยรวมค่อนข้างต่ำ มีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่สามารถเชื่อมโยงการดูแลระยะยาวเข้ากับทั้งบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลได้อย่างครบถ้วน โครงสร้างการอภิบาลมีลักษณะผสมผสานระหว่างการรวมศูนย์และการกระจายอำนาจ ขณะที่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน แม้บางประเทศจะมีสัดส่วนผู้ให้บริการภาครัฐเกินครึ่งหนึ่งเล็กน้อยก็ตาม

ในด้านคุณภาพ หลายประเทศในกลุ่มนี้กำหนดสัดส่วนบุคลากรต่อผู้รับบริการและกำหนดคุณวุฒิขั้นต่ำของบุคลากรในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มที่ 1 อย่างไรก็ตาม บางประเทศยังขาดกรอบประกันคุณภาพที่เป็นระบบ ส่งผลให้ผลลัพธ์ด้านคุณภาพโดยเฉลี่ยของกลุ่มนี้ต่ำกว่ากลุ่มอื่น แม้จะมีบางประเทศที่สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพได้ในระดับสูงก็ตาม

โดยสรุป กลุ่มที่ 4 สะท้อนระบบการดูแลระยะยาวที่มีระดับการหลุดออกจากกลไกตลาดต่ำ และมีระดับการพึ่งพาครอบครัวสูงที่สุดในทั้งสี่กลุ่ม ความเสี่ยงจากภาวะพึ่งพิงในวัยชราถูกผลักไปสู่ครัวเรือนในระดับสูง ขณะที่การสนับสนุนจากรัฐมีข้อจำกัดทั้งในด้านทรัพยากรการเงิน และการบูรณาการเชิงสถาบัน แม้จะไม่ได้พึ่งพาการคัดกรองรายได้อย่างเข้มงวด แต่ความครอบคลุมที่ต่ำและภาระค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้การดูแลระยะยาวในกลุ่มนี้ยังคงเป็นภาระส่วนบุคคลมากกว่าจะเป็นภารกิจสาธารณะของรัฐสวัสดิการอย่างเต็มรูปแบบ

จากการเปรียบเทียบทั้งสี่กลุ่มประเทศ อาจสรุปได้ว่า ระดับความครอบคลุมและคุณภาพของระบบการดูแลระยะยาวมิได้ขึ้นกับการออกแบบสิทธิแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ขึ้นกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนภาครัฐ โครงสร้างบริการ ความเข้มแข็งของตลาด และบทบาทของครอบครัว ดังนี้

1. **กระบวนการทำให้ระบบการดูแลระยะยาวหลุดพ้นจากกลไกตลาด (decommodification) มิได้เกิดจากการประกาศสิทธิในเชิงกฎหมายเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องอาศัยการลงทุนจากภาครัฐควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างบริการพื้นฐานอย่างเป็นระบบ** โดยเฉพาะจำนวนบุคลากรที่เพียงพอ มีมาตรฐานการศึกษา กรอบกำกับคุณภาพ และภาระงานที่เหมาะสม หากขาดองค์ประกอบเหล่านี้ แม้รัฐจะรับรองสิทธิในการดูแลไว้ในระดับหลักการ แต่ในทางปฏิบัติประชาชนจะมีแนวโน้มพึ่งพาภาคเอกชนหรือจัดการความเสี่ยงผ่านตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ดังกล่าวยังขึ้นกับความเข้มแข็งของตลาดบริการในแต่ละประเทศ หากตลาดมีศักยภาพ ความเสี่ยงอาจถูกถ่ายโอนไปยังปัจเจกผ่านการซื้อบริการ แต่หากตลาดอ่อนแอ ภาระอาจถูกผลักกลับไปยังครอบครัวแทน
2. **การอภิบาลระบบการดูแลระยะยาวมิได้ขึ้นกับระดับการรวมศูนย์หรือกระจายอำนาจโดยลำพัง หากแต่ขึ้นกับความชัดเจนของกรอบกฎหมายและกลไกบูรณาการระหว่างมิติสุขภาพและมิติทางสังคม** อุดมคติของการออกแบบระบบอาจอยู่ที่

การบูรณาการบริการทั้งสองมิติเข้าด้วยกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความแยกส่วนของความรับผิดชอบ และเพื่อให้การดูแลมีความต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การถ่ายโอนอำนาจไปยังท้องถิ่นอาจเอื้อให้การจัดบริการสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากขาดสมรรถนะขององค์กรระดับท้องถิ่นและกลไกกำกับคุณภาพที่เพียงพอ การกระจายอำนาจอาจนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ได้ ดังนั้น ความเป็นเนื้อเดียวกัน (coherence) ของระบบจึงสำคัญกว่ารูปแบบการจัดวางอำนาจในเชิงโครงสร้างเพียงอย่างเดียว

3. **บทบาทของผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการ (informal carers) เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบนโยบาย ความเข้มแข็งของตลาด และกำลังของระบบภาครัฐมากกว่าการมีหรือไม่มีมาตรการสนับสนุนครอบครัวเพียงอย่างเดียว** แม้หลายประเทศจะมีมาตรการส่งเสริมผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการในระดับใกล้เคียงกัน แต่สัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลในครัวเรือนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนว่าเมื่อรัฐจำกัดการลงทุนและตลาดบริการมีศักยภาพสูง ความเสี่ยงจากภาวะพึ่งพิงอาจถูกถ่ายโอนไปยังปัจเจกผ่านการซื้อบริการ แต่หากทั้งรัฐและตลาดมีข้อจำกัด ภาระจะถูกผลักกลับไปยังครอบครัวและเครือข่ายสังคมในระดับสูง การมีมาตรการสนับสนุนผู้ดูแลจึงมีความสำคัญต่อการกำหนดบทบาทของครอบครัวให้สอดคล้องกับระบบโดยรวม มากกว่าการปล่อยให้การพึ่งพาครอบครัวเกิดขึ้นจากความจำเป็นเชิงโครงสร้าง

พัฒนาการของระบบการดูแลระยะยาวและสถาบันทางสังคม

เพื่อทำความเข้าใจที่มาของความแตกต่างในระบบการดูแลระยะยาวของแต่ละประเทศ รูปแบบโครงสร้างสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการระบบการดูแลระยะยาวเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการดูแลระยะยาวของแต่ละประเทศ คณะผู้วิจัยจึงยกตัวอย่างบางประเทศที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มข้างต้น เพื่อให้เป็นบริบทของการพัฒนามากยิ่งขึ้น ก่อนจะนำเข้าสู่บริบทการพัฒนาของประเทศไทยในบทต่อไป

สวีเดน (35)

ประเทศสวีเดนเป็นตัวแทนประเทศจากกลุ่มที่ 1 ซึ่งมีความครอบคลุมของบริการการดูแลระยะยาวอย่างกว้างขวางและได้รับการสนับสนุนงบประมาณภาครัฐมากที่สุด ซึ่งตั้งแต่ทศวรรษ 1970s นั้น สวีเดนได้พัฒนาระบบบริการซึ่งมีภาครัฐเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการและใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชน ทั้งนี้ การดูแลระยะยาวในสวีเดนนั้นหมายรวมถึงบริการบางประเภทสำหรับผู้พิการที่อายุน้อยกว่า 65 ปีด้วย กล่าวคือ การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในประเทศสวีเดนถูกจัดอยู่ภายใต้ระบบการดูแลแบบสวัสดิการถ้วนหน้า (Universalistic care regime) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมและสาธารณะ ซึ่งมองว่าการดูแลระยะยาวและปัญหาของผู้สูงอายุเป็นความเสี่ยงทางสังคมที่รัฐจำเป็นต้องดูแล ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้โครงสร้างการเมืองแบบกระจายอำนาจ โดยในระดับชาตินั้น พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democratic Party) มีบทบาทหลักในการพัฒนามาเป็นเวลานาน

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของระบบการดูแลของสวีเดนคือ ครอบครัวไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลสมาชิกของตนเอง แม้ว่าในทางปฏิบัติครอบครัวจะยังมีบทบาทสำคัญอยู่มากก็ตาม นอกจากนี้ **สิ่งที่สำคัญคือ คำว่า “การดูแลระยะยาว (long-term care)” ไม่ได้เป็นคำที่ใช้ในนโยบายหรือวิวาทะทางการเมืองของสวีเดน** การดูแลผู้สูงอายุที่มีความเปราะบาง รวมถึงสถานดูแลผู้สูงอายุ (nursing homes) และการดูแลผู้พิการนั้นถูกมองว่าเป็นสาขาของการดูแลทางสังคมที่แยกออกจากการดูแลด้านสุขภาพอย่างชัดเจน

อีกลักษณะหนึ่งของระบบการดูแลในสวีเดนคือประเพณีของการมีอำนาจปกครองตนเองของเทศบาล (municipal autonomy) ที่เข้มแข็ง ในสวีเดนนั้น เทศบาลมีหน้าที่หลักในการจัดบริการการดูแลโดยภาครัฐ ในที่นี้หมายรวมทั้งบริการการดูแลที่บ้าน (home-based services) และบริการดูแลในสถานที่พักอาศัย (residential services) ซึ่งเทศบาลมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีเพื่อใช้เป็นแหล่งงบประมาณส่วนใหญ่ของสำหรับการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้พิการในพื้นที่ ซึ่งภาษีที่เทศบาลเก็บได้ถือเป็นร้อยละ 85 ของงบประมาณภาครัฐสำหรับการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่ โดยอีกร้อยละ 10 มาจากรัฐบาลกลางและร้อยละ 5 มาจากการร่วมจ่ายของประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรรูปแบบการดูแลประเภทต่าง ๆ เช่น การแบ่งสัดส่วนระหว่างการดูแลที่บ้านและการดูแลในสถานที่พักอาศัย

สำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งสัดส่วนการจัดสรรบริการในกลุ่มประชากรอื่น ๆ เช่น เด็ก เป็นต้น กล่าวคือ ในแต่ละพื้นที่นั้นจะมีสัดส่วนของบริการในแต่ละกลุ่มประชากรแตกต่างกันตามความต้องการของพื้นที่

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทศบาลจะมีบทบาทหลักในการจัดเก็บภาษีและการให้บริการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าส่วนกลางจะไม่มีความสำคัญเลย โดยรัฐบาลกลางจะมีบทบาทหลักอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) การออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 2) การใช้กลไกการเงินเพื่อจูงใจให้เกิดบริการ และ 3) การกำกับติดตามผลการดำเนินการของรัฐบาล

สำหรับกลไกแรกนั้น รัฐบาลกลางของสวีเดนจะกำหนดว่าเทศบาลต้องให้บริการดูแลแก่ประชากรกลุ่มใดบ้าง สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้มากเพียงใด และหน่วยบริการประเภทใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการ โดยสำหรับการดูแลระยะยาว[2] การให้บริการของเทศบาลจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติบริการสังคม (Social Services Act, SSA) ซึ่งประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1982 กฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมบริการการดูแลที่บ้านและบริการในสถานที่พักอาศัย รวมถึงสถานดูแลผู้สูงอายุด้วย สำหรับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายบริการ (goal-oriented legislation) ซึ่งรับรองสิทธิของประชาชนในการขอรับบริการ “หากไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ด้วยวิธีอื่น” เพื่อให้บุคคลนั้นมี “ระดับการดำรงชีวิตที่เหมาะสม” ทั้งนี้ กฎหมายไม่ได้กำหนดความหมายและขอบเขตของคำว่า “ความต้องการ” อย่างชัดเจน แต่ประชาชนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ หากถูกปฏิเสธการให้บริการจากหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าด้วยกฎหมายดังกล่าว การดูแลระยะยาวของสวีเดนนั้นจึงเป็นการให้บริการทางสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุและคงไว้ซึ่งระดับการดำรงชีวิตที่เหมาะสมของผู้สูงอายุได้

สำหรับประเด็นผู้พิการนั้น ยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ระบุบริการสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติผู้พิการ ปี ค.ศ. 1993 กฎหมายนี้แตกต่างจากพระราชบัญญัติบริการทางสังคมข้างต้น เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิที่เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลที่มีความพิการรุนแรงบางประเภท และกำหนดมาตรการที่เทศบาลต้องจัดให้เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มี “สภาพความเป็นอยู่ที่ดี” ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

[2] ถึงแม้สวีเดนจะใช้คำว่า “บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ” แต่ในรายงานฉบับนี้จะขอใช้เป็นคำว่า “การดูแลระยะยาว” แทนเพื่อความต่อเนื่องของการเขียนรายงาน

บริการทางสังคม โดยผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายฉบับนี้มีสิทธิที่จะได้รับบริการผู้ช่วยส่วนบุคคล (Personal Assistant) ซึ่งรัฐบาลกลางจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากผู้พิการต้องการการดูแลเกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกฎหมายบริการสังคมกับกฎหมายผู้พิการคือ กฎหมายบริการสังคมนั้นเปิดโอกาสให้เทศบาลมีดุลยพินิจในการกำหนดหรือตีความว่าผู้ใดมีสิทธิได้รับบริการและได้รับบริการในระดับใด ในขณะที่กฎหมายผู้พิการกำหนดอย่างชัดเจนว่าใครมีสิทธิและควรได้รับการสนับสนุนแบบใด

ในกลไกที่สองนั้น รัฐบาลกลางอาจใช้แรงจูงใจทางการเงินเป็นเครื่องมือในการกำกับกิจกรรมของเทศบาลได้ โดยออกแบบกลไกผ่านขนาดของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนกลางและโครงสร้างของเงินอุดหนุนนั้น โดยตั้งแต่ในปี 1993 เงินอุดหนุนรายกิจกรรมถูกแทนที่ด้วยเงินอุดหนุนแบบก้อน (block grants) ซึ่งเทศบาลสามารถจัดสรรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ได้เอง ทว่า ต่อมาได้มีการจัดตั้งกองทุนเฉพาะโครงการหลายประเภทควบคู่กับเงินอุดหนุนแบบก้อน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เทศบาลปรับเปลี่ยนการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลกลาง ตัวอย่างหนึ่งของกองทุนเฉพาะโครงการที่สำคัญคือ การใช้เงินอุดหนุนเพื่อกระตุ้นให้เทศบาลนำรูปแบบ “ทางเลือกของผู้ใช้บริการ (customer choice model)” มาใช้ ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ตัวอย่างอื่น อาทิ การสนับสนุนผู้ดูแลในครอบครัวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 และเงินทุนสำหรับการฝึกอบรมด้านศักดิ์ศรีในการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011

กลไกสุดท้าย คือการกำกับติดตามและการให้คำแนะนำ ในสวีเดนหน้าที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกมอบหมายให้กับคณะกรรมการสุขภาพและสวัสดิการแห่งชาติ (National Board of Health and Welfare, NBHW หรือ Socialstyrelsen) ทิศทางในปัจจุบันของสวีเดน คือ การเพิ่มความเข้มข้นของการกำกับดูแลแบบไม่เป็นทางการ (soft regulation) ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในบริบทที่แตกต่างกัน (benchmarking) การเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและคุณภาพของบริการดูแล และการพัฒนาแนวปฏิบัติและเครื่องมือประเมินผลในการให้บริการ

เดนมาร์ก (36)

เดนมาร์กเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ในกลุ่มที่ 1 และใช้ระบบการดูแลแบบสวัสดิการถ้วนหน้า (Universalistic care regime) และการให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการตัดสินใจเช่นเดียวกัน

กับสวีเดน โดยทั่วไประบบการดูแลระยะยาวในเดนมาร์กมีลักษณะคล้าย ๆ สวีเดน กล่าวคือ บริการการดูแลนั้นอยู่ในการดูแลของเทศบาลเป็นหลัก ทั้งในแง่ของการกำหนดงบประมาณและการให้บริการ อย่างไรก็ดี ลักษณะที่แตกต่างของเดนมาร์กกับสวีเดน คือ เดนมาร์กนั้นเน้นการดูแลที่บ้านมากกว่า โดยการดูแลที่บ้านในเดนมาร์กนั้นมีลักษณะเป็นบริการสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือด้านการดูแลส่วนบุคคลและการช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน การเข้าถึงบริการตั้งอยู่บนหลักการของสิทธิพลเมืองและตามกฎหมายกำหนดว่าพลเมืองมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบความยากลำบากในการทำกิจวัตรประจำวัน ในขณะเดียวกันการจัดบริการในเดนมาร์กนั้นเป็นรูปแบบการพิจารณาตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล บริการการดูแลที่บ้านในเดนมาร์กนี้เป็นบริการที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย งบประมาณในการจัดบริการนี้เป็นความรับผิดชอบของเทศบาล โดยหมายรวมถึงงบประมาณในการจัดระบบการประเมินความจำเป็น (need assessment program) ของผู้สูงอายุด้วย จะเห็นได้ว่าสำหรับเดนมาร์กเอง เทศบาลมีบทบาทสำคัญในออกแบบระบบการดูแลระยะยาวในพื้นที่เช่นเดียวกันกับสวีเดน

อย่างไรก็ดี อำนาจของเทศบาลในเดนมาร์กมีประเด็นที่น่าสนใจบางประการ ในพระราชบัญญัติบริการสังคมในเดนมาร์กนั้น มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของเทศบาลไว้ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดบริการการดูแลระยะยาว แต่ก็เปิดโอกาสให้เทศบาลสามารถตัดสินใจได้ว่าจะจัดบริการรูปแบบใด ระดับใด และการจัดบริการโดยหน่วยบริการใด ที่น่าสนใจคือ กฎหมายได้แยกแยะอย่างชัดเจนระหว่างสิ่งที่เทศบาล “ต้องทำ” กับสิ่งที่เทศบาล “สามารถทำได้”

อาจจะกล่าวโดยรายละเอียดได้ว่า กลไกการกระจายอำนาจของเดนมาร์กนั้นมีผู้ที่มีบทบาทหลักอยู่หลายกลุ่ม โดยพื้นฐานกระบวนการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระยะยาวนั้นต้องดำเนินไปภายใต้บริบทของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับหน่วยงานท้องถิ่น ส่งผลให้รัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นผู้มีบทบาทหลักสองฝ่ายแรก อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท้องถิ่นผ่านกลไกของสมาคมปกครองส่วนท้องถิ่น (Association of Local Authorities – Kommunernes Landsforening, KL) นั้นถือว่ามีความสามารถในการต่อรองสูงกว่า เนื่องจากท้องถิ่นเองนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณและการให้บริการดูแลระยะยาว อีกแง่หนึ่งหมายถึง ผลประโยชน์ของหน่วยงานท้องถิ่นในประเด็นการดูแลระยะยาวจะเป็นทั้งการรักษาหรือขยายแหล่งงบประมาณที่มีอยู่และการปกป้องความเป็นอิสระที่หน่วยงานท้องถิ่นมีในการกำกับดูแลกิจการด้านต่าง ๆ

ในขณะที่รัฐบาลกลางก็ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับทิศทางของระบบการดูแลระยะยาว ทั้งในด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายและการกำหนดรูปแบบและลักษณะของบริการ โดยความสมดุลของอำนาจระหว่างส่วนกลางและระดับท้องถิ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ในช่วงทศวรรษ 1980s ระบบมีลักษณะของการกระจายอำนาจเป็นหลัก แต่ตั้งแต่ทศวรรษ 1990s เป็นต้นมา การประกาศกฎระเบียบใหม่ที่มีรายละเอียดมากขึ้นมาแทนกรอบกฎหมายเดิมนั้น ทำให้มีการกำกับดูแลการทำงานของท้องถิ่นที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องต่อความตึงเครียดระหว่างสองสถานบันทางสังคมนี้ โดยสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงออกผ่านการต่อต้านการลดทอนอำนาจของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรูปแบบการกำหนดนโยบายของเดนมาร์กโดยรวมยังคงมีเน้นการลงฉันทามติร่วมกัน และมีช่องทางทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจำนวนมากที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบาย ในบรรดากลไกทั้งหมดนี้ การเจรจางบประมาณประจำปีระหว่างรัฐบาลกลางกับหน่วยงานท้องถิ่นถือเป็นเวทีสำคัญที่ประชาชนต่างติดตาม

นอกจากนี้ ในเดนมาร์กยังมีผู้เล่นสำคัญอีกฝ่ายในกลไกเชิงนโยบาย ได้แก่ องค์กรหลักที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ใหญ่ที่สุดชื่อว่า DaneAge (Ældresagen) โดยในปี ค.ศ. 2011 สมาชิกของ DaneAge มีจำนวนถึง 600,000 คนใน ซึ่งถือเป็นกรณีที่น่าสนใจ เพราะโดยทั่วไปมักมีข้อสันนิษฐานว่าแต่เพียงผู้สูงอายุอย่างเดียว อาจมารวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งองค์กรได้ไม่ง่ายนัก ทว่า DaneAge ได้ใช้รูปแบบการเปิดรับสมาชิกที่อายุต่ำกว่าวัยเกษียณด้วย ซึ่งทำให้องค์กรสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบุคคลอื่นได้ด้วย เช่น ญาติหรือผู้ดูแล อย่างไรก็ตาม แม้ไม่รวมสมาชิกกลุ่มนี้ จำนวนสมาชิกในกลุ่มผู้สูงอายุก็ยังถือว่าสูงมากอยู่ดี เมื่อรวมกับกิจกรรมระดมทุนทั้งหมดแล้ว DaneAge จึงมีงบประมาณจำนวนมากพอที่จะมีสามารถสร้างพื้นที่สื่อให้ตัวเองได้ ตลอดจนสามารถดำเนินงานวิจัยของตนเองได้ องค์กรนี้จึงมักทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเฝ้าระวัง (watchdog) เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้สูงอายุเผชิญกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากระบบราชการ หรือเมื่อรัฐบาลได้ลดสิทธิในการได้รับบริการช่วยเหลือ องค์กรดังกล่าวเคยถึงขั้นขู่ว่าจะดำเนินคดีต่อหน่วยงานท้องถิ่นหลายครั้ง นอกจากนี้ DaneAge ยังทำหน้าที่ล็อบบี้เพื่อต่อต้านการลดทอนสวัสดิการ กล่าวโดยสรุป เป้าหมายของ DaneAge คือการส่งเสริม คุ้มครอง และขยายสวัสดิการของผู้สูงอายุ

จะเห็นได้ว่าการออกแบบระบบสวัสดิการถ้วนหน้าเพียงอย่างเดียวไม่อาจนำมาสู่ความครอบคลุมที่สูงได้มากที่สุด โครงสร้างสถาบันทางสังคมเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้ารับบริการได้มากขึ้น จากกรณีศึกษาในเดนมาร์ก เมื่อเปรียบเทียบกับสวีเดนนั้น กลไกการต่อรองเชิงอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาสังคมทำให้เข้าใจได้ว่า หากการเปรียบเทียบนั้น ทำไมเดนมาร์กถึงมีความครอบคลุมในการดูแลระยะยาวสูงกว่าสวีเดนอย่างมีนัยสำคัญ

สหราชอาณาจักร (37)

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มที่ 2 ที่มีความครอบคลุมของบริการการดูแลระยะยาวในระดับที่สูง ทว่า ปรากฏสัดส่วนของการดูแลแบบไม่เป็นทางการสูงกว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิก ประเด็นนี้เป็นที่น่าสนใจ เพราะว่าสหราชอาณาจักรเป็นประเทศต้นแบบอีกประเทศหนึ่งที่มีการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผ่านระบบภาษี ทว่า ประเด็นในการดูแลระยะยาวนั้นมีความแยกส่วนออกจากระบบสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ และภายในรูปแบบของการดูแลระยะยาวในแต่ละประเทศก็มีการแยกส่วนทั้งในแง่ของแหล่งงบประมาณและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในสหราชอาณาจักรนั้นไม่มีนโยบายแหล่งเงินทุน หรือระบบบริการใดระบบหนึ่งที่ถูกเข้าใจโดยทั่วกันว่าเป็น “ระบบการดูแลระยะยาว” โดยเฉพาะ ทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการดูแลระยะยาวกระจายอยู่ในงบประมาณของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Services, NHS) หน่วยงานท้องถิ่น และกระทรวงแรงงานและบำนาญ (Department for Work and Pensions, DWP) ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นกระทรวงความมั่นคงทางสังคม โดยแต่ละหน่วยงานมีอำนาจกำหนดนโยบายในระดับมหภาคของตนเอง รวมทั้งมีกระบวนการจัดสรรทรัพยากรในระดับพื้นที่ของตัวเองด้วยเช่นกัน

สำหรับการดูแลในสถานที่พักอาศัย (residential care) การช่วยเหลือด้านการดูแลส่วนบุคคล งานบ้าน การดูแลระหว่างวัน (day care) และกิจกรรมในเวลากลางวันอื่น ๆ เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริการสังคมของหน่วยงานท้องถิ่น บริการนี้อาศัยแหล่งเงินทุนมาจากหลายช่องทาง ได้แก่ ภาษีที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้หน่วยงานท้องถิ่น ภาษีทรัพย์สินในท้องถิ่น และค่าบริการจากผู้ใช้บริการ โดยทั่วไปผู้ที่มีทรัพย์สินเกิน 23,250 ปอนด์ (รวมมูลค่าบ้านของครอบครัว) มักไม่สามารถเข้าถึงบริการดูแลในสถานที่พักอาศัยหรือการดูแลที่บ้านที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นได้ และแม้แต่ผู้ที่มีรายได้น้อยก็ยังต้องจ่ายค่าบริการ

บางส่วนเช่นกัน โดยรวมแล้ว ค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 17 ของค่าใช้จ่ายของบริการสังคมทั้งหมด นอกจากนี้ หน่วยงานท้องถิ่นยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการประเมินความต้องการของผู้ดูแลในครอบครัวและจัดบริการสนับสนุนสำหรับผู้ดูแลด้วย ซึ่งส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของการดูแลชั่วคราว (respite care) หรือเงินสนับสนุนเพื่อนำไปใช้บริการดังกล่าวด้วย

สำหรับงบประมาณจากระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) นั้นมีส่วนสนับสนุนอยู่ที่ประมาณ 3 พันล้านปอนด์ต่อปีสำหรับการดูแลระยะยาว ซึ่งเป็นงบประมาณสำหรับการจัดบริการด้านการพยาบาลและการบำบัดรักษาแก่ผู้ป่วยทั้งที่อยู่ที่บ้านและอยู่ที่สถานที่พักอาศัย ทั้งนี้ หากผู้ป่วยมีความต้องการทางสุขภาพที่รุนแรงมากจากต้องได้รับการดูแลจากภาคสุขภาพตลอดจนเวลานั้น NHS มีการจัดตั้งระบบการดูแลต่อเนื่อง (NHS continuing care) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งมีการสนับสนุนด้านการเงินเทียบเท่ากับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน อย่างไรก็ดี จากการประเมินความต้องการของผู้ป่วยนั้น พบว่า ในปี ค.ศ. 2005 มีเพียงผู้ป่วยประมาณ 14% ของผู้พักอาศัยในสถานดูแลพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการดังกล่าว

สำหรับสวัสดิการจากระบบประกันสังคมในสหราชอาณาจักรนั้น ประกอบด้วยเบี้ยผู้สูงอายุ (Attendance Allowance, AA) ซึ่งมีผู้สูงอายุประมาณ 1.4 ล้านคนได้รับสิทธินี้ เนื่องจากมีความต้องการการช่วยเหลือในด้านการดูแลส่วนบุคคล และเบี้ยผู้พิการ (Disability Living Allowance, DLA) ซึ่งมีเด็กและผู้พิการในวัยทำงานประมาณ 2.8 ล้านคนเป็นผู้ได้รับสิทธิ โดยสวัสดิการต้องการครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางสำหรับผู้ที่มีความยากลำบากในการเคลื่อนไหว จะเห็นได้ว่า สวัสดิการทั้งสองประเภทมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากความพิการ โดยเงินสนับสนุนจะอยู่ระหว่าง 20 ถึง 131 ปอนด์ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับอายุ ระดับ และความถี่ของการช่วยเหลือที่ต้องการ ตลอดจนการพิจารณาว่ามีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหรือไม่

สำหรับผู้ดูแลในครอบครัวของผู้ที่ได้รับ AA หรือ DLA ซึ่งมีรายได้น้อยหรือแทบไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นเลย สามารถขอรับเบี้ยผู้ดูแล (Carers Allowance, CA) ได้ โดยสวัสดิการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป เนื่องจากภาระการดูแลทำให้ไม่สามารถทำงานรับค่าจ้างได้ โดยสวัสดิการทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานและบำนาญ

และมีการจัดการในระดับมหภาค อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก AA มักถูกนำไปนับรวมในเกณฑ์การประเมินรายได้ของประชาชนสำหรับบริการสังคมของหน่วยงานท้องถิ่น ดังนั้น ในทางปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับ AA อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้รับบริการทางสังคมของหน่วยงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับบริการทางสังคมของหน่วยงานท้องถิ่นอาจไม่ได้รับ AA ก็ได้

ดังนั้น หากพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านการดูแลระยะยาวทั้งหมดของสหราชอาณาจักร เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) นั้นจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับประเทศรัฐสวัสดิการพัฒนาแล้วอื่น ๆ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา และเยอรมนี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายจากภาครัฐคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 65 ของยอดรวมทั้งหมดเท่านั้น ส่วนที่เหลือประกอบด้วยค่าบริการที่ผู้ใช้บริการต้องจ่ายเอง (ประมาณ 17%) และการซื้อบริการจากภาคเอกชนโดยตรง นอกจากนี้ ในปี ค.ศ.2007 ยังพบว่ามีผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการในการดูแลระยะยาวอยู่ประมาณ 6 ล้านคน คิดเป็นหนึ่งในสิบของประชากรทั้งหมดของสหราชอาณาจักร ซึ่งสามารถคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 87 พันล้านปอนด์ จึงอาจเห็นได้ว่า ถึงแม้สหราชอาณาจักรจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ประเด็นด้านการดูแลระยะยาวนั้นอาจเป็นข้อยกเว้นในกรอบบริการของสหราชอาณาจักร ที่ยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐจำกัด และส่งผลให้เกิดการดูแลแบบไม่เป็นทางการในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศที่มีรัฐสวัสดิการอื่น ๆ

เยอรมนี (38)

เยอรมนีเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 ซึ่งยังเป็นกลุ่มประเทศที่มีความครอบคลุมของการดูแลระยะยาวในระดับที่สูง แต่เป็นกลุ่มที่มีการดูแลแบบไม่เป็นทางการสูงกว่าเช่นเดียวกัน หากพิจารณาระบบรัฐสวัสดิการในประเทศเยอรมนีนั้น มีความแตกต่างจากระบบในกลุ่มประเทศนอร์ดิกและสหราชอาณาจักรอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ เยอรมนีเป็นประเทศต้นแบบของระบบรัฐสวัสดิการแบบสมทบ (Contributory regime) ผ่านการตั้งกองทุนการดูแลระยะยาว (Long term care insurance, LTCI) เป็นอีกหนึ่งเสาของระบบประกันสังคม ซึ่งต้องการการสมทบเงินจากประชาชนและนายจ้าง

อนึ่ง ก่อนกาจัดตั้งกองทุนการดูแลระยะยาว การดูแลระยะยาวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภายใต้พระราชบัญญัติการช่วยเหลือทางสังคมของสหพันธ์ (Federal Social Assistance Act, BSHG) ปี ค.ศ. 1961 ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลที่บ้านและการดูแลในสถานที่พักอาศัย

จะได้รับการคุ้มครองผ่านระบบสวัสดิการจากภาษีส่วนกลาง ทว่า ไม่ได้มีความถ้วนหน้าเท่าประเทศกลุ่มนอร์ดิก ในเยอรมนีนั้นจะพิจารณาสนับสนุนเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการการดูแลระยะยาวและไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง ต่อมาหลังจากการประกาศพระราชบัญญัติปฏิรูประบบสุขภาพปี ค.ศ. 1989 ได้เปิดโอกาสให้สามารถเบิกคืนค่าใช้จ่ายสำหรับบริการดูแลชั่วคราว (respite care) สำหรับผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการได้ และในการปฏิรูปปี ค.ศ. 1991 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบางเริ่มได้รับสิทธิในการรับเงินสด (in-cash service) หรือบริการดูแล (in-kind service) จากกองทุนประกันสุขภาพภาคบังคับ (Statutory Health Insurance) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เสาของระบบประกันสังคมของเยอรมนี โดยบริการด้านสุขภาพเหล่านี้ถูกออกแบบให้เป็นจุดตั้งต้นของการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวที่ครอบคลุมถ้วนหน้าและต่อมาถูกยกเลิกเมื่อมีการนำระบบกองทุนการดูแลระยะยาวมาใช้

แรงจูงใจสำคัญในการจัดตั้งระบบใหม่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการดูแลในสถานที่พักอาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นในระดับท้องถิ่นภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการช่วยเหลือทางสังคม ภายหลังการจัดตั้ง LTCI ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านการช่วยเหลือทางสังคมในระดับท้องถิ่นลดลงอย่างมาก จากประมาณ 9 พันล้านยูโรต่อปีในปี ค.ศ. 1994 เหลือ 3.5 พันล้านยูโรต่อปีในปี ค.ศ. 1997 นอกจากนี้ ยังมีผลต่อกองทุนประกันสุขภาพอีก โดย LTCI ช่วยประหยัดงบประมาณได้ประมาณ 3.3 พันล้านยูโรจากการยกเลิกการสนับสนุนการดูแลระยะยาวแบบเดิมและการลดจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล

หากพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์นั้น พบว่า การจัดตั้ง LTCI ในเยอรมนีนั้นแท้จริงแล้วเกิดจากผลลัพธ์ของการประนีประนอมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ทั้งพรรคการเมืองและภาคประชาสังคมภายใต้กรอบสถาบันทางสังคมที่มีความจำเพาะของเยอรมนี ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการกำหนดนโยบายนั้น เยอรมนีมีข้อเสนอหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบประกันสังคมเดิม การใช้ระบบประกันเอกชนภาคบังคับ และการใช้ระบบภาษี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาระทางการคลังที่สูงภายหลังจากกระบวนการรวมชาติ (reunification) ในปี ค.ศ. 1989 การพึ่งพาระบบภาษีจึงถูกมองว่าไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ถึงตรงนี้ มุมมองต่อการสร้างระบบประกันนั้นแบ่งออกเป็นสองฝ่าย โดยที่ฝ่ายเสรีนิยม อาทิ พรรคเสรีนิยม องค์กรนายจ้าง และอุตสาหกรรมประกันเอกชนนั้นสนับสนุนการใช้ระบบประกันเอกชนมากกว่า และผลักภาระการดูแลไปที่ปัจเจก ในขณะที่ฝ่ายซ้าย อาทิ พรรคประชาธิปไตยคริสเตียน (Christian Democratic Party) พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยและสหภาพแรงงาน

นั้นสนับสนุนการใช้ระบบประกันสังคมมากกว่า โดยอาศัยหลักการของการกระจายทรัพยากร (redistribution) เพื่อลดความเลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ท้ายที่สุด ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากพรรคคริสเตียนเดโมแครต ซึ่งเป็นรัฐบาลในช่วงเวลานั้น พรรคเสรีนิยมจึงยอมรับรูปแบบระบบประกันสังคม โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการเสริมสร้างความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคลและแนวทางที่มุ่งเน้นกลไกตลาดให้เข้มแข็งมากขึ้น

ดังนั้น LTCI ของเยอรมนีมีความผสมผสานลักษณะดั้งเดิมของระบบประกันสังคมแบบเยอรมันเข้ากับการเน้นความรับผิดชอบของผู้ประกันตนเป็นรายบุคคล รวมทั้งยังมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มข้น ส่งผลให้ขนาดของงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐนั้นไม่สูง ถึงจุดนี้จึงอาจเข้าใจได้ว่าด้วยบริบทการพัฒนาของประวัติศาสตร์และบทบาทของสถาบันทางสังคมนั้น ถึงแม้เยอรมนีจะใช้ระบบประกันสังคมภาคบังคับที่มีความถ้วนหน้า แต่ทำไมยังปรากฏสัดส่วนของครัวเรือนที่ต้องรับภาระการดูแลระยะยาวที่ไม่เป็นทางการมากกว่าประเทศนอร์ดิกและประเทศในกลุ่มที่ 1 โดยสรุปเป็นสาระสำคัญของการปฏิรูประบบประกันได้ดังนี้

- ในเยอรมนี เงินสมทบประกันสังคมโดยทั่วไปจะถูกแบ่งจ่ายเท่า ๆ กันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในกรณีของระบบการดูแลระยะยาวนี้ องค์กรนายจ้างได้ต่อรองสำเร็จให้มีการชดเชยส่วนเงินสมทบของนายจ้างด้วยการยกเลิกวันหยุดนักขัตฤกษ์หนึ่งวัน (bank holiday) หมายความว่านายจ้างจะได้ช่วงเวลาที่แรงงานไปทำงานเพิ่ม 1 วัน การยกเลิกวันหยุดดังกล่าวได้รับการยอมรับในฐานะข้อตกลงประนีประนอมระหว่างสหภาพแรงงานและพรรคสังคมประชาธิปไตยฝ่ายหนึ่ง กับรัฐบาลกลางและองค์กรนายจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง
- ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการกำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากสนับสนุนระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมประชากรในสัดส่วนสูง เพื่อเสริมสร้างการกระจายทรัพยากรระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม อย่างไรก็ตาม จากการต่อรองของสองฝั่งในท้ายที่สุดการจัดตั้งกองทุนการดูแลระยะยาวจึงเกิดในสองรูปแบบ คือ กองทุนภาครัฐ (ในระบบประกันสังคม) และกองทุนภาคเอกชน ซึ่งเป็นแนวเดียวกับการแบ่งระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนประกันเอกชนในระบบประกันสุขภาพ
- การจ่ายเงินสมทบในกองทุนการดูแลระยะยาวนั้นแตกต่างจากกองทุนประกันสุขภาพโดยที่กองทุนประกันสุขภาพนั้น ผู้ประกันตนจะสมทบในอัตราพื้นฐานที่ร้อยละ 14.6

ของรายได้ รวมกับอัตราส่วนเพิ่มที่แต่ละกองทุนสามารถกำหนดได้เอง โดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณร้อยละ 1.7 ในปี ค.ศ.2024 (39) แต่สำหรับอัตราเงินสมทบของกองทุนประกันการดูแลระยะยาวถูกจะถูกกำหนดไว้โดยกฎหมาย ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ของรายได้รวมจนถึงเพดานที่กำหนด และกำหนดให้ใช้อัตราเดียวกันกับกองทุนประกันทุกกองทุน ส่วนในกองทุนประกันเอกชน อัตราที่กฎหมายกำหนดทำหน้าที่เป็นเพดานสูงสุด กล่าวคือ บริษัทประกันเอกชนสามารถกำหนดอัตราที่ต่ำกว่านี้ได้ แต่ไม่สามารถสูงกว่าได้ ซึ่งการกำหนดเพดานนี้ ทำให้เป็นการกำหนดรายได้ของกองทุนประกัน และเป็นตัวกำหนดขอบเขตของการสนับสนุนจากภาครัฐ อัตราเงินสมทบนี้สะท้อนเป้าหมายของการควบคุมค่าใช้จ่ายของกองทุนประกัน

เนเธอร์แลนด์

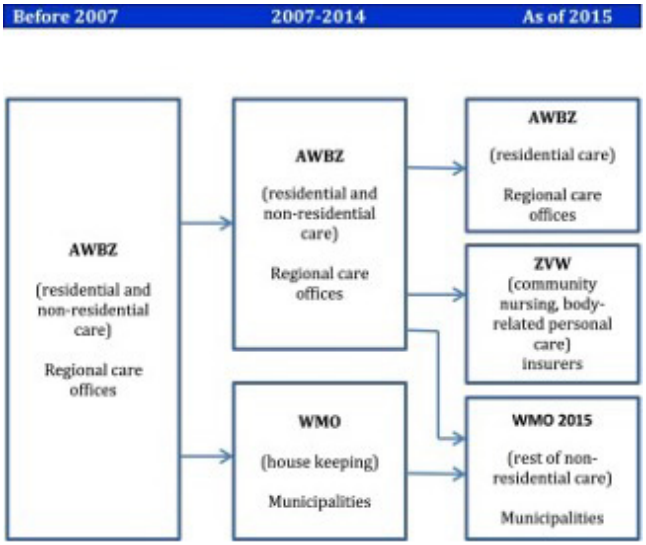
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ใช้ระบบที่คล้ายคลังกับเยอรมนี โดยอาศัยระบบประกันสังคมในการจัดสรรสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ซึ่งการพัฒนาระบบนั้นเกิดขึ้นภายหลังการขยายตัวของชนชั้นแรงงานในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการทางสังคมเพื่อคุ้มครองแรงงานและครอบครัวมากขึ้น ระบบประกันสังคมในเนเธอร์แลนด์จัดตั้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี ค.ศ.1901 ภายใต้ชื่อ Rijksverzekeringsbank (RV) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารกองทุนประกันอุบัติเหตุของแรงงาน(40) ลักษณะของประกันสังคมในเนเธอร์แลนด์นั้นคล้ายกับเยอรมนี โดยที่แรงงานต้องจ่ายเงินสมทบร่วมกับนายจ้างและรัฐ เกิดการรวมความเสี่ยง (Risk pooling) ในระดับชาติ ซึ่งกลไกเชิงสถาบันเช่นนี้ได้วางรากฐานสำคัญต่อการพัฒนา “รัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้า” ในระยะเวลาต่อมา

กองทุน RV เติบโตขึ้นและขยายสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เช่น การประกันชราภาพ (AOW, 1957) ที่ดูแลเรื่องเงินบำนาญและการประกันการทุพพลภาพ (WAO, 1967) ขณะที่สิทธิประโยชน์ด้านการดูแลระยะยาวได้รับการบรรจุอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1968 ภายใต้พระราชบัญญัติค่าใช้จ่ายทางสุขภาพในกรณีพิเศษ (Act on Exceptional Medical Expenses, AWBZ) ซึ่งครอบคลุมทั้งบริการทางการแพทย์และบริการทางสังคมสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงทั้งในสถานบริการและในชุมชน การประกาศกฎหมายนี้จึงทำให้เนเธอร์แลนด์กลายเป็นประเทศแรกของโลกที่มีระบบ “ประกันการดูแลระยะยาวถ้วนหน้า” โดยพฤตินัย (41)

ทว่า จุดเด่นของระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการของเนเธอร์แลนด์ที่อาจแตกต่างจากเยอรมนี คือ แม้จะเป็นระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันถูกดำเนินการผ่านบริษัทประกันเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งได้รับมอบหมายให้บริหารและจัดซื้อบริการภายใต้กรอบกฎหมายที่เข้มงวด โดยรัฐบาลเป็นผู้กำหนดกติกากำกับคุณภาพ และรับภาระความเสี่ยงทางการเงินโดยรวมแทนบริษัทเอกชน ทำให้เอกชนสามารถดำเนินงานได้โดยไม่ต้องกังวลต่อความเสี่ยงขาดทุน ขณะเดียวกันประชาชนก็ได้รับความคุ้มครองถ้วนหน้าโดยมีรัฐทำหน้าที่เป็นหลักประกันขั้นสุดท้าย

ความครอบคลุมของระบบนี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุของเนเธอร์แลนด์ใช้บริการดูแลสุขภาพและสวัสดิการของรัฐในสัดส่วนสูง ครอบครัวจึงมีบทบาทในการดูแลระยะยาวน้อยกว่าหลายประเทศในยุโรปในระยะแรก อย่างไรก็ดี ความสำเร็จดังกล่าวก็มาพร้อมกับภาระค่าใช้จ่ายขนาดใหญ่ โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนเธอร์แลนด์ใช้งบประมาณด้านการดูแลระยะยาว (LTC) สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก คิดเป็นกว่าร้อยละ 3 - 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (42) เพื่อรับมือกับปัญหาค่าใช้จ่ายและสร้างความยั่งยืนของระบบ รัฐบาลจึงได้ดำเนินการปฏิรูประบบ LTC ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.2015 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติ AWBZ เดิม และแบ่งความรับผิดชอบด้านการดูแลออกเป็นสามระบบหลัก ดังรูปที่ 16 (43) ได้แก่

1. Wet Langdurige Zorg (Wlz) (หรือ AWBZ เดิม) จะเป็นส่วนของผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและซับซ้อน เช่น ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ต้องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
2. Zorgverzekeringswet (Zvw) จะครอบคลุมครอบคลุมบริการพยาบาลและการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ของ Wlz
3. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ซึ่งมอบหมายให้เทศบาลรับผิดชอบการดูแลทางสังคม การช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมการใช้ชีวิตในชุมชน สำหรับกลุ่มประชากรที่ยังไม่มีภาวะพึ่งพิง



รูปที่ 16 การปฏิรูประบบหลักประกันการดูแลระยะยาวในเนเธอร์แลนด์
(Maarse & Jeurissen, 2016)

การปรับโครงสร้างนี้มีเป้าหมายเพื่อลดขอบเขตความคุ้มครองของรัฐในส่วนที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทมากขึ้นในกรณีที่ภาระการดูแลไม่รุนแรง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรผ่านการแข่งขันอย่างมีการกำกับจากภาคเอกชน ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากระบบรวมศูนย์ที่รัฐดูแลเกือบทั้งหมด ไปสู่ระบบ “บูรณาการ” ที่เน้นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างรัฐ ท้องถิ่น ครอบครัว และเอกชน โดยรัฐยังคงรับภาระในกรณีที่มีภาระหนักและค่าใช้จ่ายสูง เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณบานปลายเกินความสามารถทางการคลังของประเทศ

ดังนั้น สำหรับเนเธอร์แลนด์ จึงเห็นได้ว่ากลไกการปฏิรูปนโยบายนั้นเป็นการถ่ายโอนภาระในการดูแลระยะยาวกลับไปสู่ครอบครัวและปัจเจกมากขึ้น ดังนั้น ภายหลังการปฏิรูปจึงอาจทำให้สัดส่วนของการดูแลแบบไม่เป็นทางการสูงมากขึ้นในประเทศนี้

กรณีของเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ เป็นที่น่าสังเกตว่า ทั้งสองประเทศใช้ระบบการดูแลระยะยาวผ่านระบบประกันสังคม ซึ่งจัดหาเงินทุนผ่านการสมทบของผู้ประกันตน แตกต่างจากประเทศกลุ่มนอร์ดิกที่ใช้ระบบภาษีเป็น ซึ่งให้บริการผ่านหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลัก ในกรณีของประเทศที่ใช้ระบบประกันสังคม เช่น เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ งานวิจัยจำนวนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าการออกแบบระบบมักให้ความสำคัญกับกลไกการควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การ

กำหนดอัตราเงินสมทบและการจำกัดสิทธิประโยชน์บางประเภท (44) ในขณะที่ประเทศกลุ่มนอร์ดิกมีแนวโน้มพึ่งพาการจัดบริการโดยภาครัฐผ่านโครงสร้างของหน่วยงานท้องถิ่นมากกว่า อีกทั้ง ในระบบประกันสังคม ผู้ให้บริการภาคเอกชนมักมีบทบาทมากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศกลุ่มนอร์ดิกที่ภาครัฐมีบทบาทหลักในการให้บริการ (45) อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างด้านต้นทุนและโครงสร้างราคาของบริการระหว่างระบบที่ใช้ภาษีและระบบที่ใช้ประกันสังคมยังคงเป็นประเด็นที่ต้องการการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพิ่มเติมในอนาคต

สหรัฐอเมริกา (46)

หากพิจารณาตามบริบทประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศแรกที่มีการจัดตั้งระบบการดูแลระยะยาวในเชิงรูปธรรม โดยเฉพาะการดูแลในสถานบริการ (institutional LTC) ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมปี ค.ศ. 1935 และขยายความครอบคลุมผ่านการจัดตั้งโครงการ Medicare และ Medicaid ในปี ค.ศ. 1965 อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นสวัสดิการเฉพาะกลุ่ม (categorical welfare) โดยผู้ที่มีสิทธิใช้บริการส่วนใหญ่ต้องเป็นประชาชนรายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนด (mean-tested) อีกทั้ง Medicaid ในช่วงแรกยังครอบคลุมเฉพาะบริการในสถานพยาบาล ส่งผลให้ภาคธุรกิจบ้านพักคนชรา (Nursing home industry) เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 1970s และกลายเป็นภาระงบประมาณของรัฐในเวลาต่อมา(47)

ในปี ค.ศ. 1981 จึงได้แก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเพิ่มมาตรา 1915(c) เพื่ออนุญาตให้รัฐสามารถใช้เงินกองทุน Medicaid สนับสนุนบริการดูแลระยะยาวที่บ้านและในชุมชน (Home-and Community-Based Services: HCBS) แทนการให้บริการเฉพาะในสถานพยาบาล อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของอัตราค่าบริการระหว่างบริการในสถานพยาบาลและบริการในชุมชน รวมถึงข้อจำกัดด้านโครงสร้างและงบประมาณ ทำให้บริการส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในสถานบริการอยู่ดี (48)

ดังนั้น เมื่อพิจารณาการเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวในสหรัฐอเมริกานั้น จะพบว่าผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระยะยาวส่วนใหญ่มักพึ่งพาความช่วยเหลือที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากครอบครัวและเพื่อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาพรวมของการดูแลระยะยาวในระดับประเทศก็ยังมีมูลค่าสูง โดยแหล่งงบประมาณหลักมาจาก Medicaid และการจ่ายเงินด้วยตนเองของ

ผู้รับบริการ (out-of-pocket) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 และร้อยละ 26 ของค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลในสถานบริการและการดูแลที่บ้านในปี ค.ศ. 1998 ตามลำดับ โดยสองในสามของค่าใช้จ่ายด้านการดูแลระยะยาวถูกใช้ไปกับการดูแลในสถานบริการ

สำหรับ Medicare ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนด้านการดูแลระยะยาวทางอ้อมผ่านชุดสิทธิประโยชน์ที่มีขอบเขตจำกัด อาทิ การดูแลในสถานบริการเฉพาะทาง (Skilled Nursing Facility, SNF) และบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน ซึ่งบริการส่วนใหญ่เป็นการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะสั้น โดยครอบคลุมการดูแลได้นานสูงสุด 100 วันหลังจากการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยติดบ้านและต้องการการพยาบาลเฉพาะทางบางเวลาหรือบริการกายภาพบำบัด Medicare อาจจ่ายค่าบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน ซึ่งรวมถึงบริการดูแลส่วนบุคคลที่ให้โดยผู้ช่วยดูแลสุขภาพที่บ้านด้วย

ส่วน Medicaid นั้นจะมีบทบาทโดยตรงในการจัดหาเงินทุนสำหรับการดูแลระยะยาวให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย รวมถึงผู้ที่กลายเป็นผู้มีรายได้น้อยเนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนมากไปกับค่ารักษาพยาบาลหรือการดูแลระยะยาว ทั้งนี้ Medicaid นั้นครอบคลุมบริการการดูแลระยะยาวทั้งที่บ้านและในสถานบริการ โดยไม่จำเป็นต้องมีการดูแลทางการแพทย์ ซึ่งจะแตกต่างจาก Medicare ที่ไม่มีการคุ้มครองในลักษณะนี้

ตามระเบียบของรัฐบาลกลาง ผู้สูงอายุและผู้พิการมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จาก Medicaid หากมีรายได้และทรัพย์สินต่ำกว่าระดับที่กำหนด เช่น ในปี ค.ศ. 2000 กำหนดประชาชนจะได้รับสิทธิหากมีรายได้ไม่เกิน 532 ดอลลาร์ต่อเดือนและมีทรัพย์สิน (ไม่รวมที่อยู่อาศัย) ไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สำหรับบุคคลหนึ่งคน ทั้งนี้ รัฐส่วนใหญ่ยังอนุญาตให้บุคคลมีสิทธิได้รับ Medicaid ผ่านกลไกที่เรียกว่า “การพิจารณาความต้องการทางการแพทย์ (medically needy)” กล่าวคือ หากผู้ป่วยใช้รายได้และทรัพย์สินของตนไปกับค่าใช้จ่ายด้านการดูแลจนอยู่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด ก็จะสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จาก Medicaid ได้เช่นกัน

ในระบบการสนับสนุนในระดับรัฐนี้ รัฐบาลกลางของสหรัฐให้อิสระในการออกแบบโครงการการดูแลระยะยาวของตนเองและในการควบคุมการเข้าถึงบริการ โดยประการแรก รัฐแต่ละรัฐจะสามารถกำหนดระดับเกณฑ์คุณสมบัติในการรับสิทธิ (eligibility criteria) ได้เอง ประการที่สอง แม้ว่ารัฐจะต้องให้ความคุ้มครองบริการที่บ้าน แต่รัฐมีทางเลือกว่าจะให้บริการการดูแลส่วนบุคคล (personal care) หรือไม่ และรัฐสามารถกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสูงสุดได้

แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก็ตาม รวมทั้งสามารถกำหนดให้ขอบเขตของพื้นที่หรือกลุ่มประชากรเฉพาะได้ด้วย ประการที่สาม รัฐแต่ละรัฐยังสามารถกำกับและควบคุมจำนวนเตียงในสถานบริการได้โดยตรง และสามารถกำหนดอัตราค่าบริการที่จ่ายให้สถานบริการสำหรับผู้รับสิทธิ Medicaid ได้ด้วย

จากโครงสร้างของการสนับสนุนทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างของประเทศในกลุ่มที่ 3 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถึงแม้จะมีการคุ้มครองจากภาครัฐอยู่มาก แต่ด้วยกระบวนการกำหนดสิทธิการเข้าถึงที่มีข้อจำกัดอยู่มาก ทำให้ความครอบคลุมของบริการการดูแลระยะยาวมีอยู่อย่างจำกัด ทั้งนี้ อุดมการณ์หนึ่งที่สำคัญของประเทศกลุ่มนี้ คือ การให้ประชาชนดูแลตัวเองก่อน และรัฐสวัสดิการมีบทบาทเฉพาะในกรณีของประชาชนกลุ่มเปราะบางเท่านั้น

ระบบการดูแลระยะยาวในประเทศเอเชีย

กรณีศึกษาข้างต้นนั้นเป็นตัวอย่างจากประเทศตะวันตก ซึ่งอาจมีรากฐานทางวัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมที่แตกต่างกับประเทศไทย ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงนำตัวอย่างของประเทศในเอเชียบางประเทศมาศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมและความแตกต่างของระบบการดูแลระยะยาวในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้มากขึ้น

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในเอเชียที่สามารถจัดตั้งกองทุนประกันการดูแลระยะยาวเช่นเดียวกันกับเยอรมนี ซึ่งสามารถทำให้เกิดการให้บริการแบบถ้วนหน้าได้สำเร็จ และมักถูกยกเป็นตัวอย่างของ “การปรับตัวเชิงสถาบันต่อสังคมสูงวัย” ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบรัฐสวัสดิการแบบผสม (Hybrid Welfare Model) ระหว่างแนวคิดแบบยุโรปและเอเชียตะวันออก

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและวางรากฐานระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยในปี ค.ศ. 1961 ญี่ปุ่นประกาศใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Insurance: UHI) ทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐานได้ อย่างไรก็ตาม ระบบสวัสดิการของญี่ปุ่นในช่วงนั้นยังคงมีลักษณะ “ครอบครัวนิยมแบบตะวันออก (Oriental Familialism)” คือคาดหวังให้บุตรหลานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในบ้าน ขณะที่รัฐให้การช่วยเหลือเฉพาะรายที่ยากจนเท่านั้น

ภาวะประชากรสูงอายุเร่งตัวขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 - 1990 ส่งผลให้ครอบครัวจำนวนมากไม่สามารถแบกรับภาระการดูแลผู้สูงอายุได้เหมือนเดิม เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “การรักษาทางสังคม (social hospitalization)” ซึ่งผู้สูงอายุที่ไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลกลับถูกส่งเข้าโรงพยาบาลระยะยาวเพราะไม่มีคนดูแล ทำให้ค่าใช้จ่ายสุขภาพพุ่งสูงและเตียงผู้ป่วยล้นระบบ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเริ่มโครงการ “Gold Plan” ในปี ค.ศ. 1989 เพื่อพัฒนาบริการดูแลผู้สูงอายุ เช่น ศูนย์ดูแลกลางวัน การดูแลที่บ้าน และการฝึกอบรมผู้ดูแลมืออาชีพ (49) และหลังจากนั้น ญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 8 ฉบับในปี ค.ศ. 1990 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ (Act on Social Welfare for the Elderly) โดยกฎหมายดังกล่าวนำไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพที่สำคัญประกอบด้วย

(1) กฎหมายดังกล่าวได้ให้คำจำกัดความที่ชัดเจนของ “บริการในบ้าน (in-home welfare services)” ซึ่งเป็นบริการที่จะได้รับความสำคัญมากที่สุดเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระของผู้สูงอายุในชุมชน

(2) มีการถ่ายโอนอำนาจการบริหารจัดการบ้านพักคนชรา (Residential facilities) จากรัฐบาลจังหวัด (Prefectures) ไปยังเทศบาลท้องถิ่น (Municipalities) เพื่อจัดตั้งโครงสร้างการให้บริการสวัสดิการแบบบูรณาการและครอบคลุมทั้งในชุมชนและในสถานบริการ

(3) ได้กำหนดให้เทศบาลต้องจัดทำ “แผนด้านสุขภาพและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ (Health and welfare plans for the elderly)” เพื่อส่งเสริมมาตรการด้านสุขภาพและสวัสดิการของผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ดี การผลักดันให้เกิดบริการดังกล่าวนั้นพึ่งพางบประมาณภาษีและการบริหารระดับท้องถิ่นมากเกินไป ซึ่งกลายเป็นวิกฤตทางการคลังของญี่ปุ่นและนำไปสู่การตราพระราชบัญญัติประกันการดูแลระยะยาว (Long-term Care Insurance Act) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2000 ถือเป็นระบบประกันถ้วนหน้าระดับชาติแห่งแรกในเอเชียที่เน้น “สิทธิของพลเมืองมากกว่าการพึ่งครอบครัว” ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปต้องจ่ายเบี้ยสมทบเข้ากองทุน ส่วนเงินอีกครึ่งหนึ่งมาจากภาษี (แบ่งจ่ายระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐจังหวัด และเทศบาล) โดยผู้รับบริการต้องร่วมจ่ายร้อยละ 10 ของค่าบริการ และได้รับสิทธิตามระดับความพึ่งพิงที่ประเมินโดยคณะกรรมการท้องถิ่น

ระบบการดูแลระยะยาวของญี่ปุ่นเน้นการดูแลที่บ้านและในชุมชนมากกว่าการดูแลในสถานบริการ โดยมีบริการหลัก เช่น การเยี่ยมบ้าน การดูแลตอนกลางวัน การดูแลชั่วคราว และการดูแลแบบกลุ่มในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตในบ้านของตนเองให้นานที่สุด (aging in place) เทศบาลเป็นหน่วยบริหารหลักในการประเมินสิทธิและจัดสรรบริการ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างบริการสุขภาพ สังคม และท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

ในช่วงสองทศวรรษหลังจากนั้น ญี่ปุ่นได้ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับอัตราร่วมจ่ายตามรายได้ (2015) การขยายบริการชุมชนแบบ “ระบบการดูแลในชุมชนแบบรอบด้าน (Comprehensive Community Care System)” และการสนับสนุนเทคโนโลยีดูแล เช่น หุ่นยนต์ช่วยเคลื่อนไหวและระบบติดตามสุขภาพดิจิทัล แม้ว่าระบบ LTCI ของญี่ปุ่นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ยั่งยืนและครอบคลุมที่สุดในเอเชีย แต่ก็ยังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานดูแลและภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของ GDP และคาดว่าจะเพิ่มถึงร้อยละ 4 ภายในปี 2040)

อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นยังคงยึดหลัก “การแบ่งปันความรับผิดชอบระหว่างรัฐ ครอบครัว และประชาชน” ผ่านระบบประกันสมทบถ้วนหน้าและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางการคลังและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุในสังคมสูงวัยที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก (50)

เกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่เผชิญการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันกับญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลเกาหลีใต้จึงดำเนินยุทธศาสตร์จัดตั้งระบบการดูแลระยะยาวถ้วนหน้าตามประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยได้เปิดตัวระบบประกันการดูแลระยะยาวแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 เป้าหมายหลักคือเพื่อแบ่งเบาภาระการดูแลผู้สูงอายุที่แต่เดิมตกอยู่กับครอบครัวแต่เพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งรองรับการที่ครอบครัวขยายแบบดั้งเดิมเริ่มลดบทบาทลงในสังคมสมัยใหม่ ระบบการดูแลระยะยาวของเกาหลีใต้เป็นระบบประกันสังคมภาคบังคับที่แยกจากประกันสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับเยอรมนีและญี่ปุ่น อย่างไรก็ดี การบริหารงบประมาณนั้นเป็นบทบาทของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจะมีจัดเก็บเงินสมทบเพิ่มเติมจากประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสุขภาพตามรายได้ และรัฐบาลสมทบงบประมาณเพิ่มเติม

สำหรับด้านสิทธิประโยชน์ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (หรืออายุต่ำกว่าที่มีโรคเรื้อรังบางชนิด) จะสามารถขอรับการประเมินภาวะพึ่งพิง หากเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับบริการดูแลที่บ้าน เช่น ผู้ช่วยดูแล บริการเยี่ยมบ้าน หรือรับบริการในสถานบริการ เช่น สถานบริบาลผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐนั้นจะครอบคลุมประมาณร้อยละ 80 - 100 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขึ้นกับประเภทบริการ นั่นแสดงว่าผู้ใช้บริการมีการจ่ายร่วมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ดังนั้น เห็นได้ว่าแผนยุทธศาสตร์การดูแลระยะยาวของเกาหลีใต้มุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้สามารถเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพในราคาที่จ่ายได้ ลดการพึ่งพาการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น รวมถึงสร้างระบบการดูแลแบบเป็นทางการที่สามารถช่วยรองรับบทบาทการดูแลจากครอบครัวที่ถดถอยลง หลักฐานหลังดำเนินระบบมาร่วมสิบปีพบว่า การดูแลระยะยาวมีส่วนช่วยลดการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลระยะยาวที่ไม่จำเป็นลง เนื่องจากผู้สูงอายุได้รับบริการดูแลที่บ้านและชุมชนมากขึ้น ตลอดจนสร้างงานด้านผู้ดูแลจำนวนมากในภาคบริการการดูแลผู้สูงอายุ (51) อย่างไรก็ดี ความท้าทายในระยะถัดไปของเกาหลีใต้คือการขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการเฉพาะทาง เช่น การดูแลระยะสุดท้าย (end-of-life care) ที่ปัจจุบันยังขาดอยู่ ทำให้มีการเสนอแนวทางปรับปรุงการดูแลระยะยาวเพื่อเพิ่มบริการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในบ้านหรือในสถานดูแลภายใต้สิทธิประโยชน์การดูแลระยะยาวต่อไป(52)

ไต้หวัน

ไต้หวันเป็นอีกประเทศที่ดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนการดูแลระยะยาวระยะ 10 ปี ฉบับที่ 2 (Long-Term Care Plan 2.0) ในปี ค.ศ. 2017 ซึ่งนับเป็นการปฏิรูประบบการดูแลระยะยาวครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน (53) เดิมทีไต้หวันมีระบบการดูแลระยะยาวแบบถ้วนหน้าที่ใช้ระบบภาษีอยู่แล้ว แต่แผน 2.0 นี้เข้ามาขยายขอบเขตและความครอบคลุมของบริการให้กว้างขวางและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น เป้าหมายสำคัญของการดูแลระยะยาวในการปฏิรูปครั้งนี้คือการสร้าง บริการการดูแลระยะยาวแบบชุมชนเป็นฐาน (community-based LTC) ด้วยการเพิ่มงบประมาณและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ บริการเป้าหมายนั้นครอบคลุมตั้งแต่บริการดูแลที่บ้าน ศูนย์ดูแลกลางวันในชุมชน บริการสถานพักฟื้นระยะสั้น ตลอดจนสถานดูแลระยะยาวแบบอยู่ประจำสำหรับผู้ที่จำเป็น (54)

มาตรการในแผนนี้รวมถึงการจัดตั้ง “เครือข่ายบริการสามระดับ” ในทุกตำบล/เขต ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ดูแลหลัก ศูนย์ดูแลย่อย และจุดบริการดูแลในชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น(55) นอกจากนี้ยังปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนและค่าบริการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและสนับสนุนการใช้บริการตามความจำเป็นจริง เช่น ปรับเกณฑ์เงินช่วยเหลือให้ยืดหยุ่นตามระดับความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุแต่ละราย

จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการ แผนระยะยาว 2.0 ของไต้หวันสะท้อนถึงความพยายามในการแก้ไขจุดอ่อนเดิม เช่น การพึ่งพาผู้ดูแลที่เป็นแรงงานข้ามชาติ และการขาดการบูรณาการระหว่างระบบสุขภาพและสวัสดิการสังคม โดยแผนนี้จะสร้างระบบที่เป็นธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป แม้การดำเนินงานจะยังเผชิญความท้าทายบางประการ อาทิ งบประมาณที่จัดเก็บได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเต็มที่ในช่วงแรก แต่ถือได้ว่าไต้หวันได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการจัดบริการการดูแลระยะยาวที่ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับประเทศเอเชียอื่น ๆ ที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วเช่นกัน

กรอบการประเมินระบบการดูแลระยะยาวในต่างประเทศ

สำหรับการประเมินระบบการดูแลระยะยาว จะเห็นว่าหลายประเทศพยายามพัฒนาวิธีประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการดูแลระยะยาว โดยใช้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งด้านการบริหารจัดการ คุณภาพบริการ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ และความยั่งยืนของระบบ ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งแม้ว่าประเทศเหล่านี้จะมีวิธีการประเมินที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนากลไกติดตามและประเมินผลระบบการดูแลระยะยาวอย่างเป็นระบบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว และแน่นอนว่าสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตารางที่ 1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับการประเมินระบบการดูแลระยะยาวที่ใช้ในต่างประเทศ

ประเทศ	ตัวชี้วัดที่ใช้	ผลการประเมิน
ยุโรป (เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์) (56)	Transitional Care Assessment Tool in Long-Term Care (TCAT-LTC) โดยแบ่งออกเป็น - ตัวชี้วัดด้านการบริหารองค์กร: การสื่อสาร การส่งต่อข้อมูล การประสานงาน การให้ความร่วมมือจากคนไข้และ Caregiver - ตัวชี้วัดด้านการเงินของ โรงพยาบาล primary care และ long term care	การประเมินสามารถดำเนินการได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ และทำให้สามารถติดตาม ประเมินผลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบการดูแลระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านการดูแลภายในและระหว่างประเทศได้
อังกฤษ (57)	- Total Output / Total Input Ratio (traditional productivity) - Quality-adjusted output โดยใช้ดัชนีจาก ASCOT (Adult Social Care Outcomes Toolkit) - ASCS (Adult Social Care Survey) - ข้อมูลกิจกรรมและค่าใช้จ่าย (Activity & Expenditure data 2010 - 012)	การใช้วิธีปรับคุณภาพ (quality-adjusted) ส่งผลให้ผลลัพธ์ productivity เปลี่ยนจากค่าดั้งเดิม
ญี่ปุ่น (58)	**Standardized quality indicators for long-term care (QIs-LTC)** - เป็นการประเมินที่ให้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม - มีการใช้ตัวชี้วัด Unfavorable Health Outcomes (UHOs) เช่น “การเกิดการหกล้มจากการบาดเจ็บ” “ผู้รับบริการมีการหกล้มจากการบาดเจ็บภายใน 30 วันที่ผ่านมาหรือไม่”	QIs-LTC สามารถประเมินสภาพของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ในสถานพยาบาลที่บ้านสามารถประเมินคุณภาพของ LTC ในการทำงานประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ประเทศ	ตัวชี้วัดที่ใช้	ผลการประเมิน
โปรตุเกส (59)	Long-term Care Facilities (LTCF) - ระบุตัวชี้วัดคุณภาพที่ครอบคลุม โดยเน้นตัวชี้วัดทางคลินิก เช่น “แผลกดทับ” “การใช้ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท” และ “สมรรถภาพการทำงาน” พร้อมด้วยตัวชี้วัดเชิงโครงสร้าง เช่น “ปัญหาด้านบุคลากร” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดคุณภาพ	สอดคล้องกับความต้องการการดูแลที่ซับซ้อนของแพทย์ประจำบ้าน และข้อกังวลในอดีตที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย
เกาหลีใต้ (60)	LTC system performance assessment (LTCSPA) มีการวัด 3 domains - Coverage ความครอบคลุม: “อัตราความครอบคลุมของ LTCI” และ “ภาระทางการเงิน” - Quality คุณภาพ: “คุณภาพให้บริการ” และอีกประการหนึ่งคือ “การประสานงานและบูรณาการการให้บริการตามชุมชน” - Sustainability ความยั่งยืน: การจัดการทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบ การยอมรับของสาธารณ	แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลในเกาหลีจะค่อนข้างดี แต่การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และการสร้างตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่จำเป็นในการศึกษาก็ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย

โดยสรุป การศึกษาระบบการดูแลระยะยาวในระดับสากลสะท้อนให้เห็นว่า การออกแบบระบบสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยสามารถจำแนกออกเป็น 4 รูปแบบหลักตามระดับความครอบคลุม กลไกการคลัง และบทบาทของสถาบันทางสังคม ซึ่งความสำเร็จของแต่ละระบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประกาศสิทธิทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยไม่ต้องพึ่งพากลไกตลาด การอภิบาลระบบที่เน้นความชัดเจนของกรอบกฎหมายและการบูรณาการมิติสุขภาพและสังคมเข้าด้วยกัน และการกำหนดบทบาทของผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการผ่านมาตรการสนับสนุนเชิงนโยบายที่เข้มแข็งเพื่อไม่ให้ภาระการดูแลถูกผลักกลับสู่ครอบครัวโดยปริยาย

พัฒนาการของระบบในประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและเอเชียต่างมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากการดูแลที่เป็นภาระส่วนบุคคลไปสู่ “ภารกิจสาธารณะและความรับผิดชอบร่วมกันของสังคม” เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ซึ่งบทเรียนเชิงโครงสร้างเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับบริบทของประเทศไทยในบทต่อไป

บทที่ 4
แนวคิดและหลักการของระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย

เนื้อหาจากบทที่แล้วได้ทบทวนรูปแบบและพัฒนาการของระบบการดูแลระยะยาวในประเทศต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจแนวคิด หลักการ และรูปแบบการจัดบริการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและการเข้าสู่สังคมสูงวัยในบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านกลไกการอภิบาล ระบบการเงินการคลัง รูปแบบการจัดบริการ และบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บทเรียนจากประเทศเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวที่หลากหลาย รวมทั้งความท้าทายร่วมกันของหลายประเทศในการสร้างระบบที่มีความครอบคลุม มีคุณภาพ และมีความยั่งยืนในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม การออกแบบและพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่างกันตามบริบททางสังคม เศรษฐกิจ โครงสร้างระบบสุขภาพ และโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศนั้น ๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย บทนี้จึงมุ่งนำเสนอแนวคิดและหลักการของระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยพิจารณาทั้งในมิติของโครงสร้างนโยบาย กลไกการบริหารจัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในบริบทของประเทศไทย และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวิเคราะห์พัฒนาการและผลลัพธ์ของระบบดังกล่าวในบทถัดไป

การพิจารณาองค์ประกอบของระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย

ในการทำความเข้าใจโครงสร้างและกลไกของระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย บทนี้จะพิจารณาระบบดังกล่าวโดยอาศัยกรอบองค์ประกอบของระบบการดูแลระยะยาวที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ โดยสามารถจำแนกองค์ประกอบสำคัญของระบบออกเป็นหลายมิติ ได้แก่ การอภิบาลระบบ (governance) ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างนโยบายและการกำกับทิศทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเงินการคลัง (financing) ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งงบประมาณและกลไกการจัดสรรทรัพยากรสำหรับบริการดูแลระยะยาว กำลังคน (workforce) ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งในระบบสาธารณสุขและภาคชุมชนที่มีบทบาทในการให้บริการ รวมถึงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (medical products and technologies) ที่สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง การพิจารณาตามองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมของโครงสร้างและกลไกของระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทยได้อย่างเป็นระบบ และเอื้อต่อการทำความเข้าใจพัฒนาการของระบบดังกล่าวในบริบทของประเทศ

การอภิบาลระบบ

ในประเทศไทย มีกลไกการพัฒนานโยบายสำหรับผู้สูงอายุทั้งหมด 3 ระดับ กล่าวคือ ในระดับชาติ ระบบการดูแลระยะยาวอยู่ภายใต้การกำกับทิศของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกรรมการและเลขานุการ (61) และคณะกรรมการจะมอบหมายภารกิจไปยังกระทรวงต่าง ๆ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกำหนดให้มีหน่วยงานระดับพื้นที่ในระดับปฏิบัติการ โดยอาจสรุปบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลระยะยาวได้ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 หน่วยงานและบทบาทในระบบการดูแลผู้สูงอายุ

หน่วยงาน	บทบาทในระบบการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุข	การพัฒนารูปแบบบริการระยะยาว โดยได้จัดทำโครงการ Long-Term Care Operation Program (LTOP) ซึ่งเป็นแนวทางต้นแบบสำหรับการจัดบริการในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับตำบล พร้อมทั้งได้พัฒนามาตรฐานการดูแลและแบบประเมินภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในการคัดกรองและกำหนดประเภทการให้บริการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมบุคลากรในระดับชุมชนเพื่อให้สามารถให้บริการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการและกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อใช้ในการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของชุมชน ซึ่งถือเป็นแนวทางการดำเนินงาน LTC ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของผู้สูงอายุที่อยู่บ้านและอยู่ในภาวะพึ่งพิง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	การสนับสนุนโครงสร้างสังคมที่เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ LTC นอกจากนี้ยังได้จัดทำมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุและจัดตั้งบริการดูแลระยะสั้นในสถานสงเคราะห์ รวมถึงการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงที่อยู่อาศัย และการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานด้านผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่สำคัญ ได้แก่ การจัดสรรเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได การสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และการร่วมศึกษากลไกการดูแลภาวะพึ่งพิงร่วมกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงาน	บทบาทในระบบการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงแรงงาน	การพัฒนาหลักประกันทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในระยะยาว โดยดำเนินมาตรการด้านประกันสังคมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบผ่านมาตรา 33, 39 และ 40 รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้มีโอกาสทำงาน สร้างรายได้ และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านบทบาทวิทยากรในชุมชน ทั้งยังให้ความรู้แก่ประชากรวัยแรงงานในการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ	การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้สูงอายุ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังดำเนินนโยบายสนับสนุนโครงการพิเศษที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประเด็นการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัวและชุมชน

ทั้งนี้ แต่ละภาคส่วนก็มีแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการสำหรับการรองรับสังคมผู้สูงอายุของตัวเอง และแต่ละภาคส่วนก็มีสาระสำคัญที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เลือกแผนสำคัญเพื่อนำเสนอสาระสำคัญด้วยในโครงการนี้

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) (62) โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จัดอยู่ในฐานะ “แผนระดับที่ 2” ทำหน้าที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และเป็นกรอบกำกับการจัดทำแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบเวลาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570

หมุดหมายและกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับบริการผู้สูงอายุและ LTC

หมุดหมายที่ 4: ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

แผนพัฒนาชี้ให้เห็นพัฒนาการของบริการการแพทย์แก่ชาวต่างชาติ พร้อมระบุข้อควรระวังเรื่องผลกระทบต่อโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทย ซึ่งเชื่อมโยงกับการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังเหลื่อมล้ำ ภายใต้หมุดหมายนี้ แผนฯ กำหนด “เป้าหมายที่ 3” ให้ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยมีตัวชี้วัดสัดส่วนรายจ่ายสุขภาพของครัวเรือนต่อรายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 12 และวางแนวทางเสริม

ความพร้อมระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงการพัฒนาศักยภาพคนด้านแพทย์และสาธารณสุข และการลดผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาความพร้อมรับภัยคุกคามด้านสุขภาพ แม้จะไม่กล่าวถึงบริการ LTC อย่างชัดเจน แต่หมุดหมายนี้วางกรอบให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการและความพร้อมของระบบซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดูแลสุขภาพในระยะยาวของประชาชนสูงวัย

หมุดหมายที่ 9: ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสม

แผนพัฒนาระบุว่าหนึ่งในหมุดหมายหลักคือการทำให้ความคุ้มครองทางสังคม “เพียงพอเหมาะสม” ในระดับกลยุทธ์ย่อย แผนพัฒนาเน้นการปรับปรุงรูปแบบการจัดความคุ้มครองทางสังคมให้ทุกกลุ่มคนได้รับสวัสดิการบนฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยให้ประเมินผลมาตรการอย่างรัดกุม ปรับงบประมาณเพื่อตอบเป้าหมายการพัฒนา ส่งเสริมความคุ้มครองแบบร่วมจ่ายในกลุ่มที่มีศักยภาพ เปิดบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสวัสดิการ และจูงใจให้คนเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น ประเด็นนี้สัมพันธ์โดยอ้อมกับ LTC ซึ่งต้องอาศัยกลไกหลักประกันและสวัสดิการต่อเนื่องในระยะยาวตามหลักความยั่งยืนที่แผนฯ วางไว้

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (63)

แผนฉบับนี้เป็นแผนแม่บทระดับชาติที่กำหนดทิศทางการพัฒนาในหลายมิติ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุปรากฏชัดในประเด็น “การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต,” “การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี,” “พลังทางสังคม,” และ “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ประเด็น 11)

แผนแม่บทกำหนดให้คนไทยทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุล มีความมั่นคง ได้รับการคุ้มครองทางสังคม และนำไปสู่สังคมไทยที่ “เกิดดี อยู่ดี และแก่ดี” ภายใต้ประเด็นนี้มีแผนย่อย “การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ” ที่ระบุเป้าประสงค์ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและขับเคลื่อนประเทศ รวมทั้งส่งเสริมงานหลังเกษียณ การสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ และจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ แนวทางประกอบด้วยการสนับสนุนการ

มีงานทำของผู้สูงอายุ การส่งเสริมการออมและหลักประกันทางสังคมตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุควบคู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ทั้งนี้ แผนย่อยดังกล่าวระบุไว้เป็นองค์ประกอบเฉพาะภายใต้ประเด็น 11

การพัฒนาการเรียนรู้ (ประเด็น 12)

ในประเด็น "การพัฒนาการเรียนรู้" มีเป้าหมายย่อยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ โดยกำหนดให้ "ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอ และมีการยกระดับทักษะตลอดชีวิต" พร้อมตัวชี้วัดให้ "ดัชนีความยากจนหลายมิติของผู้สูงอายุ" ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5, 10 และ 15 ตามลำดับช่วงเวลาแผน ข้อนี้สะท้อนการมุ่งลดความเปราะบางด้านเศรษฐสังคมของผู้สูงอายุผ่านกลไกการเรียนรู้และทักษะตลอดชีวิตซึ่งเป็นฐานสำคัญของความสามารถในการพึ่งตนเองในระยะยาว

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (ประเด็น 13)

แผนแม่บทตั้งเป้าให้ "คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น" โดยใช้อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเป็นตัวชี้วัดที่ระดับไม่น้อยกว่า 72, 73 และ 75 ปี ตามช่วงเวลาในแผน ภายใต้ประเด็นนี้กำหนดแผนย่อยหลายด้าน ได้แก่ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย และการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ แผนย่อยด้านชุมชนระบุชัดว่ามุ่งเพิ่มจำนวน "ชุมชนสุขภาพดี" ผ่านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ มาตรการการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ การสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อเสริมสุขภาวะ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนก่อนดำเนินโครงการ นอกจากนี้ ส่วนบทนำของประเด็นนี้ยังย้ำการสร้างความรอบรู้และระบบสาธารณสุขมาตรฐานที่ประชาชนเข้าถึงได้ เพื่อพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และการลดโรคที่ป้องกันได้

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (ประเด็น 17)

แผนแม่บทกำหนดเป้าหมายให้คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น" โดยใช้ดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดที่ต้องลดลงตามช่วงเวลาแผน ในระดับแผนย่อย ยังระบุการบริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามความจำเป็น (รายบุคคล หมวด และรายพื้นที่) ครอบคลุมร้อยละ 100 เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม โดยเน้นกลุ่มคนจนเปราะบางทั่วประเทศ

แม้แผนแม่บทกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย การมีงานทำและหลักประกันของผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาวะผ่านชุมชน และการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ แต่เอกสารฉบับนี้ มิได้เป็นแผนเฉพาะด้าน LTC ของผู้สูงอายุโดยตรง และไม่ปรากฏรายละเอียดเชิงปฏิบัติการของรูปแบบบริการ LTC ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจึงมีลักษณะเป็น “กรอบสนับสนุน” ต่อระบบสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และหลักประกันที่เอื้อต่อการพัฒนาและบูรณาการบริการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวในระดับแผนรองลงไป (เช่น แผนปฏิบัติการและแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

3. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

แผนผู้สูงอายุแห่งชาตินับเป็นแผ่นแม่บทใหญ่ในการกำหนดทิศทางการคุ้มครองทางสังคมและการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ โดยแผนผู้สูงอายุนี้เป็นแผนระยะยาว 20 ปี โดยมีการเสนอแผนฉบับแรกในปี พ.ศ. 2524 โดยเป็นแผนที่กำหนดแนวทางในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ในแผนฉบับแรกมีการตั้งเป้าหมายในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถไปเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่การคัดกรองโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ ไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ทั้งนี้ แผนผู้สูงอายุฉบับแรกยังวางบทบาทครอบครัวเป็นผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุที่มีความต้องการการดูแลระยะยาว และให้บทบาทรัฐสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีที่พึ่งพิงเท่านั้น (64)

สำหรับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) นั้นเริ่มเน้นนโยบายการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนการเตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ทว่ามีการปรับแผนในช่วง พ.ศ. 2552 ซึ่งครอบคลุมการดูแลระยะยาวมากขึ้นในยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งส่งเสริมการจัดบริการทางสุขภาพและทางสังคมให้ผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน รูปธรรมของการปรับแผนในคราวนี้ คือ การจัดทำโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อสผ.) ขึ้นมา อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการดำเนินงานในช่วงแผนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) พบข้อจำกัดสำคัญ โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านการดูแลระยะยาวที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย เช่น ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเยี่ยมบ้านรายเดือนยังอยู่เพียงร้อยละ 38.7 สะท้อนถึงช่องว่างของระบบบริการในระดับพื้นที่และความจำเป็นในการขยายบริการให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อเสนอให้เร่งขับเคลื่อนระบบบริการการดูแลระยะยาวอย่างครอบคลุม โดยกำหนดมาตรฐานกลางของบริการ พัฒนากลไกติดตามประเมินผล และ

สร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อบริบทของสังคมสูงวัยอย่างแท้จริง (4)

4. ยุทธศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) (65)

ยุทธศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580" โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีกระบวนการจัดทำมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงาน และมีการประชุมเพื่อให้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนระดับชาติจนถึงระดับกรมสอดคล้องกัน โดยมีการประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 วิสัยทัศน์กำหนดให้ "ผู้สูงอายุมีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคงในทุกมิติและเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทย" พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประกอบด้วย การผลักดันนโยบายและมาตรการสวัสดิการ การเตรียมความพร้อมคนทุกวัย การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานบนฐานการคุ้มครองสิทธิ การพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบเกื้อหนุนเพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณะ และการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ของการการดูแลผู้สูงอายุ

แผนกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ การบูรณาการการขับเคลื่อนจากนโยบายสู่การปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมคนทุกช่วงวัย การพัฒนาระบบคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ โดยแจกแจงกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ดำเนินต่อเนื่องตามช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 วางกลยุทธ์เรื่องการเตรียมความพร้อมคนทุกวัย การส่งเสริมการมีงานทำและหลักประกันรายได้ การพัฒนาศักยภาพผ่านกลไกระดับพื้นที่ และการปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัย สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบุให้ขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติและสร้างระบบเพื่อคุ้มครองสิทธิในทุกพื้นที่อย่างเป็นขั้นตอน ด้านยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมผู้ประกอบการ และการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการ

องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการดูแลผู้สูงอายุ

1. **มาตรฐานการดูแลและการคุ้มครองสิทธิ** ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนยุทธศาสตร์กำหนดให้มีการผลักดันและขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานของสถานดูแล หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแล รวมทั้งการติดตามประเมินผลมาตรการดูแล นอกจากนี้ยังระบุการสร้างระบบเพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ทั่วถึงโดยพัฒนาและขับเคลื่อนทั้งในเขตเมืองและชนบท
2. **สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและระบบเกื้อหนุน** แผนยุทธศาสตร์กำหนดให้ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ และพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาคเอกชนและท้องถิ่น โดยนำแนวคิด Universal Design และการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) มาปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีงานทำและการเข้าถึงหลักประกันรายได้ การพัฒนาทักษะอาชีพก่อนวัยเกษียณ และการสร้างความเข้มแข็งของกลไกระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรมของชุมชน
3. **เทคโนโลยี ข้อมูล และกลไกระดับพื้นที่** แผนยุทธศาสตร์ระบุการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองและดูแลผ่านการมีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในระดับประเทศ โดยเน้นการบูรณาการและปรับปรุงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนการเสริมพลังครอบครัวและชุมชนให้เป็นกลไกระดับพื้นที่ในการดูแลผู้สูงอายุ

5. แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) (66)

แผนฉบับนี้จัดทำโดยความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุของประเทศ โดยสืบเนื่องจากแผนระยะที่ 2 และเชื่อมกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง แผนระดับปฏิบัติการฉบับนี้ครอบคลุม 15 ปี และแยกเป็น 2 ส่วนคือ แผนระยะเร่งด่วน 5 ปีแรก (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนระยะ 15 ปี พร้อมกำหนดมาตรการ แนวปฏิบัติ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเน้นผู้สูงอายุโดยรวมเป็นหลัก มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ LTC ทั้งเชิงระบบบริการชุมชน บริการที่บ้าน กลุ่มภาวะพึ่งพิง และตัวอย่างโครงการเฉพาะทาง

โครงสร้างแผนและกรอบตัวชี้วัดที่เชื่อมกับการดูแล

แผนปฏิบัติการแบ่งเป็นแผนปฏิบัติการย่อย 4 แผน โดยในส่วนที่เชื่อมกับการดูแลผู้สูงอายุและ LTC เอกสารกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสุขภาพไร้รอยต่อที่เชื่อมโยงปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิในทุกจังหวัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัว ร้อยละของผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและปลอดภัย และความพึงพอใจต่อระบบคมนาคม นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ด้านการลดการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นจากภาวะที่ควบคุมได้ด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) ซึ่งสะท้อนทิศทางลดภาระการรักษาในโรงพยาบาลและเสริมความเข้มแข็งบริการนอกสถานพยาบาล

ระบบบริการและเนื้อหาที่สัมพันธ์กับ LTC

แผนปฏิบัติการเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชนผ่านการจัดระบบดูแลและส่งต่อยามฉุกเฉิน การช่วยเหลือการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการเสริมศักยภาพครอบครัวผู้ดูแล แผนปฏิบัติการยังระบุให้พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและเปราะบาง นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างรูปแบบบริการ “ชุดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน” ในฐานะการให้บริการที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุที่สุขภาพอ่อนแอต้องการการพึ่งพา และการดูแลที่ซับซ้อนพร้อมทั้งสรุปแนวนโยบายระหว่างประเทศด้าน LTC เช่น การอุดหนุนบริการดูแลที่บ้านและบริการที่อยู่อาศัย ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีช่วยดูแลและโครงการสถานบริบาล

สภาพแวดล้อม การอยู่อาศัย และเป้าหมายเชิงปริมาณ

เอกสารกำหนดมาตรการและตัวชี้วัดเพื่อปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยตั้งค่าเป้าหมายร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับหรือมีการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมและปลอดภัย ไว้ที่ 30% ในช่วงปี 2566 - 2570, 40% ในช่วงปี 2571 - 2575 และ 50% ในช่วงปี 2576 - 2580 พร้อมกำหนดบทบาทของหน่วยงานหลักและภาคีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดแนวปฏิบัติ เช่น การปรับปรุงบ้านให้เหมาะกับคนทุกวัย การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และการจัดหาแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อการปรับปรุงที่พัก

โครงการ Preventive Long Term Care

ภาคผนวกของแผนเสนอตัวอย่างโครงการ “Preventive Long Term Care” โดยให้เหตุผลเชิงนโยบายว่าประชากรที่มีอายุยืนยาวขึ้นเผชิญความเสี่ยงโรคเรื้อรังและภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึ้น จึงต้องมีกิจกรรมเชิงป้องกันเพื่อลดการเจ็บป่วย ภาวะทุพพลภาพ และความต้อง LTC ซึ่งส่งผลต่อระบบ LTC ทั้งด้านกำลังคนและงบประมาณ โดยโครงการนี้สะท้อนความเชื่อมโยงเชิงป้องกันต่อระบบ LTC ในระดับประเทศที่แผนหยิบยกเป็นกรณีประกอบการดำเนินงาน

6. แผนปฏิบัติราชการ: แผนการบูรณาการเพื่อการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2566 - 2570) (67)

แผนฉบับนี้เป็นแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดทำโดยกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นกรอบบูรณาการงานสุขภาพผู้สูงอายุของส่วนกลางและพื้นที่ พร้อมกำหนดกลไกกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ (ตรวจเยี่ยม ประเมินผลตามรอบปี และเร่งรัดการดำเนินงานตามเป้าหมาย) โดยแผนแบ่งเป็น 5 แผนปฏิบัติราชการ ได้แก่ (1) การสร้างความรอบรู้และคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุทั่วถึงด้วยพลังเครือข่าย (2) การพัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์เพื่อบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญระดับสากล (3) การพัฒนาสวัสดิการสุขภาพ ความมั่นคงทางสุขภาวะ และวิถีสุขภาพในครัวเรือนและชุมชน (4) การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และระบบสารสนเทศสุขภาพเพื่อการจัดบริการ และ (5) การยกระดับประเทศเป็นศูนย์กลางการรักษาทางการแพทย์มูลค่าสูงเพื่อสร้างเศรษฐกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้แผนแต่ละส่วนมีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ และโครงการรองรับอย่างชัดเจน

นิยามและขอบเขต LTC ในแผน

แผนปฏิบัติราชการให้นิยามระบบ LTC ว่าเป็นการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ฟื้นฟู และเสริมความเข้มแข็งภาคีและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว กลุ่มเป้าหมายของโครงการ LTC คือ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่ง มีคะแนนความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) ≤ 11 รวมถึงการจำแนกกลุ่มติดบ้าน (ADL 5–11) และติดเตียง (ADL 0–4) โดยจะได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ที่จัดทำโดย Care Manager ร่วมกับ Caregiver บุคลากรสาธารณสุข และทีมสหวิชาชีพ

กลไกบริการเชิงพื้นที่และการบูรณาการเครือข่าย

แผนปฏิบัติราชการกำหนดกลไกระดับพื้นที่ผ่าน ทีมสหวิชาชีพ “ทีม 3 หมอ” และทีมหมอครอบครัว ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานด้านสังคมและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างบูรณาการ และสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาระบบบริการและเครือข่ายที่ไร้รอยต่อ การดำเนินงานมี รอบติดตาม 3, 6, 9, 12 เดือน โดยผู้ปฏิบัติงานประเมิน ADL และคัดกรอง 9 กลุ่มอาการ จัดทำ Care Plan ในระบบ Long Term Care (3C) เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกองทุน LTC ระดับตำบลพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณ พร้อมกำหนดเป้าหมายสัดส่วน Care Plan ที่ได้รับอนุมัติระดับตำบลในระดับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามช่วงรอบการติดตาม

เครื่องมือข้อมูลและการประเมินสุขภาพเพื่อเชื่อมโยงการดูแล

แผนปฏิบัติราชการระบุให้ใช้ การคัดกรอง 9 กลุ่มอาการผู้สูงอายุ ควบคู่กับ การประเมิน ADL เป็นระยะทุก 9 และ 12 เดือน และบันทึก พฤติกรรมสุขภาพผ่าน Blue Book Application เพื่อเชื่อมโยงสู่การจัดทำ Care Plan ในระบบ 3C ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับกำกับ ติดตาม และรายงานผลตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข แผนปฏิบัติราชการยังแนบเอกสารสนับสนุนหลายรายการ อาทิ คู่มือจัดทำ Care Plan ออนไลน์ ชุดแนวทางฝึกอบรม Care Manager และ Caregiver คู่มืออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โปรแกรมและคู่มือใช้งาน Long Term Care (3C) และ Blue Book เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในพื้นที่

ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สัมพันธ์กับ LTC และการดูแลผู้สูงอายุ

ในแผนปฏิบัติราชการ มีตัวชี้วัดหลักได้แก่ “ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan” ตั้งเป้าระดับ ร้อยละ 95 - 99 ตลอดช่วงแผน และกำหนดวิธีคำนวณอย่างชัดเจน (สัดส่วนผู้ที่มี Care Plan ได้รับอนุมัติ ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ LTC ทั้งหมด) นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าขยาย การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ จาก 1 ล้านคนจนถึง 5 ล้านคน ตลอดปีงบประมาณ 2566 - 2570 และเพิ่มสัดส่วนผู้สูงอายุที่มี แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ตามลำดับ ซึ่งเป็นฐานสำคัญต่อและลดความต้องการ LTC

Preventive Long Term Care และการคุ้มครองในครัวเรือน–ชุมชน

แผนเน้น “Preventive Long Term Care” โดยกำหนดให้ผู้สูงอายุที่ ADL ≥ 12 (กลุ่มติดสังคม) เข้าสู่กระบวนการคัดกรองความเสี่ยงและจัดทำ Wellness Plan รายบุคคล ผ่านระบบ

รายงานออนไลน์ของกรมอนามัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและชะลอการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง ขณะเดียวกัน ในแผนปฏิบัติการยังเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความสามารถของครอบครัวและชุมชน เช่น การพัฒนาโครงสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเปราะบางและพึ่งพิง และการเสริมทักษะสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน

การบริหารจัดการ กำกับติดตาม และความเชื่อมโยงงบประมาณ

แผนกำหนดให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เสนอและขออนุมัติ Care Plan ต่อคณะอนุกรรมการกองทุน LTC ระดับตำบล เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณดูแลระยะยาวจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านกองทุน LTC ระดับตำบล พร้อมกำหนดเป้าหมายร้อยละของ Care Plan ที่ได้รับอนุมัติ ในแต่ละรอบการติดตาม กลไกกำกับติดตามของแผนประกอบด้วยการตรวจเยี่ยม การประเมินตามรอบปี และการประเมินความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่กำหนด

7. แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงฉบับที่ 1

ภายหลังจากการเห็นความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อให้เกิดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จึงมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งแผนฉบับนี้ได้รับการรับรองจากทั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนในทางปฏิบัติเกิดขึ้นอย่างจริงจังในปีงบประมาณ 2559 เมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นครั้งแรก จำนวน 600 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 900 ล้านบาท และ 1,159.20 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ตามลำดับ

ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นั้น สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการกำลังคนในระบบการดูแลระยะยาวผ่านการถอดบทเรียนใน 25 อำเภอในมุมมองด้านการบริหารจัดการกำลังคน การเงินการคลัง และระบบบริการของการดูแลระยะยาว และขยายการครอบคลุมประชาชนทุกคนที่มีคะแนน ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 โดยไม่จำกัดอายุ และไม่จำกัดสิทธิ์ในปี พ.ศ. 2562 ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 มีการปรับการจัดสรรงบ จากเหมาจ่าย

ในอัตรา 5,000 บาท/คน/ปี เป็น 6,000 บาท/คน/ปี และยกเลิกจัดสรรหน่วยบริการประจำ และในปี พ.ศ. 2567 มีการเพิ่มการให้บริการในผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ป่วยระยะสุดท้าย การสนับสนุนเงินในกองทุนกองทุนตำบล และการสนับสนุนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการของผู้ดูแลในชุมชน (Caregiver)

จะเห็นได้ว่านโยบายขับเคลื่อนโครงการการดูแลระยะยาวในระยะแรกนั้นมุ่งเน้นหลักการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงถูกทอดทิ้งจากระบบการดูแลสุขภาพ (68) โดยรัฐบาลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเน้นการบูรณาการบริการสุขภาพและบริการสังคมในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวนี้ ร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและทีมหมอครอบครัว แนวทางนี้สะท้อนถึงความเชื่อว่าท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชนย่อมเข้าใจปัญหาและความต้องการได้ดีและจะช่วยให้ระบบการดูแลระยะยาวให้มีความยั่งยืนรองรับสังคมสูงวัยในอนาคตได้

ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระของแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การคัดกรองผู้สูงอายุ และพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน	
เป้าประสงค์	**แนวทางดำเนินงานหลัก**
ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองตามระดับภาวะพึ่งพิง เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการได้อย่างเหมาะสม และมีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมในทุกชุมชน	• พัฒนาเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การจำแนกภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ • อบรม อสม. และอผส. ให้สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานในการคัดกรองผู้สูงอายุ • จัดทำการสำรวจและประเมินผู้สูงอายุเชิงบูรณาการในพื้นที่ • พัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุสำหรับใช้ในการวางแผนบริการและสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาระบบบริการในชุมชนเพื่อการป้องกัน การดูแล และฟื้นฟูผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงกับระบบบริการในสถานบริบาล	
เป้าประสงค์	**แนวทางดำเนินงานหลัก**
ทุกพื้นที่มีระบบ LTC ผู้สูงอายุในชุมชนที่ครอบคลุม และมีระบบสนับสนุนรองรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	• พัฒนามาตรฐานหน่วยบริการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, day care, respite care และ community nursing home • พัฒนามาตรฐานบุคลากรและหลักสูตรการอบรม • จัดบริการดูแลเชิงรุกถึงบ้านและชุมชน • พัฒนาศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุ และ day care center ในระดับตำบล • พัฒนาระบบส่งต่อระหว่างบ้าน ชุมชน และสถานบริบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และชุดสิทธิประโยชน์	
เป้าประสงค์	**แนวทางดำเนินงานหลัก**
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมภายใต้ระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืนและเอื้อต่อการเข้าถึงบริการ	• พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์บริการ LTC ตามความจำเป็นของผู้สูงอายุ • ออกแบบระบบการคลังที่เหมาะสม เช่น รูปแบบการจ่ายค่าบริการ • จัดทำข้อเสนอการบูรณาการงบประมาณข้ามหน่วยงาน • ขยายกองทุนฟื้นฟูผู้พิการระดับจังหวัดให้ครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนากำลังคน	
เป้าประสงค์	**แนวทางดำเนินงานหลัก**
ระบบ LTC มีบุคลากรเพียงพอและมีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่	• ส่งเสริมให้ อปท. ชุมชน และเอกชนมีส่วนร่วมในการวางแผนกำลังคน • พัฒนาหลักสูตรและอบรมบุคลากร เช่น care assistant และ long-term care manager • ส่งเสริมการผลิต การจ้าง และสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรใน 3 ระดับ: o ระดับชุมชน (เช่น อสม., อผส.) o รพ.สต. (เช่น พยาบาล นักจิตวิทยา) o โรงพยาบาลชุมชนและศูนย์ (เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบำบัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้าง การจัดการความรู้ และการติดตามประเมินผล	
เป้าประสงค์	**แนวทางดำเนินงานหลัก**
มีองค์ความรู้ ระบบข้อมูล และกลไกการประเมินที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาและกำกับระบบบริการ LTC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	• ศึกษาและพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในมิติป้องกันและดูแล • วิจัยรูปแบบบริการและการบริหารจัดการกองทุนระดับต่าง ๆ • ศึกษารูปแบบการจ่ายค่าบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ • พัฒนาระบบการคลังระยะยาว (long-term care financing) • พัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานในระดับต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนากฎหมาย/ระเบียบ และการบริหารจัดการ	
เป้าประสงค์	**แนวทางดำเนินงานหลัก**
มีกฎหมาย ระเบียบ และการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนา ระบบ LTC อย่างยั่งยืน	• แก้ไขระเบียบสวัสดิการข้าราชการให้ครอบคลุมบริการ LTC ในชุมชน • กำหนดบทบาทของ อปท. ให้ชัดเจน พร้อมปรับระเบียบท้องถิ่นให้สอดคล้อง • ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริบาล และการให้บริการ LTC ที่บ้าน เพื่อยกระดับมาตรฐานและกำกับดูแล

8. แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงฉบับที่ 2

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ LTC สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้เข้าสู่ระยะที่สอง ภายใต้กรอบของ “แผนแม่บทการพัฒนาระบบ LTC สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2562 - 2565” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบที่ครอบคลุม มีคุณภาพ และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์ของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2

“ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะพึ่งพิงหรืออยู่ในภาวะพึ่งพิงทุกสิทธิ พึงได้รับการดูแลทั่วถึงอย่างมีประสิทธิผล (effective coverage) ตรงตามระดับความเสี่ยงหรือระดับการพึ่งพิง โดยอาศัยระบบ LTC ที่เน้นการดูแลที่บ้าน และส่งเสริมบทบาทของผู้ดูแลในครอบครัว เพื่อนบ้าน ร่วมกับการดูแลของภาคส่วนต่าง ๆ”

วัตถุประสงค์เฉพาะของแผนแม่บทฯ

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง และมีระบบส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และ LTC ที่บ้านและในชุมชน ตามระดับความจำเป็นในการดูแล ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
2. เพื่อจัดให้มีระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างครบวงจร
3. เพื่อให้ชุมชนมีระบบสนับสนุนที่เข้มแข็งในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้สามารถอยู่อาศัยในครอบครัวได้อย่างมีความสุข
4. เพื่อให้สถานพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและในชุมชนอย่างเป็นระบบ

หลักการสำคัญที่ใช้ในการดำเนินงาน

1. ผู้สูงอายุทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงหรือมีความเสี่ยง ต้องสามารถเข้าถึงบริการที่เหมาะสม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. ทุกพื้นที่ควรมีระบบ LTC ที่เชื่อมโยงด้านสุขภาพและสังคมอย่างทั่วถึง และมีการบูรณาการระหว่างบ้าน ชุมชน สถานบริบาล และสถานพยาบาล
3. ท้องถิ่นมีบทบาทในการบริหารจัดการ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการ LTC ในพื้นที่
4. ต้องมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผล เพื่อเชื่อมโยงและบริหารจัดการการจัดบริการดูแลในทุกระดับ
5. ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนเชิงโครงสร้างต่อบทบาทของท้องถิ่นในการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ
6. ควรมีกองทุนในระดับพื้นที่ที่บูรณาการแหล่งเงินจากหลายภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืนในระยะยาว

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวฉบับที่ 2

แผนแม่บทการพัฒนาระบบ LTC สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2562–2565 ได้สานต่อจากแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรก โดยยังคงเนื้อหาเดิมไว้หลายส่วนแต่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านมุ่งเน้นให้เกิดระบบการดูแลที่มีคุณภาพ ยั่งยืน และครอบคลุมผู้สูงอายุทุกกลุ่มในทุกพื้นที่ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขยายความครอบคลุมบริการ LTC ในชุมชน	
เป้าประสงค์	**มาตรการสำคัญ**
ให้ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงหรือมีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการอย่างทั่วถึงและตรงตามระดับความจำเป็น	• ขยายงบประมาณบริการ LTC ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพทุกสิทธิ • ส่งเสริมให้ อปท. ตั้งงบเพื่อสนับสนุนบริการด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม • จัดทำฐานข้อมูลและคัดกรองความเสี่ยง เช่น การหกล้ม ภาวะสมองเสื่อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาระบบการดูแลแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	
เป้าประสงค์	**มาตรการสำคัญ**
ทุกพื้นที่มีระบบบริการที่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ	• พัฒนามาตรฐานการจัดบริการของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต • จัดตั้งศูนย์ในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน • จัดทีมหมอครอบครัวและบริการ home ward โดยทีมสหวิชาชีพ • จัดให้มีบริการพักดูแลชั่วคราว (respite care)

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อความยั่งยืน	
เป้าประสงค์	**มาตรการสำคัญ**
ให้มีระบบการสนับสนุนด้านการเงินที่ยั่งยืนและสร้างแรงจูงใจให้เกิดบริการที่เหมาะสม	• ทบทวนสิทธิประโยชน์และแนวทางการให้บริการ • พัฒนาแบบแผนการจ่ายเงินที่สนับสนุนการบริการแบบบูรณาการ • สนับสนุนการระดมทุนจากชุมชน • บูรณาการแหล่งเงินจากภาครัฐและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนากำลังคนในระบบ LTC	
เป้าประสงค์	**มาตรการสำคัญ**
ให้มีบุคลากรที่มีความรู้และศักยภาพเพียงพอรองรับความต้องการแรงจูงใจให้เกิดบริการที่เหมาะสม	• พัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลในชุมชน เช่น CG, CM และ Family Care Giver • จัดอบรมเชิงลึก และระบบ coaching เพื่อพัฒนาและติดตามคุณภาพ บูรณาการแหล่งเงินจากภาครัฐและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้าง การจัดการความรู้ และการติดตามประเมินผล	
เป้าประสงค์	**มาตรการสำคัญ**
มีข้อมูลและองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาระบบและประเมินประสิทธิผลได้จริง	• พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการทั้งแนวราบและแนวดิ่ง • คาดการณ์จำนวนผู้มีภาวะพึ่งพิงในระยะ 20 ปี • ศึกษาและประเมินประสิทธิผลของการให้บริการ และแหล่งทุนทางเลือกใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การแก้ไขกฎหมายและระเบียบ	
เป้าประสงค์	**มาตรการสำคัญ**
มีกฎหมายและระเบียบที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลในชุมชน	• ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการจัดบริการระยะยาวในชุมชน • ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุน (PPP) และอำนาจหน้าที่ของ อปท.

ทั้งนี้ สำหรับแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นได้ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขึ้นมาในระดับพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งสำหรับประเทศไทยแนวทางการจัดระบบการดูแลระยะยาว (LTC) ที่เหมาะสมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ (1) การใช้โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสุขภาพเป็นศูนย์กลาง แนวทางนี้มีข้อดีคือสามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันที เนื่องจากไทยมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำเป็นต้องเชื่อมโยงทั้งด้านสาธารณสุขและสังคมเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากในระยะยาว อีกทั้งยังต้องใช้งบประมาณสูง โดยเฉลี่ยประมาณ 146,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกินศักยภาพของงบประมาณภาครัฐ (2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการดูแล แนวทางนี้มีความเหมาะสมมากกว่าในบริบทของไทย เนื่องจากผู้สูงอายุติดบ้านหรือติดเตียงมักอาศัยอยู่ภายในชุมชนหรือครอบครัวอยู่แล้ว ทำให้สามารถใช้กลไกของท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและให้การสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (29)

ซึ่งในปัจจุบัน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน ขณะเดียวกันชุมชนเองก็มีทรัพยากรบุคคลที่สามารถมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุได้ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) อาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (อผก.) รวมถึงผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุซึ่งมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่เหมาะสม

ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์นั้นได้กำหนดองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับพื้นที่ ได้แก่ ประธานอนุกรรมการ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย และอนุกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ สาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐในพื้นที่ ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นต้น โดยองค์ประกอบนี้ได้สะท้อนความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในระดับพื้นที่

โดยแบ่งบทบาทของหน่วยงานออกเป็น (1) หน่วยบริการ สถานบริการ หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจะมีบทบาทหลักในการจัดบริการเชิงรุก/บริหารการจัดบริการ ตรวจคัดกรอง ตรวจประเมินความต้องการดูแลความต้องการผู้สูงอายุ และ (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่ประสานงานกับผู้จัดการระบบบริการ ประสานความร่วมมือกับทีมหมอครอบครัวของหน่วยบริการและเครือข่ายบริการปฐมภูมิในพื้นที่ ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยบริการและเครือข่ายบริการปฐมในพื้นที่

การเงินการคลัง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ริเริ่มโครงการ LTC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยทดลองดำเนินงานในพื้นที่กองทุนท้องถิ่นที่สมัครใจเข้าร่วม จัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่าย (capitation) 6,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งแบ่งจ่ายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(อปท.) จำนวน 5,000 บาท และจัดสรรให้หน่วยบริการประจำดำเนินการคัดกรอง 1,000 บาท โดยมุ่งเป้าผู้สูงอายุสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีคะแนนการทำกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living: ADL) ≤ 11 คะแนน และให้บริการตามกรอบชุดสิทธิประโยชน์ ผู้จัดการการดูแล (Care Manager: CM) ผู้ดูแล (Care Giver: CG) และแผนการดูแล (Care plan)

ในปี พ.ศ. 2563 ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกกลุ่มอายุและทุกสิทธิประกันสุขภาพ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ LTC อย่างทั่วถึง ปีถัดมา (พ.ศ. 2564) ปรับโครงสร้างงบเหมาจ่าย อปท. เพิ่มจาก 5,000 เป็น 6,000 บาทต่อคนต่อปี และยกเลิกการจัดสรรงบคัดกรองแยกต่างหากให้รวมอยู่ในงบเหมาจ่ายของ อปท.

ต่อมาในปี พ.ศ. 2566 เปลี่ยนเกณฑ์การจ่ายงบเหมาจ่ายจากการนับจำนวนผู้ลงทะเบียนสู่การจ่ายตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติแผนการดูแล (Care plan) และในปี พ.ศ. 2567 ปรับอัตราเหมาจ่ายเป็น 10,442 บาทต่อคนต่อปี ขยายบริการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินสมทบจาก สปสช. สำหรับบริการ LTC และบริการอื่น ๆ พร้อมเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสมทบต้นทุนการให้บริการด้วยกัน

โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพการพัฒนาการจัดการบริการได้ดังรูปที่ 17



รูปที่ 17 แผนภาพการพัฒนาการจัดการบริการ LTC สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

งบประมาณและแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (69) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนจำนวน 2,769.5540 ล้านบาท โดยใช้ระบบงบประมาณแบบมีเพดาน (Global budget) ภายใต้วงเงินงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

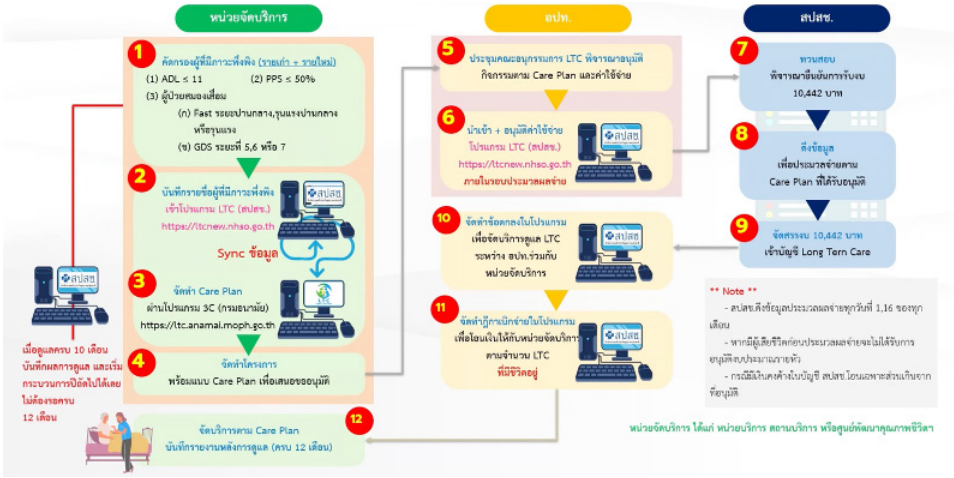
ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน พ.ศ. 2567 ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง ผู้รับบริการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่มีคะแนนการประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน
2. ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการประเมินระดับผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Performance Scale ; PPS) เท่ากับหรือน้อยกว่า 50%
3. ผู้ป่วยสมองเสื่อมตามการประเมินระยะของภาวะสมองเสื่อม ดังต่อไปนี้
   3.1) Functional Assessment Staging Test (FAST) ระยะปานกลาง ระยะรุนแรงปานกลาง หรือระยะรุนแรง หรือ
   3.2) Global Deterioration Scale (GDS) ระยะที่ 5 ระยะที่ 6 หรือระยะที่ 7

ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน พ.ศ. 2567 มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนดังนี้

1. กรณีหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านสถานชีวาภิบาล จะได้รับการจ่ายเงินสนับสนุนตามแผนการดูแล (Care plan) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะทำงานของหน่วยบริการ หรือจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการในพื้นที่ โดยจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายในอัตรา **ไม่เกิน 10,442 บาทต่อคนต่อปี**

2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติแผนการดูแล (Care plan) โดยจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายในอัตรา **ไม่เกิน 10,442 บาทต่อคนต่อปี** เช่นเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณแสดงในรูปที่ 18



รูปที่ 18 ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการ LTC ที่ สปสช. จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567

กลไกการจ่ายเงินไปยังหน่วยบริการและ CG

รูปแบบการจ่ายเงินเพื่อจัดบริการ LTC ที่จ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเหมาจ่าย 10,442 บาทต่อคนต่อปี ให้กับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้าร่วมจัดบริการ LTC ซึ่งงบประมาณเหมาจ่ายนี้จะรวมค่าตอบแทน CG ค่าวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ หลังจากได้รับงบประมาณเหมาจ่ายนี้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงในแผนการดูแล (Care plan) รายละเอียดการบริหารระบบแสดงในรูปที่ 19 โดยแบ่งเป็นรูปแบบการจ่ายเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. การจ่ายค่าบริการให้กับโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้รับเข้าเป็นเงินบำรุงโรงพยาบาล และใช้ระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขในการพิจารณาจ่ายงบประมาณ ในส่วนจ่ายค่าตอบแทน CG หาก CG ดูแลผู้ป่วย 1-4 คน ให้จ่าย 600 บาทต่อเดือนและหาก CG ดูแลผู้ป่วย 5-10 คน ให้จ่าย 1,500 บาทต่อเดือน

2. การจ่ายค่าบริการให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนภารกิจ รวมถึงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จะมีการจ่ายโดยอาศัยประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริหารจัดการโดยคณะกรรมการศูนย์ ในส่วนการจ่ายค่าตอบแทน CG จะจ่ายค่าตอบแทน CG ตามจริงตามค่าแรงขั้นต่ำ หรือตามคณะกรรมการบริหารศูนย์ หรือตามที่กำหนดระเบียบในระเบียบศูนย์



รูปที่ 19 กรอบการการจ่ายเงินเพื่อจัดบริการ LTC ที่จ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567

ค่าใช้จ่ายสำหรับ LTC

LTC ในระดับครัวเรือนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีองค์ประกอบค่าใช้จ่ายหลักสามส่วน ได้แก่ ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง ค่าตอบแทนบุคลากร CG และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ CG และ CM โดยหลักฐานเชิงประจักษ์จากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI) (พ.ศ. 2560) ชี้ให้เห็นว่าภาระค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนแตกต่างกันตามระดับการพึ่งพิง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างประชากรสูงอายุที่ขยายตัวต่อเนื่อง (70)

ในมิติของ “ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง” ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,829 บาทต่อเดือน แยกเป็นค่าอุปกรณ์ 587 บาท และค่าวัสดุสิ้นเปลือง 3,242 บาท ขณะที่กลุ่มติดบ้านมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,767 บาทต่อเดือน แยกเป็นค่าอุปกรณ์ 191 บาท และค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2,576 บาท รายละเอียดเชิงรายการปรากฏในตารางที่ 3 และ 4 และสามารถสรุปภาพรวมเพื่อการสื่อสารเชิงนโยบายได้ดังรูปที่ 20 ซึ่งแสดงองค์ประกอบค่าใช้จ่ายรายเดือนจำแนกตามระดับการพึ่งพิง

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำหรับการดูแลระยะยาวที่บ้าน

อุปกรณ์	ราคาเฉลี่ย (บาท)	อายุการใช้งาน (ปี)	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
กลุ่มติดเตียง			
รถเข็น	3,200	5	53
เตียงผู้ป่วย	15,500	6	215
เบาะนอน/ที่นอนลม-น้ำ/ป้องกันแผลกดทับ	4,600	2	192
ผ้ายาง	850	1	71
โต๊ะคร่อมเตียง	4,000	6	56
รวม			**587**
กลุ่มติดบ้าน			
ไม้เท้าสามขา/ขาเดียว	502	3	14
โครงจับให้เพิ่มความมั่นคงเวลาเดิน	513	5	9
รถเข็น	3,200	5	53
เก้าอี้นั่งถ่าย	2,683	5	45
เตียงนอน	1,300	7	15
เบาะนอน	1,990	3	55
รวม			**191**

ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการดูแลระยะยาวที่บ้าน

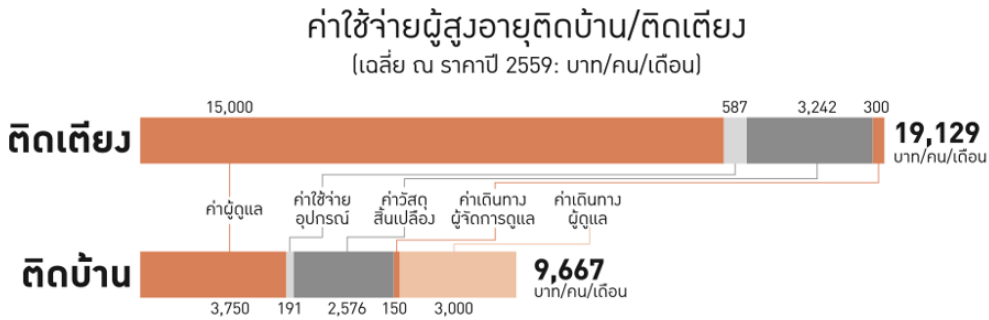
อุปกรณ์	ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย (บาท)	จำนวนที่ใช้เฉลี่ยต่อสัปดาห์	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
กลุ่มติดเตียง			
แผ่นรองซับ	8.17	13.3	468
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่	15.27	20.1	1,320
กระดาษชำระ	11.58	6.1	305
สำลี	0.11	1,542.9	735
สำลีพันไม้	0.80	120.2	414
รวม			**3,242**
กลุ่มติดบ้าน			
แผ่นรองซับ	8.17	10.4	367
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่	15.27	19.4	1,273
กระดาษชำระ	11.58	5.0	249
สำลี	0.11	900.0	429
สำลีพันไม้	0.80	75.0	258
รวม			**2,576**

สำหรับ “ค่าตอบแทนบุคลากร CG” ซึ่งครอบคลุมการช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันและงานบ้าน การศึกษาประเมินความต้องการดูแลของผู้สูงอายุติดบ้านเฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง 20 นาที หรือราว 100 ชั่วโมงต่อเดือน โดยใช้อัตราค่าตอบแทน CG ขั้นพื้นฐาน 37.50 บาทต่อชั่วโมง (คำนวณจากค่าจ้างขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน ณ พ.ศ. 2560 หารเทียบชั่วโมงทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ตลอด 30 วัน) ได้ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,750 บาทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มติดเตียงพบว่าค่าบุคลากรเป็นองค์ประกอบต้นทุนหลัก และสะท้อนอยู่ในค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนที่สูงกว่ากลุ่มติดบ้านอย่างมีนัยสำคัญ

ด้าน “ค่าใช้จ่ายการเดินทาง” แบ่งเป็นค่าเดินทางของ CM และของ CG ที่ออกเยี่ยมบ้าน โดยกำหนดเหมาจ่ายสำหรับ CM ครั้งละ 150 บาท ภายในรัศมี 30 กิโลเมตรจากหน่วย

บริการต้นสังกัด ในทางปฏิบัติ กลุ่มติดบ้านได้รับการเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง (150 บาทต่อเดือน) ส่วนกลุ่มติดเตียงเดือนละ 2 ครั้ง (300 บาทต่อเดือน) ขณะเดียวกัน CG ในชุมชนที่เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านทุกวันได้รับเหมาจ่ายครั้งละ 100 บาท ภายในรัศมี 20 กิโลเมตร คิดเป็นราว 3,000 บาทต่อเดือน เมื่อนำมารวมกัน ค่าเดินทางของกลุ่มติดบ้านจึงเฉลี่ย 3,150 บาทต่อเดือน (CG 3,000 บาท และ CM 150 บาท) ขณะที่กลุ่มติดเตียงเฉลี่ย 300 บาทต่อเดือนจากการเยี่ยมของ CM (ดูรูปที่ 21)

จากองค์ประกอบข้างต้น เมื่อนำมารวมเป็น “ค่าใช้จ่ายรวมรายเดือน” พบว่า กลุ่มติดเตียงมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 19,129 บาทต่อคนต่อเดือน แยกเป็นค่าบุคลากร 15,000 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,829 บาท และค่าเดินทาง 300 บาท ส่วนกลุ่มติดบ้านมีค่าใช้จ่ายรวม 9,667 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย CG และค่าเดินทาง 6,750 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,767 บาท และค่าเดินทางของ CM 150 บาท ตามรายละเอียดในรูปที่ 22 (ตารางที่ 3-11) โดยภาพรวมชี้ชัดว่าค่าตอบแทนบุคลากรเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายหลักของทั้งสองกลุ่ม และเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของภาระต้นทุน



รูปที่ 20 แสดงค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง

การประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับ LTC

ในระดับมหภาค การประมาณการค่าใช้จ่าย LTC ช่วง พ.ศ. 2560 - 2590 อาศัยจำนวนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงคูณด้วยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายเดือนต่อคนในแต่ละองค์ประกอบ (อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง บุคลากร และการเดินทาง) คูณ 12 เดือน พร้อมปรับตามอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 ต่อปี (อ้างอิงค่าเฉลี่ย พ.ศ. 255 - 2558) ผลการประมาณการบ่งชี้ว่า

ภาระค่าใช้จ่ายรวมของประเทศจะเพิ่มจากประมาณ 60,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 เป็น 340,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2590 หรือเพิ่มขึ้นราว 5 เท่าภายใน 30 ปี ทั้งที่จำนวนผู้สูงอายุติดบ้านมีมากกว่า แต่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มติดเตียงสูงกว่ามาก จึงทำให้ภาระรวมของกลุ่มติดเตียงยังคงสูงกว่าในทุกช่วงปี แสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของไทย ในปี พ.ศ. 2560 - 2590

ปี	กลุ่มติดเตียง (ล้านบาท)	กลุ่มติดบ้าน (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
2560	32,001	27,842	59,843
2565	43,761	38,277	82,038
2570	59,716	51,549	111,265
2575	80,696	69,188	149,884
2580	108,292	92,523	200,815
2585	143,746	122,043	265,788
2590	184,358	155,838	340,196

ข้อมูลสถานการณ์ปีฐาน พ.ศ. 2560 ระบุว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุติดบ้าน 235,301 คน และติดเตียง 136,677 คน โดยคาดว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.3 เท่าภายใน 30 ปีข้างหน้า ขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของกลุ่มติดเตียงและติดบ้านอยู่ที่ 19,129 บาท และ 9,667 บาทตามลำดับ ตัวเลขดังกล่าวตอกย้ำประเด็นเชิงนโยบายว่าการบริหารกำลังคน LTC การคุ้มครองด้านอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง และการออกแบบรูปแบบการเยี่ยมบ้านที่มีประสิทธิภาพ ล้วนเป็นคันโยกสำคัญในการควบคุมต้นทุนโดยไม่ลดทอนคุณภาพบริการ

ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของผู้ป่วยระยะท้าย

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ระบุว่าร้อยละ 82 ของผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั่วโลกมีสาเหตุมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตทั้งหมด (ร้อยละ 53) มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลระยะท้ายหรือการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ซึ่งความต้องการดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากผู้ป่วยหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิตเอง (71)

ค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะท้ายที่บ้าน

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านในช่วง 30 วันสุดท้ายของชีวิต โดยเฉพาะในกรณีผู้ป่วยโรคมะเร็ง พบว่ามีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลี่ยเดือนละ 2,787 บาท ซึ่งอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน (ประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน) ที่นอน และเครื่องพ่นยา ตามลำดับ ดังตารางที่ 6 (70)

ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านอุปกรณ์ของผู้ป่วยระยะท้าย

รายการอุปกรณ์	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/เดือน/ผู้ป่วย)
1. เตียงผู้ป่วย	243
2. ที่นอนลม/น้ำ ป้องกันแผลกดทับ	382
3. ผ้ายาง	100
4. โต๊ะคร่อมเตียง	65
5. เครื่องผลิตออกซิเจน	994
6. เครื่องดูดเสมหะ	231
7. เครื่องให้ยา (Syringe driver)	295
8. เครื่องปั่นอาหาร	55
9. เครื่องพ่นยาพร้อมอุปกรณ์	285
10. รถเข็น	137
รวม	**2,787**

ในส่วนของวัสดุสิ้นเปลือง มีรายการใช้งานทั้งหมด 19 รายการ คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ย 7,835 บาทต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์เกือบสามเท่า วัสดุสิ้นเปลืองที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เข็มฉีดยาแบบแก้ว และแผ่นรองซับ ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านวัสดุสิ้นเปลืองของผู้ป่วยระยะท้าย

อุปกรณ์	จำนวนหน่วย	ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย	จำนวนเฉลี่ยต่อสัปดาห์	ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
1. แผ่นรองซับ	10	8.17	26	913
2. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่	10	15.27	23	1,510
3. กระดาษชำระ	12	11.58	7	349
4. สำลีก้อน	1,200	0.11	171	81
5. สำลีพันไม้อ้วน	100	0.80	94	323
6. สาย oxygen	1	32.50	2	280
7. ผ้า gauze ทำแผล	100	0.75	107	345
8. พลาสเตอร์ม้วน	1	20.00	2	172
9. สายให้อาหาร และน้ำ*	1	25.00	1	108
10. top gauze (4"x6")	50	3.90	28	470
11. syringe แก้วให้อาหาร (50 มล)*	1	225.00	1	968
12. สายดูดเสมหะ	100	3.80	41	670
13. ลูกสูบยางแดง (30 มล)*	1	55.00	1	237
14. ถุงมือ	100	1.38	31	183
15. ผ้าปิดจมูก	20	7.00	9	271
16. เข็ม butterfly	50	9.00	1	39
17. แผ่นแปะใช้กับ syringe driver	10	26.00	3	335
18. หลอดน้ำงอได้	200	0.15	18	11
19. สำลีม้วน (ม้วนใหญ่ 450 กรัม)	1	133.00	1	572
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านวัสดุสิ้นเปลืองของผู้ป่วยระยะท้ายต่อเดือน				**7,835**

การให้การดูแลที่บ้านอย่างเหมาะสมจำเป็นต้องมี CG ที่มีทักษะเฉพาะด้าน ทั้งในด้านการจัดการความเจ็บปวดและการดูแลตามอาการของโรค โดยพิจารณาจากบริบทตลาดแรงงานของประเทศไทย ค่าตอบแทนขั้นต่ำของ CG อยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับค่าตอบแทนของแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

นอกจากนี้ การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายยังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมประคับประคอง เพื่อให้บริการทางคลินิก ให้คำแนะนำแก่ CG และจัดการอาการเฉพาะด้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญคิดเป็นแบบเหมาจ่ายครั้งละ 150 บาท โดยในช่วงเดือนสุดท้ายของชีวิต ผู้เชี่ยวชาญจะเข้าเยี่ยมบ้านผู้ป่วยรวม 5 ครั้ง ได้แก่ สัปดาห์ละ 1 ครั้งในช่วง 3 สัปดาห์แรก และ 2 ครั้งในสัปดาห์สุดท้ายก่อนเสียชีวิต รวมค่าเดินทาง 750 บาทต่อเดือน (150 บาท × 5 ครั้ง)

โดยสรุป ค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านในช่วง 30 วันก่อนเสียชีวิต อยู่ที่ 26,372 บาทต่อรายต่อเดือน แบ่งเป็นค่าตอบแทน CG 15,000 บาท ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 10,622 บาท (วัสดุสิ้นเปลือง 7,835 บาท และอุปกรณ์ 2,787 บาท) และค่าเดินทางของผู้เชี่ยวชาญ 750 บาท ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 การประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน

รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาทต่อเดือน)
ด้านอุปกรณ์	2,787
ด้านวัสดุสิ้นเปลือง	7,835
ด้านการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ	750
ด้านบุคลากร/ผู้ดูแล	15,000
ทั้งหมด	**26,372**

ค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะท้ายในสถานพยาบาล

จากข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมด 65,751 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลหรือภายในหนึ่งวันหลังออกจากโรงพยาบาลจำนวน 9,023 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลช่วง 1 เดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 45,000 บาทต่อราย ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายการดูแลที่บ้านเกือบเท่าตัว สะท้อนให้เห็นถึงภาระทางการเงินของระบบสุขภาพเมื่อการดูแลระยะท้ายต้องอาศัยสถานพยาบาลเป็นหลัก (70)

การประมาณการค่าใช้จ่าย LTC ผู้สูงอายุไทย: กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร (72)

ความไม่เท่าเทียมระหว่างชนบทและเมืองในการเข้าถึงบริการ LTC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่รวดเร็ว งานวิจัยนี้จึงมุ่งประเมินค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อผู้สูงอายุในการรับบริการ LTC และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการและต้นทุน LTC ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองและชนบทของประเทศไทย

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 837 คน คัดเลือกจากพื้นที่ชนบทและเขตเมืองในจังหวัดพิจิตร ต้นทุนการดูแลถูกประเมินในระยะเวลา 1 เดือน โดยแบ่งเป็นต้นทุนทางตรงจากการให้การดูแลและต้นทุนทางอ้อมตามวิธีการคำนวณต้นทุนทางเลือก (opportunity cost method) จากนั้นจึงใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยแบบจำลอง Binary logistic regression เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุน LTC

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมืองเท่ากับ 7,285 ดอลลาร์สหรัฐ (237,782 บาท ณ มีนาคม 2569) และ 7,280.6 ดอลลาร์สหรัฐ (237,639 บาท ณ มีนาคม 2569) ตามลำดับ ทั้งบริการแบบเป็นทางการ (formal care) และบริการไม่เป็นทางการ (informal care) เป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุด ผลวิเคราะห์ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างการอยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทกับต้นทุนบริการดูแลไม่เป็นทางการ การดูแลกลางวันกลางคืน และค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์บ้าน (ดังแสดงในตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 ค่าใช้จ่ายด้านบริการสำหรับประชากรในชนบทและเขตเมือง (ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี)

รายการ/บริการ	ชนบท (ชาย)	ชนบท (หญิง)	ชนบท (เฉลี่ย)	เขตเมือง (ชาย)	เขตเมือง (หญิง)	เขตเมือง (เฉลี่ย)
การดูแลในระบบ	3,309.1	2,612.5	2,844.7	4,005.8	3,134.9	2,380.3
สัดส่วนการใช้บริการ (%)	37.4	38.7	39.1	42.7	41.2	32.7
การดูแลนอกระบบ	2,065.2	2,145.2	2,114	2,192.3	2,021.4	2,089
สัดส่วนการใช้บริการ (%)	23.4	31.7	29.0	23.3	26.6	28.7
การดูแลกลางวัน/กลางคืน	2,717	1,268.9	1,590.7	2,438.3	1,741.6	2,090
สัดส่วนการใช้บริการ (%)	30.7	18.8	21.8	26.0	22.9	28.7
ของใช้ประจำวัน	681.2	664	668.7	724.7	663.3	680.6
สัดส่วนการใช้บริการ (%)	7.7	9.8	9.2	7.7	8.7	9.4
การปรับปรุงที่อยู่อาศัย	34.6	42.3	42.7	21.5	22.6	22.4
สัดส่วนการใช้บริการ (%)	0.5	0.6	0.6	0.2	0.3	0.3
อุปกรณ์ทางการแพทย์	25.0	23.8	24.3	10.5	20.7	18.4
สัดส่วนการใช้บริการ (%)	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2
ค่าใช้จ่ายรวม	**8,841.2**	**6,756.6**	**7,285**	**5,387.4**	**7,604.7**	**7,280.6**

แม้ว่ามูลค่ารวมของค่าใช้จ่าย LTC จะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างพื้นที่ชนบทและเมือง แต่ควรตระหนักถึงความแตกต่างเชิงโครงสร้างในแต่ละพื้นที่ การปรับโครงสร้างระบบการให้บริการในระดับประเทศและการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการจึงเป็นแนวทางสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพ LTC ต่อไป

กำลังคน

ในบริบททางสัดส่วนประชากรของไทยที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดอุปสงค์ในระบบการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีปริมาณที่เพียงพอ และมีความพึงพอใจในการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดภาวะสมองไหลไปภาคส่วนอื่น ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดดุลยภาพระหว่างอุปสงค์ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) และอุปทาน (ผู้ให้บริการในกลุ่มต่าง ๆ) การมองให้เห็นถึงคันโยก

เชิงระบบในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นสิ่งสำคัญ และสามารถมองผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ของกรอบแนวคิด Health labour market framework for universal health coverage ที่กล่าวมาในบทที่ 2

โครงสร้างทรัพยากรบุคคลบริการของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ในแง่ของโครงสร้างระบบการดูแลระยะยาว (Long-Term Care: LTC) สามารถแบ่งออกเป็นการบริการภาครัฐที่จัดโดยสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ และการให้บริการในภาคเอกชน โดยในส่วนของภาครัฐจะมีการแบ่งออกเป็นอีกสองส่วนตามลักษณะและสถานที่ให้บริการ ได้แก่ การบริการในหน่วยบริการ (Hospital based) จะทำงานในการสนับสนุนด้านวิชาการให้สำหรับการบริการในชุมชน (Community based) โดยทั้งหมดเพื่อให้เกิดกลไกสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ (Medical service) และบริการทางสังคม (Social Service) ควบคู่กัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเป็นผู้บริหารจัดการระบบ LTC ในส่วนนี้เองก็เป็นโครงสร้างสำคัญของระบบ LTC ของไทยที่ส่งผลให้ CG และ CM ในหลายพื้นที่มีการขึ้นตรงและบริบาลจากระบบที่แตกต่างกัน ตามการบริบาลของหน่วยงานนั้น ๆ นอกเหนือจากการให้บริการในภาครัฐ การบริการ LTC ยังเกิดขึ้นในภาคเอกชนรูปแบบของสถานดูแลผู้สูงอายุ (nursing home) โดยมีลักษณะแบบ In-facility service

การจำแนกประเภทตำแหน่งงาน

ในแง่ของประเภทอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ LTC สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. กำลังคนที่เป็นวิชาชีพ เช่น นักกายภาพบำบัด ที่มีบทบาทในการให้การดูแลทางการแพทย์ในแง่ของการทำกายภาพบำบัดเพื่อมุ่งเน้นการสร้างเสริมและดูแลการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผ่านกลไกต่าง ๆ ในระบบ LTC และระบบสุขภาพ เช่น การเป็นส่วนหนึ่งของทีมเยี่ยมบ้านเพื่อวินิจฉัยและให้คำแนะนำการรักษาโดยกายภาพบำบัด และการให้ความรู้และการอบรมเพื่อฝึก CG ในการทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย นอกจากนี้ นักกายภาพบำบัดก็อาจทำหน้าที่เป็นผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวเพิ่มเติมด้วย

2. กำลังคนที่เป็นผู้จัดการการดูแล (Care Manager: CM) ส่วนใหญ่คือพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการโดยมีบทบาทในการจัดทำแผนการดูแล (Care plan) การจัดประชุมร่วม

กับทีมสหวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยในรูปแบบของ Case conference ทุก ๆ 3 เดือน รวมไปถึงการดูแลการทำงานของนักบริบาล

3. กำลังคนที่เป็น CG มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางสังคม (Social care) โดยมีบทบาทในการสนับสนุนการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การพาออกกำลังกายหรือทำกายภาพบำบัด การทำแผล การให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ และรวมไปถึงการให้คำแนะนำทางการรักษาตามแนวทางที่ CM ได้วางไว้ โดย CG ที่ทำงานให้บริการในสถาบันต่าง ๆ จะมีบทบาทและลักษณะงานต่างจากการดูแลที่บ้าน เช่น CG ที่มีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจะต้องไปดูแลเป็นรายสัปดาห์หรือเดือน

การจำแนกประเภทตามลักษณะค่าตอบแทนที่ได้รับ

ในแง่ของทรัพยากรบุคคลภายในระบบสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนตามค่าตอบแทนที่ได้รับ ได้แก่

1. กำลังคนที่เป็นวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเพื่อรับใบประกอบการทำงาน ได้รับค่าตอบแทน แต่บางตำแหน่งอาจได้น้อยหรือไม่ได้เพิ่มเติมเลย โดยตัวอย่างของอาชีพในระบบที่เป็นวิชาชีพได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว CM กล่าวคือ บุคลากรในประเภทนี้มีลักษณะการจ้างงานส่วนมากในรูปแบบเต็มเวลา มีรายได้ที่แน่นอนและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต

2. กำลังคนที่ไม่เป็นวิชาชีพ โดยเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือได้รับน้อย ไม่สามารถเป็นรายได้หลักได้ และได้รับการอบรมในระยะสั้นหรือไม่ได้รับการอบรม เช่น CG ภายใต้ตำแหน่งนักบริบาลอาสาสมัครชุมชนและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลแต่ไม่ได้รับการอบรมเช่น ญาติ คู่สมรส หรือบุคคลใกล้เคียงที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง (73) เปรียบเสมือนกับการทำงานในรูปแบบอาสาสมัครที่ค่าตอบแทนทางการเงิน ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพการดูแลอย่างยั่งยืน

ในโครงสร้างดังกล่าวนั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงกลไกของกำลังคนแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งในหลาย ๆ กรณีนั้นมีแรงขับเคลื่อนมาจากค่านิยมในสังคมไทยของความกตัญญู ซึ่งมาเป็น Social safety net สำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทยแทนที่การให้บริการในฐานะสวัสดิการภาครัฐ ซึ่งก็สามารถเป็นข้อดีให้กับภาครัฐในการลดค่าใช้จ่ายของสวัสดิการส่วนนี้ แต่ก็อาจส่งผลต่อ

ความมั่นคงของระบบในยุคสมัยใหม่ที่บริบททางเศรษฐกิจสังคม รวมไปถึงค่านิยมและวัฒนธรรมที่ทำให้ประชากรวัยทำงานมีความสามารถและความต้องการในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุในบ้านลดลง ซึ่งสามารถนำไปสู่ช่องว่างในการดูแลผู้สูงอายุในด้าน Social care สูงขึ้น

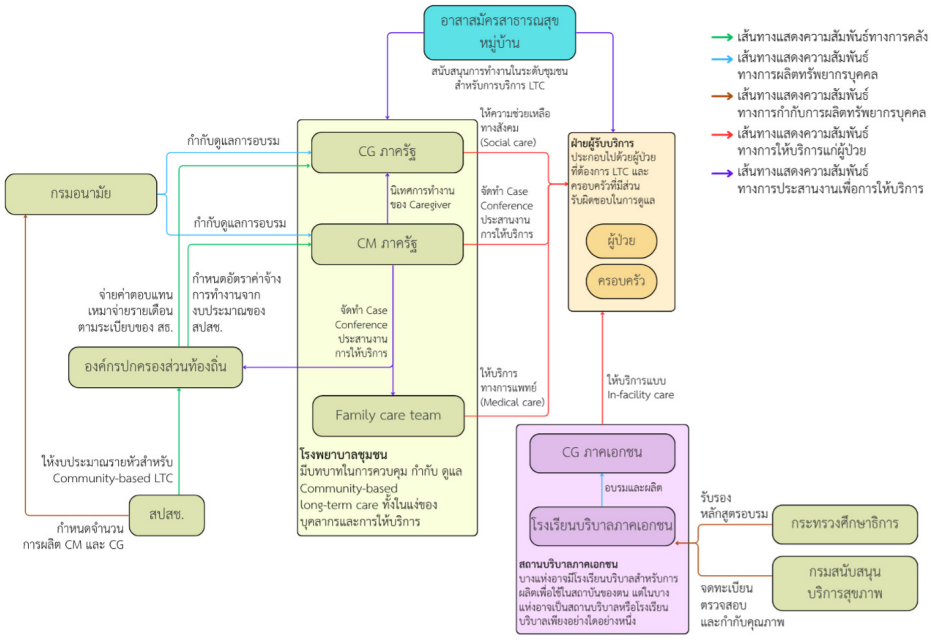
ภาพรวมระบบกำลังคนด้านสุขภาพของระบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

โครงหลักของบริการภาครัฐตั้งอยู่ที่ระดับพื้นที่ โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รพ.สต. และโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อน Family Care Team (FCT) ซึ่งรวมวิชาชีพต่าง ๆ พร้อม Care Manager (CM) และ Caregiver (CG) เพื่อให้บริการทางแพทย์และสังคมแก่ผู้สูงอายุในบ้านและชุมชน โดย CM มีหน้าที่จัดทำ Care plan, ประสานทีม และจัด case conference ประมาณทุก 3 เดือน, ขณะที่ CG เน้นการดูแลด้านสังคมและกิจวัตรประจำวันตามแผนที่กำหนด เช่น สนับสนุนการออกกำลังกาย/ทำกายภาพ การทำแผล และการติดตามอาการ ในภาคเอกชนประกอบด้วย สถานดูแลเอกชนและโรงเรียนบริบาล โดยมีความสัมพันธ์เชิงกำกับดูแลและตลาดแรงงานที่ต่างจากภาครัฐ

ในการผลิตและกำกับคุณภาพกำลังคน ภาครัฐใช้หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมงของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย เป็นฐานสำหรับการทำงานของ CG/CM ในชุมชน และภาคเอกชนมีสถาบันฝึกอบรมที่เปิดหลักสูตร/ผู้ดูแล โดย กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่อนุมัติหลักสูตรของสถานศึกษาเอกชน ในขณะที่ผู้ผ่านการอบรมและสถาบันฝึกอบรมต้องขึ้นทะเบียน/อยู่ภายใต้การตรวจสอบคุณภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

ในแง่ของค่าตอบแทนและแรงจูงใจในภาครัฐ CG ที่ทำงานในหน่วยบริการที่ได้รับทุนจาก สปสช. ได้รับค่าจ้างเหมาบุคคลรายเดือน ไม่เกิน 600 หรือ 1,500 บาท ตามจำนวนผู้รับบริการที่รับผิดชอบ (ผ่านการคิดจากมุมมองที่มองบทบาท CG เป็นแรงงานเชิงจิตอาสา) โดยแยกต่างหากจากโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท. ที่ให้ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน ตามเงื่อนไขของพื้นที่ (ไม่ใช่ทุน สปสช.) ส่วนภาคเอกชน ค่าตอบแทนและสวัสดิการขึ้นกับสถานประกอบการ

ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิ รูปที่ 21



รูปที่ 21 แผนภาพสรุประบบกำลังคนด้านสุขภาพของระบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

<u>การผลิตทรัพยากรบุคคลสำหรับระบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง</u>

การผลิตบุคลกรวิชาชีพ (นักกายภาพบำบัด)

จากการศึกษาการผลิตบุคลกรวิชาชีพสำหรับระบบ LTC ด้านสาธารณสุข เช่น นักกายภาพบำบัด พบว่า การผลิตนักกายภาพบำบัดมีปัญหาในความสามารถในการผลิตบุคลกรให้เหมาะสมต่อประชากรในประเทศจากการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ ทำให้กำลังผลิตและคุณภาพในการผลิตของแต่ละสถานศึกษาไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพได้ เช่น การขาดการเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในพื้นที่ชุมชน นอกจากนี้สถานศึกษาที่ผลิตนักกายภาพบำบัดของภาครัฐและเอกชนยังกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ทำให้เกิดภาวะการกระจายตัวที่ไม่เท่ากันของนักกายภาพบำบัด (74,75) ในกระบวนการผลิตนักกายภาพบำบัดก็พบว่ามีอัตราการลาออกจากการเรียนอยู่ที่ร้อยละ 12.3 โดยที่สถานศึกษาเอกชนมีอัตราลาออกจากการเรียนอยู่ที่ร้อยละ 29.1 โดยถึงแม้ว่าจะมีสถานศึกษาที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตนักกายภาพบำบัดนอกพื้นที่ภาคกลาง แต่ก็ประสบปัญหาในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion)

ปัจจุบัน การเพิ่มการผลิตนักกายภาพบำบัดถูกบรรจุลงในยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ ระยะ 10 ปี ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายอัตราส่วนนักกายภาพบำบัดต่อประชากรอยู่ที่ 1 : 2,000 ในปี 2577 ผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ รวมไปถึงการเพิ่มเม็ดเงินสนับสนุนการสร้างบุคลากร ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวในแง่ของปริมาณบุคลากรในสภาวะที่สถานพยาบาลต่าง ๆ มีความต้องการนักกายภาพบำบัดสูงขึ้น ด้วยเหตุผลที่ต้องการกำลังในการรองรับประชากรที่ต้องการการทำกายภาพบำบัดมากขึ้น และรูปแบบการให้บริการที่เป็นการเข้าถึงผู้ป่วยจากที่พักอาศัยมากขึ้น

การผลิตนักบริบาลภาครัฐ

ในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ CG จะมีการใช้หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) จำนวน 70 ชั่วโมง โดยสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย มีการตั้งเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมไว้ค่อนข้างต่ำที่ ป.6 เพื่อซึ่งส่งผลให้ผู้ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรมีความหลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ในอดีตไม่มีโอกาสได้ศึกษาเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่มีความชำนาญในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับโอกาสในการสร้างรายได้ (6) ในด้านของเนื้อหาอบรม มีการกล่าวถึงประเด็นที่เป็นพื้นฐานของ Long Term Care เช่น โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการประเมินค้นหาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลและการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับระบบสุขภาพของไทย เช่น สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ แต่ก็มีปัญหาด้านความไม่เพียงพอของชั่วโมงการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ CG ที่ผลิตมามีปัญหาในการปฏิบัติงานและบ่อยครั้งต้องเรียนรู้หน้างาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรผลิตนักบริบาล 420 ชั่วโมง ซึ่งมีความครอบคลุมมากกว่าแต่มีปัญหาด้านการปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักสูตร 70 ชั่วโมง เช่น หลักในการดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม (76) และปริมาณของ CG ที่ได้รับการอบรม 420 ชั่วโมง ก็ยังคงน้อยกว่า CG ที่ได้รับการอบรม 70 ชั่วโมงค่อนข้างมาก โดยหลังจากการอบรมแล้วจะมีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีละปฏิบัติ โดยมีการทดสอบทั้งระหว่างแผนการสอน การทดสอบก่อน-หลังการอบรม และการทดสอบโดยการปฏิบัติในภาคสนาม

โดยสรุปแล้ว ในแง่ของหลักสูตรในการผลิต CG จะพบได้ว่าหลักสูตร 70 ชั่วโมงนั้นเป็นหลักสูตรหลักในการพัฒนา CG ซึ่งประกอบกับเกณฑ์ทางการศึกษาที่ค่อนข้างต่ำ เพื่อให้ประชากรที่อาจไม่ได้เข้าถึงการศึกษาจนครบถ้วนสามารถมาทำงานได้ ซึ่งอาจหมายถึงการที่ระบบการผลิตบุคลากรที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพของความรู้และทักษะของ CG จึงมี

ความสอดคล้องกับความตั้งใจของกระทรวงสาธารณสุขที่ในตอนแรกต้องการให้บทบาทของ CG เป็นงานอาสา โดยหากทิศทางของการว่าจ้าง CG จะเป็นแบบการจ้างเต็มเวลามากขึ้น อาจจะทำให้ระบบการผลิต CG ต้องมีความเข้มข้นเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมในการทำงานแบบเต็มเวลามากขึ้น โดยอาจหมายถึงการให้บริการที่ดีมากขึ้น

การผลิตนักบริบาลภาคเอกชน

ในขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานเอกชนหลายแห่งที่มีการเปิดอบรม โดยงานวิจัยในปี 2563 พบว่ามีสถาบันผลิตกำลังคนในตำแหน่งผู้ช่วยเพื่อทำงาน CG ภาคเอกชนทั้งหมด 88 แห่ง โดยมี 35 แห่งที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (77) โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่รับรองหลักสูตรของสถาบันต่าง ๆ โดยในบางแห่งนั้นมีตำแหน่งให้เข้าทำงานเมื่อผ่านการอบรม เกณฑ์ในการรับสมัครคือการมีวุฒิระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป และอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับอายุของผู้ปฏิบัติงาน

โดย CG ทั้งที่มาจากการอบรมของกรมอนามัยหรือโรงเรียนนอกระบบ แล้วทำงานในกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือ In-facility care service จะต้องมีการขึ้นทะเบียนและได้รับการตรวจสอบกำกับคุณภาพกับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (แสดงดังตารางที่ 10)

หลักสูตรและการผลิต CM

ส่วนในประเด็นของการผลิต CM โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นคือมีอายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี และเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือหน่วยจัดบริการที่มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เช่น พยาบาลวิชาชีพ และอาจรวมไปถึงบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด เช่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โดยคนส่วนใหญ่ที่มาอบรมการเป็น CM นั้นคือพยาบาลวิชาชีพ

แต่ในแง่ของการผลิต CM พบว่าในอดีตมีการขาดการทำงานที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันระหว่างสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีหน้าที่ในการรับสมัครพื้นที่ที่มีความพร้อม และกรมอนามัยที่มีหน้าทีในการกำหนดปริมาณการผลิต CM ในแต่ละปี ทำให้ในช่วงปี 2560 ร้อยละ 12 ของพื้นที่ขาด CM เพื่อทำงานร่วมกับ CG ในการดำเนินนโยบาย Long Term Care โดยในปี 2567 ก็ยังมีบางอำเภอที่ไม่มี CM ปฏิบัติงาน (78)

โดยรวมแล้ว รูปแบบของการผลิต CG นั้นเน้นไปที่การเพิ่มจำนวนในระยะเวลาที่สั้น โดยลดคุณภาพของ CG ที่สำเร็จหลักสูตร โดยการกำหนดหลักสูตรหลัก 70 ชั่วโมงนั้น ตอบโจทย์ในแง่ของการดูแลทางสังคม (Social care) แต่ก็มีปัญหาด้านการเตรียมผู้อบรมในการจัดการปัญหาทางการแพทย์เพิ่มเติม เช่น การดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม การดูแลระยะสุดท้าย (Palliative care) รวมไปถึงชั่วโมงในการปฏิบัติที่ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ต้องมีการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงานเพิ่มเติม การผลิตผู้ช่วยพยาบาลในโรงเรียนนอกระบบที่กำกับดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการก็อาจเข้ามาช่วยเพิ่มเติมการเพิ่ม CG ที่มีมาตรฐานได้บ้าง แต่ก็ยังมีปัญหาในการกระจายตัวของโรงเรียนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ รวมไปถึง CG ที่ผลิตจากโรงเรียนนอกระบบหลายส่วนก็เข้าทำงานในระบบเอกชน ทำให้อาจไม่ได้ช่วยให้ระบบ Long term care ของภาครัฐขนาดนั้น ส่วนในกระบวนการการผลิต CM ก็มีปัญหาในอดีตในเชิงของการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินนโยบายระบบ LTC

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบการอบรมและโครงสร้างบุคลากรระหว่าง CG ที่ทำงานแบบ Community-based และ In facility-based

มิติการเปรียบเทียบ	Community-based LTC	In-facility LTC
ประเภทบุคลากร	เป็นรูปแบบของ Family care team (FCT) โดยมีองค์ประกอบ เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ เภสัชกร อาสาสมัคร สาธารณสุขหมู่บ้าน รวมไปถึงตำแหน่งในระบบ LTC เช่น CG และ CM	เป็นรูปแบบทีมที่ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ CG และบุคลากรอื่น ๆ ตามการบริหารของสถานบริการ
การฝึกอบรม	ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัยในการอบรม CM และ CG ในการปฏิบัติงาน	มีโรงเรียนบริบาลของเอกชนที่ให้การอบรมในการเป็น CG โดยอยู่ในการรับรองคุณภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การจ้างงาน ผลตอบแทน สวัสดิการ ของ Caregiver

Caregiver สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทตามสถานะอาชีพและค่าตอบแทนที่ได้รับ ได้แก่ (1) Caregiver แบบเป็นทางการที่ได้รับค่าตอบแทนของหน่วยบริการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2) Caregiver แบบเป็นทางการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และ (3) Caregiver ที่ทำงานในสถาบันเอกชน

โดยในกรณีของ CG ที่ได้รับค่าตอบแทนของหน่วยบริการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทนแบบค่าจ้างเหมาบุคคล เดือนละไม่เกิน 600 หรือ 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยที่รับผิดชอบ และจะไม่ได้รับสวัสดิการใด ๆ (79) ในปัจจุบันหลาย ๆ กองทุนเลือกจ่ายค่าตอบแทน CG ที่เป็นอาสาสมัครในลักษณะรายชั่วโมงแทน คือ 50 บาท/ชั่วโมง ส่วน CG ที่รับค่าตอบแทนในฐานะอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จะได้รับค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน และเมื่อปฏิบัติงานให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเป็นระยะเวลา 3 ปีและมีความประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยได้รับการอบรมเพิ่มพูนทักษะอีก 50 ชั่วโมง จะได้รับค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (80)

โดยในประเด็นของการรับเงินสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาจากจุดประสงค์เดิมของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้การทำงานของ CG เป็นในรูปแบบของจิตอาสา โดยได้รับค่าตอบแทน 300 บาทต่อเดือน ต่อมาจึงปรับเพิ่มเป็น 600 หรือ 1,500 บาทในปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการทำงานของ CG โดยมี CM และ CG จำนวนมากมองว่าค่าตอบแทนนั้นไม่เหมาะสมต่อการทำงาน ซึ่งในงานวิจัยที่สำรวจความพึงพอใจของ CM CG และวิชาชีพอื่น ๆ ในระบบ Long term care พบว่าเพียงร้อยละ 27.7 ของผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่ได้รับ (81) ส่งผลให้ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วหลายส่วนไม่ทำงานหรือทำแล้วตัดสินใจออก ซึ่งในเหตุผลเชิงโครงสร้างนั้น CG ควรเป็นผู้ที่ทำงานเต็มเวลา เนื่องจากในบางหน้าที่ที่สำคัญจะต้องทำในเวลาทำงานของบุคคลทั่วไป การใช้ระบบอาสาสมัครเพื่อสรรหา CG จึงเป็นแนวคิดที่ขัดกับความต้องการของระบบ โดยในปัจจุบันมีความเคลื่อนไหวผ่านการส่งข้อเสนอไปทางคณะรัฐมนตรีในการเพิ่มค่าตอบแทนให้ CG คงที่อยู่ที่ 5,000 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน และเพิ่มจำนวน CG ในระบบ (82)

ทั้งหมดนี้มีความสำคัญต่อการคุณภาพบริการโดยตรงของผู้สูงอายุ โดยจากการศึกษาของสัมฤทธิ์

ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ (2560) พบว่าพื้นที่ที่ให้ค่าตอบแทนแก่ CG มีการให้บริการที่สม่ำเสมอและครอบคลุมกว่าพื้นที่ที่ไม่มีการให้ค่าตอบแทนทั้งในแง่ของการดูแลทางการแพทย์และทางสังคม รวมไปถึงการดำเนินงานอื่น ๆ ในภาพรวม เช่น การจัดทำแผนดูแลเฉพาะราย การติดตามและประเมินผล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงค่านิยมที่เปลี่ยนไปของสังคมในการทำงานที่เน้นความมั่นคงทางอาชีพมากขึ้นกว่าการทำงานในฐานะของจิตอาสา ถึงกระนั้น ค่าแรงในระดับที่ 5,000 บาทต่อเดือน (ประมาณ 167 บาทต่อวัน) ก็อาจยังเป็นตัวเลขที่ประชาชนที่สนใจไม่สามารถเข้ามาทำหน้าที่ CG เป็นงานเต็มเวลาได้ เมื่อเทียบกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำโดยอ้างอิงจากกระทรวงแรงงานที่อยู่ที่ประมาณ 337 - 400 บาทต่อวัน แต่ไม่ว่าอย่างไร ทิศทางในปัจจุบันของรัฐบาลในการจัดแจงค่าตอบแทนให้กับผู้ดูแลทั่วประเทศก็ยังมีความสำคัญในแง่ของการคงไว้ซึ่ง CG ในระบบ LTC ให้มีความมั่นคงและพอดีต่อภาระงาน ซึ่งจะนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ ยั่งยืน และครอบคลุมในที่สุด

ในองค์กรภาคเอกชนที่มีการว่าจ้าง CG ในการประกอบธุรกิจ งานศึกษาถึง CG ในสถานบริการแห่งหนึ่งของธัญกมล รงรองรจเรข (2567) พบว่า ในสถาบันที่ศึกษานั้นมีการให้เงินเดือนที่ CG มองว่า ‘มีความเหมาะสมต่องานที่ได้รับ’ และมีระบบการปรับฐานเงินเดือนทุกปีตามอายุการทำงานกับสถาบัน ทำให้เกิดความพึงพอใจในด้านความก้าวหน้าในระดับ ‘พึงพอใจมากที่สุด’ ซึ่งอาจเป็นรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ลดอัตราในการลาออกของ CG ในระบบ LTC ได้ (83)

<u>สภาพการทำงานและความพึงพอใจของ Caregiver</u>

จากการศึกษาของ Khongboon et al. (2023) พบว่า CG จำนวนมากทำงานภายใต้กองทุน LTC ของ สปสช.โดยได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยเพียง 1,620 บาท/เดือน ต้องออกค่าเดินทางเองราว 214 บาท และกว่า 48.7 % เคยประสบปัญหาเบิกเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับเลย (84) ภาวะนี้ซ้ำเติมภาระที่ต้องออกเยี่ยมบ้านหลายหลังต่อวันให้ตึงตัวยิ่งขึ้น งานศึกษาในนครราชสีมาพบว่า CG ที่ไม่พอใจงาน มีโอกาสประกาศจะเลิกทำงานมากกว่าผู้ที่พอใจถึง 5.6 เท่า (85) ขณะเดียวกัน การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างในภาคเหนือของ Netpradit (2023) ยืนยันว่า ความผูกพันต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมในงาน ส่งผลตรงต่อการคงอยู่ของผู้ดูแล ส่วน

ค่าตอบแทน มีผลทางอ้อมผ่านความสมดุลชีวิต (86) โดยมีเหตุผลส่วนหนึ่งในการรับค่าตอบแทนล่าช้ามาจากระเบียบทางการเงินของท้องถิ่นที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบราชการกลาง เช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงความบกพร่องในการของบประมาณของ CM ผ่านการทำสัญญาจ้างจากภาระงานล้นมือ

โดยรวมแล้ว สภาพแวดล้อมงานที่ได้รับการสนับสนุนพร้อมค่าตอบแทนตรงเวลาไม่เพียงบรรเทาภาระและยกระดับขวัญกำลังใจ แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษากำลังคนและคงความถี่การเยี่ยมบ้านซึ่งเป็นหัวใจของบริการ LTC

<u>การจ้างงาน ผลตอบแทน สวัสดิการของ Care manager</u>

ในการศึกษาของสัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์และคณะ (2560) พบว่าสาขาวิชาชีพที่ทำหน้าที่ CM หลักคือ พยาบาลวิชาชีพ และในวิชาชีพอื่น ๆ เช่น นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และนักสังคมสงเคราะห์ (6) โดยได้รับค่าตอบแทนผ่านงบเหมาจ่ายของผู้ใช้ระบบ LTC แต่ไม่มีการกำหนดอัตราที่ชัดเจนและแน่นอน ขึ้นอยู่กับการบริหารของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดคค่าตอบแทน เช่น

1. จากการอ้างอิงรายงานการประชุมอนุกรรมการ LTC ขององค์กรบริหารส่วนตำบล บานา มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ CM ตามการปฏิบัติงาน เช่น CM จะได้รับค่าตอบแทนในการจัดทำ Care plan อยู่ที่ 100 บาทต่อคน
2. จากการวิจัยของ สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ (2560) พบว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก มีการให้ค่าตอบแทน CM และวิชาชีพอื่น ๆ อยู่ที่ 80 บาทต่อชั่วโมง

แต่ในเงินที่จัดสรรมาก็อาจไม่เพียงพอต่อการทำงานของ CM โดยเงินค่าตอบแทนตรงนี้จะต้องรวมกับค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติม เช่น ผ้าอ้อม ทำให้ CM หลายคนเลือกที่จะนำเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายกับอุปกรณ์ และให้การทำงานของตนไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งเป็นการแก้ไขที่อาจส่งผลต่อความยั่งยืนด้านบุคลากรของระบบ LTC ได้ โดยถึงแม้ว่าหน้าที่เหล่านี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพ CM อยู่แล้ว แต่การอาศัย ‘น้ำใจ’ ของ CM ในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นก็อาจเป็นทิศทางที่ต้องได้รับการพิจารณาใหม่ในการปรับระบบด้านกำลังคนของระบบ LTC จากงานในรูปแบบ ‘จิตอาสา’ ไปเป็นระบบที่มีค่าตอบแทนที่ชัดเจนและแน่นอนมากขึ้น

สภาพการทำงานและความพึงพอใจของ Care manager

ในส่วนของการทำงานของ CM นั้น พบว่าระบบ LTC ยังไม่สามารถสนับสนุนการทำงานเชิงสหสาขาวิชาชีพของ CM ได้อย่างเพียงพอทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพ โดยผู้ที่มาเป็น CM นั้นจะต้องมีเงื่อนไขตามที่กรมอนามัยได้วางไว้ เช่น วิชาชีพ ส่งผลให้ CM ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีภาระหน้าที่ในระบบสุขภาพที่หนัก การเพิ่มภาระงานในการดูแลระบบ CM ที่มีทั้งการออกตรวจเยี่ยมบ้าน จัดทำแผนการดูแลรายบุคคล การนิเทศการทำงานของ CG และภาระอื่น ๆ ทำให้การทำงานของ CM นั้นอยู่ในสภาวะ ‘ล้นมือ’ เมื่อประเด็นเหล่านี้ประกอบกับการที่ CM มีการขาดแคลน ก็ส่งผลให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของระบบ LTC มีปัญหาและไม่ครบถ้วน

การกระจายตัวและปริมาณของทรัพยากรบุคคล

การกระจายตัวและปริมาณของนักกายภาพบำบัด

ในข้อมูลของปริมาณนักกายภาพบำบัด มีการกล่าวถึงไว้ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุข ในภาพรวมทั้งระบบ ระยะ 10 ปีว่าอัตราส่วนของนักกายภาพบำบัดต่อประชากรอยู่ที่ 1 : 4,792 ซึ่งมีความต่างจากเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งไว้ที่นักกายภาพบำบัด 1 คนต่อประชากร 2,000 คน โดยสถานการณ์นี้หมายถึงการทำงานที่มีความขัดข้องของระบบ LTC ที่ต้องอาศัยการให้บริการของทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะนักกายภาพบำบัดที่สามารถส่งผลถึงการใช้ชีวิตประจำวันโดยตรง ในสาเหตุของการขาดนักกายภาพบำบัดนั้นมาจาก

1. กำลังการผลิตที่ต่ำกว่าความต้องการในระยะยาว และอัตราการลาออกระหว่างการศึกษา
2. ค่าตอบแทนในการทำงานที่ส่งผลให้ระบบสุขภาพเกิดสภาวะสมองไหล (Brain drain)

โดยจากการศึกษาของ S. Kaewsawang, et. al. (2017) กายภาพบำบัดที่เลือกทำงานในสถาบันเอกชนที่อาจให้ค่าตอบแทนที่ดีกว่าทั้งในและต่างประเทศ (87)

โดยในปัจจุบันการเพิ่มกำลังการผลิตนักกายภาพบำบัด ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุข ในการเพิ่มกำลังการผลิตเป็นปีละ 1,700 คน โดยการเพิ่มจำนวนอาจารย์ปีละ 60 คนและจัดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ปีละ 200 คน

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามาถในการผลิตให้มีความเข้มแข็งของสถานศึกษามากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาภาวะสมองไหลของนักกายภาพบำบัดในแง่ของการตอบแทนความพึงพอใจ และอัตราการคงอยู่ของนักกายภาพบำบัดได้อย่างดีเพียงพอ

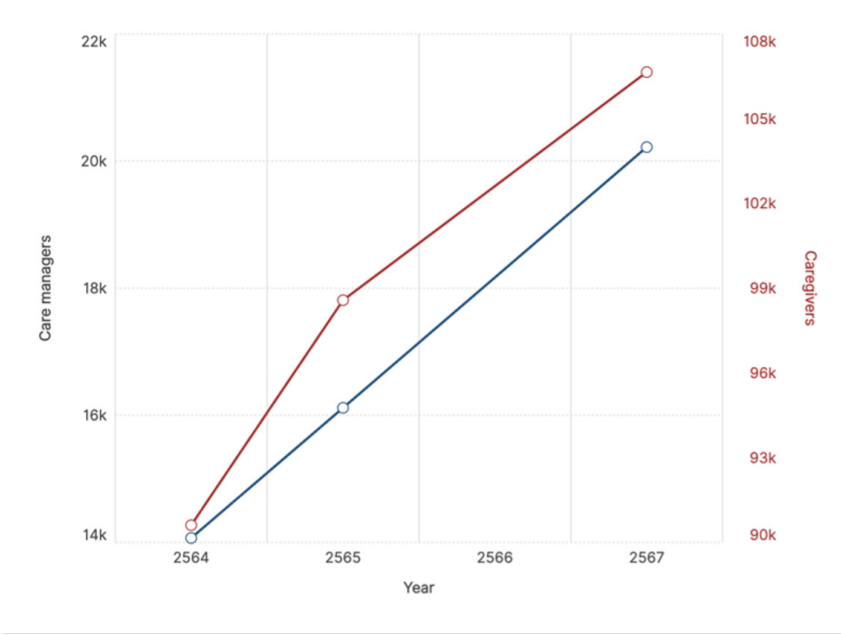
การกระจายตัวและปริมาณของ CM และ CG

ข้อมูลสถิติของ Care manager และ Caregiver ในช่วงปี 2564 - 2567 แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนระหว่าง CG และ CM ที่มีความเหมาะสมมากขึ้นโดยมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับความต้องการอยู่ที่ CG 5 คน ต่อ CM 1 คน (แสดงดังตารางที่ 12 และรูปที่ 28 และ 29)

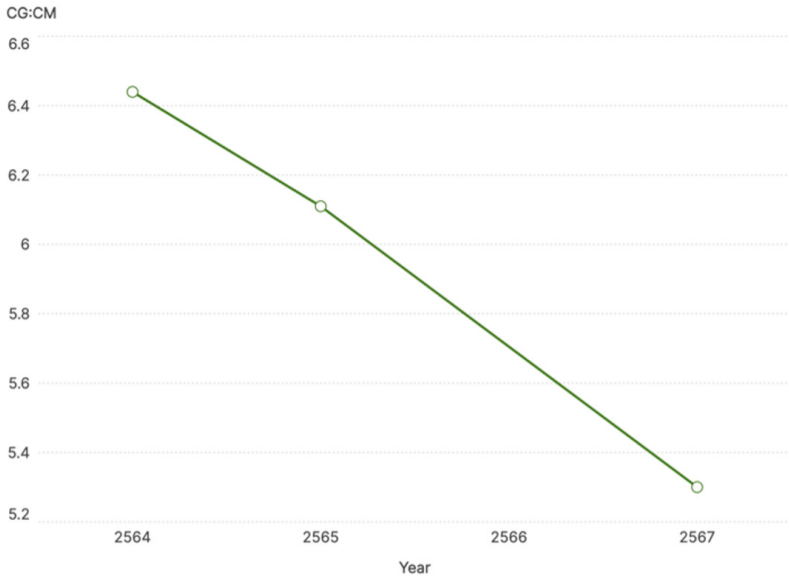
ตารางที่ 11 ข้อมูล CM และ CG ผู้ปฏิบัติงานระหว่างปี 2564 ถึง 2567

ปี	Caregivers	Care managers	CG:CM
2564	90,610	14,069	6.44 : 1
2565	98,575	16,117	6.11 : 1
2566		ไม่มีข้อมูล	
2567	106,650	20,220	5.3 : 1

ที่มา: รายงานบุคลากรด้านการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ระบบข้อมูลบุคลากรการดูแลระยะยาวและแผนการดูแลรายบุคคล (Long Term Care : 3C) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



รูปที่ 22 การแสดงจำนวนยอด CM และ CG ในแต่ละปี



รูปที่ 23 การแสดงอัตราส่วน CG:CM ในแต่ละปี

ในแง่ของความสมดุลของ CG ต่อความต้องการของประชากรในอนาคต งานวิจัยในอดีตได้คำนวณความต้องการ CG ต่อการเติบโตของประชากรสูงวัย โดยพบว่าในปี 2569 ความต้องการ CG อยู่ที่ประมาณ113,401-117,075 คน (88) ซึ่งจากข้อมูลบุคลากรการดูแลระยะยาวและแผนการดูแลรายบุคคลของกรมอนามัย พบว่า ในปี 2567 ถือว่ามีความขาดเพียงเล็กน้อย (ตารางที่ 12) หากดูในสถิติของแต่ละเขตสุขภาพ จะพบว่าในยังมีการกระจายตัวที่ไม่เท่ากันของบุคลากร ส่งผลให้เกิดภาวะที่ CG ต้องรับภาระผู้สูงอายุมากกว่าในภูมิภาคอื่น ๆ เช่น ในเขตสุขภาพที่ 10 ที่ CG 1 คนต้องดูแลผู้สูงอายุโดยเฉลี่ย 7 ราย ในขณะที่ภาพรวมของประเทศอยู่ที่ CG 1 คน ดูแลผู้สูงอายุ 3.2 ราย (89) (แสดงดังตารางที่ 13) การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการกระจายบุคลากรให้มีความเหมาะสมต่อพื้นที่ต่าง ๆ โดยถึงแม้ว่าภาพรวมของประเทศจะกำลังไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่หากการกระจายกำลังคนยังไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ต่อไปได้

ตารางที่ 12 สถิติ CM CG และผู้ใช้งานระบบ LTC แบ่งตามเขตสุขภาพปี 2567

เขตสุขภาพ	CM	CG	LTC User	User:CG
1	2,133	9,807	24,341	2.5
2	1,682	6,147	16,519	2.7
3	1,185	6,473	17,509	2.7
4	1,792	7,605	16,813	2.2
5	1,574	6,405	14,616	2.3
6	1,561	7,839	13,034	1.7
7	1,660	14,302	52,080	3.6
8	1,474	11,754	46,269	3.9
9	2,146	14,040	50,259	3.6
10	1,809	9,673	67,672	7.0
11	1,619	6,019	18,414	3.1
12	1,586	5,906	15,357	2.6
ค่าเฉลี่ย				**3.2**

สภาพแวดล้อมการทำงาน แรงจูงใจ และอัตราการคงอยู่ของทรัพยากรบุคคล

ในการศึกษา Pilot Program สำหรับระบบ LTC ใน 11 อำเภอของ Pagaiya et al. (2021) พบว่าอัตราการคงอยู่อยู่ที่ร้อยละ 88.1 โดยประชากรส่วนใหญ่ที่มาเป็น CG คือ กลุ่ม อสม. ในการให้เหตุผลของผู้ที่ตัดสินใจลาออกมีตั้งแต่สภาวะการทำงานที่ไม่อำนวย ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ และอื่น ๆ (81) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Choomplang and Anantanasuwong (2023) ที่ระบุถึงการมีงานอื่นที่ดีกว่า ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ รวมไปถึงการขาดความก้าวหน้าทางอาชีพ ขาดสวัสดิการ และปัจจัยส่วนตัวอื่น ๆ เช่น การดูแลครอบครัว การแต่งงาน เป็นเหตุผลในการลาออก (90) ซึ่งในบริบทในการศึกษาจะยังเป็นในช่วงที่ทิศทางของ CG ยังเป็นรูปแบบของจิตอาสาอยู่ ซึ่งก็อาจเป็นอีกส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทิศทางของ CG จะเป็นการจ้างเต็มเวลามากขึ้น ดังนั้น การมุ่งเน้นไปที่การการแก้ไขปัญหาที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นหลัก จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพ เพื่อเพิ่มจำนวน CG ได้อย่างยั่งยืนให้แก่ระบบ

<u>การทำงานในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพของระบบ LTC</u>

รูปแบบและความสำคัญของการทำงานในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ

ในระบบ LTC ของไทย กลไกในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลชุมชน เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน Family care team (FCT) ซึ่งประกอบไปด้วย นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ เภสัชกร อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน รวมไปถึงตำแหน่งในระบบ LTC เช่น CG และ CM โดยมีหน้าที่ในการให้การบริการทางการแพทย์และทางสังคม (91)

โดยอิงจากการศึกษาการประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม (CGA: Comprehensive Geriatric Assessment) ที่มีการใช้สหสาขาวิชาชีพในการรักษาผู้สูงอายุในสถานพยาบาล จะช่วยลดโอกาสในการเข้ารับบริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ และเพิ่มคุณภาพชีวิตในการอาศัยอยู่ที่บ้านอย่างมีคุณภาพ การทำงานในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วย เนื่องจากโดยเฉพาะในรูปแบบของ LTC การรักษาคนหนึ่งคน จะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลา โดยการมีทีม FCT ที่ให้บริการที่ตรงกับความต้องการ ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม นำไปสู่ผลทางสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป (92)

การพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมมือกันของบุคลากรด้านสุขภาพในการแก้ไขปัญหา

จากการศึกษาของ Kitreerawutiwong et al. (2017) พบว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการจัดกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Management Learning: DHML) ซึ่งส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันในและนอกหมู่บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านการเปิดรับการเข้าร่วมเป็นทีม ซึ่งมีทั้งจากหน่วยบริการสุขภาพ สาธารณสุขอำเภอ รวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล และภาคประชาชน ทำให้เกิดบรรยายกาศในการทำงานร่วมดันตามโอกาสต่าง ๆ ซึ่งสามารถเป็นกลไกในการส่งเสริม FCT ในระดับพื้นที่อำเภอได้ แต่ก็มีข้อจำกัดที่เป็นโครงการที่ต้องสมัครใจและไม่ครอบคลุมกับทุกพื้นที่ (93)

นอกเหนือจากกลไก โครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอแล้ว การอบรม CM และ CG ก็ได้มีการกล่าวถึงการทำงานร่วมกันในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ ซึ่ง CM และ CG ทุกคน โดยในหลักสูตรของ CG มีการพูดถึงการทำงานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพในบทเรียนต่าง ๆ โดยเฉพาะในการอบรม CM ที่มีบทบาทติดต่อ ประสานงาน และไกล่เกลี่ยกับทีมสหสาขาวิชาชีพค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของ FCT ก็ยังมีอุปสรรคในการมีการทำงานเป็นทีมที่มีการมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในทีมที่ยังไม่เพียงพอ ทำให้การส่งต่อข้อมูลและการประสานงานยังมีจุดที่สามารถพัฒนาต่อได้ (94,95)

<u>บริบททางสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์ในระบบ LTC</u>

1. **ด้านพลวัตโครงสร้างประชากร** ในบริบทในอดีตของสังคมไทยมีความคาดหวังให้ลูกหลานเป็นผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุในครอบครัว โดยอัตรา Older Persons Support Ratio (ซึ่งหมายถึงอัตราประชากรวัยทำงานต่อผู้สงอายุ) ของประเทศไทยมีแนวโน้มของการหดตัว ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประชาชนในระดับจุลภาคที่แต่ละครัวเรือนมีกำลังและอัตราในการดูแลผู้สูงอายุต่ำลง กลับกัน สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อาศัยตามลำพังได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.3 ในปี 2545 มาเท่าตัวเป็นร้อยละ 12.8 ในปี 2564 โดยข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของระบบ LTC การเป็นโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social safety net) ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว (17)

2. **ด้านการกระจายอำนาจปกครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น** ระบบงบประมาณและการจัดการของภาครัฐที่เน้นการทำงานในหน่วยงานและแยกส่วนกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นลักษณะงานของการดูแลแบบผสมผสานระหว่างการดูแลทางการแพทย์และทางสังคมด้วยการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงระบบตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เน้นการใช้เงินให้ถูกต้องตามระเบียบ ส่งผลให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำงานได้แค่ตามกรอบและปิดกั้นอิสระในการปรับระบบให้ตอบโจทย์ต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ขณะเดียวกันแม้ พรบ.กระจายอำนาจกำหนดเป้าหมายของสัดส่วนงบประมาณภาครัฐทั้งหมดที่ลงไปสู่ท้องถิ่นที่ร้อยละ 35 แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่เป็นไปตามแผน ทำให้ท้องถิ่นมีศักยภาพด้านการคลังที่จำกัดในการขยายงาน

3. **ด้านการเมืองและนโยบาย** ปัจจุบันปัญหาโครงสร้างทางประชากรเป็นปัญหาที่ฝ่ายการเมืองค่อนข้างให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับโครงสร้างการบริการ รวมไปถึงโครงสร้างทางการดูแลบุคลากรเพื่อให้มีเสถียรภาพและความต่อเนื่องของระบบ LTC (96)

4. **ด้านสังคมและวัฒนธรรม** ในหลายพื้นที่มีความเข้มแข็งของชุมชนในรูปแบบของเครือข่ายการทำงาน เช่น อสม. รวมไปถึงการมีอยู่ของการดูแลระดับปฐมภูมิในรูปแบบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทำให้เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนได้ดี นอกจากนี้ ค่านิยมของคนไทยก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบ LTC ให้สามารถพึ่งสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้ดีขึ้น จึงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น อย่างไรก็ดีด้วยข้อจำกัดของระบบจิตอาสาทำให้ไม่สามารถคาดหวังด้านคุณภาพมาตรฐานบริการตามที่พึงเป็นได้ ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสภาพครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงรวมถึงการเคลื่อนย้ายของวัยแรงงานและบทบาทสตรีในระบบเศรษฐกิจก็ทำให้ศักยภาพของครัวครอบในการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนถดถอยลง

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ วัสดุ และครุภัณฑ์สำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง อ้างอิงประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (97) ซึ่งดำเนินตามนโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง มีการกำหนดไว้อย่างกว้างว่า ให้เบิกจ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 4 ประเภท และได้มีการยกตัวอย่างไว้อย่างกว้างดังรูปที่ 30

ประเภทและกิจกรรมบริการ	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง			
	กลุ่มที่ ๑ เคลื่อนไหวได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง	กลุ่มที่ ๒ เหมือนกลุ่มที่ ๑ แต่มีภาวะสับสนทางสมอง	กลุ่มที่ ๓ เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง	กลุ่มที่ ๔ เหมือนกลุ่มที่ ๓ และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต
๔. จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยอาจขอยืมหรือได้รับจากสิทธิบริการอื่น ๆ เช่น จาก อปท. หน่วยบริการ สถานบริการ หรือภาคเอกชน)	จัดหาอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นตามสภาพผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	จัดหาอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นตามสภาพผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นตามสภาพผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ที่นอนลมชุดออกซิเจน เตียงปรับระดับ เป็นต้น	จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นตามสภาพผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ที่นอนลมชุดให้ออกซิเจน เตียงปรับระดับ ชุดดูดเสมหะ/ของเหลว เป็นต้น

รูปที่ 24 การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบ่งตามผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ

ในระยะเริ่มแรกของแนวคิดการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดหมวดหมู่การสนับสนุนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในการจัดหาอุปกรณ์และการเบิกจ่ายนั้นเป็นไปตามแผนการดูแลส่วนบุคคล (Care Plan) ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละท่านที่กำหนดโดย Case Manager

อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการ และเป็นไปตามหลักการงบประมาณแผ่นดิน สปสช. ได้ประกาศแยกหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สามารถรับการสนับสนุนหรือจ่ายชดเชยได้ตามกองทุนต่าง ๆ ตามประกาศกองทุนฯ ว่าด้วยค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ชนิดของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นั้นล้อตาม

กลไกการสนับสนุนงบประมาณในการบริการทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) บริการสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 2) บริการสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ 3) บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน โดยรายละเอียดและหมวดหมู่ของอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ตามตารางที่ 13

ตารางที่ 13 รายละเอียดและหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทย

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือวัสดุทางการแพทย์	กระบวนการเบิกจ่าย หรือจ่ายชดเชย	การจัดหาและการส่งมอบให้ผู้รับบริการ
1. กายอุปกรณ์		
อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ 9 รายการ ได้แก่ 1. ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม 2. ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา 3. ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ 4. ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้ 5. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ 6. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ 7. เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ 8. รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ 9. แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม (98)	มีระเบียบในการสนับสนุนผ่านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ซึ่งให้การสนับสนุนผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสามารถสนับสนุนผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้เช่นกัน ราคาการเบิกจ่าย อ้างอิงราคากลาง 2566 (เท่ากับราคาในการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางสำหรับสิทธิ์การรักษาเบิกจ่ายตรง/ข้าราชการ)	ครุภัณฑ์เหล่านั้นมีสถานะเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานที่จัดซื้อ การส่งมอบมักอยู่ในรูปแบบการให้ยืมกายอุปกรณ์ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการผ่านธนาคารกายอุปกรณ์ และการทำเรื่องแสดงความจำเป็นในการขอยืมกายอุปกรณ์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดหาสถานที่ในการจัดเก็บกายอุปกรณ์ และมีการระบุระยะเวลาการยืมชัดเจน กระบวนการที่สำคัญได้แก่ 1. การตรวจประเมินเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการและการให้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 2. การเตรียมความพร้อมก่อนให้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 3. การติดตามการใช้งานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 4. การแก้ปัญหากรณีอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการชำรุด 5. การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือวัสดุทางการแพทย์	กระบวนการเบิกจ่าย หรือจ่ายชดเชย	การจัดหาและการส่งมอบให้ผู้รับบริการ
2. วัสดุสิ้นเปลือง		
ผ้าอ้อม แผ่นรองซับการขับถ่าย แผ่นเสริมซึมซับ และผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่ม 3 และ 4 ที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และกลุ่มผู้ที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ (99) (หมายเหตุ: ก่อนมีประกาศฉบับล่าสุด มีการแนะนำว่าให้เขียนโครงการตาม care plan แล้วเบิกในวงเงินเหมาจ่ายรายหัว 6,000 บาท/คน/ปี หากเขียนไม่พอในวงเงิน 6,000 บาท ให้โยกมาเบิกกับกองทุน สปสช. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้)	กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล) สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนไทยทุกสิทธิ ผ้าอ้อมอัตราชิ้นละ 9.50 บาท แผ่นรองซับการขับถ่ายอัตราชิ้นละ 6 บาท แผ่นเสริมซึมซับอัตราชิ้นละ 4.70 บาท (ต้องใช้ร่วมกับผ้าอ้อม ผ้าอ้อมทางเลือก (ยังไม่ได้กำหนดอัตราเนื่องจากยังไม่ถูกจัดให้เป็นวัสดุทางการแพทย์) มีการเสนอเพื่อขออนุมัติตาม care plan โดยลงบันทึกผ่านระบบข้อมูลบุคลากรการดูแลระยะยาวและแผนการดูแลรายบุคคล (โปรแกรม Long Term Care: 3C) จัดการโดยกรมอนามัย	กระบวนการประกอบด้วยการค้นหากลุ่มเป้าหมายทั้งเชิงรับและเชิงรับ ได้แก่ 1. บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มที่ 3 และ 4 ที่มีภาวะติดเตียง ที่มีการขึ้นทะเบียนรายใหม่ 2. บุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ค้นหาเชิงรับผ่านการเปิดให้ลงทะเบียน 3. บุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ค้นหาเชิงรุกโดยหน่วยบริการทำการค้นหากลุ่มเป้าหมายเอง จากนั้นจึงมีการจัดทำ care plan รายบุคคลเพื่อขอรับการสนับสนุน และเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตำบลต่อไป จากนั้นหน่วยบริการจะเป็นผู้จัดซื้อ และจัดหาจากผู้ประกอบการ ในอัตราราคาที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือวัสดุทางการแพทย์	กระบวนการเบิกจ่าย หรือจ่ายชดเชย	การจัดหาและการส่งมอบให้ผู้รับบริการ
3. ครุภัณฑ์จำเป็นอื่น ๆ		
เช่น ชุดให้อาหารทางสายยาง ชุดให้ออกซิเจน ชุดดูดเสมหะ/ของเหลว	กองทุนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ให้การสนับสนุนตาม care plan ที่จัดทำโดย case manager ภายในวงเงินตามประกาศของกองทุนฯ (10,442 บาท/คน/ปี) สำหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนไทยทุกสิทธิ (100) หมายเหตุ: การตีความเป็นไปตามความจำเป็นในการดูแลระยะยาวหลังจากผู้มีภาวะพึ่งพิงปรากฏอาการ หรือภาวะพึ่งพิงดังกล่าวไปแล้ว ดังนั้น อุปกรณ์บางประเภท เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต ถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับการคัดกรองก่อนให้บริการ จะไม่สามารถสนับสนุนโดยกองทุนฯ ได้	รูปแบบการดำเนินการขึ้นกับสถานบริการและ care manager
4. อาหารเสริม		
อยู่ในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อผู้มีภาวะพึ่งพิง (101)	กองทุนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ให้การสนับสนุนตาม care plan ที่จัดทำโดย case manager ภายในวงเงินตามประกาศของกองทุนฯ (10,442 บาท/คน/ปี) สำหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนไทยทุกสิทธิ	รูปแบบการดำเนินการขึ้นกับสถานบริการและ care manager

ผลลัพธ์ของระบบการดูแลระยะยาวในช่วงที่ผ่านมา

ข้อมูลจากสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านกำลังคน โครงสร้างบริการ และการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (แสดงดังตารางที่ 14)

ในด้านกำลังคน พบว่าจำนวนผู้จัดการการดูแล (care manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (caregiver) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 มีผู้จัดการการดูแลสะสมจำนวน 13,703 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 16,117 คนในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2565 ขณะที่จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุมีจำนวนสะสม 86,829 คนในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 98,575 คนในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2565

ในด้านการเข้าถึงบริการ พบว่าจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและได้รับบริการดูแลระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 67,023 คนในปี พ.ศ. 2559 เป็น 180,821 คนในปี พ.ศ. 2562 และเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานสะสม พบว่ามีผู้สูงอายุที่ได้รับบริการรวม 255,327 คนในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 396,955 คนในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2565

ในขณะเดียวกัน การจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของระบบการดูแลระยะยาว ก็เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน โดยมีจำนวน 57,936 แผนในปี พ.ศ. 2559 และเพิ่มขึ้นเป็น 167,118 แผนในปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานสะสม พบว่ามีการจัดทำ care plan รวม 228,664 แผนในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 370,366 แผนในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2565

นอกจากนี้ ระบบการรับรองตำบลที่ดำเนินการดูแลระยะยาวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (LTC accreditation) ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยจำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มจาก 1,569 ตำบลในปี พ.ศ. 2559 เป็น 6,282 ตำบลในปี พ.ศ. 2562 และเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานสะสม พบว่ามีตำบลที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 6,752 ตำบลในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 7,124 ตำบลในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2565 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98.19 ของตำบลเป้าหมาย

โดยรวมแล้ว ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของระบบบริการดูแลระยะยาวในประเทศไทย ทั้งในด้านกำลังคน การเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการพัฒนามาตรฐานบริการในระดับพื้นที่

นอกจากล่าสุดในปี พ.ศ. 2567 มีการกำหนดตัวชี้วัดและกำหนดผลลัพธ์ในแต่ละไตรมาส นอกเหนือจากจำนวนของผู้ให้บริการ อาทิเช่น ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ จำนวนชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ สัดส่วนของผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในเรือนจำ มากไปกว่านั้นยังมีตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ และพระคิลานุปัฏฐากและผู้นำทางศาสนาด้านสุขภาพ (6)

ตารางที่ 14 ผลการดำเนินการการดูแลระยะยาวจากสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย (102,103)

ตัวชี้วัด	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ผลการดำเนินงานสะสมระหว่าง	
					2559-2563	2559-2565
Care manager (คน)	3,252	4,424	5,623	367	13,703	16,117
Caregiver (คน)	27,696	22,304	27,325	380	86,829	98,575
ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล (คน)	6,023	99,495	182,812	180,821	255,327	396,955
การจัดทำ Care Plan (ฉบับ)	57,936	83,598	162,588	167,118	228,664	370,366
ตำบล LTC ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ)	1,569 (ร้อยละ 96) เฉพาะตำบลนำร่อง	3,709 (ร้อยละ 51)	5,158 (ร้อยละ 71)	6,282 (ร้อยละ 86)	6,752 (ร้อยละ 93.07)	7,124 (ร้อยละ 98.19) (Re-Accreditation)

การประเมินระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ตั้งแต่การจัดตั้งระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทยนั้น มีความพยายามในการประเมินระบบการดูแลระยะยาวเป็นระยะ ๆ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยจะทำการทบทวนผลการประเมินในอดีต เพื่อเป็นฐานในการประเมินในครั้งนี้

การประเมิน SWOT

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการริเริ่มและพัฒนาระบบ LTC สำหรับผู้สูงอายุมาหลายปี โดยมีกลไกการขับเคลื่อน และโครงการนำร่องในหลายระดับ แต่ในภาพรวม ระบบ LTC ยังคงเผชิญกับทั้งศักยภาพและข้อจำกัดในหลายมิติ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคาม (SWOT) ของระบบ (แสดงดังตารางที่ 15) จึงเป็นแนวทางสำคัญในการมองภาพรวมเชิงกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาในระยะต่อไป (6)

ตารางที่ 15 SWOT Analysis ของการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว

SWOT Analysis	**รายละเอียดในแต่ละด้าน**
จุดแข็ง (Strengths)	สังคมไทยยังคงมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุภายในครอบครัว เช่น ค่านิยมความกตัญญู ความสัมพันธ์ในครอบครัว และเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ประเทศไทยยังมีการจัดสรรงบประมาณจากหลายแหล่งทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ กองทุนสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งช่วยสนับสนุนการจัดบริการในระดับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีกรอบนโยบาย กฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่รองรับแนวทางการดำเนินงานในด้านนี้อย่างชัดเจน และต้นทุนทางสังคมที่สามารถนำมาต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มจิตอาสา การบริการนวดแผนไทย และกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
จุดอ่อน (Weaknesses)	การขาดกลไกด้านการคลังที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ขาดการจัดการในระดับนโยบายที่เชื่อมโยงหน่วยงานด้านสุขภาพและด้านสังคมอย่างเป็นองค์รวม ระบบบริการยังมีลักษณะแยกส่วน ไม่เป็นระบบ และขาดการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการวางแผนการให้บริการ นอกจากนี้ยังขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางทั้งในมิติสุขภาพและสังคม และไม่มีระบบสนับสนุนบุคลากรผู้ดูแลในระยะยาว ขอบเขตหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการ LTC ก็ยังไม่มีความชัดเจนทางกฎหมาย ขาดระเบียบรองรับ และยังไม่มีการออกกฎหมายส่งเสริมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายใน LTC

SWOT Analysis	รายละเอียดในแต่ละด้าน
โอกาส (Opportunities)	ระบบ LTC ได้รับความสนใจในระดับนโยบายทั้งจากรัฐบาลโดยตรงและจากองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งยังเอื้อต่อการพัฒนาระบบที่ยึดฐานชุมชนเป็นศูนย์กลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นที่มีความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานด้าน LTC และกองทุนสุขภาพตำบลเป็นกลไกทางการคลังที่สามารถขยายผลการดำเนินงานได้ครอบคลุมทั่วประเทศ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพและแนวทางการพัฒนาระบบบริการตามแผน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถสนับสนุนระบบได้ในระยะยาว
ปัจจัยคุกคาม (Threats)	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและครอบครัวอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดควบคู่กับอัตราการเกิดที่ลดลง ส่งผลให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ขณะที่ระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับภาระด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและภาวะพึ่งพิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบบริการทางสังคมของไทยเองก็ยังไม่มีโครงสร้างถาวรที่รองรับ LTC อย่างยั่งยืน และยังคงพึ่งพาโครงการเฉพาะกิจหรือโครงการนำร่องที่ขาดความต่อเนื่อง

การประเมินภายใต้โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long term care) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินนโยบายระบบ LTC สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย ได้มีการดำเนินการประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทางการขับเคลื่อนผ่านกลไกกองทุนสุขภาพระดับตำบล รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดบริการและความครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เฉพาะสี่ประการ ได้แก่

1. เพื่อประเมินความสอดคล้องของการดำเนินระบบ LTC ผ่านกองทุนตำบลกับเจตนารมณ์ของนโยบาย ตลอดจนปัจจัยส่งเสริม อุปสรรค และช่องว่างในระดับพื้นที่
2. เพื่อประเมินขอบเขตของบริการที่จัดขึ้นและความครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายในระบบ LTC

3. เพื่อประเมินกระบวนการให้บริการและการบริหารจัดการกำลังคนในระบบ LTC
4. เพื่อศึกษาบทบาทของกลไกสนับสนุนจากส่วนกลาง เขต จังหวัด และอำเภอ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง

ตารางที่ 16 สรุประเบียบวิธีวิจัยของการประเมินแผนการวิจัยในโครงการฯ

ระเบียบวิธีวิจัย: การประเมินใช้ระเบียบวิธีแบบ formative evaluation โดยอาศัยกรอบแนวคิดจากการวิจัยเชิงระบบ (translation research) และโมเดลระบบLTCขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework on Integrated Care for Older People) นอกจากนี้ การศึกษาดำเนินการในลักษณะวิจัยแบบผสมผสาน (mixed-methods research) ซึ่งประกอบด้วยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ	การเก็บข้อมูลดำเนินการในรูปแบบภาคตัดขวางผ่านแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยมีประชากรเป้าหมายคือ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีบทบาทในคณะอนุกรรมการ LTC ระดับตำบล และตัวแทนโรงพยาบาลที่รับผิดชอบการดำเนินงาน LTC ในพื้นที่นำร่องของปีแรกของการดำเนินนโยบาย ผลการตอบแบบสอบถามที่ได้คือจากตัวแทน อปท. 397 แห่ง จากทั้งหมด 1,067 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 37) และจากตัวแทนโรงพยาบาล 246 แห่งจาก 892 แห่ง (ร้อยละ 28)
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	การเก็บข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการทบทวนเอกสารนโยบายและการดำเนินงาน โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (purposive sampling) ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารส่วนกลาง (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้บริหารเขตสุขภาพ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาล ไปจนถึงผู้จัด LTC (Care Manager: CM) ผู้ดูแล (Caregiver: CG) และอาสาสมัครในพื้นที่ชุมชน
พื้นที่การศึกษา	พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งหมด 24 ตำบลจาก 11 จังหวัด โดยกระจายทั่ว 4 ภาคของประเทศ และครอบคลุมทั้งพื้นที่นำร่องเดิมจากโครงการของ JICA, สปสช., และ สสส. ตลอดจนพื้นที่นำร่องใหม่ภายหลังการประกาศใช้นโยบาย LTC อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความหลากหลายของลักษณะพื้นที่ และบริบททางสังคมการเมืองในระดับท้องถิ่น

สรุปผลการศึกษา

1. ประสิทธิผลของกลไกกองทุนตำบล กลไกกองทุนสุขภาพตำบลถูกนำมาใช้เป็นฐานการขับเคลื่อนระบบดูแลระยะยาวในชุมชน โดยมอบบทบาทหลักให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขณะที่โรงพยาบาลมีบทบาทสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ การบริหารงบประมาณ และการบูรณาการกับบริการที่มีอยู่เดิมยังมีข้อจำกัด ปัญหาสำคัญคือขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณที่ซับซ้อน และความไม่มั่นใจในระเบียบการใช้จ่ายงบ LTC โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องบริหารร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่

2. ขอบเขตบริการและความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย บริการ LTC ในระยะแรกเน้นหนักไปที่การดูแลด้านสุขภาพ เช่น การเยี่ยมบ้าน การฟื้นฟูสมรรถภาพ การดูแลต่อเนื่องผ่านการดูแลที่บ้าน (Home Health Care: HHC) โดยเน้นความต่อเนื่องของการดูแล (Continuity of Care: COC) ซึ่งมีความสม่ำเสมอมากกว่าบริการด้านสังคม ข้อมูลจากทั้ง อปท. และโรงพยาบาลสะท้อนว่าบริการทางสังคมมักประสบปัญหาเรื่องข้อจำกัดด้านระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ อีกทั้งความแตกต่างในวิธีการจ่ายค่าตอบแทน CG ส่งผลต่อความเสถียรของระบบ โดยพื้นที่ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอมักมีประสิทธิภาพการจัดบริการที่ดีกว่า ในด้านความครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมาย พบว่าระบบ LTC ในช่วงเริ่มต้นจำกัดเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน 4 กลุ่มหลัก และเฉพาะผู้ใช้สิทธิ UC ทำให้ไม่สามารถครอบคลุมผู้มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มดังกล่าวได้

3. กระบวนการจัดบริการและการบริหารจัดการกำลังคน ระบบ LTC มีการพัฒนาแนวทางจัดทำ Individual Care Plan โดยใช้กระบวนการ case conference เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงผู้สูงอายุ ญาติ และภาคีต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ความไม่ชัดเจนในการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานกลาง เช่น สปสช. กับกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้การผลิตและกระจายกำลังคน เช่น CM และ CG ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บางพื้นที่ไม่มี CM รองรับบริการ ขณะที่บางพื้นที่อบรม CG โดยไม่มี CM นำทีม จึงเกิดความไม่ต่อเนื่องของระบบบริการ

นอกจากนี้ แนวคิดที่ไม่ตรงกันเรื่อง “จิตอาสา” กับ “การจ้างงาน” CG ส่งผลให้หลายพื้นที่ลังเลในการจ่ายค่าตอบแทน CG หรือจ่ายในอัตราไม่เป็นมาตรฐาน ปัญหานี้ยังเชื่อมโยงกับความยากในการหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรม และอัตราการคงอยู่ในระบบที่ต่ำ

4. ระบบและกลไกการสนับสนุนจากส่วนกลางและระดับพื้นที่ ความไม่สอดคล้องกันในระดับนโยบายระหว่างหน่วยงานกลาง เช่น สปสช., กระทรวงสาธารณสุข, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สตง. ทำให้ท้องถิ่นเกิดความสับสนและลังเลต่อการใช้จ่ายงบ LTC แม้จะมีแนวทางและหนังสือเวียนออกมาแล้วก็ตาม ระบบการอบรม CM และ CG ยังขาดความเชื่อมโยงในระดับกลไก ทำให้กระบวนการจัดบริการในพื้นที่ไม่ราบรื่น

อย่างไรก็ตาม ระดับจังหวัดและอำเภอยังคงเป็นหน่วยสนับสนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะโรงพยาบาลในอำเภอ ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทเชิงบวกในการขับเคลื่อนนโยบาย ส่วนบทบาทของฝ่ายปกครองยังมีความหลากหลาย โดยบางพื้นที่ได้รับการสนับสนุนที่ดี ขณะที่บางพื้นที่ยังขาดการมีส่วนร่วมจากฝ่ายปกครองอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากข้อค้นพบในการประเมิน พบว่าความไม่ชัดเจนในด้านกฎระเบียบ บทบาทขององค์กรต่าง ๆ และการสื่อสารนโยบายจากส่วนกลางเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน LTC ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญจึงประกอบด้วย

- เร่งจัดทำระเบียบการใช้งบ LTC ที่ชัดเจน โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งบประมาณ รวมถึงอาจพัฒนาโปรแกรมช่วยบริหาร Care Plan และการอนุมัติการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับกฎหมายการเงินของ อปท.
- บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานกลาง โดยเฉพาะ สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานเขต/จังหวัด ควรมีการประสานข้อมูลร่วมกันตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพื้นที่ การจัดสรรโควตา และการอบรมบุคลากร (CM / CG) อย่างเป็นระบบ
- พัฒนาบทบาทของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น ให้สามารถทำหน้าที่จัดการงบ LTC และบริหารค่าตอบแทน CG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุและกระทรวงมหาดไทย
- ยกระดับการสื่อสารนโยบาย โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์รวมคำถามที่พบบ่อย วิดีทัศน์แนะนำเอกภาพของนโยบาย และเอกสารต้นแบบทางการเงิน เพื่อเพิ่มความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่

- พิจารณาทบทวนกลไกพิจารณา Care Plan ระดับตำบล โดยอาจยกระดับมาที่อำเภอ และให้ System Manager ภายใต้ระบบ DHS มีบทบาทบูรณาการระบบบริการให้ราบรื่นขึ้น
- ขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายและสิทธิการเข้าร่วม ไม่จำกัดเฉพาะผู้สูงอายุในระบบ UC เท่านั้น แต่ควรครอบคลุมประชากรทุกสิทธิ์ที่มีภาวะพึ่งพิง และอยู่ในชุมชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและตอบโจทย์สุขภาพถ้วนหน้าอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะด้านการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

จากช่องว่างในการดำเนินงาน LTC ในระยะแรก พบประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายและระบบบริการ ได้แก่

- เปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้งบผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับสถานพยาบาลว่ามีผลต่อคุณภาพการจัดบริการและการบริหารจัดการในพื้นที่แตกต่างกันหรือไม่
- ประเมินผลกระทบและความยั่งยืนของแนวทาง CG แบบมีค่าตอบแทนและแบบจิตอาสา ทั้งในแง่ความคุ้มค่า (cost-effectiveness) และผลต่อความต่อเนื่องในการดูแลผู้สูงอายุ
- ถอดบทเรียนจากพื้นที่ที่สามารถบูรณาการบริการได้ดี เพื่อระบุปัจจัยด้านโครงสร้างและระบบที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงบริการทางสุขภาพและบริการด้านสังคมในระดับพื้นที่

การประเมินภายใต้โครงการประเมินและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่มุ่งเป้าในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและรายงานผลการประเมินรอบแรก ซึ่งให้ภาพสะท้อนทั้งในเชิงผลสัมฤทธิ์ของนโยบายและจุดอ่อนเชิงระบบ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการออกแบบยุทธศาสตร์ในระยะถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (104) จากการประเมินการดำเนินงานในช่วงปี 2559 - 2561 สามารถสรุปจุดแข็งของแผนยุทธศาสตร์ได้ดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17 จุดเด่นของแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงฉบับที่ 1

จุดเด่นของแผนยุทธศาสตร์	รายละเอียด
การกำหนดทิศทางที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง	แผนยุทธศาสตร์มุ่งเป้าไปยังผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีคะแนน ADL ≤ 11 ซึ่งอยู่ในภาวะติดบ้านหรือติดเตียง การเน้นการดูแลที่บ้านในชุมชนส่งผลดีหลายประการ ได้แก่ ลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการดูแลในสถานบริบาล (จาก 15,000–30,000 บาท/เดือน เหลือเพียง 6,000 บาท/คน/ปี) ลดจำนวนผู้สูงอายุที่นอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น และสร้างงานในท้องถิ่นผ่านการจ้างงานนักบริบาลชุมชน (Caregiver, CG)
ความพยายามบูรณาการระดับนโยบาย	แผนดังกล่าวผลักดันให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับชาติ เช่น สปสช., กระทรวงสาธารณสุข, และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ LTC
การจัดสรรบทบาทของหน่วยงานตาม 6 ยุทธศาสตร์	แผนฯ ระบุบทบาทและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้งหกด้าน ได้แก่ การคัดกรอง การจัดบริการ การเงิน กำลังคน ข้อมูล และกฎหมาย
การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่วัดผลได้	มีการออกแบบตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงาน และสะท้อนผลลัพธ์ในแต่ละระดับได้
มีโครงสร้างการกำกับติดตามระดับชาติ	คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ LTC ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ขับเคลื่อน ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน
เกิดรูปธรรมในบางด้านของการดำเนินงาน	เช่น สปสช. จัดสรรงบประมาณต่อเนื่องในด้านการเงิน ด้านกำลังคน มีการอบรม CM และ CG อย่างชัดเจน และด้านบริการมีการคัดกรองผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมการจัดทำแผนดูแล (care plan) ในบางพื้นที่

และแม้แผนยุทธศาสตร์จะมีจุดเด่นหลายประการ แต่ในทางปฏิบัติก็พบข้อจำกัดสำคัญในทุกมิติของระบบ โดยสามารถจำแนกออกเป็น 5 ด้านหลักดังแสดงในตารางที่ 18

ตารางที่ 18 สรุปโอกาสและข้อจำกัดของแผนยุทธศาสตร์ LTC

โอกาสและข้อจำกัด	รายละเอียด
ด้านการเงินการคลัง	ระบบงบประมาณของรัฐที่ยังคงยึดตามกิจกรรม (functional-based budgeting) มากกว่าการมุ่งผลลัพธ์ (result-based) ทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่ตอบสนองกับความหลากหลายของบริบทพื้นที่ (area-based) อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังพบข้อจำกัดด้านระเบียบการเบิกจ่าย โดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทน CG ที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ รวมถึงการตีความระเบียบที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ซึ่งนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงงบประมาณ สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความจำเป็นในการปรับโครงสร้างการเงินการคลังของภาครัฐให้ยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การดูแลในพื้นที่อย่างเป็นธรรม
ด้านกำลังคน	บทบาทของ CG ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการดูแลแบบรายวันอย่างต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ครอบครัวไม่สามารถเป็นผู้ดูแลหลัก ซึ่งแตกต่างจากในหลายประเทศพัฒนาแล้วที่มีมาตรการสนับสนุนญาติผู้ดูแลเพื่อชะลอความเสื่อมถอยของครัวเรือน นอกจากนี้ยังพบข้อขัดแย้งในบางพื้นที่ระหว่าง อสม. และ CG เนื่องจากแนวคิดค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน ตลอดจนภาระงานที่ทับซ้อนกัน การกำหนดบทบาทของพยาบาล รพ.สต. ในฐานะ care manager ก็เผชิญข้อจำกัดจากภาระงานเดิม ทำให้การวางแผนดูแล (care plan) ขาดความละเอียดและความทันสมัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะซับซ้อน
ด้านสารสนเทศ	ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการวางแผนและการประเมินผลยังขาดความครอบคลุมและทันสมัย โดยเฉพาะในมิติการประเมินคุณภาพการดูแลรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐาน เช่น จำนวนผู้สูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบ LTC ยังไม่มีความแม่นยำพอจะใช้วางแผนหรือตัดสินเชิงนโยบาย แม้ สปสช. จะมีบทเรียนจากการพัฒนาระบบสารสนเทศในกรณีอื่น เช่น stroke fast track หรือยา ARV แต่ยังไม่มีการยกระดับความสำคัญของสารสนเทศในระบบ LTC อย่างชัดเจน
ด้านองค์กรและการอภิบาลระบบ	การนำเชิงนโยบายยังขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้นำบ่อยครั้ง ส่งผลให้การขับเคลื่อนขาดเสถียรภาพ นอกจากนี้กลไกระดับชาติที่มีบทบาทในการร่างแผน เช่น คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ หรือ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แม้สามารถขับเคลื่อนนโยบายเข้าสู่วาระสาธารณะได้ แต่ยังไม่สามารถสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือสร้าง

โอกาสและข้อจำกัด	รายละเอียด
	แรงขับเคลื่อนในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ความไม่ต่อเนื่องในการติดตามประเด็นเดิมจึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการยกระดับระบบ LTC ให้เป็นกลไกถาวร
ด้านการวิจัยและพัฒนา	แม้ สปสช. จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ แต่การใช้จุดแข็งนี้ในการพัฒนาต้นแบบการบริการและกลไกควบคุมกำกับยังเกิดขึ้นในวงจำกัด การขาดการพัฒนารูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการดำเนินงาน อีกทั้ง การสร้างความรู้ร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายยังไม่เพียงพอที่จะสร้างฐานความรู้สำหรับพัฒนาระบบในระยะยาว

ทั้งนี้ ยังมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ LTC ฉบับแรก ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในแต่ละด้านมีความคืบหน้าแตกต่างกัน โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 19

ตารางที่ 19 สรุปการประเมินความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดทั้ง 6 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	รายละเอียด
1. การคัดกรองและพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุ	มีความคืบหน้าชัดเจนในด้านการจัดทำเกณฑ์จำแนกภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ และมีการคัดกรองผู้สูงอายุจำนวนมาก โดยรายงานของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า มีการคัดกรองได้กว่า 6.67 ล้านคน หรือประมาณ 55% ของผู้สูงอายุทั้งหมดในประเทศ อย่างไรก็ตาม จำนวน อปท. ที่มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีการโอนงบประมาณจาก สปสช. ไปยังหน่วยบริการ ทำให้ไม่สามารถจัดทำ care plan และฐานข้อมูลได้ครบถ้วน
2. การพัฒนาระบบ LTC ในชุมชน	มีความก้าวหน้าในด้านการกำหนดมาตรฐานหลักสูตรและการจัดอบรม CM และ CG รวมถึงการจัดบริการโดย รพ.สต. และการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม โดยมีการคัดกรองความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบ LTC เช่น ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และภาวะสมองเสื่อม อย่างไรก็ตาม บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยังเน้นเฉพาะการจัดการทางการ เงินมากกว่าการให้บริการจริง และผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียงที่ได้รับการดูแลครอบคลุมประมาณ 70% ซึ่งยังไม่ทั่วถึงทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์	รายละเอียด
3. การพัฒนาระบบการเงินการคลังและชุดสิทธิประโยชน์	เป็นด้านที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด มีเพียงการเริ่มต้นกำหนดชุดสิทธิประโยชน์เบื้องต้น แต่ยังขาดการออกแบบรูปแบบการจ่ายที่เหมาะสม และการบูรณาการแหล่งเงินที่หลากหลาย กองทุนฟื้นฟูจังหวัดยังไม่ขยายการดำเนินงาน ส่งผลให้การจัดบริการในระดับพื้นที่มีข้อจำกัด
4. การพัฒนากำลังคน	มีความคืบหน้าเด่นชัดในการอบรม CM และ CG โดยมีกระบวนการฝึกอบรมที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ยังไม่มีความชัดเจน และการบูรณาการทีมสหวิชาชีพในระดับพื้นที่ยังจำกัด
5. การจัดการความรู้และการติดตามประเมินผล	แม้จะมีการกำหนดตัวชี้วัดไว้ถึง 5 ด้าน แต่การดำเนินการยังล่าช้า โดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่ควรรองรับการวางแผนและประเมินผลที่ยังไม่มีความทันสมัยและเชื่อถือได้เพียงพอ ข้อเสนอด้านการเงินการคลัง และการพัฒนารูปแบบการจ่ายที่เหมาะสมก็ยังไม่มีการจัดทำอย่างเป็นระบบ
6. การพัฒนากฎหมาย/ระเบียบ และการบริหารจัดการ	มีความคืบหน้าในระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้ประกาศให้บริการ LTC เป็นสิทธิของผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง รวมถึงมีประกาศให้อปท. มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดบริการในระดับพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การออกระเบียบรองอื่น ๆ เช่น การควบคุมดูแลสถานบริบาลเอกชน (nursing home) ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และการบังคับใช้ในทางปฏิบัติก็ยังมีข้อจำกัดหลายประการ

<u>ประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อความยั่งยืน</u>

- การขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ของภาคีหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เกิดช่องว่างในการขับเคลื่อนจริงในระดับปฏิบัติ
- รูปแบบการดำเนินงานบางประเด็น เช่น การจ้าง CG แบบมีค่าตอบแทน ยังขัดแย้งกับบริบทการทำงานของ อสม. ซึ่งเป็นอาสาสมัครในชุมชน
- ขาดการเชื่อมโยงบริการระยะยาวเข้ากับบริการ acute care และระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดูแลผู้สูงอายุ
- ข้อมูลจากภาคสนามชี้ว่า ความสำเร็จในบางพื้นที่อาศัยผู้นำที่มีความเข้าใจและมีแรงผลักดันสูง ซึ่งสะท้อนถึงภาวะการนำที่ไม่สม่ำเสมอในภาพรวม

ข้อเสนอของคณะทำงานเฉพาะกิจภายใต้คณะทำงานพัฒนาบริการสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง ระยะยาวในชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ

นอกจากนี้ ใน ปี พ.ศ. 2565 สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจภายใต้คณะทำงานพัฒนาบริการสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาของระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน อย่างไรก็ตาม จากบทเรียนการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา ยังคงพบข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง ความไม่ต่อเนื่องของงบประมาณ และข้อท้าทายด้านความยั่งยืนของระบบการจ้างงานและคุณภาพการดูแลในระดับพื้นที่ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของแนวทางสำหรับการยกระดับและปรับปรุงระบบในประเทศไทยให้มีคุณภาพ ความครอบคลุม และความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งในเชิงโครงสร้าง นโยบาย และการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<u>หลักการพัฒนาระบบการดูแลที่มีคุณภาพตามแนวคิด SAFE</u>

การพัฒนาระบบ LTC ควรตั้งอยู่บนหลักการ SAFE ได้แก่

- **S (Sustainable):** ยั่งยืนด้วยกลไกการสนับสนุนจากรัฐและชุมชน
- **A (Adequate):** เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ
- **F (Fair):** เป็นธรรมต่อผู้ดูแล ครอบครัว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- **E (Efficiency):** มีประสิทธิภาพทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ระบบควรสนับสนุนให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแลหลัก โดยมีภาครัฐ อปท. และชุมชนร่วมเกื้อหนุนในทุกมิติอย่างยั่งยืน โดยองค์ประกอบของบริการ LTC ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ การดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน การบริหารจัดการโดย CM การเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองทั่วไป

ข้อเสนอที่ 1 การปรับปรุงเกณฑ์จำแนกกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง

ข้อเสนอคือการปรับขอบเขตของผู้มีสิทธิเข้ารับบริการให้ครอบคลุมกลุ่มที่มีภาวะสมองเสื่อมปานกลางขึ้นไป รวมถึงผู้ป่วยระยะประคับประคอง โดยใช้ค่า PPS (Palliative Performance Scale) ดังต่อไปนี้ (แสดงดังตารางที่ 20)

ตารางที่ 20 สรุปการปรับปรุงเกณฑ์จำแนกกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง

การจำแนกกลุ่ม	กลุ่มเป้าหมาย	ค่าใช้จ่ายต่อคน / ปี (บาท)
กลุ่มที่ 1	ผู้ป่วยติดบ้านไม่มีภาวะสับสน / PPS = 50%	60,575
กลุ่มที่ 2	ผู้ป่วยติดบ้านมีภาวะสับสน / สมองเสื่อมระดับปานกลาง	98,256
กลุ่มที่ 3	ผู้ป่วยติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อน / PPS = 40%	138,011
กลุ่มที่ 4.1	ผู้ป่วยติดเตียงมีภาวะแทรกซ้อน / PPS = 30%	174,825
กลุ่มที่ 4.2	ผู้ป่วยระยะใกล้เสียชีวิต / PPS < 30%	14,784/2 สัปดาห์

โดยค่าใช้จ่ายด้านสังคม เช่น ค่าเสียโอกาสของผู้ดูแลในครอบครัว มีสัดส่วนสูงถึงกว่า 90% ในกลุ่ม 1 - 2 และลดลงในกลุ่มอาการหนัก

ข้อเสนอที่ 2 ทางเลือกนโยบายด้านการเงินการคลังในการสนับสนุนจากรัฐ

ในการสนับสนุนของภาครัฐนั้นจัดทำเป็น 3 ทางเลือกสำหรับบริการประเภทต่าง ๆ โดยทางเลือก 2 เป็นทางเลือกหลักที่พึงปรารถนา ส่วนทางเลือก 1 และ 3 เป็นทางเลือกที่ยอมรับได้ในกรณีมีข้อจำกัดในระบบบริการและ การเงินการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (แสดงดังตารางที่ 21)

ตารางที่ 21 สรุปทางเลือกนโยบายด้านการเงินการคลังในการสนับสนุนจากรัฐ

รายการสนับสนุน	ทางเลือกที่ 1	ทางเลือกที่ 2	ทางเลือกที่ 3
สนับสนุนค่าบริหารการดูแล	สนับสนุน	สนับสนุน	สนับสนุน
เยี่ยมบ้านโดย CM / ทีมสหวิชาชีพ	สนับสนุน	สนับสนุน	สนับสนุน
อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์	60%	80%	80%
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล	15,628 ราย	20,930 ราย	20,930 ราย
วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	30%	40%	100%
ค่าใช้จ่ายรวมโดยเฉลี่ย/คน/ปี	24,732 บาท (รัฐสนับสนุน 29%)	32,680 บาท (รัฐสนับสนุน 38%)	44,677 บาท (รัฐสนับสนุน 52%)

โดยแหล่งรายได้และข้อเสนอเชิงโครงสร้าง มาจากภาษีส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อรองรับทั้งด้านสุขภาพและสังคม โดยเฉพาะงบอุดหนุน อปท. ที่ศักยภาพจำกัด และการประกันระยะยาวโดยเสนอให้ผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไปสมทบปีละ 300 บาท ซึ่งจะเพียงพอสำหรับการสนับสนุนวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป

ทั้งนี้ ประโยชน์เชิงระบบของการจัดบริการ LTC ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่

1. ผู้มีภาวะพึ่งพิง 300,000 - 500,000 คน/ปี จะได้รับบริการอย่างเหมาะสม
2. ครอบครัวได้รับการสนับสนุน ลดภาระการดูแล และยังสามารถประกอบอาชีพได้
3. ลดภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ ปอดอักเสบ ภาวะติดเชื้อ
4. ลดค่าใช้จ่ายสุขภาพระยะท้ายชีวิต (ลดค่ายา 13%, ค่ารักษา รพ. 35%, ผู้ป่วยนอก 16%)
5. สร้างงานในชุมชนปีละ 15,000 - 20,000 อัตรา ลดการย้ายถิ่น และเสริมพลังเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ

ข้อเสนอที่ 3 การพัฒนารูปแบบการจ้างงานเต็มเวลา: จากอาสาสมัครสู่ระบบอาชีพ

ระบบ LTC ที่ริเริ่มขึ้นในช่วงต้น มักดำเนินการโดยอาศัยพลังของ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ซึ่งได้รับการอบรมในระยะสั้นและได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเบี้ยเลี้ยงแบบไม่ประจำ แม้ระบบอาสาสมัครจะสามารถขยายเครือข่ายบริการดูแลได้อย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังหรือครอบครัวที่มีข้อจำกัดในการดูแล แต่เมื่อระบบดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 - 10 ปัญหาทางโครงสร้างหลายประการเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้น ได้แก่

- ความไม่ชัดเจนของสถานะและความมั่นคงของอาสาสมัครบริบาล
- ความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรค่าตอบแทนและอัตราการจ้างงานระหว่างพื้นที่
- ความไม่ต่อเนื่องของการสนับสนุนจากงบประมาณส่วนกลาง
- ความสามารถจำกัดในการบูรณาการกับระบบบริการสุขภาพในพื้นที่
- ช่องว่างระหว่างภาระงานจริงกับบทบาทหน้าที่ตามที่กำหนดไว้

สถานการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของการพึ่งพาอาสาสมัครเป็นหลักในระบบ LTC และนำไปสู่ข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบ “จ้างงานเต็มเวลา” ที่มีความมั่นคง มีระบบอบรมและกำกับดูแลที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเปลี่ยนอาสาสมัครจากบทบาทจิตอาสาไปสู่บุคลากรดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่มีสถานะและคุณภาพในระดับเดียวกับงานบริการสุขภาพอื่น ๆ

นอกจากนี้ การประเมินผลของโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ยังได้ชี้ให้เห็นว่า ในพื้นที่ที่มีการสนับสนุนให้มีการจ้างงานต่อเนื่องในลักษณะใกล้เคียงกับงานประจำ ผู้สูงอายุในชุมชนมีแนวโน้มที่จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าพื้นที่ที่ยังดำเนินการในรูปแบบอาสาสมัครเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนารูปแบบการจ้างงานเต็มเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนจึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างระบบดูแลระยะยาวที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ และยั่งยืนภายใต้บริบทของการสูงวัยของประชากรในระยะยาว

การประเมินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมาได้มีการประเมินประสิทธิภาพและอุปสรรคในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” (อสบ.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แบบสุ่มอย่างเป็นระบบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศจำนวน 1,466 แห่ง มีเพียง 625 แห่งที่สามารถติดต่อได้ และมีเพียง 243 แห่ง (ร้อยละ 39) ที่ให้ข้อมูล เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมโครงการหรือไม่สามารถตอบได้ (105)

โดยผลการประเมินสามารถสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ (แสดงดังตารางที่ 22)

ตารางที่ 22 สรุปผลการประเมินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประเด็นข้อค้นพบ	รายละเอียดสำคัญ
การดำเนินโครงการ	ร้อยละ 95 ของอปท.ที่เข้าร่วม มีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบฯ และร้อยละ 93 รับทราบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ร้อยละ 88 ได้ดำเนินการอบรมอาสาสมัครแล้ว ส่วนหนึ่งยังไม่สามารถสรรหา อสบ. ได้ครบตามจำนวนที่รับงบสนับสนุน
ลักษณะการบริหารในพื้นที่	ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง และเป็นบุคลากรที่ไม่ได้มาจากสายงานสาธารณสุขโดยตรง โดยเฉลี่ยอาสาสมัคร 1 คนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2.7 - 4.5 คน ในขณะที่ CG มีอยู่เฉลี่ย 1.9 คนต่ออปท. บางแห่งมีเพียง 1 คนเนื่องจากไม่มีผู้สมัครเพิ่ม
แหล่งงบประมาณ	การดำเนินงานพึ่งพางบ LTC ของ สปสช. เป็นหลัก (ร้อยละ 86) ที่เหลือเป็นงบท้องถิ่นและแหล่งอื่น การจัดการอยู่ภายใต้กลไกคณะอนุกรรม LTC ในระดับท้องถิ่น
ความยั่งยืนของโครงการ	หากงบกู้สิ้นสุดลง อปท. ร้อยละ 47 ระบุว่าจะตั้งงบของตนเพื่อจ้างต่อ ร้อยละ 34 ยังรอนโยบาย และร้อยละ 20 ระบุว่าจะยุติโครงการ โดยให้กลับไปใช้ระบบ CG เดิมแทน

โดยอุปสรรคที่พบในการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) ได้แก่

- ระเบียบยังขาดความชัดเจน และค่าตอบแทนต่ำ
- ไม่เกิดการบูรณาการกับระบบ CG เดิม
- การจัดการภายในอปท. ยังไม่เข้มแข็ง
- การขาดช่วงจาก COVID-19 ทำให้การดำเนินงานสะดุด
- ขาดงบประมาณและระบบข้อมูลที่ชัดเจน

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้แก่

- สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า อสบ. คือส่วนหนึ่งของระบบ LTC และควรได้รับการผลักดันเป็นกลไกหลักในชุมชน
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่
- จัดตั้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจโดยแยกตามระดับความสามารถทางการเงินของแต่ละอปท.
- ปรับค่าตอบแทนและจัดสรรงบเดินทางสำหรับพื้นที่ห่างไกล
- ให้โรงพยาบาลในพื้นที่จัดอบรมทักษะและฟื้นฟูความรู้ของ อสบ. อย่างต่อเนื่อง

การประเมินโครงการและปัจจัยขับเคลื่อนเชิงระบบของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

นอกจากนี้ในช่วงปี 2565 ได้มีการประเมินประสิทธิภาพโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) ใน LTC ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และศึกษาปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือข้อจำกัดของโครงการ เพื่อเสนอแนวนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ผ่านการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามไปรษณีย์ใน 24 จังหวัด 144 อำเภอ 528 ตำบล และเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มใน 6 จังหวัด รวมทั้งการสำรวจครัวเรือนที่มีผู้ดูแลและผู้สูงอายุจำนวน 279 และ 224 รายตามลำดับ (106)

โดยผลการประเมินสามารถสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ (แสดงดังตารางที่ 23)

ตารางที่ 23 สรุปผลการประเมินโครงการและปัจจัยขับเคลื่อนเชิงระบบของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประเด็นข้อค้นพบ	รายละเอียดสำคัญ
การตอบสนองต่อปัญหาท้องถิ่น	อปท.ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90+) เห็นว่าโครงการ อสบ. เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสามารถแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความยั่งยืน	ร้อยละ 70 ของ อปท. แสดงเจตจำนงที่จะจ้าง อสบ. ต่อแม้งบกลางสิ้นสุด แต่มีความกังวลเรื่องงบประมาณที่จำกัดและค่าตอบแทนที่ต่ำ
ทัศนคติของ อสบ.	มากกว่าร้อยละ 90 ของ อสบ. มีความเต็มใจทำงานต่อเนื่อง แม้งานหนักและมีข้อจำกัดด้านรายได้ เพราะรู้สึกว่าการทำงานของตนได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่า
ผลต่อครอบครัว	พื้นที่ที่มีการดำเนินการที่ดีพบว่าช่วยลดภาระของครอบครัว และผู้ดูแลรู้สึกพึงพอใจมากขึ้น แม้คุณภาพบริการระหว่างพื้นที่ยังแตกต่างกันไม่ชัดเจน

โดยสรุป จากการพิจารณาองค์ประกอบของระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยในบทนี้ พบว่าการพัฒนาระบบดังกล่าวมีลักษณะเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งด้านนโยบายระดับชาติ กลไกการบริหารจัดการ การจัดบริการสุขภาพและสังคมในระดับพื้นที่ ตลอดจนการสนับสนุนด้านงบประมาณและกำลังคนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย นอกจากนี้ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของภาครัฐในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเข้าถึงบริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม จากบทเรียนและผลการประเมินการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมายังพบข้อจำกัดบางประการทั้งในด้านการเข้าถึงบริการ ความครอบคลุมของระบบ และความพร้อมของกลไกสนับสนุนในระดับพื้นที่ ดังนั้น เพื่อทำความเข้าใจถึงพัฒนาการของระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทยภายหลังการดำเนินนโยบายและการจัดบริการมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งทศวรรษ บทถัดไปจะนำเสนอผลการศึกษาของการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมุ่งประเมินภาพรวมของการพัฒนาระบบดังกล่าว รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในอนาคต

บทที่ 5
การวิเคราะห์การเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวของประชากรไทย

บทที่ผ่านมานำเสนอแนวคิด หลักการ และโครงสร้างของระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย โดยอธิบายพัฒนาการของนโยบาย กลไกการดำเนินงาน และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาระบบดังกล่าวในบริบทของประเทศ อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจระบบการดูแลระยะยาวอย่างรอบด้านไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการพิจารณาในเชิงโครงสร้างนโยบายหรือการออกแบบระบบเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องพิจารณาถึงสถานการณ์การเข้าถึงบริการและผลลัพธ์ของระบบที่เกิดขึ้นจริงในประชากรกลุ่มเป้าหมายด้วย

ดังนั้น บทนี้จึงมุ่งนำเสนอผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อประเมินภาพรวมของสถานการณ์การเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวของประชากรไทย โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจผู้สูงอายุของสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการให้บริการจากฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การวิเคราะห์ในบทนี้จะครอบคลุมทั้งลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รูปแบบการเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาว แหล่งการดูแลและบทบาทของครอบครัว ตลอดจนแนวโน้มการใช้บริการในระบบสุขภาพภายหลังการเข้าสู่ระบบการดูแลระยะยาว การวิเคราะห์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์และผลลัพธ์ของระบบ การดูแลระยะยาวในระดับมหภาค ก่อนที่จะนำไปสู่การศึกษาเชิงคุณภาพในบทถัดไป ซึ่งจะช่วยอธิบายประสบการณ์ มุมมอง และกลไกการดำเนินงานของระบบการดูแลระยะยาวในระดับพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ระเบียบวิธี

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative study) โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data analysis) จากฐานข้อมูลการสำรวจผู้สูงอายุและฐานข้อมูลการให้บริการสุขภาพระดับประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์การเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมถึงลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และรูปแบบการดูแลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การศึกษามุ่งนำเสนอภาพรวมของระบบการดูแลระยะยาวในเชิงประจักษ์ ทั้งในด้านขนาดของประชากรกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการได้รับการดูแล และการใช้บริการในระบบสุขภาพ โดยลักษณะของการศึกษาเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่ออธิบายสถานการณ์และแนวโน้มของการเข้าถึงบริการในระดับประเทศ

ฐานข้อมูลและการคัดเข้าชุดข้อมูล

การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากสองแหล่งหลัก ได้แก่ (1) ข้อมูลจากการสำรวจผู้สูงอายุของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นการสำรวจระดับประเทศที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพ ความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน (Activities of Daily Living: ADL) ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และการดูแลของผู้สูงอายุ โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2567 และ (2) ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายในกองทุนการดูแลระยะยาวและข้อมูลบริการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระบบบริการการดูแลระยะยาวภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับข้อมูลจากการสำรวจผู้สูงอายุ ได้มีการใช้ค่าน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่าง (sampling weights) เพื่อปรับค่าประมาณให้สะท้อนโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของประเทศ โดยหน่วยวิเคราะห์หลัก (Unit of analysis) คือผู้สูงอายุรายบุคคล ส่วนข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้บริการจะใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของจำนวนผู้รับบริการ ระยะเวลาที่อยู่ในระบบ และการใช้บริการในระบบสุขภาพก่อนและหลังการเข้าสู่ระบบการดูแลระยะยาว

นิยามตัวแปรและผลลัพธ์

ตัวแปรสำคัญในการศึกษานี้ประกอบด้วยระดับความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน (Activities of Daily Living: ADL) ซึ่งใช้ในการจำแนกระดับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (ติดสังคม: ADL ≥ 12) กลุ่มที่มีข้อจำกัดบางส่วนในการดำรงชีวิตประจำวัน (ติดบ้าน: ADL 5–11) และกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงสูง (ติดเตียง: ADL ≤ 4)

ผลลัพธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย (1) ขนาดและลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (2) รูปแบบการเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาว เช่น การได้รับการดูแลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ดูแลในชุมชน (3) ลักษณะของผู้ดูแลหลักและภาระการดูแลภายในครอบครัว และ (4) แนวโน้มการใช้บริการในระบบสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระบบการดูแลระยะยาว โดยพิจารณาตัวชี้วัดด้านการใช้บริการผู้ป่วยใน เช่น จำนวนวันนอนโรงพยาบาล (Length of stay, LOS) และค่าความรุนแรงของการรักษา (Adjusted Relative Weight, AdjRW)

การวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลในงานศึกษานี้มุ่งเน้นการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของประชากรผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การกระจายตัวของลักษณะทางประชากรและเศรษฐกิจ รูปแบบการเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาว และบทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ โดยรายงานผลในรูปของจำนวน สัดส่วน ร้อยละ ค่ามัธยฐาน และช่วงระหว่างควอไทล์ (Interquartile range: IQR) ตามความเหมาะสมของตัวแปร

นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์แนวโน้มของจำนวนผู้รับบริการในระบบ LTC จากฐานข้อมูลการเบิกจ่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงการเปรียบเทียบการใช้บริการผู้ป่วยในก่อนและหลังการเข้าสู่ระบบ LTC โดยคำนวณการเปลี่ยนแปลงของจำนวนวันนอนโรงพยาบาลและค่าความรุนแรงของการรักษาในระดับบุคคล และนำมาสรุปผลในระดับจังหวัด เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความครอบคลุมของระบบ LTC กับการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดการใช้บริการในระบบสุขภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการโดยใช้โปรแกรมภาษา Python สำหรับการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการเผยแพร่ข้อมูลดิบต่อสาธารณะตามข้อกำหนดของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

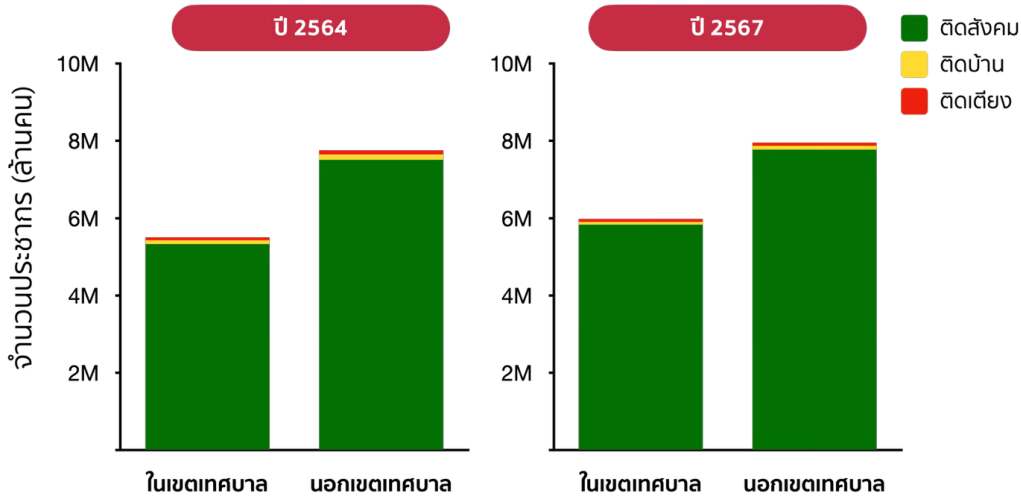
สถานการณ์ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

จากผลการสำรวจผู้สูงอายุของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2567 และนำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 13.15 ล้านคนในปี พ.ศ. 2564 และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 13.94 ล้านคนในปี พ.ศ. 2567 เมื่อจำแนกตามระดับความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน (Activities of Daily Living: ADL) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (ติดสังคม: ADL ≥ 12) ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวันบางส่วน (ติดบ้าน: ADL 5–11) และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูง (ติดเตียง: ADL ≤ 4)

ในปี พ.ศ. 2564 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มติดสังคม โดยมีจำนวน 12,839,602 คน คิดเป็นสัดส่วนเกือบทั้งหมดของผู้สูงอายุ ขณะที่กลุ่มติดบ้านมีจำนวน 241,395 คน และกลุ่มติดเตียงมีจำนวน 174,408 คน ส่วนในปี พ.ศ. 2567 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มติดสังคมเพิ่มขึ้นเป็น 13,597,291 คน ขณะที่กลุ่มติดบ้านมีจำนวน 183,294 คน และกลุ่มติดเตียงมีจำนวน 154,755 คน (รูปที่ 25)

เมื่อพิจารณาตามพื้นที่ที่อยู่อาศัย พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมากกว่าในเขตเทศบาลในทุกกลุ่มระดับความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยในปี พ.ศ. 2564 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีจำนวนรวมประมาณ 5.50 ล้านคน ขณะที่นอกเขตเทศบาลมีประมาณ 7.76 ล้านคน ส่วนในปี พ.ศ. 2567 จำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5.98 ล้านคน และนอกเขตเทศบาลประมาณ 7.96 ล้านคน

โดยรวมแล้ว ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ขณะที่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มติดบ้านและติดเตียง มีจำนวนค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด และผู้สูงอายุในทุกกลุ่มส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมากกว่าในเขตเทศบาล



รูปที่ 25 จำนวนผู้สูงอายุจำแนกตามระดับความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน (ADL) และพื้นที่ที่อยู่อาศัยระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2567

เมื่อพิจารณาลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี พ.ศ. 2567 (ตารางที่ 24) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มติดบ้านและติดเตียง พบว่ามีจำนวนรวมทั้งสิ้น 338,049 คน โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 149,958 คน และนอกเขตเทศบาลจำนวน 188,091 คน

ในด้านเพศ พบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยในเขตเทศบาลมีผู้หญิงจำนวน 106,453 คน คิดเป็นร้อยละ 70.99 ขณะที่ผู้ชายมีจำนวน 43,505 คน คิดเป็นร้อยละ 29.01 ส่วนในพื้นที่นอกเขตเทศบาล ผู้หญิงมีจำนวน 120,360 คน คิดเป็นร้อยละ 63.99 และผู้ชายมีจำนวน 67,731 คน คิดเป็นร้อยละ 36.01

ในด้านอายุ พบว่าค่ามัธยฐานของอายุของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอยู่ที่ 68 ปีในทั้งสองพื้นที่ โดยในเขตเทศบาลมีช่วงควอไทล์ระหว่าง 63–74 ปี ขณะที่นอกเขตเทศบาลมีช่วงควอไทล์ระหว่าง 64–75 ปี

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า โดยในเขตเทศบาลมีจำนวน 129,596 คน คิดเป็นร้อยละ 86.42 และนอกเขตเทศบาลมีจำนวน 178,566 คน คิดเป็นร้อยละ 94.94 ขณะที่ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีจำนวน 11,864 คน (ร้อยละ 7.91) ในเขตเทศบาล และ 6,408 คน (ร้อยละ 3.41) นอกเขต

เทศบาล ส่วนผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีจำนวน 8,497 คน (ร้อยละ 5.67) ในเขตเทศบาล และ 3,117 คน (ร้อยละ 1.66) นอกเขตเทศบาล

จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีค่ามัธยฐานของอายุอยู่ที่ประมาณ 68 ปี และมีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่าเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตเทศบาลที่มีสัดส่วนผู้ที่มีการศึกษาระดับต่ำสูงกว่าในเขตเทศบาลอย่างชัดเจน

ตารางที่ 24 ลักษณะประชากรของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2567

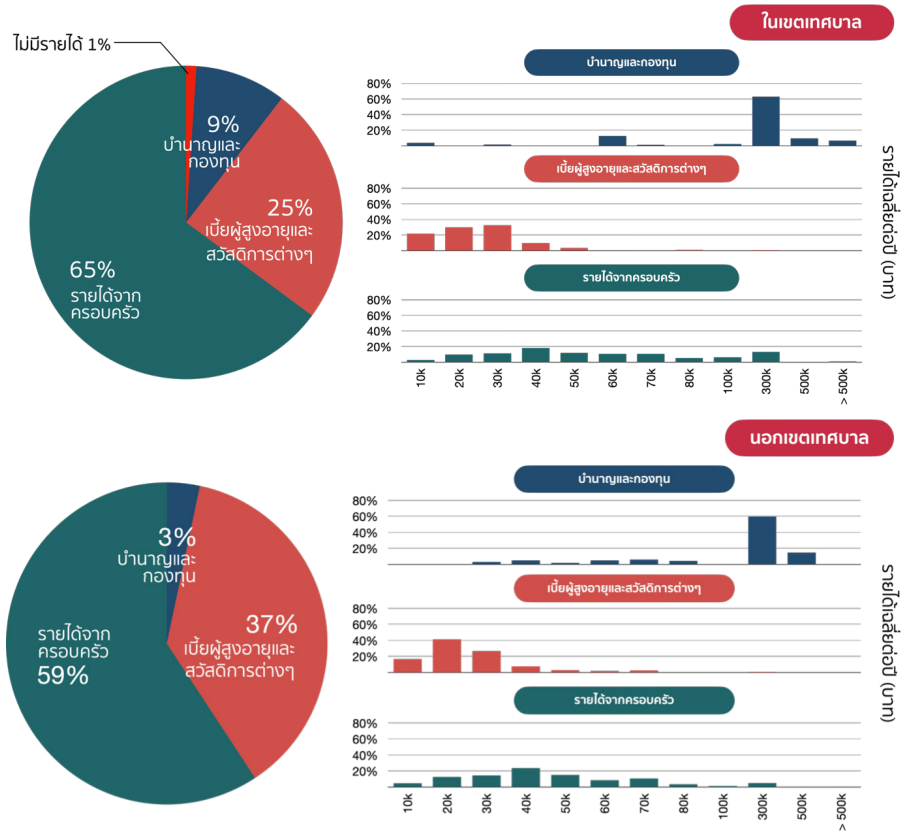
ลักษณะประชากร	ในเขตเทศบาล n = 149,958	นอกเขตเทศบาล n = 188,091
เพศ		
ชาย	43,505 (29.01%)	67,731 (36.01%)
หญิง	106,453 (70.99%)	120,360 (63.99%)
อายุ	68 (63–74)	68 (64–75)
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	129,596 (86.42%)	178,566 (94.94%)
มัธยมศึกษา	11,864 (7.91%)	6,408 (3.41%)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	8,497 (5.67%)	3,117 (1.66%)

คำนวณจากค่าน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่าง

เมื่อพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากแหล่งรายได้หลัก พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่พึ่งพารายได้จากครอบครัวเป็นหลักทั้งในและนอกเขตเทศบาล โดยในพื้นที่นอกเขตเทศบาล ผู้สูงอายุร้อยละ 59 มีรายได้หลักจากครอบครัว รองลงมาคือรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสวัสดิการต่าง ๆ ร้อยละ 37 และรายได้จากบำนาญหรือกองทุนเพียงร้อยละ 3 ขณะที่ในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุร้อยละ 65 มีรายได้หลักจากครอบครัว รองลงมาคือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสวัสดิการต่าง ๆ ร้อยละ 25 และรายได้จากบำนาญหรือกองทุนร้อยละ 9 นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 1 ที่ไม่มีรายได้ (รูปที่ 26)

เมื่อพิจารณาระดับรายได้เฉลี่ยต่อปีตามแหล่งรายได้ พบว่ารายได้จากบำนาญและกองทุนมีระดับรายได้สูงกว่ารายได้จากแหล่งอื่น โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีรายได้จากแหล่งดังกล่าวมีรายได้อยู่ในช่วงประมาณ 300,000 บาทต่อปี ขณะที่รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสวัสดิการต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ในช่วงรายได้ระดับต่ำ โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ 20,000 - 30,000 บาทต่อปี ส่วนรายได้จากครอบครัวมีการกระจายตัวในหลายช่วงรายได้ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ 30,000 - 50,000 บาทต่อปี

ดังนั้น ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มพึ่งพารายได้จากครอบครัวเป็นหลัก ขณะที่รายได้จากระบบบำนาญหรือกองทุนมีสัดส่วนค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตเทศบาล ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับรายได้จากแหล่งดังกล่าวต่ำกว่าในเขตเทศบาลอย่างชัดเจน



รูปที่ 26 แหล่งรายได้หลักและขนาดของรายได้ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2567

เมื่อพิจารณาสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบว่าส่วนใหญ่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ทั้งในและนอกเขตเทศบาล โดยในเขตเทศบาลมีจำนวน 117,580 คน คิดเป็นร้อยละ 78.59 ขณะที่นอกเขตเทศบาลมีจำนวน 161,301 คน คิดเป็นร้อยละ 85.82 รองลงมาคือสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ (CSMBS) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 20.56 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 13.63 นอกเขตเทศบาล ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคม (SSS) มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย โดยคิดเป็นร้อยละ 0.77 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 0.07 นอกเขตเทศบาล (ตารางที่ 25)

ในด้านการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาว พบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนที่ได้รับการดูแลระยะยาวสูงกว่าในเขตเทศบาล โดยในเขตเทศบาลมีผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลระยะยาวจำนวน 89,924 คน คิดเป็นร้อยละ 60.90 ขณะที่นอกเขตเทศบาลมีจำนวน 154,223 คน คิดเป็นร้อยละ 81.99 ทั้งนี้ การได้รับการดูแลระยะยาวในที่นี้หมายถึงการได้รับการดูแลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผม.)

ตารางที่ 25 การเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2567

ลักษณะประชากร	ในเขตเทศบาล n = 149,958	นอกเขตเทศบาล n = 188,091
สิทธิการรักษา		
กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	117,580 (78.59%)	161,301 (85.82%)
กองทุนสวัสดิการข้าราชการ	30,768 (20.56%)	25,617 (13.63%)
กองทุนประกันสังคม	1,151 (0.77%)	137 (0.07%)
การเข้าถึงการดูแลระยะยาว	89,924 (60.90%)	154,223 (81.99%)

การเข้าถึงบริการ หมายถึง การได้รับการดูแลระยะยาวหมายถึงการดูแลโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อพม.)
คำนวณจากค่าน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่าง

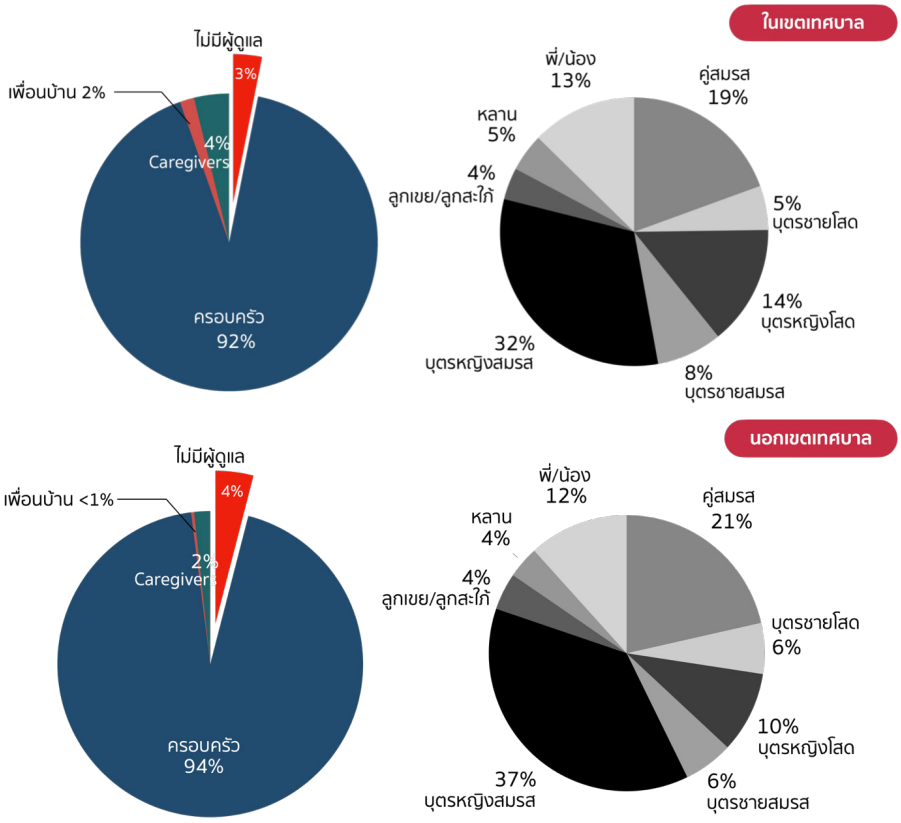
สถานการณ์ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อพิจารณาผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบว่าการดูแลส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นภายในครอบครัว โดยทั้งในและนอกเขตเทศบาล ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 92 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 94 นอกเขตเทศบาล ขณะที่ผู้ดูแลที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ (caregiver) หรือผู้ดูแลจากระบบบริการมีสัดส่วนค่อนข้างจำกัด โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 2 นอกเขตเทศบาล นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้สูงอายุบางส่วนที่ไม่มีผู้ดูแล โดยคิดเป็นร้อยละ 3 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 4 นอกเขตเทศบาล ส่วนการดูแลจากเพื่อนบ้านมีสัดส่วนน้อยมาก (รูปที่ 27)

เมื่อพิจารณารายละเอียดของผู้ดูแลภายในครอบครัว พบว่าผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่เป็นคู่สมรสและบุตร โดยเฉพาะบุตรหญิงที่สมรสแล้ว ซึ่งมีสัดส่วนสูงที่สุดทั้งในและนอกเขตเทศบาล โดยคิดเป็นร้อยละ 32 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 37 นอกเขตเทศบาล รองลงมาคือคู่สมรส ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 21 นอกเขตเทศบาล ขณะที่บุตรหญิงโสดมีสัดส่วนร้อยละ 14 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 10 นอกเขตเทศบาล ส่วนบุตรชายมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยกว่า โดยบุตรชายที่สมรสแล้วคิดเป็นร้อยละ 8 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 6 นอกเขตเทศบาล และบุตรชายโสดคิดเป็นร้อยละ 5 และร้อยละ 6 ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวอื่น เช่น พี่น้องหรือหลาน มีสัดส่วนรองลงมา โดยพี่น้องคิดเป็นประมาณร้อยละ 13 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 12 นอกเขตเทศบาล ขณะที่หลานมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 และร้อยละ 4 ตามลำดับ

จะเห็นได้ว่าถึงแม้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวนหนึ่งจะได้รับการดูแลจากระบบบริการดูแลระยะยาว แต่ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุยังคงเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคู่สมรสและบุตรหญิง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาระการดูแลผู้สูงอายุยังคงตกอยู่กับครอบครัวเป็นสำคัญ



รูปที่ 27 ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อพิจารณาลักษณะทางประชากรและเศรษฐกิจของผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบว่าผู้ดูแลมีจำนวน 126,529 คนในเขตเทศบาล และ 164,801 คนนอกเขตเทศบาล โดยผู้ดูแลในเขตเทศบาลมีอายุมัธยฐาน 61 ปี (IQR: 52–69 ปี) ขณะที่นอกเขตเทศบาลมีอายุมัธยฐาน 58 ปี (IQR: 49–67 ปี)

ในด้านระดับการศึกษา พบว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า โดยคิดเป็นร้อยละ 50.51 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 60.60 นอกเขตเทศบาล รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29.58 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 28.34 นอกเขตเทศบาล ขณะที่ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีสัดส่วนร้อยละ 19.91 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 11.07 นอกเขตเทศบาล

ในด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่าผู้ดูแลในเขตเทศบาลมีรายได้ต่อเดือนมัธยฐานประมาณ 10,000 บาท (IQR: 4,000 - 30,000 บาท) ขณะที่นอกเขตเทศบาลมีรายได้มัธยฐานประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน (IQR: 3,000 - 20,000 บาท) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ดูแลบางส่วนต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุ โดยคิดเป็นร้อยละ 9.38 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 10.76 นอกเขตเทศบาล โดยผู้ดูแลในเขตเทศบาลมีระยะเวลาการดูแลมัธยฐานประมาณ 5 ปี (IQR: 1 - 7 ปี) ขณะที่นอกเขตเทศบาลมีระยะเวลามัธยฐานประมาณ 2 ปี (IQR:2 - 5 ปี)

เมื่อพิจารณาภาระเวลาในการดูแล พบว่าผู้ดูแลจำนวนหนึ่งใช้เวลาในการดูแลผู้สูงอายุค่อนข้างมาก โดยในเขตเทศบาลมีผู้ดูแลร้อยละ 20.06 ที่ใช้เวลาดูแลมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนร้อยละ 18.18 ส่วนผู้ดูแลจำนวนมากใช้เวลาในการดูแลระหว่าง 1 - 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยคิดเป็นร้อยละ 35.27 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 48.00 นอกเขตเทศบาล

ในด้านการได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ พบว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรม โดยคิดเป็นร้อยละ 83.78 ในเขตเทศบาล และร้อยละ 82.38 นอกเขตเทศบาล ขณะที่ผู้ที่เคยได้รับการอบรมมีสัดส่วนค่อนข้างจำกัด โดยส่วนหนึ่งเป็นการอบรมแบบไม่เป็นทางการ (ประมาณร้อยละ 11 ในทั้งสองพื้นที่) ส่วนผู้ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในระดับต่าง ๆ เช่น หลักสูตร 18 ชั่วโมง 70 ชั่วโมง และ 420 ชั่วโมง มีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ดูแลทั้งหมด

ตารางที่ 26 ลักษณะประชากรของผู้ดูแลหลักในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2567

ลักษณะประชากร	ในเขตเทศบาล n = 126,529	นอกเขตเทศบาล n = 164,801
อายุ	61 (52–69)	58 (49–67)
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	63,909 (50.51%)	99,865 (60.60%)
มัธยมศึกษา	37,431 (29.58%)	46,700 (28.34%)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	25,189 (19.91%)	18,236 (11.07%)

ลักษณะประชากร	ในเขตเทศบาล n = 126,529	นอกเขตเทศบาล n = 164,801
รายได้ต่อเดือน	10,000 (4,000-30,000)	7,000 (3,000-20,000)
จำนวนผู้ดูแลต้องลาออกมาดูแล	14,062 (9.38%)	20,248 (10.76%)
จำนวนปีที่ลาออกมาดูแล	5 (1-7)	2 (2-5)
ชั่วโมงการดูแลต่อสัปดาห์		
< 1 ชั่วโมง	1,026 (0.81%)	3,220 (1.95%)
1-8 ชั่วโมง	44,625 (35.27%)	79,102 (48.00%)
8-20 ชั่วโมง	32,643 (25.80%)	35,831 (21.74%)
20-40 ชั่วโมง	22,851 (18.06%)	16,688 (10.13%)
> 40 ชั่วโมง	25,384 (20.06%)	29,960 (18.18%)
การเข้ารับการอบรมการดูแล		
ไม่เคย	106,009 (83.78%)	135,760 (82.38%)
อบรมแบบไม่เป็นทางการ	14,429 (11.40%)	18,861 (11.44%)
หลักสูตร 18 ชั่วโมง	3,507 (2.77%)	7,655 (4.64%)
หลักสูตร 70 ชั่วโมง	1,832 (1.45%)	1,396 (0.85%)
หลักสูตร 420 ชั่วโมง	751 (0.59%)	1,130 (0.69%)

คำนวณจากค่าน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่าง

การใช้บริการของผู้ป่วยที่อยู่ในระบบกองทุนการดูแลระยะยาว

จากฐานข้อมูลการให้บริการดูแลระยะยาวของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่าผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระบบบริการดูแลระยะยาวสามารถจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มตามระดับความต้องการการดูแลด้านสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุที่ยังสามารถเคลื่อนไหวได้บางส่วนแต่มีปัญหาด้านการกินหรือการขับถ่าย กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มที่ 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง กลุ่มที่ 3 ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองและมีปัญหาการกิน การขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง และกลุ่มที่ 4 ผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต

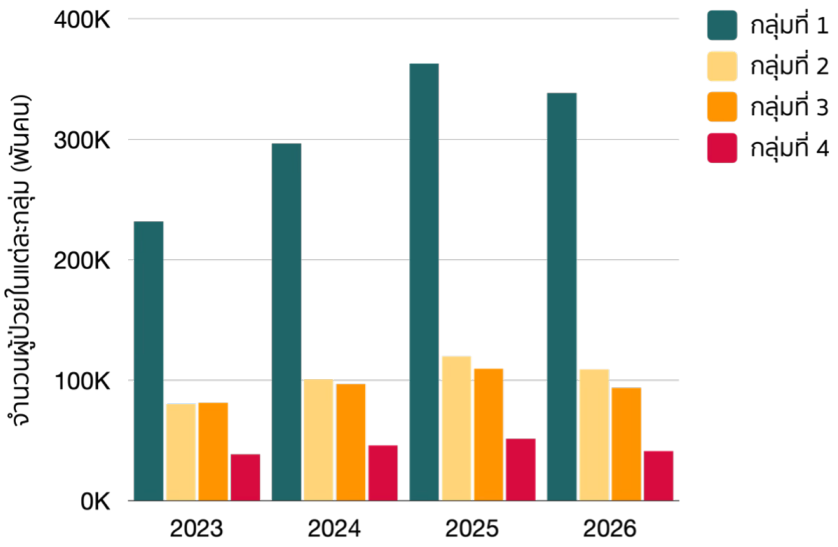
เมื่อพิจารณาจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการในระบบ LTC ในช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2569 พบว่าจำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 ก่อนที่จะลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2569 โดยกลุ่มที่ 1 มีจำนวนผู้รับบริการมากที่สุดในทุกปี จาก 231,984 คนในปี พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 296,757 คนในปี พ.ศ. 2567 และ 363,011 คนในปี พ.ศ. 2568 ก่อนจะลดลงเล็กน้อยเป็น 338,452 คนในปี พ.ศ. 2569 รองลงมาคือกลุ่มที่ 2 ซึ่งเพิ่มจาก 80,601 คนในปี พ.ศ. 2566 เป็น 100,981 คนในปี พ.ศ. 2567 และ 119,938 คนในปี พ.ศ. 2568 ก่อนจะลดลงเล็กน้อยเป็น 109,163 คนในปี พ.ศ. 2569

ในขณะที่กลุ่มที่ 3 มีจำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจาก 81,268 คนในปี พ.ศ. 2566 เป็น 97,108 คนในปี พ.ศ. 2567 และ 109,820 คนในปี พ.ศ. 2568 ก่อนจะลดลงเล็กน้อยเป็น 93,830 คนในปี พ.ศ. 2569 ส่วนกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต มีจำนวนผู้รับบริการน้อยที่สุด โดยเพิ่มจาก 38,645 คนในปี พ.ศ. 2566 เป็น 46,099 คนในปี พ.ศ. 2567 และ 51,547 คนในปี พ.ศ. 2568 ก่อนจะลดลงเป็น 41,448 คนในปี พ.ศ. 2569

เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่ผู้สูงอายุอยู่ในระบบบริการดูแลระยะยาว พบว่าผู้สูงอายุในกลุ่มที่ 1 มีระยะเวลามัธยฐานในการอยู่ในระบบประมาณ 19 เดือน (ช่วงควอไทล์ 8 - 38 เดือน) รองลงมาคือกลุ่มที่ 2 ที่มีระยะเวลามัธยฐานประมาณ 18 เดือน (ช่วง 7 - 36 เดือน) กลุ่มที่ 3 มีระยะเวลามัธยฐานประมาณ 16 เดือน (ช่วง 5 - 32 เดือน) และกลุ่มที่ 4 มีระยะเวลามัธยฐานประมาณ 13 เดือน (ช่วง 4 - 28 เดือน) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับรุนแรงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระบบบริการในระยะเวลาที่สั้นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงน้อยกว่า (แสดงดังรูปที่ 28)

เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการขยายความครอบคลุมของระบบบริการดูแลระยะยาวกับการใช้บริการผู้ป่วยในของผู้สูงอายุ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการโรงพยาบาลก่อนและหลังการเข้าสู่ระบบ LTC จากฐานข้อมูลการเบิกจ่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยทำการคัดเลือกเฉพาะผู้สูงอายุที่มีระยะเวลามีชีวิตหลังเข้าสู่ระบบ LTC มากกว่า 1 ปี เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบการใช้บริการก่อนและหลังการเข้าสู่ระบบได้อย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์ได้คำนวณการเปลี่ยนแปลงของจำนวนวันนอนโรงพยาบาล (length of stay, LOS) และค่าความรุนแรงของการรักษาในระบบผู้ป่วยใน (Adjusted Relative Weight,

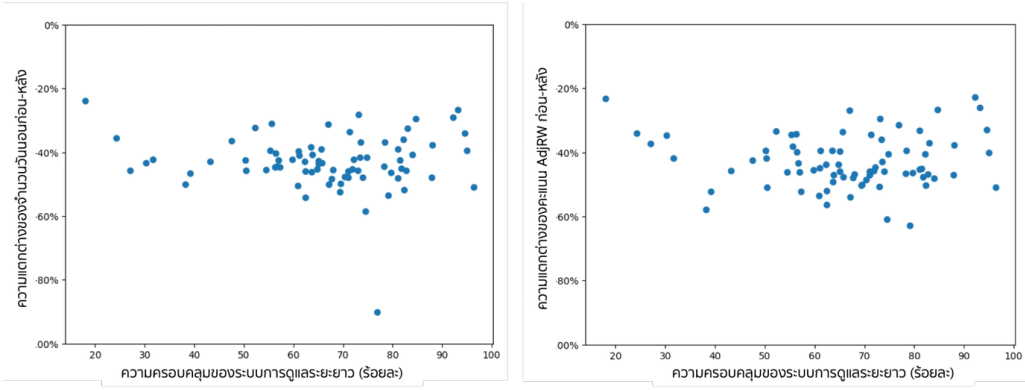


รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยที่เบิกจ่ายในกองทุนการดูแลระยะยาว

AdjRW) ของผู้ป่วยแต่ละราย โดยเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาก่อนเข้าสู่ระบบ LTC และหลังเข้าสู่ระบบ LTC และคำนวณเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงนำค่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาหาค่าเฉลี่ยในระดับจังหวัด และเปรียบเทียบกับระดับความครอบคลุมของระบบ LTC ในแต่ละจังหวัด

ผลการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมจังหวัดส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลและค่าความรุนแรงของการรักษาลดลงหลังจากเข้าสู่ระบบ LTC อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความครอบคลุมของระบบ LTC กับการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดดังกล่าวในระดับจังหวัด ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สำหรับจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล (LOS) ความสัมพันธ์ระหว่างความครอบคลุมของระบบ LTC กับการเปลี่ยนแปลงของ LOS มีค่า p-value เท่ากับ 0.322 และค่า R^2 เท่ากับ -0.114 ซึ่งสะท้อนว่าไม่พบความสัมพันธ์เชิงเส้นที่มีนัยสำคัญระหว่างตัวแปรทั้งสอง ในทำนองเดียวกัน สำหรับค่าความรุนแรงของการรักษา (AdjRW) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความครอบคลุมของระบบ LTC กับการเปลี่ยนแปลงของ AdjRW ก็ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.850 และค่า R^2 เท่ากับ -0.022 (แสดงดังรูปที่ 29)



รูปที่ 29 ความสัมพันธ์ของความครอบคลุมและการเปลี่ยนแปลงของจำนวนวันนอนและ AdjRW

ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนว่า แม้หลายจังหวัดจะมีแนวโน้มของการลดลงของการใช้บริการผู้ป่วยในหลังเข้าสู่ระบบ LTC แต่ระดับความครอบคลุมของระบบ LTC ในระดับจังหวัดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างชัดเจนในเชิงสถิติ

สรุปข้อค้นพบสำคัญ

ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลการสำรวจผู้สูงอายุของสำนักงานสถิติแห่งชาติและฐานข้อมูลการให้บริการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสะท้อนให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์การดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุในประเทศไทยในหลายมิติ ประการแรก โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของประเทศยังคงประกอบด้วยผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ ขณะที่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งประกอบด้วยกลุ่มติดบ้านและติดเตียงมีจำนวนค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กลุ่มประชากรดังกล่าวยังคงมีความสำคัญในเชิงนโยบาย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องการบริการการดูแลระยะยาวอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนในการดูแล

ในด้านลักษณะทางประชากรและเศรษฐกิจ พบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุค่อนข้างสูง และมีระดับการศึกษาค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตเทศบาล นอกจากนี้ แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากครอบครัว ขณะที่รายได้จากระบบบำนาญหรือกองทุนมีสัดส่วนค่อนข้างจำกัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในหลายพื้นที่ของประเทศ

ในด้านการเข้าถึงบริการ พบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวนหนึ่งได้รับการดูแลจากระบบบริการการดูแลระยะยาว โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตเทศบาลที่มีสัดส่วนการเข้าถึงบริการสูงกว่าในเขตเทศบาล อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุ พบว่าการดูแลส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นภายในครอบครัว โดยเฉพาะคู่สมรสและบุตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาระการดูแลผู้สูงอายุยังคงตกอยู่กับครอบครัวเป็นสำคัญ ขณะที่ผู้ดูแลจากระบบบริการมีสัดส่วนค่อนข้างจำกัด

ในด้านระบบบริการ ข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้บริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระบบบริการ LTC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงการขยายตัวของระบบบริการในระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความครอบคลุมของระบบ LTC กับการใช้บริการผู้ป่วยในของผู้สูงอายุไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับจังหวัด แม้ว่าหลายพื้นที่จะมีแนวโน้มของการลดลงของการใช้บริการผู้ป่วยในหลังเข้าสู่ระบบ LTC ก็ตาม

โดยสรุป ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทยมีพัฒนาการในด้านการขยายการเข้าถึงบริการและจำนวนผู้รับบริการในระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงยังคงพึ่งพาครอบครัวเป็นกลไกหลัก ขณะที่บทบาทของระบบบริการยังมีลักษณะเป็นการสนับสนุนมากกว่าการทดแทนการดูแลในครัวเรือน ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณในบทนี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจภาพรวมของระบบ LTC ในระดับประเทศ ก่อนที่จะนำไปสู่การศึกษาเชิงคุณภาพในบทถัดไป ซึ่งจะช่วยอธิบายกลไกการดำเนินงาน ประสบการณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และความท้าทายของระบบการดูแลระยะยาวในระดับพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บทที่ 6
ผลการประเมินการดำเนินการของระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน

ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณในบทก่อนหน้าได้สะท้อนให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์การเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุในประเทศไทย ทั้งในด้านขนาดของประชากรผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ลักษณะทางประชากรและเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการเข้าถึงบริการ และบทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นแนวโน้มของการขยายตัวของระบบบริการการดูแลระยะยาวในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เชิงปริมาณดังกล่าวยังมีข้อจำกัดในแง่ของการอธิบายกลไกการดำเนินงานของระบบบริการในระดับพื้นที่ รวมถึงประสบการณ์ มุมมอง และความท้าทายที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเผชิญในการนำระบบการดูแลระยะยาวไปปฏิบัติจริง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบการดูแลระยะยาวในบริบทของพื้นที่ การศึกษานี้จึงดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม โดยมุ่งสำรวจมุมมองและประสบการณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการดูแลระยะยาว อาทิ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารหน่วยบริการ บุคลากรสาธารณสุข ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงผู้มีบทบาทในระดับชุมชน การศึกษาเชิงคุณภาพในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกลไกการดำเนินงานของระบบ LTC ในทางปฏิบัติ ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของการจัดบริการ ตลอดจนข้อจำกัดและความท้าทายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มข้อค้นพบจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณในบทก่อนหน้า และนำไปสู่การทำความเข้าใจระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทยอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวิธี

การศึกษาในบทที่เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) เพื่อความเข้าใจสถานการณ์ในเชิงลึก ค้นหาปัจจัยเกื้อหนุน (facilitating factors) และปัจจัยอุปสรรค (barriers) ในการจัดระบบบริบาลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง รวมถึงประเด็นการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ผู้กำหนดนโยบายกำหนด คณะผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม

พื้นที่ศึกษาประกอบด้วยสี่จังหวัดจากแต่ละภูมิภาค โดยในแต่ละภาคเก็บข้อมูลจากสองพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอ/จังหวัดเดียวกัน เป็นพื้นที่ที่มีการจัดระบบการดูแลที่ดี (มีเรื่องราวความสำเร็จ มีการจัดระบบที่เป็นรูปธรรม) และพื้นที่ที่ยังมีอุปสรรคในการจัดระบบ โดยพื้นที่ศึกษาในแต่ละจังหวัดเป็นดังนี้

1. **จังหวัดเพชรบูรณ์** ประกอบด้วย
    - อำเภอเมือง (คลินิกหมอครอบครัวคลองศาลา รพ.เพชรบูรณ์, เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์, สาธารณสุขอำเภอเมือง, รพ.สต.หนองผักบุ้ง ตำบลนายม, อบต.บ้านโตก, รพ.สต.พนานิคม ตำบลบ้านโตก)
    - อำเภอหล่มสัก (รพ.หล่มสัก, เทศบาลเมืองหล่มสัก, อบต.สักหลง และ รพ.สต.หนองบัว ตำบลสักหลง)
2. **จังหวัดขอนแก่น**
    - อำเภอน้ำพอง (รพ.น้ำพอง, เทศบาลตำบลน้ำพอง, เทศบาลตำบลสะอาด, เทศบาลตำบลม่วงหวาน, รพ.สต.ม่วงหวาน, รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ)
3. **จังหวัดลพบุรี** ประกอบด้วย
    - อำเภอท่าวุ้ง (รพ.ท่าวุ้ง, รพ.สต.บางลี่)
    - อำเภอเมือง (รพ.สมเด็จพระนารายยณ์มหาราช, สาธารณสุขอำเภอเมือง, เทศบาลโคกตูม, รพ.สต.โคกตูม)
4. **จังหวัดนราธิวาส**
    - อำเภอละงู (รพ.ละงู, สาธารณสุขอำเภอละงู, เทศบาลตำบลกำแพง. อบต.ละงู)

ผู้ให้ข้อมูลในส่วนกลาง ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมาธิการ กิจการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา, ผู้บริหารระดับสูงด้านนโยบาย LTC ระดับท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ผู้อำนวยการกองกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารด้านส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ / กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้รับผิดชอบโปรแกรม สอน.บัดดี้

สำหรับในแต่ละพื้นที่ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทีมงาน (นายก, รองนายก,กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม) ผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ (LTC, palliative care) นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและ LTC ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาว (CM) ผู้ช่วยดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง (CG อสม./ CG เต็มเวลา/ ผู้ช่วยคนพิการ)

ทั้งนี้รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ LTC ของแต่ละพื้นที่สามในสี่จังหวัดบริหารงบผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีเพียงจังหวัดเดียวคือ ลพบุรี ที่บริหารผ่านสถานพยาบาล (เมื่อได้รับงบประมาณมาก็โอนให้หน่วยบริการเพื่อบริหารจัดการต่อ) ในขณะเดียวกันในทุกพื้นที่จะมี CG อสม.ซึ่งทำงานบางเวลาในลักษณะจิตอาสาและรับค่าตอบแทนรายชั่วโมง หลายแห่งมี CG ที่ทำงานเต็มเวลาทั้งที่เป็นอาสานักบริบาลชุมชนที่จ้างด้วยงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และนักบริบาลชุมชนของพ่อ ซึ่งในการทำงานของ CG ทุกประเภทจะทำงานร่วมกันอยู่ภายใต้การกำกับของ CM และในบางพื้นที่ก็มีผู้ช่วยคนพิการ (PA) ทำงานร่วมด้วยในการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ติดเตียง เนื่องจากกลุ่มที่ติดเตียงก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการได้และสามารถได้รับเงินช่วยเหลือผู้พิการของ พม.ด้วย ทั้งนี้ข้อมูลจำนวนผู้มีภาวะพึ่งพิงจำแนกตามกลุ่ม (กลุ่ม 1 - 4) ของแต่ละพื้นที่แสดงในตารางที่ 27

ตารางที่ 27 จำนวนผู้มีภาวะพึ่งพิงจำแนกตามกลุ่มของแต่ละพื้นที่ในสี่จังหวัด

	จำนวน ผู้มีภาวะพึ่งพิง	กลุ่ม 1	กลุ่ม 2	กลุ่ม 3	กลุ่ม 4
รพ.เพชรบูรณ์	310	174	12	107	17
รพ.สต.หนองผักบุ้ง ต.นายม	209	35	109	40	25
รพ.สต.พนานิคม ต.บ้านโคก	29	11	1	16	1
รพ.หล่มสัก	125	80	16	29	0
รพ.สต.หนองบัว	122	105	7	10	0
รพ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	230	202	0	27	1
รพ.สต. น้ำพอง	68	42	18	8	0
รพ.สต.ม่วงหวาน	50	32	6	8	4
รพ.สต.สะอาด	85	59	20	5	1
รพ.สต. บ้านคำแก่นคูณ	183	64	89	27	3
รพ.ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี	70	42	6	7	15
รพ.สต. บางลี่ อ.ท่าวุ้ง	22	17	1	4	0
รพ.สต.โคกตูม อ.เมือง ลพบุรี	88	65	4	14	5
ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง รพ.ละงู	53	2	22	29	0
รพ.สต.ละงู	33	15	2	8	8

ที่มา: ระบบข้อมูลบุคลากรการดูแลระยะยาวและแผนการดูแลรายบุคคล (Long Term Care: 3C) https://ltc.anamai.moph.go.th/ ณ. มีนาคม 2569

แนวคำถามในการสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่ม

1. รูปแบบการบริหารงบประมาณในพื้นที่ (บริหารผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/บริหารผ่านหน่วยบริการ) เหตุผลหลักที่เลือกรูปแบบนี้คืออะไร และมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรหรือไม่ในการใช้รูปแบบดังกล่าว?
2. การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยบริการสุขภาพกับท้องถิ่น ระว่าง รพ./สสอ./รพ.สต. กับอปท. อย่างไรบ้าง? (ใครเป็นผู้ประสานหลักในพื้นที่ อะไรคือจุดที่ทำงานร่วมกันได้ดี /ุดที่สะดุดหรือเป็นอุปสรรค
3. กลไกบริหารจัดการ พัฒนา และสนับสนุนการทำงานของ CG (การคัดเลือก อบรม/ฟื้นฟู การจ่ายผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ CG แต่ละประเภทในการดูแล ระบบพี่เลี้ยงและระบบสนับสนุนต่าง ๆ ในการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนและอัตรา)
4. ระบบกำกับคุณภาพ (Quality & Supervision) ในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง มีใคร และมีกลไกใดในการกำกับติดตามคุณภาพบ้าง (ตัวชี้วัด การทบทวนหรือสะท้อนกลับ หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานทำอย่างไร)
5. ระบบจัดทำ Care Plan และการติดตาม ขั้นตอนตั้งแต่คัดกรอง และค้นหากลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย จนถึงการทำ care plan เป็นอย่างไร และใครเป็นเจ้าภาพหลัก? มีการทบทวนแผนถี่บ่อยแค่ไหน?
6. การมีส่วนร่วมของชุมชนและญาติ/ครอบครัว คนในชุมชน ญาติ หรือครอบครัวมีส่วนร่วมอย่างไรในการดูแลผู้สูงอายุในระบบนี้?
7. การเชื่อมต่อระหว่างระดับบริการ (Intermediate – LTC – Palliative – End-of-Life Care) ในพื้นที่เป็นอย่างไร?
8. ทรัพยากร เวชภัณฑ์ วัสดุ และค่าใช้จ่ายที่ระบบไม่ครอบคลุม ในพื้นที่การจัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ช่วยเหลือ วัสดุสิ้นเปลืองหรือของใช้จำเป็นในระบบดูแล ทำอย่างไรกันบ้าง?
9. ปัญหา – อุปสรรค – ความท้าทายในพื้นที่
10. ข้อคิดเห็นทั่วไป เรื่องดี ๆ ที่อยากแชร์ มองอนาคตระบบนี้ในอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้าเป็นอย่างไร และสิ่งที่อยากฝากถึงผู้กำหนดนโยบาย

ผลการศึกษาจากข้อค้นพบในพื้นที่และบทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

มิติที่ 1 กำลังคนและพลวัตตลาดแรงงาน (Workforce & Labor Dynamics)

เป้าหมายและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้ (Intended system design & expectation)

จากการทบทวนวรรณกรรมและการออกแบบเชิงนโยบาย (Blueprint) ระบบการดูแลระยะยาว (LTC) ของประเทศไทยถูกคาดหวังให้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด “ชุมชนเป็นฐาน” (Community-based Care) เพื่อบูรณาการบริการทางการแพทย์และบริการทางสังคมเข้าด้วยกัน โดยกำหนดบทบาทอย่างเป็นระบบ คือให้ ผู้จัดการการดูแล (Care Manager: CM) ซึ่งเป็นบุคลากรวิชาชีพ ทำหน้าที่ประเมินและวางแผนการดูแลรายบุคคล และให้ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver: CG) เป็นผู้รับแผนไปปฏิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือทางสังคมในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ในระยะยาวยังมีความคาดหวังเชิงนโยบายที่จะเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพากำลังคนแบบ “จิตอาสา” (Volunteerism) ไปสู่ระบบ “การจ้างงานเต็มเวลา” ที่มีความมั่นคงเพื่อความเป็นวิชาชีพ

อย่างไรก็ตาม เมื่อนำกรอบความคาดหวังเชิงโครงสร้างนี้มาเป็นมุมมองในการวิพากษ์ (Critique) ข้อมูลจากพื้นที่จริงทั่วประเทศ กลับพบ “ช่องว่างระหว่างการออกแบบและการปฏิบัติ” (Design-Implementation Gap) อย่างมีนัยสำคัญ โครงสร้างที่ออกแบบไว้เผชิญกับข้อจำกัดเมื่อต้องปะทะกับพลวัตของตลาดแรงงานจริง ซึ่งสามารถสังเคราะห์ข้อค้นพบเพื่อวิพากษ์ระบบออกเป็น 11 แก่นสาระ (themes) ดังนี้

Theme 1.1: สถานการณ์หน้างานจริง: เมื่อความคาดหวังเชิงระบบกดทับจนเกิดภาวะหมดไฟและต้องพึ่งพา “ใจรัก” (The Reality of Sacrificial Social Capital & Burnout)

เมื่อวิพากษ์ผ่านเลนส์ของการออกแบบระบบที่ต้องการให้บุคลากรทำงานอย่างเป็นมืออาชีพตามสายพานหน้าที่ (CM สั่งการ - CG ปฏิบัติ) พบว่าในความเป็นจริง ระบบไม่ได้จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการบรรลุความคาดหวังนั้น ระบบ LTC ขับเคลื่อนอยู่ได้ด้วยการดึง “ทุนทางสังคมเชิงเสียสละ” (Sacrificial Social Capital) ของผู้ปฏิบัติงานมาใช้อย่างสิ้นเปลือง CG ทั่วประเทศยอมทำงานเกินหน้าที่และควักทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อดูแลผู้ป่วย

ด้วยความผูกพัน ขณะที่ CM (พยาบาลวิชาชีพ) ซึ่งระบบคาดหวังให้เป็นผู้บริหารจัดการหลัก กลับต้องแบกรับภาระงานคลินิกและงานเอกสารที่ซับซ้อนจนเกิดภาวะหมดไฟ (Burnout) สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างที่ออกแบบมายังไม่สามารถหล่อเลี้ยงผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานได้อย่างยั่งยืนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

มุมมองจากพื้นที่:

“แรงจูงใจที่เข้ามาเป็น CG เพราะเราเป็นอสม. เป็นจิตอาสาอยู่แล้ว... เราอยากทำบุญกับคนที่ว่าป่วยติดเตียงติดบ้าน... เราอาสาช่วยไปรับให้ ช่วยเหลือ เราไม่หวังอะไรเลย”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคเหนือ

“อย่างพี่ไปเยี่ยมพี่ต้องซื้อของทุกครั้ง เพราะว่าเป็นผู้สูงอายุ ซื้อน้ำ นม ขนม ลูกชิ้น ถ้าเราไม่ช่วย... หนูคิดว่าเป็นความสุขที่ไปอยู่กับยาย... ถึงเราไม่มีค่าตอบแทนเรายังทำอยู่”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคเหนือ

“บางทีดูไม่ได้ห้องน้ำก็ขัดถูให้หมดเลยค่ะ ล้างจานให้ ซักผ้าให้ แม้กระทั่งว่าบางทีแพมเพิสไม่มี ขอจากที่อื่นบริจาคกัน... ต้องนึกก่อนว่าทุกข์อะไรก็ตามที่คุณมาคุณต้องมีคำว่าจิตอาสานำ... ถ้าหากว่า 6,000 น่ะ ถ้าคุณไม่เอาจิตใจอาสามาบวกมาเพิ่มอ่ะ คุณทำไม่ได้หรอก”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

“ไปประชุมบ่อยมาก ใน 1 สัปดาห์อยู่ 2 วัน และงานที่เหลือสะสม และนัดทีมนอกเวลาตลอด และส่วนเรื่องระเบียบกองทุนเป็นอีก 1 อุปสรรค... ระเบียบเยอะมาก และเงินเบิกจ่ายอย่างไรต่อ เอกสารก็เยอะ”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“พยาบาลหายากมาก หน่วยสาธารณสุขของแต่ละ รพ.สต. ขาดแคลนพยาบาล ทั้งจากการลาออกหรือเกษียณ... จึงไม่มีแรงจูงใจที่จะอยู่ทำงานต่อ”

— เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ / พื้นที่ภาคกลาง

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

“ณ เวลานี้ [Volunteer CG] โอเค แต่ในอนาคตอาจจะต้องมีระยะเปลี่ยนผ่าน... มีการค่อย ๆ เปลี่ยนขึ้นเรื่อย ๆ ผมยังเชื่อว่าต้องเป็น full-time เพื่อความมั่นคงของระบบ... ถ้าเป็นอาสาสมัครเนี่ย burden [ภาระหนัก] แน่นอน”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

“ปัญหาคือ CG ที่ผ่านการอบรมไปได้กลับมาฟื้นฟูมากน้อยแค่ไหน CM เหมือนกัน... หลายครั้งเวลาการลงไปเก็บข้อมูลเราจะพบว่า CG ไม่ได้รับการฟื้นฟูเลย CM ไม่ได้รับการฟื้นฟูเลย... CM คาดหวังให้เขาไปทำได้ Performance ของ CG ทำได้แค่ไหน หรือแม้แต่ CM เองสามารถเทรนให้กับ CG ในการมอบหมายงานได้มากแค่ไหน อันนี้มันก็เลยต้องมีการลูปของการเทรนนิ่งที่ไปเรื่อย ๆ”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

“สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากคนที่มีใจรัก... ถ้าเห็นว่าโมเดลนี้มันดี ก็ให้ภาครัฐเข้าไปสนับสนุนงบประมาณ... ระบบวิชาชีพและระบบจิตอาสาควบคู่กันไป บางงานนี่ถ้ามีเจ้าหน้าที่ประจำอย่างเดียว จะยิ่งสร้างบรรยากาศที่ไม่ศิวิไลซ์ ยิ่งทำให้บรรยากาศมันเครียด... แต่มีพวกจิตอาสาทั่วไปจะทำให้มีชีวิตชีวา”

— สมาชิกวุฒิสภา / คณะอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

Theme 1.2: ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างและพลวัตการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน: ความเหลื่อมล้ำความทับซ้อน ระบบธุรการที่ล่าช้า และความล้มเหลวในการเปลี่ยนผ่านสู่วิชาชีพ (Structural Limits, Fragmentation, Administrative Delays & Brain Drain)

นโยบายของรัฐที่คาดหวังจะยกระดับและเปลี่ยนผ่านฐานะกำลังคนระดับพื้นที่จาก “อาสาสมัคร” ไปสู่ “ระบบอาชีพการจ้างงานเต็มเวลา” กำลังเผชิญกับรอยปริแตกเชิงโครงสร้างอย่างรุนแรงเมื่อพิจารณาจากข้อมูลหน้างานจริง ความล้มเหลวนี้เริ่มต้นจากความทับซ้อนและความเหลื่อมล้ำของกลไกการจ้างงานในระดับพื้นที่ (Fragmentation & Inequality of Workforce Mechanisms) แม้รัฐจะมีเป้าหมายในการจัดหาผู้ดูแลให้ครอบคลุม แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการสร้างเส้นทางการจ้างงาน (Tracks) ที่กระจัดกระจายและทับซ้อนกันหลายสาย เช่น ผู้ช่วยคนพิการ (PA) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ, ผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ, ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ที่ใช้งบกองทุน สปสช., อสม. ที่รับค่าตอบแทนรายชั่วโมง, ผู้ดูแลกระตุ้นเศรษฐกิจ ไปจนถึงนักบริบาลชุมชนของพ่อ การมีกลไกที่หลากหลายแต่วิธีการบริหารจัดการแยกส่วนกันนี้ นำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำทางรายได้และสวัสดิการในกลุ่มคนที่ทำงานดูแลลักษณะคล้ายคลึงกันในพื้นที่เดียวกัน ทำให้เกิดการเปรียบเทียบ ขาดความมั่นคง และนำไปสู่ความยากลำบากในการสรรหาบุคลากรเข้าสู่ระบบ โครงสร้างที่ทับซ้อนเหล่านี้ยังถูกซ้ำเติมด้วยการติดอยู่ใน “กับดักจิตอาสา” (Volunteer Trap) กล่าวคือ ระบบคาดหวังมาตรฐานการทำงานและภาระงานระดับมืออาชีพ แต่กลับจัดสรรค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่าภาระค่าครองชีพในความเป็นจริงอย่างมาก (ประมาณ 1,500 - 6,000 บาท) รวมถึงมีความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนระหว่างกลุ่ม กล่าวคือ PA และผู้บริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ของ พม. ได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า CG เต็มเวลา ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาค่าตอบแทนที่ต่ำยังถูกกดทับด้วยผลกระทบลูกโซ่จากความล่าช้าของระบบธุรการ (Domino Effect of Administrative Delays) เนื่องจากระบบการเงินของ LTC ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองต่อวิถีชีวิตแบบ “หาเช้ากินค่ำ” ของกลุ่มแรงงานระดับฐานราก ความล่าช้าในสายพานธุรการไม่ว่าจะเป็น Care Manager (CM) ส่งแผนล่าช้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมช้า หรือระบบไอทีขัดข้อง ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ CG ที่มักจะถูกดองไว้เป็นเวลาหลายเดือน ความไม่แน่นอนของรายได้และขวัญกำลังใจที่ถูกบั่นทอนนี้ ทำให้แรงงานไม่สามารถยึดงานบริบาลเป็นอาชีพหลักได้และต้องดิ้นรนไปหาอาชีพเสริมอื่นเพื่อความอยู่รอด

ซึ่งบั่นทอนความสม่ำเสมอและคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว การออกแบบระบบที่ก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำรงชีพและช่องว่างของค่าแรง (Wage Gap) อย่างมหาศาลนี้จึงกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดปรากฏการณ์ “สมองไหล” (Brain Drain) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในที่สุดบุคลากรที่รัฐได้ลงทุนฝึกอบรมจนมีทักษะและได้รับใบประกาศนียบัตรต่างตัดสินใจย้ายออกจากระบบของรัฐเพื่อไปทำงานในภาคเอกชน ซึ่งสามารถให้ค่าตอบแทนในระดับค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ หรือ “Living Wage” (ประมาณ 10,000 - 15,000 บาท) ที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตได้จริง ท้ายที่สุด ความบกพร่องเชิงโครงสร้างทั้งในมิติของการบริหารจัดการที่เหลื่อมล้ำ ระบบปฏิบัติการที่ล่าช้า และอัตราค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม จึงทำให้เป้าหมายการสร้างระบบกำลังคนในชุมชนที่ยั่งยืนของรัฐต้องพังทลายลง

มุมมองจากพื้นที่:

“ค่าตอบแทนที่เราสามารถเลี้ยงตัวเองเป็นอาชีพได้ ขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำ 10,000+ บาท... 10,000 - 15,000 บาท เพราะ CG ไม่ได้ทำทุกวัน... ไม่ใช่ 5,000 - 6,000 บาท บางราย 4,000 บาท บางราย 7,000 บาท”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคเหนือ

“ประมาณขั้นต่ำแล้วกันนะ 12,000 เออ... 12,000 พี่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องตัดยางก็ได้ เช้ามา 4:00 น. พี่ต้องไปตัดยางก่อน”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

“ชาวบ้าน 1 คนที่จะสามารถที่จะทำงานอยู่บ้านแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่บ้านได้โดยไม่เดือดร้อนและก็เป็นจิตอาสาบ้านได้นี่เงินเดือนมันจะประมาณหมื่นกว่าต้นๆ... เราก็พยายามพิสูจน์ว่าถ้าผลลัพธ์มันออกมาดี ทำไมคุณไม่เอาเงินเนี้ยมาจ้างเขาให้เขาอยู่ในพื้นที่ได้ 10,000 บาทเศษ ๆ”

— นักวิชาการและพยาบาลวิชาชีพระดับบริหาร / พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“สาธารณสุขมันจ่ายเอาเปรียบเค้าอ่ะ 5,000 - 6,000 บาท ส่วน PA [ผู้ช่วยคนพิการของ พม.] 6,000+2,000 เท่ากับ 8,000 บาท”

— ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / พื้นที่ภาคกลาง

“พวกที่ไม่ใช่ อสม. มาอบรม เค้าบอกไม่ได้อยากเป็น CG กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เค้ามาเอาอบรมเอาใบประกาศในการไปทำงานข้างนอก เพราะค่าตอบแทนได้เยอะถ้าไปเมืองนอกได้ 40,000 บาท แต่ถ้าอยู่ในไทย 20,000 บาท”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“เห็นโรงพยาบาล [เอกชน] เค้าประกาศมา คนไหนที่อบรม CG และผ่าน 70 ชั่วโมงไปแล้ว เค้าเริ่มต้นที่ 25,000 บาท ที่ไปดูแลผู้สูงอายุ และอยู่ในชุมชนที่ได้ค่าตอบแทน 5,000 บาท เค้าแทบไม่เอาเลย”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“CG อสม. ได้ชั่วโมงละ 50 บาท” ... “นักบริบาลของพ่อ รับค่าจ้างรายวัน 360 บาท”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“เมื่อมีนโยบายจ้าง CG กระตุ้นเศรษฐกิจแบบเต็มเวลา แต่มีเงื่อนไขห้ามเป็น อสม. เงื่อนไขต้องไม่มีตำแหน่งมาก่อนหน้านี้... เค้าไม่ลาออกจาก อสม. เพราะว่าไม่มั่นคงเท่ากับ อสม... สัญญาปีเดียวเอง”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ทุกอย่างคือ CM plan ให้เราหมด... แต่เวลาเราส่งงานเราส่งให้ CM ถ้า CM ช้า ค่าตอบแทนเราก็ไม่มา... 2 - 3 เดือนได้ทีเมื่อก่อน”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“บางทีพี่แจ้งวันที่ 15 CM มาวันที่ 24...กว่าจะนัดประชุมมีวาระที่จะประชุมกันเนี่ยค่ะก็ยาก...ทำงานไปแล้วเบิกเงินไม่ได้ติดขัดเรื่องระบบ”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

“ถ้าถามว่าพอมั้ย พี่ไม่พออ่ะ พี่ต้องหางานเสริม...กรีดยางจ้างขายขนม...ค่าน้ำมันบางทีจิตอาสาเราเดินทางไป...6,000 ไม่พอสำหรับนี้นะคะ เราต้องมีงานเสริมหลาย ๆ งานถึงจะอยู่ได้”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

“จ่ายค่าตอบแทน 3 เดือน 1 ครั้ง มันจะได้เป็นก้อน ถ้าจ่ายเดือนละครั้งได้น้อย... บางราย 4,000 บาท บางราย 7,000 บาท ของพี่ไปดูเดือนที่ 1 พอมาเดือนที่ 2 คนไข้เสียชีวิต บางคน 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 บาท”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคเหนือ

“รับจากตรงนี้ 6,000... แล้วก็ไปรับจ้างนอกอีกประมาณ 5,000... รับจ้างล้างแผล 3,000... ทำถึงตอนมืดเลย 20:00 น. กว่าจะเสร็จ”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

“คือถ้าพูดถึงนะ ถ้าหากว่า 6,000 น่ะ ถ้าคุณไม่เอาจิตใจอาสามาบวกมาเพิ่มอ่ะ คุณทำไม่ได้หรอก”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

“สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาก็คือ Caregiver อยู่ในระบบค่อนข้างยาก เนื่องจากว่าค่าตอบแทนที่เป็นอินเซ็นทีฟให้ Caregiver มันแตกต่างกันมากในแต่ละหน่วยบริการ”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“หน่วยบริการที่สังกัดกระทรวง [สาธารณสุข] ติดข้อจำกัดของระเบียบ เงิน LTC ท้องถิ่นไปก็จ่ายค่าตอบแทน CG ได้ไม่เกินหกร้อยกับพันห้า... แต่ถ้าท้องถิ่นรับงบผ่าน หน่วยบริการที่ถ่ายโอนไปที่ อบจ. หรือศูนย์ผู้สูงอายุ ก็จะทลายข้อจำกัดได้ ราคาก็อยู่ประมาณสักสองพันสามพันหมื่นกว่า”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“เราคุยกันตัวเลขที่เก้าพันบาทต่อเดือน สำหรับ CG... ทั้งระยะสามปีเรามองถึงความอยู่ได้ของ CG ในระบบ”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“ถามว่าตอนนี้เป็น Volunteer Caregiver โอเคไหม ณ เวลานี้โอเค แต่ในอนาคตอาจจะต้องมีทรานซิชชั่นพีเรียด”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

“พม. เขาก็มี PA [ผู้ช่วยคนพิการ] ที่ไปดูแลผู้พิการ เขาก็จ้างอยู่ในอัตราประมาณเก้าพันบาท... แต่ว่าของเราจ้างได้ในราคาแค่ห้าพันบาท” ผู้บริหารระดับนโยบาย สปสช. ยืนยัน: *“ในระเบียบ อสม. ปีหกแปดนี่ผมเสนอไปแล้วครับว่า CG เจ็ดสิบกับร้อยยี่สิบชั่วโมงให้ห้าหกพัน แต่ถ้าสี่ร้อยยี่สิบชั่วโมงให้เก้าพัน”*

— บทสนทนาระหว่างนักวิชาการ - ตัวแทนผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 1.3: ความเสี่ยง สวัสดิภาพ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ไร้การคุ้มครอง (Occupational Hazards & Lack of Welfare Protection)

ระบบ LTC คาดหวังให้บุคลากรระดับฐานราก (CG) ทำงานเชิงรุกด้วยการลงพื้นที่ไปถึง “เตียง” ของผู้ป่วยในชุมชน แต่ระบบกลับละเลยมิติด้าน “ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” (Occupational Health and Safety) ผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงสารพัดรูปแบบ ทั้งอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ความเสี่ยงจากการติดเชื้อสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (เช่น ครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด) ไปจนถึงความเสี่ยงทางกฎหมายจากการถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง โดยที่ระบบไม่มีโครงสร้างสวัสดิการหรือกฎหมายมารองรับ “ความเสี่ยง” เหล่านี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งทำให้ความตั้งใจในการเป็นจิตอาสาต้องสะดุดลงด้วยความกลัวและความไม่ปลอดภัย

มุมมองจากพื้นที่:

> *“ตำรวจจับพี่ไปโรงพัก... เพราะลูกเขาขายยา... พี่ไม่รู้เรื่อง พี่รู้แค่ว่าทำยังไงให้คนแก่สุขภาพดีขึ้น... ทำให้รู้ว่างานนี้จะไม่ปลอดภัยกับเรานะ... เราไม่มีเกราะป้องกันตัวเราเลย ไม่มีสิทธิประโยชน์ที่คุ้มครองตัวเราเลย มีอย่างเดียวคือแขวนป้ายชื่อ”*
>
> — ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

> *“บ้านที่ครอบครัวติดยา กลัวเข้าไปน่ะ จ้องหน้าแบบน่ากลัว... บางทีต้องชวนไป [ด้วยกัน] เพราะว่าไปคนเดียวไม่กล้า”*
>
> — ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

> *“CG เคยประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน ไม่มีสวัสดิการ หรือหลักประกันอะไรให้กับเค้า... ถามว่าถอดใจมั้ย CG กลุ่มนี้ขอชื่นชมเลยอยู่กันมายาวนานและไม่เคยบ่น คิดว่าต้องมีสิ่งใดที่ดูแลเค้าตรงนี้ให้หน่อย”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ / CM พื้นที่ภาคเหนือ

> *“อสม.มีสวัสดิการการเจ็บการป่วยการตาย แต่เราทำ CG เราไม่มีสวัสดิการอะไรเลย”*
>
> — ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคเหนือ

Theme 1.4: วิกฤตคุณภาพกำลังคนและขอบเขตวิชาชีพ: ปรากฏการณ์ “จับคนว่างงานมาแต่งตัว” และความขัดแย้งระหว่างข้อจำกัดทางกฎหมายกับวิกฤตหน้างาน (Workforce Quality, The “Dressed-up Unemployed” Phenomenon, Scope of Practice & The Tension with Emergency Needs)

ความพยายามของรัฐในการตอบสนองต่อวิกฤตสังคมสูงวัยควบคู่ไปกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้นำไปสู่การอัดฉีดงบประมาณเพื่อจ้างงานผู้ดูแลแบบเต็มเวลาผ่านการอบรมระยะสั้น (เช่น 70 ชั่วโมง) ทว่านโยบายที่มุ่งเน้นการผลิตกำลังคนเชิงปริมาณนี้กลับสร้างปรากฏการณ์ “จับคนว่างงานมาแต่งตัว” (The “Dressed-up Unemployed” Phenomenon) กล่าวคือ ผู้ที่เข้ามาสมัครจำนวนมากเป็นเพียงผู้ที่กำลังว่างงานและต้องการรายได้ชั่วคราว ขาดทั้งองค์ความรู้ที่แท้จริง อุดมการณ์จิตอาสา และความผูกพันกับชุมชน ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากบุคลากรรุ่นบุกเบิกอย่างเครือข่าย อสม. การหลั่งไหลเข้ามาของกลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าไปทับซ้อนกับระบบโครงสร้างกำลังคนเดิมที่มีความหลากหลายอยู่แล้ว ทั้ง CG อสม. 70 ชั่วโมง, นักบริบาล 120 ชั่วโมง, นักบริบาลชุมชนของพ่อ 420 ชั่วโมง ไปจนถึงผู้ช่วยคนพิการ (PA) ของกระทรวง พม. ส่งผลให้เกิดความลักลั่นของความเชี่ยวชาญ และทำให้การควบคุมคุณภาพบริการ (Quality Control) เป็นไปได้ยาก นำมาซึ่งปัญหา “คุณภาพการบริการที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียว” (Workforce Typology & Competency) ยิ่งไปกว่านั้น ความย้อนแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้นได้ปรากฏชัดเมื่อบุคลากรระดับฐานรากเหล่านี้ลงสู่การปฏิบัติงานหน้างานจริง ในขณะที่ระบบเผชิญปัญหาจากบุคลากรหน้าใหม่ที่ขาดทักษะและใจรัก แต่ในทางกลับกัน เมื่อผู้ปฏิบัติงานที่อยู่รอดในระบบสามารถสั่งสมประสบการณ์จนเชี่ยวชาญ พวกเขากลับต้องพุ่งชนกับ “เพดานทางกฎหมายวิชาชีพ” (Scope of Practice Boundaries) ที่กลายมาเป็นอุปสรรคสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยที่รอไม่ได้ เช่น กรณีแผลกดทับระดับลึกที่ลุกลาม หรือสายสวนหลุด แม้ผู้ดูแลจำนวนมากจะมีศักยภาพและทักษะเพียงพอที่จะทำหัตถการเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการได้ แต่ระบบกลับผูกมัดและสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการติดเชื้อและการฟ้องร้อง ความขัดแย้งระหว่างข้อจำกัดทางวิชาชีพและความต้องการฉุกเฉินหน้างาน (The Tension Between Scope of Practice and Emergency Needs) นี้ สร้างความตึงเครียดอย่างหนัก

ให้แก่บุคลากรที่ต้องทำงานด้วยความรู้สึก “ไร้เกราะป้องกัน” ทางกฎหมาย สถานการณ์อันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้บีบบังคับให้พวกเขาต้องเลือกปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือเพื่อปกป้องตนเองจากความเสี่ยงทางคดีความ ผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการที่ผู้ป่วยต้องสูญเสียโอกาสในการได้รับการดูแลรักษาที่ทันท่วงที ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวเชิงโครงสร้างที่ซ้อนทับกัน ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่ไม่ได้คุณภาพ ไปจนถึงความไม่สอดรับกันอย่างรุนแรงระหว่างกรอบของขอบเขตวิชาชีพและวิกฤตความเป็นจริงหน้างานที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยโดยตรง

มุมมองจากพื้นที่:

“ปัญหาที่ผมมองในคนที่จะมาทำงานตรงนี้ ปัจจุบันมันกลายเป็นจับคนว่างงานไปแต่งตัว แต่ไม่ได้มาจากสถาบัน หรือจากองค์ความรู้ที่แท้จริง พอมีโครงการมาเราสรรหาคน เริ่มจาก อสม. ก่อนเลย... วุฒิภาวะของเค้าไม่ตอบเรื่องความรู้... และโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เค้ามองที่เม็ดเงินก่อน”

— เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“เราจำเป็นต้องบอกวันและชั่วโมงที่เค้าทำงานเพราะว่าบางคนเค้าเห็นได้เงินเค้ามาเลย แต่ลืมไปว่างานเรื้อรังมาทุกวันจะต้องสละงานพวกนั้นมาดูตรงนี้ ส่วนใหญ่คนที่มาสมัครคือคนไม่มีงานทำ”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM

“อุปสรรคคือเราอาจจะไม่สามารถประเมินคุณภาพของ CG ที่เราอบรมไปได้... เรา Certificate ให้ว่าเขามีความรู้ที่ผ่านการอบรม แต่ความรู้นั้นสามารถเอาไปปฏิบัติงานหรือว่าดูแลเค้าอ่ะได้หรือเปล่า อันเนี้ยเราไม่สามารถประเมินได้”

— แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

“เราอยากให้เราชำนาญการไปเลยค่ะ เราสามารถถอด [สายสวน] ได้... แต่ ณ ตอนนี้บางครั้งเราใส่ได้ก็จริง แต่ว่า CM ไม่อนุญาตให้เราใส่ เข้าใจ CM นะคะว่ากลัวติดเชื้อ... แต่ด้วยความที่ล่าช้าทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ระหว่างนั้น”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

“เคสหนักๆ จริงๆ พี่ไม่กล้าลง... เวลาเกิดความผิดพลาด เราแค่คนดูแล... เขาฟ้องเรามา...เราไม่กล้า เราจะปัดให้ รพ.สต. เลย... ในกรณีฉุกเฉินเราไม่มีอะไรมารองรับความเสี่ยง เผื่อญาติไปฟ้อง”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

“นักบริบาลที่อบรมจากมูลนิธิสถาบันการแพทย์ ได้ประโยชน์เยอะจริงๆ... เรื่องการทำแผล การ feed อาหาร ทำกายภาพบำบัด... และที่ผ่านมา CG ที่ผ่านการอบรม 70 hr... ไม่กล้า ทำแผล ไม่กล้า feed เค้ามาทางทฤษฎี แต่ฝึกปฏิบัติชั่วโมงน้อย”

— พยาบาลวิชาชีพ / CM พื้นที่ภาคใต้

“ถ้าเป็นแผลกดทับที่ใหญ่ๆ ที่ดำ กินไปถึงกระดูก... จะแนะนำญาติให้พาไปโรงพยาบาลให้หมอไป debride... พยาบาลวิชาชีพเท่านั้น เกรด 4 จะไปแตะไม่ได้”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

“เผื่อเหลือเผื่อขาดในกรณีฉุกเฉิน เราไม่มีอะไรมารองรับความเสี่ยง เผื่อญาติไปฟ้องว่า เออ นักบริบาลมันทำให้เสียชีวิต... เราก็อยู่บนความเสี่ยง... เราก็ปัดให้ รพ.สต. เลย”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

“อบต... ส่งน้องไปอบรม CM 2 คน คนหนึ่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อีกคนเป็นผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ แต่ถามว่าไปอบรมบางอย่างคือมีเสียงสะท้อนมา ว่าสายงานเราไม่ใช่สายงานด้านสาธารณสุข เพราะว่าหลาย ๆ ตัวชี้วัด หรือหลาย ๆ ศัพท์เทคนิคมีความเฉพาะและยากที่จะเข้าใจ... อาจจะรู้แค่ ไม่ถึง 50%... เป็นสิ่งหนึ่งที่น้อง ๆ ไปอบรมมาอัดอั้นตันใจ”

— ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

“ปัญหาคือ CG ที่ผ่านการอบรมไปได้กลับมาฟื้นฟูมากน้อยแค่ไหน... หลายครั้งเวลาการลงไปเก็บข้อมูลเราจะพบว่า CG ไม่ได้รับการฟื้นฟูเลย CM ไม่ได้รับการฟื้นฟูเลย อันนี้ก็เป็น gap อีกเรื่องหนึ่ง”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

“กรมส่งเสริม [การปกครองท้องถิ่น] จัดอบรม [CM] ไม่ได้เขียนคุณสมบัติไม่ชัดนะครับ บางทีก็จะได้สายงานอื่นเติมเข้ามาด้วย... พอมาเจอกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีการศึกษาด้านสุขภาพมาก็จะทำให้ลำบากเวลาทำ Care Plan”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“การควบคุมคุณภาพบริการ ยอมรับเลยนะครับว่า [เรา] จะต้องหาหากลไกที่จะไปมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับ”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Theme 1.5: วิกฤตการผลิตบุคลากรและนวัตกรรมการปรับตัวระดับพื้นที่: เมื่อช่องว่างของการอบรมระยะสั้นไม่สอดรับกับความซับซ้อนของโรค (Training Gap, Complex Care & Local Innovation in Capacity Building)

นโยบายส่วนกลางของรัฐที่มุ่งเร่งขยายการครอบคลุมของบริการดูแลผู้ป่วย ได้ออกแบบหลักสูตรการผลิตผู้ดูแล (CG) ระยะสั้น (เช่น 70 ชั่วโมง) โดยมุ่งเน้นปริมาณและคาดหวังว่าหลักสูตรมาตรฐานนี้จะเพียงพอต่อการสร้างกำลังคนที่พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที (Ready-to-use workforce) ทว่าเมื่อนำมาปฏิบัติจริง มุมมองเชิงวิพากษ์จากพื้นที่กลับสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตการผลิตบุคลากรที่รุนแรง เนื่องจากช่องว่างของการอบรมระยะสั้นนั้น ไม่สอดรับกับความซับซ้อนของโรคและสภาวะความเป็นจริงหน้างาน (Training Gap: Quantity vs. Quality in Complex Care) การอบรมที่เน้นเพียงทฤษฎีหรือการฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลองถูกประเมินว่า “ไม่เพียงพอ” อย่างยิ่งเมื่อบุคลากรต้องรับมือกับความซับซ้อนของอาการผู้ป่วย เช่น ภาวะพฤติกรรมอารมณ์จากโรคสมองเสื่อม (Dementia) ปัญหาสุขภาพจิต การดูแล

ผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care) ไปจนถึงการทำหัตถการที่ละเอียดอ่อนอย่างการจัดการแผลกดทับระดับลึกและการให้อาหารทางสายยาง ความไม่พร้อมนี้ส่งผลให้บุคลากรระดับฐานรากต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดจากการทำงาน บางรายต้องยอมใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวไปขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อจำกัดและช่องโหว่ของคุณภาพการอบรมจากส่วนกลางนี้ได้ผลักดันให้พื้นที่ที่มีศักยภาพต้องหาทางออกจนเกิดเป็น “นวัตกรรมการปรับตัวด้านการพัฒนาสมรรถนะระดับรากหญ้า” (Local Innovation in Capacity Building) นวัตกรรมเหล่านี้ปรากฏในรูปแบบของระบบพี่เลี้ยงและเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy Systems & Mentorship) เช่น การจัดระบบจับคู่บัดดี้ระหว่าง CG รุ่นพี่ที่ผ่านการอบรม 120 ชั่วโมง ให้ประกบดูแลและถ่ายทอดประสบการณ์แก่ CG รุ่นน้อง 70 ชั่วโมง รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชนเพื่อจัดอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติหน้างานจริง (On-the-job training) ปรากฏการณ์นี้จึงเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่า ท่ามกลางความบกพร่องของการออกแบบหลักสูตรที่เน้นเพียงปริมาณ กลไกระดับพื้นที่ต้องกลายเป็นผู้แบกรับภาระในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อประคับประคองคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยให้สามารถดำเนินต่อไปได้

มุมมองจากพื้นที่:

> *“ที่ไปอบรมคือวัดความดันแบบไหน พลิกตะแคงตัวแบบไหน... แต่ในความจริงเราต้องเจอ มีสุขภาพจิตแบบไหน burnout หรือเปล่า... [ในหลักสูตร] ไม่มีค่ะ”*
>
> — ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคเหนือ

> *“บางที CM ก็ติดภารกิจ... พี่ก็หาเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันไหนไม่มีเคส... ไปเรียนต่อที่ ม.อ. บ้าง เรื่องใส่สายสวน... นั้นคือจ่ายเงินนอกค่ะ จ่ายเงินเอง เพื่อไปเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ”*
>
> — ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

> *“รุ่นใหม่ ๆ [อบรม palliative] ผ่านออนไลน์ เค้าอยากให้จัดแบบ onsite มากกว่า จะได้พาทำด้วย เค้ายังไม่มั่นใจ อยากให้อบรมเพิ่ม”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ / CM พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“เราจะจับคู่เป็นบัดดี้กัน 120 ชั่วโมง + 70 ชั่วโมง... จะเป็น CG น้องใหม่ 70 ชั่วโมง ไม่ใช่น้องในพื้นที่... ไปคู่กับ CG ในพื้นที่จริง ๆ ก่อน”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM

“นักบริบาลที่อบรมจากมูลนิธิสถาบันการแพทย์ ได้ประโยชน์เยอะจริง ๆ... ที่ผ่านมา CG ที่ผ่านการอบรม 70 hr... มาทางทฤษฎี แต่ฝึกปฏิบัติชั่วโมงน้อย”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM

“ที่อบรมจาก อบจ.ฝึกคือเอาหุ่นมาตั้งบนโต๊ะ แต่เราให้ทำกับเคสจริง ๆ... เลย จัดเองของอำเภอ... มีหมอ นักบริบาลรุ่นพี่มาช่วยเทรนให้กล้าที่จะทำขึ้น กล้าให้อาหาร กล้าผลิกตะแคงตัง กล้าทำแผล”

— ทีมพยาบาลระดับอำเภอ / CM พื้นที่ภาคใต้

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

“ต้องมี Learning ตลอดเวลา ต้องมีมาฟื้นฟูอยู่ตลอด ทั้งพยาบาลแล้วก็ CG เอง ให้เกิดการเรียนรู้ เรื่อง Dementia, Palliative Care หรือสกิลในเรื่องของการทำแผล ทำอะไรที่มันแอดวานซ์มากขึ้นเรื่อย ๆ... CG ดูหลายเรื่อง ไม่ใช่ดูแต่เรื่อง health อย่างเดียว”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

“หลักสูตรอย่างตอนนี้เราก็จะต้องเพิ่มในเรื่องของ Palliative Care เรื่องของ Dementia ให้มากขึ้น... มันจะต้องพัฒนาเรื่อย ๆ ต้องปรับปรุงเรื่อย ๆ ย้อนกลับไปหากระบวนการเรียนรู้ ถามว่าท่านสามารถยัดตั้งแต่แรกได้ไหม มันต้องเป็นสเต็ปที่มีเลิร์นนิ่งตลอดเวลา”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Theme 1.6: กำลังหลักที่ถูกมองข้าม: ภาระของผู้ดูแลในครอบครัวและภาวะหมดไฟ (The Invisible Backbone: Informal Caregiver Burden & Burnout)

แม้นโยบายจะจัดสรร CG ให้ลงไปดูแลผู้ป่วย แต่ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณที่ทำให้ CG ลงเยี่ยมได้เพียงสัปดาห์ละไม่กี่ชั่วโมง (เช่น วันละ 1 - 2 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง) ภาระการดูแลในช่วง “เวลาที่เหลืออีกกว่า 90% ของสัปดาห์” จึงตกอยู่กับ “ผู้ดูแลในครอบครัว” (Informal Caregiver) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แรงกดดันนี้นำไปสู่การต้องลาออกจากงาน ขาดรายได้ และเกิดภาวะหมดไฟ (Burnout) อย่างรุนแรง ระบบกำลังคนของ LTC จึงไม่ควรละเลยการเข้าไปสนับสนุนและเยียวยาทั้งด้านจิตใจและเศรษฐกิจของกลุ่มญาติผู้ดูแลเหล่านี้

มุมมองจากพื้นที่:

> *“ลูกสาวลาออกมาดูแลพ่อแม่ พ่อแม่ติดเตียง... ถ้าเทียบเรื่องเงินไม่สามารถชดเชยได้เลย แต่เป็นส่วนที่ช่วยเหลือเค้าได้บ้าง เค้ามาดูแลพ่อเค้าคนเดียวไม่มีรายได้เลย กับการที่เค้าออกไปดูแลเพื่อนบ้านอีก 4 หลัง [โดยสมัครเป็น CG] ... เท่ากับ 5 คน”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพระดับอำเภอ / พื้นที่ภาคกลาง

> *“ลูกไปทำมาหากิน ปล่อยคนป่วยนอนอยู่บ้าน นอนแช่ปัสสาวะ สมมติเป็นแม่ของเรา เราจะทำอย่างไร ทีนี้เราพร้อม เราอุ้มเลย”*
>
> — ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคเหนือ

> *“ญาติผู้ดูแลมีปัญหาภาวะเครียด และภาวะหมดไฟ เลยทำวิจัยพัฒนารูปแบบการรับมือภาวะหมดไฟ... ทีมนี้เข้าไปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน... ให้ญาติได้ผ่อนคลาย 2 - 3 ชั่วโมงก่อนกลับไปดูแลต่อ”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ / CM พื้นที่ภาคเหนือ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

"[กรมกิจการผู้สูงอายุ] มีโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือรายเดือน 2,000-3,000 บาท แก่ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุเปราะบางในชุมชน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง 1,107 รายทั่วประเทศ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการจริงที่มีมากกว่า 3,000-4,000 เคส"

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"ถ้าเราคิดว่า Family Caregiver มีศักยภาพที่จะอัพเกรดตัวเองในหลักสูตรเจ็ดสิบชั่วโมงได้ก็อาจจะต้องให้เขาเทรนนิ่งหลักสูตรนี้... อาจจะให้งานเขาเพิ่มในการที่จะไปดูแล ผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้เคียงกับครัวเรือนเขาได้ แล้วเขาได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม เราพยายามที่จะทำเรื่องนี้กันอยู่"

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

"[เรามีแนวคิดว่า] CG ในระบบ LTC ไปช่วยซัพพอร์ตญาติในการที่จะให้เขาไปทำงานในเวลาปกติ แล้วเย็นก็กลับมาดูแล บวกกับเสาร์อาทิตย์ยังไง — นี่ก็พยายามออกแบบระบบให้มันตอบรับกันอยู่"

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

"[เราจำเป็นต้องทำยังไงที่จะ] คืนกลับไปสู่ครอบครัว ให้อยู่ที่ครอบครัวเป็นหลัก แล้วก็เทคแคร์กันในครอบครัว ไม่งั้นเราจะไปจ้างคนมากมาย การจ้างมันส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องงบประมาณ... ถ้าเกิดต้องการให้เกิดขึ้นได้จริง มันน่าจะบนฐานของความเป็นจริง ก็อยากจะเชียร์ส่งเสริมให้เน้นเรื่องครอบครัว"

— สมาชิกวุฒิสภา / คณะอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

"[ญาติที่] ดูแลผู้ป่วยอยู่ในโรงเรียนของตัวเองนั้น ค่อยค่อยฝึกทักษะไป... ถ้าคิดว่า Family Caregiver มีศักยภาพที่จะอัพเกรดตัวเอง [สู่ระบบ 70 ชั่วโมง] แล้วเขาได้รับ

ค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม... หรือเราจะอาศัย CG ในระบบ LTC ไปช่วยซัพพอร์ตญาติในการที่จะให้เขาไปทำงานในเวลาปกติ แล้วเย็นก็กลับมาดูแลบวกกับเสาร์อาทิตย์ยังไง นี่ก็พยายามออกแบบระบบให้มันตอบรับกันอยู่”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 1.7: วิกฤต “ผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุ” และสภาวะสุญญากาศของคนรุ่นใหม่ (Aging Workforce & Quality Control Dilemma)

ระบบปัจจุบันพึ่งพากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ทำให้กำลังคนในระบบ LTC เผชิญกับสภาวะ “ผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุ” ในขณะเดียวกัน การขาดแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนทำให้ไม่สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่หรือประชากรวัยแรงงานเข้าสู่งานด้านนี้ได้ นอกจากนี้ เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีอายุมากขึ้นและสมรรถภาพทางกายถดถอย ระบบกลับยังไม่มีกลไกในการประเมินผลหรือแนวทางให้ยุติบทบาท (Exit strategy) ที่ชัดเจน เนื่องจากข้อจำกัดด้านความสัมพันธ์และบริบทของการเป็นจิตอาสา ซึ่งท้ายที่สุดปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการดูแลในภาพรวม

มุมมองจากพื้นที่:

“ส่วนใหญ่ที่เจอกันในชุมชนหน้าเดิม ๆ ทำไมไม่มีคนใหม่ ๆ รุ่นใหม่ ๆ บางทีพวกค่าตอบแทนยังไม่ตอบโจทย์ของเค้า เรื่องการทำเป็นอาชีพ หรืองานหลักได้”

— พยาบาลวิชาชีพ / CM พื้นที่ภาคกลาง

“เมื่ออายุมากขึ้น หรือว่าเค้ามีภาวะอื่น ๆ เราก็ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะเลือกคนนี้เข้า หรือจะเอาคนนี้ออกมั้ย คือเราไม่ได้เป็นนายจ้างเขา... ผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น... ควรที่จะเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงดูแลผู้สูงอายุที่เปราะบาง... แต่วันนึงที่เขาไม่สามารถดูแลคนอื่นได้ เค้าก็อาจจะไม่ได้อยากออก... เราก็ไม่สามารถแบบว่า เออ คนเนี่ยคุณภาพไม่ได้แล้วนะ คุณไม่สามารถทำงานต่อได้นะ”

— แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

“อสม.บางท่านอายุเยอะ ไม่ได้ดูถูกคนอายุเยอะเลยเพราะเขามีความเอื้ออาทร ให้กันดีกว่าเด็กหลาย ๆ คน แต่อาจจะเรียนรู้ได้ช้า”

— พยาบาลวิชาชีพ / CM พื้นที่ภาคเหนือ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

“สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเติมเข้ามาในระบบตลอด ปีละสี่ถึงหกหมื่นทุกปีทุกปี... เพราะฉะนั้นเราก็คงมีความต้องการ [Caregiver] เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ตลาดที่เป็นส่วนของเอกชนก็โตขึ้นไปอีก”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

“[เราอาจต้อง] อัพเกรดกลุ่มหกสิบถึงหกสิบห้าปีที่ยังมีกำลังวังชาอยู่ มาช่วยเป็นกำลัง Caregiver ในระบบ... เป็นส่วนที่คิดว่ามีความเป็นไปได้เช่นเดียวกัน”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 1.8: ช่องว่างความคาดหวัง: ภาวะพึ่งพิงและการผลักภาระให้ผู้ดูแลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (Expectation Gap & Dependency on CGs)

ตามเจตนารมณ์ของนโยบาย CG ถูกส่งเข้าไปเพื่อ “สนับสนุนและสอน” ให้ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยต่อได้ (Empowerment) แต่สถานการณ์หน้างานจริงกลับพบว่า ญาติจำนวนไม่น้อยเกิดภาวะพึ่งพิงระบบอย่างผิดวัตถุประสงค์ (Dependency) โดยปล่อยปละละเลยและผลักภาระทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ CG หรือคาดหวังให้ CG เป็น “ผู้ให้บริการดูแลทดแทนญาติแบบเบ็ดเสร็จ” ส่งผลให้เมื่อ CG ไม่ได้เข้าเยี่ยม ผู้ป่วยจะไม่ได้รับการดูแลใด ๆ เลย ซึ่งสร้างความกดดันและความยากลำบากใจในการปฏิบัติงานของกำลังคนในพื้นที่อย่างมาก

มุมมองจากพื้นที่:

“คือเหมือนกับว่าถ้าเราธุระไปไหนมาไหน คือไม่ให้เราหยุดเลย... รอเราให้ไปทำ... ทั้ง ๆ ที่เราสอนทุกอย่างให้กับเค้า... เค้ามาโยนภาระให้กับเรา”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

“บางบ้านลงทุนไม่ทำอะไรเพื่อรอ CG หรือนักบริบาลทำ... ไม่ทำเลย”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM พื้นที่ภาคใต้

“พี่เคยไปทำแผลให้คนไข้ แล้วก็สอนญาติทุกอย่าง... คาดหวังว่าเราไปทำให้อยู่หลายวันเนี่ย เค้าดูจนเข้าใจจริงจังแล้วก็ให้ทำ... แต่สุดท้ายแล้ว ไม่ทำ พอเราไม่ไป เค้าก็ไม่ทำ”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM พื้นที่ภาคใต้

“ญาติบางบ้านไม่ให้เราเข้าไปยุ่ง... คิดว่าเราจะไปดูสภาพบ้านเค้า หรือไปรู้เกี่ยวกับการอยู่ของครอบครัวเค้า”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคกลาง

“เวลาเราลงเยี่ยมบ้านแต่ละครั้ง ญาติไม่เห็น... พอเราลงไปเยี่ยมหลัง ปรากฏว่าคนที่เยี่ยมหลังนั้นจะถูกด่า... เค้าจะมาฟ้องเราที่ระดับสถานบริการทันทีว่าคนนี้ไม่เห็นจะไปเลย”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG และพยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM พื้นที่ภาคใต้

Theme 1.9: กำแพงการเข้าสู่วิชาชีพและความไม่มั่นคงในการจ้างงาน: ต้นทุนค่าเสียโอกาสและภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจากการสวมหมวกหลายใบ (Barriers to Entry, Opportunity Costs, Job Insecurity & The “Multiple Hats” Dilemma)

ในความพยายามของนโยบายระดับชาติที่จะยกระดับและเปลี่ยนผ่านกำลังคนระดับพื้นที่สู่ความเป็นวิชาชีพ รัฐได้ออกแบบระบบที่คาดหวังการพัฒนาคุณภาพผ่านการอบรมที่เข้มข้น (เช่น 70 - 120 ชั่วโมง) ควบคู่ไปกับการออกนโยบายจ้างงานผู้ดูแลแบบเต็มเวลา ทว่า ในทางปฏิบัตินโยบายเหล่านี้กลับสร้าง “กำแพงการเข้าสู่วิชาชีพ” (Barriers to Entry) เนื่องจากระบบอาจยังไม่ได้คำนึงถึง “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” (Opportunity Costs) ของประชาชนใน

วัยแรงงานอย่างครอบคลุม ผู้สมัครต้องยอมสูญเสียรายได้ประจำวันเพื่อมาเข้ารับการอบรม โดยไม่มีเบี้ยเลี้ยงสนับสนุน

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อผ่านการอบรมแล้ว กำลังคนเหล่านี้กลับต้องเผชิญกับ “ความไม่แน่นอนของการจ้างงาน” (Employment Insecurity) เนื่องจากไม่มีหลักประกันอาชีพที่ชัดเจนและมักผูกพันด้วยสัญญาจ้างเพียงปีต่อปี ความเปราะบางนี้ถูกซ้ำเติมเมื่อรัฐพยายามผลักดันตำแหน่งลูกจ้างโครงการแบบเต็มเวลา (เช่น CG กระตุ้นเศรษฐกิจ) แต่กลับมีเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจากการ “สวมหมวกหลายใบ” (The “Multiple Hats” Dilemma) กล่าวคือ ผู้ที่ต้องการรับงานเต็มเวลา (Full-time) จะถูกกำหนดให้ต้อง “สละสิทธิ์” จากการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งเป็นฐานะเดิมที่มีสวัสดิการคุ้มครองที่มั่นคงกว่า (เช่น ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ และสิทธิการรักษาพยาบาล) เพื่อแลกกับการรับตำแหน่งใหม่ที่มีอายุสัญญาเพียง 1 ปีและไม่มีสวัสดิการเทียบเท่ารองรับ

เงื่อนไขที่ขาดความยืดหยุ่นนี้ ทำให้บุคลากรที่มีศักยภาพหลายรายตัดสินใจปฏิเสธการเข้าสู่วิชาชีพแบบเต็มเวลา เพราะแม้ระบบใหม่จะให้อัตราค่าตอบแทนที่สูงกว่า แต่กลับทำให้พวกเขาต้องสูญเสียความมั่นคงในระยะยาว ท้ายที่สุด กำแพงอุปสรรคทั้งในมิติของต้นทุนที่ต้องจ่ายและความเสี่ยงที่ต้องแบกรับ จึง เป็นข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้ระบบยังไม่สามารถดึงดูดประชากรวัยแรงงานหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานบริบาลได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้

มุมมองจากพื้นที่:

> *“เงื่อนไขต้องไม่มีตำแหน่งมาก่อนหน้านี้ ของปีนี้ ต้องไม่เป็น อสม. ไม่เป็นจิตอาสา... เค้าไม่ลาออกจาก* อสม. เพราะว่าไม่มั่นคงเท่ากับ อสม... สัญญาปีเดียวเอง”
>
> — พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

> *“ถ้าไปเป็น CG กระตุ้นเศรษฐกิจ สิทธิของ อสม.จะถูกยกเลิกไป รู้สึกไม่ยั่งยืนเท่า อสม. เลยทำให้ตัดสินใจยากค่ะ”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ / พื้นที่ภาคเหนือ

“ไม่ว่าการทำงานตรงนี้จะยากลำบากแค่ไหน สิ่งสำคัญคือเราต้องมีคำว่า ‘จิตอาสา’ นำหน้าเสมอ แต่น้องนึกภาพออกไหม ล่าสุดมีนโยบายมาว่า หากใครเป็น CG ควบคู่กับ อสม. จะถูกบังคับให้เลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น สำหรับคนที่เริ่มต้นและผูกพันกับคำว่า อสม. มาตั้งแต่แรก การต้องเลือกทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่ลำบากใจมากนะ... เสียงกระซิบเล็ก ๆ จากพวกเราคนทำงานก็คือเป็นไปได้ไหมที่จะอนุญาตให้เราควบทั้งสองตำแหน่งนี้ได้เหมือนเดิม”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

“อสม. มีสวัสดิการการเจ็บการป่วยการตาย แต่เราทำ CG เราไม่มีสวัสดิการอะไรเลย”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคเหนือ

“หาลำบากตั้งแต่เรื่องอบรมแล้วค่ะอาจารย์ บางคนถอดใจไปตั้งแต่การอบรม บางคนหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในเวลา 2 สัปดาห์เค้าไม่ได้ไปหารายได้ทางไหนเลย และเค้าไม่รู้ว่าสรุปแล้ว จบอบรมแล้วจะได้เซ็นสัญญามั้ย ถึงแม้ไม่ได้มีเกณฑ์อะไรมาคัด”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ไปอบรม 70 ชั่วโมงที่ รพ... แต่ไม่มีค่าใช้จ้าย ไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรให้ เราดูแลตัวเอง ซื้อข้าว... หลังจากที่ไปตรงนั้น... แต่อันนี้คือเราไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยง”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคเหนือ

“ถ้ากระตุ้นเศรษฐกิจต้องไม่เป็น อสม. หรือถ้าเป็นต้องสละเงิน อสม. 2,000 บาท อสม.เค้าเลยไม่เอา เป็น part-time ไป”

— เจ้าหน้าที่ รพ.สต. / พื้นที่ภาคกลาง

“การจ้างนักบริบาล full time หลังจากที่ให้งบมาปีเดียว พอหมดงบก็ไม่มีแล้ว เหลือน้อยมากที่จ้างต่อ”

— พยาบาลวิชาชีพ / พื้นที่ภาคเหนือ

“บางคนจะท้อเรื่องการอบรม 70 ชั่วโมง ทิ้งบ้าน ทิ้งลูก ทิ้งเมียไป ก็ค่อนข้างยาก และต้องหาคนที่เสียสละจริง ๆ”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM พื้นที่ภาคเหนือ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.) ริเริ่มโครงการ “ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน” ซึ่งรับค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือน ปฏิบัติงานในพื้นที่ตนเอง มีแผนขยายให้ครอบคลุมทุกอำเภอในปี 2569 และถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. ภายใน 5 ปี เป็นการยืนยันระดับนโยบายว่าค่าตอบแทน 5,000 - 6,000 บาท ในระบบ LTC สปสช. นั้นต่ำเกินไปต่อการจ้างงานอย่างเป็นระบบ

— ผู้บริหารระดับนโยบาย /
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“[CG กระตุ้นเศรษฐกิจ] จากรัฐบาลมา 1,015 ล้านบาท จ้างได้ประมาณสัก 18,000 คน... ในปี 69 นี้ เราอาจจะเติมได้ถึง 30,000 คนที่จ้างงาน 5,000 - 6,000 บาทได้ แล้วปีถัดไปก็อยู่ประมาณสัก 50,000 คน”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“[เราพยายาม] ปรับระเบียบ อสม. ให้ [CG] ทำงาน 16 วันต่อเดือน วันละ 5 ชั่วโมง... เพื่อรับข้อจำกัดว่าค่าแรงมันเหมาะสมกับตัวค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่อย่างไร ซึ่งน่าจะประกาศได้ในระยะเดือนสองเดือนนี้”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 1.10: พลวัตของการจัดสรรภาระงาน: ความท้าทายระหว่างการจ้างงานเต็มเวลาและบางเวลา (Workload Stratification: The Full-time vs Part-time Dilemma)

เพื่อยกระดับความเป็นวิชาชีพ รัฐมีนโยบายสนับสนุนการจ้างงานผู้ดูแลแบบเต็มเวลา (Full-time) เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการดูแล อย่างไรก็ตาม ในบริบทชุมชน การจัดสรรงานมักต้องเผชิญกับ ความท้าทายในการรักษาสมดุล ระหว่าง “ความครอบคลุม” (Coverage) กับ “คุณภาพ” (Quality)

พื้นที่จึงได้เกิดกระบวนการปรับตัว โดยให้ CG แบบเต็มเวลารับผิดชอบเคสกลุ่มอาการหนัก (กลุ่ม 3 - 4) ที่มีความซับซ้อนสูง ในขณะที่กระจายเคสกลุ่มอาการเบา (กลุ่ม 1 - 2) ให้กับ CG ที่เป็น อสม. (Part-time) เพื่อรักษาสมดุลไม่ให้บุคลากรเต็มเวลาเกิดภาวะหมดไฟ และยังคงรักษาเจตนารมณ์ของการมีส่วนร่วมในระดับกว้างของชุมชนเอาไว้ได้

มุมมองจากพื้นที่:

“CM จะเลือกคนไข้กลุ่ม 3 และ กลุ่ม 4 ที่ต้องดูแลเยอะ ๆ ให้ CG full time บางคนจะ fix เลย... และ 6 คน เป็นประเภท 1 หรือ 2 อาจจะสลับวันเว้นวัน”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM พื้นที่ภาคเหนือ

“จริง ๆ CG full time เค้าได้ดูคนไข้เยอะกว่า แต่ถ้าถูกจำกัดด้วย 5 เคสที่มีคุณภาพ ในความคิดเห็นมันจะได้น้อยเคส แต่ถ้ากระจายแบบนี้ เค้าสามารถดูคนไข้ที่ไม่หนักแต่มีความเสี่ยง ก็ดูได้หลายเคสกว่ากัน”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM พื้นที่ภาคเหนือ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

“ผมยังเชื่อว่าต้องเป็น full time เพื่อความมั่นคงของระบบ เติมเข้ามาในระบบค่อย ๆเปลี่ยนถ่ายเพื่อความยั่งยืน เพราะว่าถ้าเป็น volunteer เนี่ย burden [ภาระหนัก] แน่นอน แต่ก็ยังยืนยันว่า Community-based ยังไงก็เป็นคำตอบของ LTC ปัจจุบันอยู่”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

“CG ส่วนใหญ่ที่รับเงินผ่านระบบกองทุนจะเป็น CG part-time ที่รับในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท... [แต่] CG หนึ่งคนสามารถดูแลได้มากกว่า [ที่ระเบียบกำหนดไว้สี่คน] ถ้าไม่มีข้อจำกัด เขาก็สามารถรับเป็นพาร์ทไทม์เพิ่มได้ ทำให้รายได้รวมอยู่ที่แปดเก้าพันบาทต่อเดือน”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“กลุ่มป่วยหนักกลุ่ม 3 กลุ่ม 4 นั้น ถ้าเราจัดสรร CG 1 ต่อ 5 อย่างปกติ แต่ถ้าเป็นผู้ป่วย Stroke Dementia จะต้องเป็นเท่าไหร่ CG จะต้องเป็นเท่าไหร่ แม้แต่พยาบาลเองยัง burden เลย... นี่เป็นโจทย์วิจัยต่อไปว่าสัดส่วนที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Theme 1.11: การเปลี่ยนผ่านจากความสูญเสียสู่เส้นทางวิชาชีพ และการหล่อเลี้ยงแรงจูงใจด้วยคุณค่าที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Transition from Personal Grief to Professional Caregiving & Non-Financial Incentives)

จุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วิชาชีพดูแลผู้ป่วยในระดับพื้นที่มักไม่ได้มาจากแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่บุคลากรจำนวนมากถูกขับเคลื่อนด้วย “การเปลี่ยนผ่านจากประสบการณ์ความสูญเสียส่วนบุคคลสู่เส้นทางวิชาชีพบริบาล” (Transition from Personal Grief to Professional Caregiving) โดยเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยหรือความสูญเสียบุคคลในครอบครัว ให้เป็นความเห็นอกเห็นใจและความตั้งใจที่จะทุ่มเทดูแลผู้อื่น

ทว่าเมื่อก้าวเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง บุคลากรกลุ่มนี้กลับต้องเผชิญกับข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง ทั้งอัตราค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับภาระงาน และเงื่อนไขทางระเบียบของกระทรวงมหาดไทยตลอดจน สปสช. ที่ไม่อนุญาตให้นำงบประมาณดูแลผู้ป่วย (LTC) ไปใช้ในการศึกษาดูงานหรือพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล (CG) ได้โดยตรง ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้ คณะทำงานในพื้นที่จึงพยายามรักษากำลังใจของคนทำงาน ผ่านการนำ “แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินและการให้คุณค่าทางสังคม” (Non-Financial Incentives and Peer Recognition) เข้ามาเป็นกลไกเสริม

กลไกดังกล่าวถูกขับเคลื่อนโดยการนำผลลัพธ์การดูแลมาเชื่อมโยงกับการมอบ “ใบประกาศเกียรติคุณ” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ การสร้างพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจและการยอมรับจากสังคมนี้ นับเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่ช่วยเยียวยาความรู้สึกจากอดีต และเป็นแรงสนับสนุนให้ผู้ดูแลยังคงมีกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แม้ระบบจะยังมีข้อจำกัดด้านผลตอบแทนทางการเงินก็ตาม

มุมมองจากพื้นที่:

“จุดเริ่มต้นก็คือดูแลคนในครอบครัว ดูแลพ่อพี่เป็นโรคหัวใจ... ติดเตียงอยู่ 17 ปี... รักษาแบบทีมแบบประคับประคอง สุดท้ายทำให้เรารู้สึกว่า เออ เราไปได้นะ... ยอมรับไม่เอาทุนตรงนั้นยอมมาดูแลพ่อก่อน พอเสียก็เริ่มสมัครเป็นจิตอาสาของ รพ.สต. ใกล้บ้าน”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

“แรงจูงใจที่เข้ามาเป็น CG เพราะเราเป็น อสม. เป็นจิตอาสาอยู่แล้ว... สมมติเป็นแม่ของเรา เราจะทำอย่างไร ทีนี้เราพร้อม เราอุ้มเลย... พอลงไปลึก ๆ สัมผัสเราเข้าใจแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคเหนือ

“น้อง CG กระตุ้นเศรษฐกิจ ก็เป็นคนในพื้นที่ค่ะ น่าจะอยู่ยาว... เดิมที่น้อง CG กระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นญาติผู้ป่วยก่อน มองเห็นการประกาศขอรับสมัคร ไม่มีใครมาสมัครเลย... เรามองที่ญาติของดูแล ไหน ๆ ต้องดูแลญาติตัวเองแล้ว มาอบรมเพิ่มมั้ย ขยายต่อยอดมาแบบนี้ค่ะ”

— พยาบาลวิชาชีพ / CM พื้นที่ภาคกลาง

“ทุกวงรอบของการทำงาน... จะมีการประเมินความพึงพอใจของ CG โดยที่เคสเป็นคนประเมิน และ CG จะมีการประเมินภาวะ burnout การทำงาน ซึ่งให้

ทางคณะกรรมการได้รับทราบ และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ทาง CG ในรอบปีที่เคสประเมินมาจาก 20 คน... ใครคะแนนอันดับ 1 2 3... เพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน"

— ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ภาคกลาง

"ด้วยข้อจำกัดของ CG ที่เราไม่สามารถพา CG ไปศึกษาดูงานได้ ติดข้อระเบียบข้อบังคับที่ว่า LTC โอนมาให้ศูนย์เพื่อใช้ในการทำงานของเคสเท่านั้น... ผมว่าอาจจะเป็นข้อเสนอแนะหนึ่ง ถ้าหากศูนย์ฯ ไหนที่สามารถบริหารจัดการได้ น่าจะเพิ่มโอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพของ CG อีกตัวก็จะดีนะครับ"

— ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ภาคเหนือ

"คนที่ออกจากงานมาดูแลญาติ พอหมดภารกิจแล้วก็ไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหนได้อีกแล้ว... คนเหล่านี้ถือว่ามีประสบการณ์ แล้วก็มีจิต มีความรักเป็นฐานแล้ว มีประสบการณ์แล้ว Career Path ของพวกนี้เรามาสร้างสู่อาชีพ [Caregiver] ได้เลย ก็จะไปเป็นเรื่องวิชาชีพเลย นี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่ทำให้คนเหล่านี้ไม่ต้องเคว้งคว้าง"

— สมาชิกวุฒิสภา / คณะอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

"ถ้าเราไป inspire เขา แล้วให้เขาเกิดอยากทำ เขาก็จะทำต่อไป หรือถ้าเกิดมีภาวะสะเทือนใจ มีใจรัก... แล้วก็อยากไปช่วย อันนี้จะทำต่อเนื่องยาว"

— สมาชิกวุฒิสภา / คณะอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

มิติที่ 2 การเงินการคลังและการจัดหาทรัพยากร (Financing & Resource Procurement)

เป้าหมายและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้ (Intended system design & expectation)

ระบบการเงินการคลังสำหรับการดูแลระยะยาว (Long-Term Care: LTC) ของประเทศไทย ถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจให้พื้นที่สามารถบริหารจัดการและจัดซื้อบริการหรือวัสดุทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม รัฐบาลผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบเหมาจ่ายรายหัว (Capitation) เข้าสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) โดยมีพัฒนาการของอัตราการจ่ายเงิน เริ่มต้นที่ 6,000 บาท/คน/ปี ต่อมาปรับเพิ่มเป็น 10,442 บาท/คน/ปี เพื่อขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มผู้ป่วยซับซ้อน เช่น ผู้ป่วยระยะท้ายและสมองเสื่อม และล่าสุดได้มีการปรับโครงสร้างงบประมาณกลับมาเป็น 6,000 บาท ที่โอนลงพื้นที่ โดยกันงบอีก 4,442 บาทไว้ที่ส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการเป็นค่าตอบแทนบุคลากรผู้ดูแล

เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังภายใต้ระบบงบประมาณแบบมีเพดาน (Global budget) โดยให้คณะอนุกรรมการระดับพื้นที่เป็นผู้อนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเบ็ดเสร็จและยั่งยืน

ข้อค้นพบจากพื้นที่ (Empirical Findings from the Field)

จากการประมวลผลข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 ภูมิภาค และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับนโยบายจากหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ สปสช. กรมอนามัย กระทรวง พม. และสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการปฏิบัติงานจริงต้องเผชิญกับพลวัตความท้าทายที่ทำให้ระบบไม่เป็นไปตามความคาดหวังเชิงทฤษฎี โครงสร้างการอภิบาลทางการเงินสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง งบประมาณเหมาจ่ายที่เท่ากันทุกรายไม่สะท้อนถึงระดับความรุนแรงและภาวะความจำเป็นทางคลินิกที่แตกต่างกัน ขณะที่งบประมาณส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 - 80 ถูกดึงไปใช้กับวัสดุสิ้นเปลืองพื้นฐานและค่าตอบแทน

Caregiver (CG) จนก่อให้เกิดภาวะงบประมาณตึงตัวในทุกพื้นที่ ข้อค้นพบสามารถสังเคราะห์เป็น 9 แก่นสาระ (Themes) ดังต่อไปนี้

Theme 2.1: ความไม่เพียงพอของงบเหมาจ่ายรายหัวต่อต้นทุนการดูแลตามความเป็นจริง (Inadequacy of Flat-rate Capitation vs. Actual Care Costs)

งบประมาณบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (LTC) ถูกตั้งและจำกัดให้เฉพาะบริการสาธารณสุขเป็นหลักตามบทบาทและภาระกิจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยในการคำนวณตั้งงบประมาณก็ชดเชยค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพียงร้อยละ 60 เท่านั้น (ข้อเสนอเชิงนโยบาย คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาบริการสาหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ, 2565) อย่างไรก็ดีเมื่อนำไปสู่การปฏิบัติระบบนี้ขับเคลื่อนโดยกำลังคนเป็นสำคัญโดยเฉพาะผู้ช่วยดูแล จึงทำให้ต้องนำเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ CG ทั้ง ๆที่ไม่ได้ถูกตั้งไว้ รวมถึงค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ซึ่งจะพบว่าบางแห่งใช้เงินส่วนใหญ่ไปเพื่อเป็นค่าตอบแทน CG หรือผ้าอ้อมผู้ใหญ่

การจัดสรรงบประมาณในอัตราคงที่ไม่สามารถสะท้อนความหลากหลายของความต้องการทางคลินิกระหว่างผู้ป่วยแต่ละรายได้ งบประมาณส่วนใหญ่ถูกดูดซับไปกับวัสดุสิ้นเปลืองพื้นฐาน โดยเฉพาะผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จนหมดก่อนสิ้นปีงบประมาณ ทำให้ไม่เหลือทรัพยากรสำหรับโภชนาการทางการแพทย์เฉพาะโรคหรือการสนับสนุนทางคลินิกที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care) และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องการอาหารทางการแพทย์ราคาสูง

มุมมองจากพื้นที่:

> *“6,000 บาท ค่านม ค่าดูแลส่วนอาหารเฉพาะโรคไม่พออยู่แล้ว ไหนจะค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่ได้อะไรเลย อย่างนม 500 บาท... ถ้าไม่บวกกับกายอุปกรณ์ซึ่งมีราคาแพง ซึ่งเราจะมีกองทุนฟื้นฟูที่เป็นของ อบจ. และสนับสนุนจาก รพ.”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ประมาณเดือนกรกฎาคม ผ้าอ้อมก็หมดแล้ว ยังไม่ถึงปีงบใหม่เลย เราไม่ได้ใช้เฉพาะคนไข้ Long Term Care แต่คนไข้ Intermediate Care ที่ออกจาก รพ. เราเอามากระจายให้ได้ทุกคน เพราะเราให้ทุกคนที่จำเป็นต้องใช้”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ที่เราขอเงิน Long Term Care ให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง แต่ละคนไม่เหมือนกัน ผู้หญิงแบบนึง ผู้ชายแบบนึง คนนี้ใส่สาย คนนี้ทำแผล มันจะให้เหมือนกันไม่ได้ ผ้าอ้อมเป็นส่วนเสริม”

— ผู้แทนหน่วยบริการสาธารณสุข พื้นที่ภาคกลาง

“เพราะว่าถ้า 6,000 แล้วบวกกับค่าจ้าง CG วัสดุการแพทย์ กายอุปกรณ์ 6,000 นี้ เราอาจจะไม่ได้อะไรเลย อย่างนม Nepro 500 อย่างเงี้ยค่ะ ที่เป็นของไต หรือว่า Ensure... 3 ช้อนต่อมื้อถึงจะพอ แล้วมันก็แค่ 850 มันก็ไม่พอ”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM (ทีม Palliative Care) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

ผู้บริหารระดับนโยบาย สปสช. ยืนยันว่าการกำหนดอัตราเหมาจ่ายเป็นการออกแบบตามข้อจำกัดทางการคลังของประเทศ โดยตั้งอยู่บนหลักการให้พื้นที่บริหารงบในลักษณะ “ถัวเฉลี่ยระหว่างเคสหนักและเคสเบา” ผ่านระบบ Global budget ซึ่งออกแบบให้เกิดความยืดหยุ่นภายในกรอบงบที่มี

“อัตราที่เราให้ไปเป็นงบต่อหัว เราไม่ได้ให้ไปแบบรายปีที่คิดว่าเคสหนักต้องได้อัตราเท่านี้ เราใช้เหมาจ่าย แล้วก็ให้พื้นที่บริหารว่างบที่ไปแล้วจะเฉลี่ยระหว่างเคสหนักและเคสเบาร่วมกันอย่างไร”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารด้านกำลังคน LTC กรมอนามัยยอมรับว่าการพึ่งพางบประมาณจากรัฐแหล่งเดียวไม่เพียงพอ และเห็นว่าการที่ท้องถิ่นเข้ามาเป็น “หุ้นส่วนทางการเงิน” (Financial Partnership) ผ่านกลไก Co-funding เป็นทิศทางที่ถูกต้อง

> *“เราคงไม่ Hold ไว้อย่างเดียว เราคงต้องหาภาคีเครือข่ายหลายๆ อย่าง ซึ่งตอนนี้ท้องถิ่นก็รับไปช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะ... ท้องถิ่นทำให้เกิด Co-Funding ได้ รูปแบบตอนนี้มันเป็นโมเดลที่ดี”*
>
> — ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เชี่ยวชาญนโยบายสุขภาพอาวุโสตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ระบบ LTC เผชิญล้วนสะท้อนกลับมายังข้อจำกัดด้านงบประมาณ และเชื่อว่าคำตอบของระบบต้องอยู่บนฐานของความเป็นจริงทางทรัพยากร

> *“แล้วสภาวะประเทศไทยที่ยังไม่พ้นกับดักความยากจน นั่งมองดูแล้วส่วนใหญ่จะติดงบประมาณหมดเลย แล้วก็เรื่องบุคลากร ขาดงบขาดบุคลากร เพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการให้เกิดขึ้นได้จริง มันน่าจะบนฐานของความเป็นจริง”*
>
> — ผู้เชี่ยวชาญนโยบายสุขภาพอาวุโส

Theme 2.2: ความไม่ยืดหยุ่นของงบประมาณรายปีที่สวนทางกับพลวัตทางคลินิก (Inflexibility of Annual Capitation vs. Clinical Dynamics)

การจัดสรรงบประมาณที่ผูกติดกับการเขียน “แผนการดูแล (Care Plan)” ล่วงหน้าเป็นรายปีนั้น ขัดแย้งกับธรรมชาติของโรคที่ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างปีโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ เมื่อผู้ป่วยมีอาการทรุดลง เช่น เกิดแผลกดทับใหม่ที่ต้องใช้ชุดทำแผลปริมาณมาก งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนเดิมจะไม่สามารถปรับเพิ่มหรือเบิกวัสดุนอกรายการได้

ในทางกลับกัน เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต วัสดุที่จัดซื้อไว้ตามแผนของบุคคลนั้นกลับค้างอยู่ในระบบโดยไม่สามารถโอนสิทธิไปให้ผู้ป่วยรายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ได้ โครงสร้างการเบิกจ่ายที่ขาดความยืดหยุ่นนี้จึงก่อให้เกิดทั้งความสูญเปล่าของทรัพยากร (Waste) และความตึงเครียด

จากการขาดแคลนวัสดุ (Shortage) ขึ้นในเวลาเดียวกัน

มุมมองจากพื้นที่:

> *“เงิน Long Term Care คือไม่อยากจะของบประมาณครั้งเดียว เงินตอนนี้ซื้อวัสดุต้องซื้อตามงบประมาณอยู่แล้ว Care Plan มันไปตามคน ซื้อตามปีงบประมาณ เพราะฉะนั้นมันจะฟุ่มเฟือย อยากจะให้มีโอกาสเบิก 2 ครั้ง... จากที่ไม่มีแผลแล้วไม่มีแผลก็เบิกเซตเพิ่มไม่ได้ สรุปแล้วต้องไปขอเบิกที่โรงพยาบาล กลายเป็นว่าที่หน่วยงานน่ะเป็นคลัง ที่เบิกเยอะมากเป็นแสนๆ”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ/CM พื้นที่ภาคกลาง

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

ผู้บริหารระดับนโยบาย สปสช. ชี้แจงว่าระบบได้ออกแบบให้ Care Manager (CM) สามารถปรับ Care Plan ได้ทุก 3 - 6 เดือนภายในรอบปีงบประมาณ เพื่อตอบสนองต่อสภาวะทางคลินิกที่เปลี่ยนแปลง แต่ยอมรับว่ากลไกนี้ยังไม่ได้รับการสื่อสารและปฏิบัติอย่างทั่วถึง

> *“ตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ Care Manager สามารถปรับ Care Plan ได้เสมอครับ หากลงพื้นที่แล้วพบว่าผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้น ก็สามารถปรับเพิ่มความถี่ในการเข้าดูแลได้เลย โดยระบบกำหนดให้มีการทบทวนแผนการดูแลทุก ๆ 3 ถึง 6 เดือนในแต่ละปี”*
>
> — ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ทั้งนี้ ผู้บริหารด้านกำลังคน LTC กรมอนามัยชี้ให้เห็นว่าระบบ 3C ที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เดิมเพื่อ “ออกแบบ Care Plan เพื่อเสนอโครงการต่อท้องถิ่น” เป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อการติดตามผลลัพธ์ทางคลินิกแบบ Real-time ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างในการบริหารจัดการงบประมาณระหว่างปี

“3C ตอนที่เราตั้งขึ้นมานั้นเราต้องการให้เขาสามารถดีไซน์ Care Plan เพื่อไปเสนอโครงการที่ท้องถิ่น แค่นั้นเอง... ส่วนเรื่องการอนุมัติเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ฝั่งเราเป็นแค่ขาขึ้น แต่ขาลงที่ผ่านบอร์ดผ่านแล้วนี่จะเป็นเรื่องของการเงิน สปสช.”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Theme 2.3: ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างงบประมาณกะทันหันต่อการบริหารจัดการระดับพื้นที่ (Impact of Sudden Central Budget Restructuring on Local Management)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรงบประมาณของ สปสช. ในปีงบประมาณ 2568 - 2569 ได้สร้างผลกระทบอย่างกะทันหันต่อการทำงานในระดับพื้นที่ จากการปรับลดอัตราเหมาจ่ายที่โอนให้ท้องถิ่น จากเดิม 10,442 บาท ลดลงเหลือเพียง 6,000 บาทต่อผู้มีภาวะพึ่งพิง 1 คน โดยดึงงบประมาณส่วนต่าง (4,442 บาทต่อคน) กลับไปไว้ที่ส่วนกลางเพื่อดำเนินนโยบายจ้างงาน “CG กระตุ้นเศรษฐกิจ” การปรับลดงบประมาณรายหัวอย่างฉับพลันนี้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ต้องรื้อและจัดทำแผนการเงินใหม่ทั้งหมด อีกทั้งยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดที่เม็ดเงินสำหรับจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยแต่ละรายลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานการณ์ดังกล่าวยิ่งทวีความท้าทายมากขึ้น เมื่อส่วนกลางยังไม่มีการประกาศแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณส่วนที่ดึงกลับไป ณ ช่วงเวลาที่นโยบายมีผลบังคับใช้แล้ว

มุมมองจากพื้นที่:

“เมื่อประมาณ 1 ตุลาคม ตัดงบประมาณจาก 10,442 บาท เหลือ 6,000 บาท เท่าเดิม เพราะว่าเอา 10,442 (ส่วนต่าง) ไปไว้ส่วนกลางที่ สปสช. แล้วให้ท้องถิ่นมาจัดอบรม CG กระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านทาง สปสช. โดยให้ท้องถิ่นเป็นคนคีย์ข้อมูล”

— ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / อปท. พื้นที่ภาคกลาง

“สปสช. ไม่มีเงิน เค้าให้โอนมาในศูนย์ 6,000 บาท ปีนี้ แต่ 4,442 บาทจะอยู่ส่วนกลาง แต่ประกาศการใช้เงินของ สปสช. ยังไม่ประกาศว่าต้องใช้อย่างไร แต่มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM (รพ.สต.) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“จากเดิมงบ 10,442 บาท เรามีการเฉลี่ยให้ค่าตอบแทน CG ก่อน และมาดูว่าค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้จะได้มากน้อยเท่าไร แต่ว่าพอลดงบประมาณมาเหลือ 6,000 บาท ก็เลยโยกค่าแพมเพิสและวัสดุอุปกรณ์ไปค่ะ”

— พยาบาลวิชาชีพ / กองสาธารณสุขท้องถิ่น พื้นที่ภาคเหนือ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

ผู้บริหารระดับนโยบาย สปสช. ชี้แจงว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้มีเหตุผลเชิงนโยบายชัดเจน โดยมุ่งแก้ปัญหาการที่ CG ไม่สามารถอยู่ในระบบได้อย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างระบบจ้างงาน CG แบบเป็นทางการในระยะ 3 ปี โดยตั้งเป้าขยายจำนวน CG ในระบบจากประมาณ 18,000 คน เป็น 50,000 คน และยกระดับค่าตอบแทนให้เหมาะสม

“เราอยากให้เห็นในสองสามปีนี้คือยกระดับ Caregiver ให้มีค่าตอบแทนในราคาที่เหมาะสม เราคุยกันตัวเลขที่เก้าพัน [บาทต่อเดือน]... ในปีนี้ [จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ] เราจ้างได้ประมาณสักหมื่นแปดพันคน แล้วปีถัดไปก็อยู่ประมาณสักห้าหมื่นคน ที่เราวางเป้าในระยะสามปี”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

อย่างไรก็ดี ช่องว่างระหว่างเจตนาของนโยบายกับประสบการณ์ของพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการสื่อสารและการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านยังไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพียง “การตัดงบ” มากกว่า “การปรับโครงสร้างเพื่อยกระดับ”

Theme 2.4: ความเหลื่อมล้ำของโครงสร้างค่าตอบแทนจากแหล่งทุนที่แยกส่วน (Compensation Discrepancy Across Fragmented Funding Sources)

ระบบการดูแลระยะยาวในชุมชนกำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ อันเกิดจากการพึ่งพาบุคลากรจากแหล่งงบประมาณที่แยกส่วนกัน ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนและเงื่อนไขการทำงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ ตำแหน่ง “ผู้ช่วยคนพิการ (PA)” ภายใต้งบประมาณของกระทรวง พม. จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า (รวมค่าเดินทาง) และมีขั้นตอนการเบิกจ่ายที่รวดเร็วกว่าผ่านการโอนตรงถึงผู้ปฏิบัติงาน

ในทางตรงกันข้าม ตำแหน่ง “Caregiver (CG)” ที่ขับเคลื่อนด้วยงบประมาณจาก สปสช. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลับได้รับค่าตอบแทนที่ต่ำกว่า แต่ต้องเผชิญกับขั้นตอนด้านเอกสารธุรการที่ซับซ้อนกว่ามาก โครงสร้างที่ลักลั่นนี้ ทำให้บุคลากรที่ทำงานในพื้นที่เดียวกันเกิดการเปรียบเทียบและรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญกำลังใจและเป็นอุปสรรคต่อการธำรงรักษาบุคลากร (Retention) ให้อยู่ในระบบต่อไป

มุมมองจากพื้นที่:

> *“การจัดการกับความมั่นคงในแง่ input ดีกว่าแน่ มั่นใจได้เลยว่าถ้าเค้าไม่ลาออก อยู่ไปตลอดชีวิต มีงบที่ตั้งทุกปี สาธารณสุขมันจ่ายเอาเปรียบเค้าอ่ะ 5,000 - 6,000 บาท ส่วน PA 6,000+2,000 เท่ากับ 8,000 บาท และที่จริงมากกว่านี้ได้ ถ้าชั่วโมงทำงานมากกว่านี้”*
>
> — ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ภาคกลาง

> *“แตกต่างชัดเจน เงินจาก พม.มีการเบิกจ่ายผ่าน อบต. อบต.เพียงยื่นเอกสารประกอบ และ พม.จะโอนตรงให้ CG แต่ถ้าเป็นเงินขา LTC จะทำโครงการขึ้นไปโอนเข้ามา อบต. อบต.โอนเข้า รพ.สต. และต้องทำแผนการใช้เงินของ รพ.สต. ประกอบด้วย ถึงจะใช้จ่ายได้... ในส่วนพื้นที่ไม่ต้องทำแผนเพื่อใช้จ่ายเงินเลย”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ / ผู้บริหารหน่วยบริการ พื้นที่ภาคกลาง

“ของ PA ชั่วโมงละ 60 บาท วันละ 6 ชั่วโมง... เต็มที่ 9,000 บาท ที่ตัวเองทำอยู่ค่ะ มีค่าเดินทางแยกอีกส่วน”

— นักบริบาล / ผู้ช่วยคนพิการ (PA) พื้นที่ภาคใต้

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

ผู้บริหารระดับนโยบาย สปสช. รับทราบปัญหาความลักลั่นนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขผ่านระเบียบ ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นใหม่ที่อยู่ระหว่างประกาศ ซึ่งจะกำหนดมาตรฐานค่าตอบแทน CG ให้เป็นทางการมากขึ้น และตั้งเป้าขยับค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับค่าแรงขั้นต่ำ อย่างไรก็ดี ยอมรับว่าการประสานงานข้ามหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหานี้ยังไม่มีเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน

“สิ่งที่เราอยากให้เห็นใน 2-3 ปีนี้คือยกระดับ Caregiver ให้มีค่าตอบแทนในราคาที่เหมาะสม... เราต้องตั้งวงพูดคุยกัน ระหว่าง สปสช. กรมอนามัย และกระทรวงมหาดไทยในฐานะนายจ้างของภาคท้องถิ่น แต่ยังขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นเจ้าภาพหลัก”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

กระทรวง พม. ชี้ให้เห็นว่าตำแหน่ง “ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน” ที่ พม. พัฒนาขึ้นใหม่นั้น ออกแบบให้มีค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่ง มีฐานรายได้ที่สูงกว่า CG ของสาธารณสุขมากพอสมควรและยังมีกรอบการขยายผลสู่ความยั่งยืนผ่านการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น

“ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน... ได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือน ปฏิบัติงานในพื้นที่ตนเองเพื่อสร้างความไว้วางใจ โดยมีอัตราดูแลผู้สูงอายุ 1 ต่อ 100 คน”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย /
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Theme 2.5: การกระจุกตัวของงบประมาณในค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหน้างาน (Budget Concentration on Frontline Workforce Compensation)

กระบวนการจัดสรรงบประมาณระดับพื้นที่เผชิญกับความตึงเครียดในการรักษาสมดุลระหว่างค่าจัดหาวัสดุทางการแพทย์และค่าตอบแทน CG เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนรายชั่วโมงหรือเหมาจ่ายรายเดือน คิดเป็นสัดส่วน งบประมาณสูงถึงร้อยละ 70 - 80 แม้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการยึดเป็นอาชีพหลักก็ตาม

มุมมองจากพื้นที่:

> *“70 - 80% เพราะเราแบ่งมาเป็นค่าจ้างดูแล น่าจะประมาณ 80%... ถ้าเป็นกอง 2 คือ 30% กอง 1 อยู่เป็นหลักด้วยให้เกือบ 80%”*
>
> — ผู้แทนหน่วยบริการสาธารณสุข พื้นที่ภาคกลาง

> *“เกณฑ์ของเขตสุขภาพเราจะจ่ายตามกลุ่มอาการค่ะ กลุ่ม 1 ดูแลอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ได้ชั่วโมงละ 50 บาท (รวม 400 บาท/เดือน) กลุ่ม 2 ได้ 500 บาท กลุ่ม 3 ได้ 600 บาท และกลุ่ม 4 ได้ 800 บาท... พอรวมค่าตอบแทนแต่ละเดือนมันก็ค่อนข้างเยอะ ทีนี้พอเรากังวลว่างบที่อนุมัติมาจะไม่พอซื้ออุปกรณ์ เราก็เลยต้องใช้วิธี ‘ถัวเฉลี่ย’ งบประมาณค่ะ คือดึงงบจากผู้ป่วยกลุ่ม 1 และ 2 ที่เขายังไม่ถึงขั้นติดเตียง มาช่วยซัพพอร์ตเป็นค่าผ้าอ้อมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับเคสที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM (สังกัด อปท.) พื้นที่ภาคเหนือ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

ผู้บริหารระดับนโยบาย สปสช. ชี้แจงว่าปัญหาการกระจุกตัวในค่าตอบแทนบุคลากรเป็นเหตุผลสำคัญที่นำมาสู่การแยกงบออกเป็น 2 ก้อน โดยหวังให้งบ 6,000 บาทที่โอนลงพื้นที่เป็น “งบสิทธิประโยชน์/วัสดุ” ส่วนงบ 4,442 บาทที่อยู่กลางเป็น “งบค่าแรง CG” โดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาการชนกันของสองรายการนี้ อย่างไรก็ตามก็จะได้เฉพาะพื้นที่ที่สามารถหาคนมาทำหน้าที่เป็น CG เต็มเวลาเท่านั้นส่วนพื้นที่ที่ไม่สามารถหาคนมารับงานตรงนี้ก็ต้องใช้เงินในส่วนที่โอนไปให้พื้นที่เหมือนเดิม

“เราทำข้อเสนอแยกไปแล้วว่าอันนี้เป็นงบสิทธิประโยชน์ อันนี้เป็นงบจ้างงาน เพื่อให้พื้นที่ไม่ต้องแบกรับภาระทั้งสองส่วนในวงเงินก้อนเดียว”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 2.6: ภาระต้นทุนแฝงของผู้ปฏิบัติงานและการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ (Frontline Hidden Costs and Economic Struggle)

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ระบบ LTC ยังผลักภาระ “ต้นทุนแฝง” (Hidden costs) ไปยัง CG โดยตรง ทั้งในรูปแบบค่าน้ำมันรถในการเดินทางเยี่ยมบ้าน ค่าเสื้อปฏิบัติงาน การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานประจำตัว (เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องเจาะน้ำตาล) รวมถึงการซื้อของบำรุงขวัญผู้ป่วยด้วยเงินส่วนตัว สภาวะนี้บีบบังคับให้ CG ต้องรับจ้างทำงานเสริมหลายทางเพื่อความอยู่รอด ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟ (Burnout) และส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบในระยะยาว

มุมมองจากพื้นที่:

“ถ้าถามว่าพอไหม พี่ไม่พอ พี่ต้องหาจ้างเสริม เพราะว่าพี่เลี้ยงลูกด้วย... กรีดยางจ้าง ขายขนม... ค่าน้ำมันบางทีจิตอาสาเราเดินทางไปเนาะ... อย่างที่พี่ไปเยี่ยมพี่ต้องซื้อของทุกครั้ง เพราะว่าเป็นผู้สูงอายุ ซื้อน้ำ นม ขนม ลูกชิ้น ถ้าเราไม่ช่วย...”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคใต้

“ตอนนี้รายได้หลักจากในระบบหนูได้แค่ 6,000 บาทค่ะ เลยต้องไปรับจ้างดูแลนอกเวลาอีก 5,000 บาท และรับจ้างล้างแผลอีก 3,000 บาท รวม ๆ แล้วถึงจะได้เดือนละ 14,000 บาท... แต่วันนึงกว่าจะเลิกงานก็ปาเข้าไป 20:00 น. เพราะต้องวิ่งรอกจัดสรรเวลา... กลายเป็นว่ายิ่งตั้งใจทำงาน สุดท้ายก็เหมือนทำงานจนตัวตายเลยค่ะ”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ /
CG (ปฏิบัติงานเต็มเวลา) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“อยากได้เสื้อทำงาน เวลาเราเข้าบ้านคนไข้ เป็น CG นะ เสื้อพวกนี้เราลงทุนซื้อเอง หรืออุปกรณ์เจาะปลายนิ้วอยากให้มี ไม่ต้องไปเบิกที่เทศบาล ของพี่ซื้อเองทุกอย่าง เทศบาลเค้าของบอยู่ค่ะ รอสั่งซื้อให้ทุกคน ช่วงนั้นขาด ต้องไปยืมที่เทศบาล”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG พื้นที่ภาคเหนือ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

กระทรวง พม. ตระหนักถึงช่องว่างด้านสวัสดิการของ Family Caregivers (ผู้ดูแลในครอบครัว) ซึ่งเป็นกลไกหลักกว่า 90% ของการดูแลจริง โดยมีมาตรการ “โครงการครอบครัวอุปถัมภ์” ให้เงินสนับสนุนรายเดือน 2,000 - 3,000 บาท แต่ยอมรับว่าปัจจุบันครอบคลุมได้เพียง 1,107 รายทั่วประเทศ ในขณะที่ความต้องการจริงมีมากกว่า 3,000 - 4,000 เคส

“ปัจจุบัน [โครงการครอบครัวอุปถัมภ์] ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง 1,107 รายทั่วประเทศ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการจริงที่มีมากกว่า 3,000–4,000 เคส”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้บริหารระดับนโยบาย สปสช. ยังได้ระบุว่ากำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะให้ “Family Caregiver” ที่ผ่านการอบรม 70 ชั่วโมง สามารถรับค่าตอบแทนจากระบบได้อย่างเป็นทางการ เพื่อลดภาระที่ตกอยู่กับครัวเรือนโดยไม่มีการสนับสนุน

“เรากำลังพยายามออกแบบระบบให้เป็นทางออกของครอบครัวครับ ทางเลือกแรกคือทำอย่างไรให้ Family Caregiver พอมีรายได้ชดเชยจากระบบบ้าง แทนที่จะต้องลาออกจากงานมาดูแลโดยไม่ได้เงินเลย หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ การส่ง CG ในระบบเข้าไปช่วยดูแลสลับสับเปลี่ยน เพื่อให้ญาติยังสามารถออกไปทำงานหาเลี้ยงชีพตามปกติได้”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 2.7: นวัตกรรมการบูรณาการข้ามกองทุน (Innovation in cross-fund integration)

ในสภาวะที่งบประมาณ LTC มีจำกัดและถูกตีกรอบการใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ผู้บริหารและ CM ระดับพื้นที่ที่เข้าใจกฎระเบียบ ได้ใช้ยุทธวิธี “ผสมผสานแหล่งทุน” (Funding Mix) โดยเขียนโครงการคู่ขนานเพื่อดึงงบประมาณจาก “กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (กปท. กอง 1)” และ “งบปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของกระทรวง พม.” เข้ามาบริหารจัดการร่วมกัน โดยแยกโครงการออกจากกันเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนของงบประมาณ

มุมมองจากพื้นที่:

> *“ปีนี้เราขอกองทุน LTC ปี 2569 ทราบว่า 6,000 บาทนี้เราซื้อแพมเพิสไม่พอ เราสามารถเขียนโครงการไปขอใช้กองทุนตำบลได้อีก... ที่พิจารณาไปถ้าเป็นกอง 2 (LTC) คือ 30% กอง 1 อยู่เป็นหลักด้วยให้เกือบ 80%”*
>
> — ผู้แทนหน่วยบริการสาธารณสุข พื้นที่ภาคกลาง

> *“ถ้าเราใช้งบ อปท.ของเราเอง... งบที่เราตั้งไว้ในการซ่อมแซมบ้านไม่เกินหลังละ 20,000 บาท แต่ถ้าเราประสานหน่วยงานภายนอก (พมจ.) ชาวบ้านจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะได้งบ 40,000 บาท สามารถซ่อมแซมได้มากกว่าครับ ถือว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนสำคัญจริงๆ”*
>
> — ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / อปท. พื้นที่ภาคเหนือ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

ผู้บริหารด้านกำลังคน LTC กรมอนามัยมองว่ากลไกที่ท้องถิ่นทำหน้าที่เป็น “หุ้นส่วนการเงิน” (Financial partner) และใช้กลไก LTC เป็นช่องทางในการมองเห็นปัญหา นำมาสู่การจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นเพิ่มเติม คือโมเดลที่ดีที่สุดในเชิงความยั่งยืน และแตกต่างจากระบบที่ สปสช. จ่ายตรงสู่หน่วยบริการแบบเดิม

“รูปแบบที่เอางบ LTC ลงไปที่ท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม เหมือนเป็น Financial Co-operation หรือ Financial Partnership มันคือช่องทางที่เขาได้เห็นปัญหา ได้เข้าใจสภาพ แล้วก็มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สำคัญคือทำให้เกิด Co-funding ได้ ถ้าไม่มีกระบวนการนำเสนอโครงการในท้องถิ่น การซ่อมแซมบ้าน การจัดสรรอุปกรณ์เตียงอะไรต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้น”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Theme 2.8: ยุทธวิธีการถัวเฉลี่ยงบประมาณในระดับปฏิบัติการ (Cross-subsidization Tactics to Fill Care Gaps)

เนื่องจากโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณไม่ยืดหยุ่นพอที่จะครอบคลุมผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงต่างกัน หรือผู้ป่วยที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ LTC (เช่น กลุ่ม Intermediate Care: IMC) ผู้ปฏิบัติงานหน้างานจึงใช้แนวคิด “ถัวเฉลี่ย” (Cross-subsidization) โดยโยกทรัพยากรทางการเงินและวัสดุของผู้ป่วยกลุ่มที่อาการเบาไปโปะให้กลุ่มที่อาการหนัก หรือแบ่งปันให้ผู้ป่วยกลุ่มนอกสิทธิ เพื่อรักษาหลักมนุษยธรรมในชุมชน แม้จะเสี่ยงต่อการใช้งบประมาณนอกเกณฑ์ก็ตาม

มุมมองจากพื้นที่:

“ค่าตอบแทนในการดูแลแต่ละเดือนจะค่อนข้างเยอะ และผู้สูงอายุที่กังวลว่าเงินที่อนุมัติมาไม่พอ เราถัวเฉลี่ยในผู้สูงอายุกลุ่ม 1, 2 ที่เค้ายังไม่ได้ติดเตียง แต่จำเป็นในเรื่องการใช้ผ้าอ้อม หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม้เท้า รถเข็น เราถัวเฉลี่ยเงินในแต่ละราย”

— เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาคเหนือ

“เราไม่ได้ใช้เฉพาะคนไข้ Long Term Care แต่คนไข้ Intermediate Care ที่ออกจาก รพ. เรากระจายงบ คือ 10,442 บาท ไม่ใช่เฉพาะคนนี้... เราเอามากระจายให้ได้ทุกคน ประมาณเดือนกรกฎาคม ผ้าอ้อมก็หมดแล้ว ยังไม่ถึงปีงบใหม่เลย เพราะเราให้ทุกคนที่จำเป็นต้องใช้”

— พยาบาลวิชาชีพ/CM พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

ผู้บริหารระดับนโยบาย สปสช. ชี้แจงว่าการออกแบบระบบเหมาจ่ายตั้งอยู่บนหลักการที่ตั้งใจให้เกิดการถัวเฉลี่ยดังกล่าวอยู่แล้ว โดยให้พื้นที่มีอำนาจบริหารจัดการงบในลักษณะ Global budget อย่างไรก็ดี สปสช. ยังพบว่ามีถึง 20% ของผู้มีสิทธิ LTC ที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับ Care Plan จริง และกำลังปรับระบบให้จ่ายตาม Care Plan ที่อนุมัติแล้วแทนการจ่ายตามการลงทะเบียน

> *"เราเจอ Pain Point ที่ผ่านมาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของ Long-Term Care ที่ลงทะเบียนไว้นั้นมีแค่ 20เปอร์เซ็นต์ที่นำไปสู่การทำ Care Plan จริง ๆ เราก็เลยปรับระบบใหม่ไปซื้อ [ตาม] Care Plan แล้วกันนะครับ เมื่อไหรก็ตามมีการอนุมัติ Care Plan เข้ามาในระบบ เราจะจ่ายไปที่ท้องถิ่นเพื่อไปจัดซื้อบริการต่อ"*
>
> — ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 2.9: ความขัดแย้งระหว่าง "สวัสดิการสิ่งของ" กับ "บริการดูแล" ในมุมมองของประชาชน (Expectation Gap Between Material Welfare and Care Services)

มีช่องว่างความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่างผู้กำหนดนโยบาย/ผู้ให้บริการ กับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมักมองระบบ LTC ว่าเป็นแหล่งจัดหา "สวัสดิการวัสดุสิ้นเปลือง" (เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) เป็นหลัก มากกว่าจะเห็นคุณค่าของ "บริการดูแล" ที่ CG ให้ ทำให้เกิดความตึงเครียดในการจัดสรรงบประมาณและนำไปสู่ข้อร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับสิ่งของตามที่คาดหวัง ปรากฏการณ์นี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารนโยบายที่เน้น "การให้" มากกว่า "การดูแล" จนสร้างความคาดหวังที่ไม่ตรงกับเป้าหมายเชิงคลินิกของระบบ

มุมมองจากพื้นที่:

> *"มองในรูปแบบของมุมสะท้อนของคนไข้หรือญาติ เห็นว่าแบบเดิมดีกว่า สมมติเราสนับสนุนแพมเพิส งบส่วนนี้มีเยอะกว่าสามารถเอาไปซื้อได้มากกว่า... แต่มองเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการกับชาวบ้านเอง มุมมองต่างกันเลย ชาวบ้านเห็นว่าแพม*

เพิสสำคัญที่สุดสำหรับเค้า แต่เรามองว่าการดูแลผู้ป่วยและญาติสำคัญกว่าในเรื่องของคุณภาพชีวิต”

— พยาบาลวิชาชีพ / พื้นที่ภาคกลาง

“สปสช. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการให้อย่างเดียว เช่น คุณสามารถมาขอผ้าอ้อมได้ที่บริการใกล้บ้าน แต่พอเอาจริงๆ ขั้นตอนมันเยอะมากกว่าจะได้ผ้าอ้อม คือเป็นเคสที่ยังไม่ได้เข้า Long Term Care เพราะ ADL มันเกิน 11... สุดท้ายก็ร้องเรียนไปที่ ศปส. [ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน] 3 รอบเพื่อผ้าอ้อม”

— เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพื้นที่ พื้นที่ภาคกลาง

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

ผู้บริหารระดับนโยบาย สปสช. รับทราบว่าการสื่อสารที่เน้น “การให้วัสดุ” ในอดีตสร้างความคาดหวังที่ไม่ตรงกับหลักการ ซึ่งเป็นความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบที่เน้นผลลัพธ์ทางสุขภาพ ทั้งนี้ยอมรับว่าแม้แต่ระบบการวัดผลก็ยังไม่มีตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) ที่ชัดเจน โดยปัจจุบันข้อมูลหลักที่เก็บคือ ADL ก่อนและหลังการรับบริการ 12 เดือน

“สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือ ณ ปัจจุบัน ขอข้อมูลขั้นต่ำจากพื้นที่ คือ ADL ก่อนบริการ เมื่อครบ 12 เดือนก็จะดูว่าเคสนั้นต้องได้รับการดูแลในปีถัดไปหรือไม่ นี่คือขั้นต่ำของข้อมูลที่ สปสช. ร้องขอจากพื้นที่”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

กระทรวง พม. มองว่าการขยายคำนิยาม “ความพิการ” ให้ครอบคลุมถึงภาวะสมองเสื่อม เป็นโอกาสสำคัญในการเปิดช่องทางการเงินใหม่ เนื่องจากกองทุนคนพิการมีศักยภาพทางการเงินสูงกว่ากองทุน LTC อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่าง “งบวัสดุ” กับ “งบบริการ” ในระยะยาว

“ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ‘บอร์ดชาติผู้สูงอายุ’ คือกลไกสำคัญที่สุดในการกำหนดทิศทางประเทศ โดยมีประเด็นเร่งด่วนคือการขยายคำนิยามความพิการให้ครอบคลุมถึงภาวะสมองเสื่อม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงงบประมาณจากกองทุนคนพิการที่มีศักยภาพทางการเงินสูงกว่า”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย /
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มิติที่ 3 ระบบสารสนเทศและตัวชี้วัด (Information Systems & Data Governance)

เป้าหมายและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้ (Intended system design & expectation)

ตามกรอบแนวคิดการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการต่อเนื่อง (Integrated Continuum of Long-Term Care) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบบข้อมูลสารสนเทศที่พึงประสงค์ควรเป็นระบบบูรณาการที่เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและข้อมูลทางสังคมเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถติดตามสถานะสุขภาพ ประเมินผลลัพธ์การจัดบริการ วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย และบริหารจัดการกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับประเทศไทย โครงสร้างระบบถูกออกแบบโดยมุ่งหวังให้มีการใช้ฐานข้อมูลส่วนกลางแบบบูรณาการ ดังนี้

- การคัดกรองและประเมิน ผ่านแอปพลิเคชันสมุดสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application)
- การจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) บันทึกในระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ของกรมอนามัย และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนระดับพื้นที่
- การเชื่อมต่อระบบการเงิน ส่งต่อข้อมูลไปยังระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่ออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
- การติดตามประเมินผลระดับประเทศ ผ่านระบบ Health Data Center (HDC) และ Health KPI ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังตัวชี้วัด ประเมินผลลัพธ์ระดับชาติ และสะท้อนข้อมูลกลับสู่พื้นที่เพื่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ข้อค้นพบจากพื้นที่ (Empirical Findings from the Field)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่และผู้บริหารส่วนกลาง พบปรากฏการณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างเจตนารมณ์ของการออกแบบระบบสารสนเทศส่วนกลางกับความเป็นจริงในระดับปฏิบัติการ โดยสามารถสังเคราะห์เป็น 6 แก่นสาระ (theme) ดังนี้

Theme 3.1: ความแตกแยกของระบบฐานข้อมูลและภาระการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน (Fragmented Central Databases and Redundant Data Entry)

การพัฒนาระบบสารสนเทศที่แยกส่วนกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง (Siloed IT Development) ส่งผลให้เกิดความแตกแยกของฐานข้อมูลอย่างรุนแรง พยาบาลผู้จัดการการดูแล (CM) และบุคลากรสาธารณสุขต้องเผชิญกับภาระงานธุรการที่ซ้ำซ้อน (Double/Triple Data Entry) โดยต้องบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยรายเดียวกันลงในหลายแพลตฟอร์มที่ไม่สามารถดึงข้อมูลข้ามกันได้ ได้แก่ ระบบ 3C ของกรมอนามัย, ระบบเบิกจ่ายของ สปสช., โปรแกรม HOSxP ของโรงพยาบาล, โปรแกรม Smart COC และระบบ สอน.บัดดี้

ความซ้ำซ้อนนี้ไม่เพียงแต่ดึงเวลาอันมีค่าของบุคลากรออกจากการลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วย แต่ยังทำให้ระบบถูกใช้งานในฐานะ “เครื่องมือส่งเอกสารเพื่อเบิกเงิน” มากกว่าการเป็น “เครื่องมือบริหารจัดการทางคลินิก” ในระดับรายละเอียด แม้แต่แผนการดูแล (Care Plan) ในระบบกลางก็กลายเป็นเพียงเอกสารเพื่อปลดล็อกงบประมาณ เนื่องจากข้อมูลในระบบมักไม่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับอาการของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปรายวันหรือรายสัปดาห์ ส่งผลให้แผนการดูแลที่ใช้ปฏิบัติงานจริงระหว่าง CM และผู้ดูแล (CG) ถูกจัดทำแยกต่างหากในรูปแบบกระดาษหรือแอปพลิเคชันส่วนตัว

นอกจากนี้ ความล้มเหลวของการบูรณาการยังฝังรากลึกในสถาปัตยกรรมเชิงโครงสร้างของรัฐ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง (PCU) ซึ่งได้รับรหัสหน่วยบริการใหม่จากส่วนกลางแล้ว แต่ระบบเวชระเบียนกลับไม่สามารถแยกฐานข้อมูลออกมาได้ ทำให้ต้องคีย์ข้อมูลปะปนกับรหัสของโรงพยาบาลแม่ข่าย ส่งผลให้การส่งออกรายงาน 43 แฟ้มมีความคลาดเคลื่อน

มุมมองจากพื้นที่:

“ทุกโปรแกรมไม่มีการเชื่อมต่อเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นฐานอะไร ทุกโปรแกรมตัดขาดจากกันหมดเลยค่ะ เริ่มใหม่หมดเลยค่ะ การนำเข้าประชากร การลงข้อมูล”

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล CM

“กว่าจะถึงขั้นตอนนั้นมีการทำเยอะ ต้องประเมิน ADL ให้ได้ ต้องทำการพยาบาลที่คีย์ในระบบ LTC ของกรมอนามัย ต้อง care plan เสนอก่อน... ทำเป็นโครงการเสร็จต้องเสนอไปก่อน อบต.ประชุม อนุกรรมการอนุมัติ เอาทั้งหมดมาคีย์เข้าระบบ LTC ของสปสช. เพื่อให้น้องที่อยู่อบต.เห็นรายชื่อที่เราคีย์เข้าไป”

— พยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.สต.

“เราเอาคนไข้เข้า สปสช. เสร็จแล้วพอมีการอนุมัติวงเงินเข้ามาในเทศบาล เราจะต้องเข้าไปทำ care plan โดยผ่านของกรมอนามัย... (สปสช.) มีแต่รายชื่อ เบิกงบประมาณ ไม่มี care plan ไปด้วย”

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแลประจำสถานบริการ

“ระบบ 3C ของท้องถิ่นจะมีปัญหาเรื่องโปรแกรมการคีย์ ท้องถิ่นคือต้องคีย์ตามข้อมูล รพ.สต. ถ้าคีย์แล้วข้อมูลไม่ตรงกับ รพ.สต. คือต้องให้ รพ.สต.แก้ บางทีของแก้แล้วมันไม่เปลี่ยนหน้าเว็บ เราก็คีย์ของไม่ได้... รพ.สต.เนี่ยคือ Sync ให้จริงจะเห็นแค่ข้อมูลผู้ป่วยจะไม่เห็น Care Plan จะเห็นแค่ข้อมูลว่ามีกี่ราย”

— ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

ที่น่าสนใจคือ ผู้บริหารส่วนกลางยืนยันว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของการปฏิบัติงาน แต่เป็นผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ล่วงหน้าจากการออกแบบระบบที่มีวัตถุประสงค์ต่างกันตั้งแต่ต้น ผู้อำนวยการกองงานของ กรมอนามัย ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่า

“ ตอนที่เราตั้งระบบ 3C ขึ้นมา วัตถุประสงค์หลักคือต้องการฝึกให้เขาสามารถเขียนแผนการดูแล (Care Plan) เพื่อไปเสนอขอรับงบประมาณจากท้องถิ่นได้แค่นั้นเลยครับ นั่นคือจุดเริ่มต้น แต่หลังจากนั้นการพัฒนาระบบก็ชะงักไปเพราะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยว ส่วนขั้นตอนหลังจากที่โครงการผ่านบอร์ดแล้ว เรื่องการจัดการเงินทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของ สปสช.”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ในขณะที่ สปสช. ก็ยอมรับเช่นกันว่าระบบข้อมูลที่ตนถือครองถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ใช่การบูรณาการข้อมูลแบบครบวงจร

“ระบบของ สปสช. ออกแบบเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณเป็นหลัก เพื่อให้พื้นที่ได้รับงบตามจำนวนผู้รับบริการที่ใกล้เคียงมากที่สุด... ข้อมูลชุดที่สองที่มีความสำคัญ—ด้านคุณภาพบริการ (LTC for Service)—เป็นบทบาทของกรมอนามัยที่ทำผ่านโปรแกรม 3C”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“เราจะ API กันหลังบ้านอยู่หลายเรื่องนะครับ เพราะว่าอะไรที่ 3C มี แล้ว สปสช. ไม่มี เราจะ API เชื่อมกัน อะไรที่ สปสช. มี แล้ว 3C ไม่มี เราก็เชื่อมกันลักษณะนี้ครับ”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ผู้บริหาร สอน.บัดดี้ สะท้อนภาพรวมของปัญหาจากมุมมองระดับนโยบาย โดยชี้ว่าการแตกแยกของระบบข้อมูลเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นทั่วทั้งระบบ ไม่จำกัดแค่ในกลุ่ม LTC

“มันจะเป็นยุคที่แอปเฟ้อแน่ๆในช่วงนี้ ทุกคนผลิตแอป อยากมีแอปของตัวเอง หวงเดต้า ทุกอย่างเลยยังคงกลายเป็น silo อยู่ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องช่วยกันข้ามผ่านตรงนี้ไป”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สอน.บัดดี้ / สป.สธ.

“คนทำมันเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดแล้วรับทุกแอพ เพราะฉะนั้น ถามว่าในประเทศเราตอนนี้ยังมีการทำซ้อนของแอพในมุมของ Long Term Care เองเยอะไหม ก็ยังเยอะอยู่ จริงจริงไม่ได้เยอะแค่ Long Term Care ด้วย เยอะในหลายหลายมิติเลยค่ะ”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สอน.บัดดี้ / สป.สธ.

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสังคม (ระดับนิติบัญญัติ) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสังคม ยังเสริมว่า ภาระงานเอกสารที่ซ้ำซ้อนนั้นสะท้อนถึงการออกแบบระบบที่ยังไม่ได้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

“ตรงนี้ที่เราบอกว่ามันเป็นภาระเรื่องเอกสารนะ มันต้องหมดแล้ว ภาระจริง ๆ แล้วมันต้องไม่เป็นภาระ มันต้องเป็นภารกิจ ภารกิจคือทำเป็นประจำทุกวัน ถ้าทำประจำทุกวันสม่ำเสมอก็ไม่ใช่ภาระ... เมื่อทำก็บันทึกเข้าไปในคอมเลย ใส่เข้าไปเลยมันก็ประมวลผลออกมา”

— สมาชิกวุฒิสภา / คณะอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

Theme 3.2: สุญญากาศข้อมูลช่วงรอยต่อการดูแล จากการเปลี่ยนผ่านนโยบายสารสนเทศ (Information Void at Care Transitions from Top-Down IT Policy Changes)

การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศตามนโยบายจากส่วนกลางสร้างรอยต่อในการดำเนินงานอย่างรุนแรง เมื่อพื้นที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนจากโปรแกรมส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยเดิม (เช่น Smart COC หรือ ThaiCOC) ซึ่งมีระบบแจ้งเตือน (Pop-up Notification) แบบเรียลไทม์และมีชุดแบบฟอร์มการดูแลเฉพาะโรค มาใช้ระบบใหม่ (เช่น สอน.บัดดี้) ที่ขาดฟังก์ชันการแจ้งเตือนและออกแบบให้ข้อมูลส่งตรงไปยังอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยตรงแต่ปิดกั้นการมองเห็นของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.

ผลที่ตามมาคือเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลแบบ manual ทุกวัน เพิ่มความเสี่ยงที่เคสผู้ป่วยวิกฤตจะตกหล่นระหว่างการส่งตัวจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน และก่อให้เกิดความ

วุ่นวายในการประสานงาน เช่น กรณีที่แพทย์จัดให้มี Video Call กับผู้ป่วยในเวลาเดียวกับที่ อสม. ถูกส่งไปรอที่บ้าน แต่ไม่มีการประสานงานเวลาร่วมกัน

มุมมองจากพื้นที่:

"ข้อเสียคือว่าถ้าเป็น COC เหมือนก่อนจะเตือนเราเลยว่ามีเคสเยี่ยมนะ แต่ถ้าเป็น สอน.บัดดี้ เราต้องเข้าไปดู มันไม่เตือน แต่เข้าไปดูจะมีเหมือน dashboard เหมือนปฏิทินให้เห็นว่าวันนี้เรามีเคสอะไรบ้างส่งมากี่ราย"

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล

"ระบบ สอน.บัดดี้ จะส่งตรงไปที่ อสม. ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เห็นเคส และเมื่อไปเชื่อมโยงข้อมูลกับ Telemed จะเกิดปัญหาว่าโรงพยาบาลให้หมอ Video call คุยกับคนไข้หรือญาติ แล้วให้ อสม. ไปรอที่บ้านซึ่งอาจจะไปถึงก่อนหรือบางเวลาหมอติดเคสอยู่ ก็จะเหลื่อมเวลากัน"

— ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

"พอเป็น สอน.บัดดี้ ไม่มีรูปแบบนั้น แปลว่าต้นทางส่งมา ถ้าส่ง complete คนปลายทางจะรู้รายละเอียดทั้งหมด เพราะมันเป็นการพิมพ์ทั้งหมด ไม่มีรูปแบบมา แต่ถ้าส่งมาไม่ครบ ปลายทางเยี่ยมรายละเอียดครบ และต้นทางจะรู้รายละเอียด แต่ถ้าปลายทางส่งรายละเอียดไม่ครบ ข้อมูลจะไปไม่ครบค่ะ มันอาจจะกำลังพัฒนา"

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล

"เมื่อก่อนเราใช้ ThaiCOC เป็นหลักในการส่งต่อเคส ตอนนี้ ThaiCOC ปิดตัวลง เราเลยส่งเคสที่มีประวัติเคส มียา การวางแผนการรักษาส่งผ่าน LINE เป็นหลัก"

— แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

ผู้บริหาร สอน.บัดดี้ ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างระบบยังไม่ใช่กระบวนการที่ไร้รอยต่อ (Seamless) ในปัจจุบัน

"การส่งออกข้อมูลจาก HOSxP หรือจาก HIS มาที่ สอน.บัดดี้ เนี่ยยังไม่ใช่กระบวนการส่งแบบไร้รอยต่อ แต่ขารับเข้านั้น ต้องยอมรับเรื่องของโอกาสในการพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่อง"

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สอน.บัดดี้ / สป.สธ.

"แอพเพื่อการเบิกเคลมเป็นแอปหนึ่ง แอพเพื่อการเยี่ยมบ้านเป็นแอปหนึ่ง แอพเพื่อการรับส่งต่อจากโรงพยาบาลเป็นแอปนึงอย่างนี้เป็นต้น... จริง ๆ มุมนี้คงไม่สามารถแก้ได้ด้วยคนใดคนหนึ่ง แต่ว่าอาจจะต้องมามองภาพระบบร่วมกัน"

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สอน.บัดดี้ / สป.สธ.

ผู้บริหาร สอน.บัดดี้ ยังชี้แจงถึงเจตนารมณ์เดิมของการพัฒนาระบบ ซึ่งไม่ได้มุ่งหวังให้เป็นระบบสารสนเทศหลัก (HIS) แต่เป็นเพียง "ตัวเชื่อมต่อ" สำหรับงานนอกหน่วย ที่ภายหลังถูกดึงมาใช้ในบทบาทที่กว้างขึ้นตามนโยบาย digital transformation

"สอน.บัดดี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาเนื่องจาก ณ ช่วงเวลานั้น มันยังไม่มีระบบปฏิบัติการที่เอาไว้เก็บข้อมูลการดูแลผู้ป่วยในชุมชนของหน่วยบริการปฐมภูมิเลย... เราเอามาขับเคลื่อนในมุมของการทำ digitalization ทั้งหมดของหน่วยบริการปฐมภูมิ"

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สอน.บัดดี้ / สป.สธ.

Theme 3.3: นวัตกรรมจากคนทำงานหน้างาน และการเกิดระบบไอทีทางเลือก (Frontline IT Innovations and Alternative Systems)

เมื่อระบบสารสนเทศทางการของรัฐตอบโจทย์เพียงแค่การเบิกเงินและการส่งรายงาน ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จึงต้องหาทางเอาตัวรอดด้วยการสร้าง "ระบบไอทีทางเลือก" ขึ้นมาใช้

อุดช่องโหว่ในการดูแลผู้ป่วย เราจึงได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น แอปพลิเคชัน CG 4.0 ที่พัฒนาโดยบุคลากรในท้องถิ่น, แอปพลิเคชันเฉพาะกิจของ ผอ. รพ.สต. ที่ใช้บันทึกพิกัด ถ่ายภาพ และให้ญาติเซ็นรับรองแบบดิจิทัล ไปจนถึงการใช้กลุ่ม LINE (Line OA) และระบบ Telemedicine เพื่อปรึกษาอาการและติดตามผู้ป่วยแบบเรียลไทม์

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญของนวัตกรรมเหล่านี้คือการทำงานที่ “แยกส่วน” (Siloed) และไม่สามารถดึงข้อมูลข้ามไปเชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียนหลักของโรงพยาบาล (HOSxP) หรือระบบส่วนกลางอย่าง 3C ได้ ทำให้ข้อมูลทางคลินิกที่มีค่า ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายแผลกดทับ ระดับน้ำตาล หรือบันทึกการดูแลแบบประคับประคอง ถูกกักเก็บอยู่แค่ในช่องทางสื่อสารส่วนตัว ข้อมูลที่ไม่ถูกรวมเข้าสู่ฐานข้อมูลสุขภาพระดับชาตินี้ ทำให้ระบบสาธารณสุขสูญเสียโอกาสสำคัญในการประเมินและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว

มุมมองจากพื้นที่:

> *“ส่งการบ้านผ่าน application CG 4.0 เข้ามาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนกลุ่ม 2 จะมีปัญหาเรื่องของสมอง จะเยี่ยม 5 ครั้ง... จะส่งการบ้าน 5 ครั้งผ่าน Line application... ไปเจอวันนี้อาการคนป่วยเป็นอย่างไรบ้าง กินได้มั้ย ปวดมั้ย มีอาการอย่างไร และมีรูปภาพด้วย”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล CM

> *“care plan ของ LTC ที่ทาง รพ.สต. จะผลิต app มา เป็น app CG และบันทึกในนั้น... ผอ.ผลิตออกมา จะมีข้อมูลครบหมด ไปเยี่ยมวันไหน เช่นเคสยายคนนี้มีครบหมด มีรูป... มีญาติเซ็น... เก็บไว้เป็นผลงาน และส่งงาน อบต. มีแบบฟอร์มอีก ต้องทำทั้ง 2 อย่าง”*
>
> — ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG

> *“(ผู้สัมภาษณ์: CG 4.0 มันเชื่อมข้อมูลใน รพ. มั้ยครับ) ไม่ได้เชื่อมค่ะ... เราทำทะเบียนแยกต่างหาก เราเป็น excel ธรรมดาขึ้นทะเบียนไว้”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล

“คนไข้ที่เป็น LTC และมีการคุย Advanced Care Plan ทุกรายจะเข้ากลุ่ม Line OA มีการคุยต่อเนื่อง มีการส่งอาการของผู้ป่วย update... รวมถึงเคสที่เป็น palliative care ทุกครั้งที่มีการจัดการอาการอยู่ที่บ้าน เหนื่อยเป็นอย่างไร อาการเป็นอย่างไร VDO call”

— แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

“คนไข้ LTC ที่ติดเตียงจะไม่สามารถที่มาขึ้นทะเบียนได้ ของระบบในอำเภอสามารถที่จะอัด VDO ในกรณีที่หมอลงไม่ได้... ให้คุณหมอที่ รพ. ประเมินได้... ได้ใบรับรอง ไปชี้นขอเบี้ยผู้พิการที่ อบต.”

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

ผู้บริหาร สอน.บัดดี้ มองว่าฉากทัศน์ที่พึงประสงค์ในอนาคตไม่ใช่การสร้างแอปใหม่เพิ่มเติม แต่เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบต่าง ๆ ให้ไหลเวียนหากันสะท้อนว่าแม้ส่วนกลางจะตระหนักถึง ปัญหาการที่แต่ละหน่วยงานต่างคนต่างพัฒนาระบบสารสนเทศของตนเองอย่างไม่เป็นเอกภาพ แต่ทางออกที่ว่าต้องอาศัยกลไกเชิงระบบที่ใหญ่กว่าที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะทำได้เพียงลำพัง

“เราไม่ได้อยากสร้างแอปใหม่เพิ่ม ไม่ได้อยากแตกฟังก์ชันเพิ่ม แต่เราอยากให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เพราะว่ามันถูกสร้างมาเพื่อรายการบริการ มันชัดคือเราก็จะพัฒนาสเกลและฟังก์ชันเพื่อตอบโจทย์ระบบบริการ แล้วก็ทำหน้าที่ในการเชื่อมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของข้อมูลและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลประชาชน”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สอน.บัดดี้ / สป.สธ.

กรมอนามัย ก็มีวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกัน โดยมองว่าข้อมูลระดับพื้นที่ต้องเชื่อมกลับสู่ฐานข้อมูลระดับชาติ แต่ยังไม่มีกลไกที่ชัดเจนในการทำให้เกิดขึ้นจริงในระยะสั้น

“สิ่งที่ทำได้คือเราทำกลาง แต่ถ้าพื้นที่หรือจังหวัดสามารถพัฒนาเองได้ตรงนี้จะช่วยในการลงทุนหรือการพัฒนาได้มาก แต่ก็มาซิงค์ข้อมูลกัน ผมยังคิดว่าดาต้าเซตในระดับพื้นที่สำคัญ แต่สุดท้ายก็มาเชื่อมกับดาต้าฮับของระดับประเทศเพื่อให้เห็นข้อมูลในการชี้เป้าหรือการปิดช่องว่างหรือการนำวิเคราะห์”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Theme 3.4: การบันทึกข้อมูลเชิงรับและวิกฤตความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูล (Defensive Documentation and Data Reliability Crisis)

วัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อมูลหน้างานของผู้ดูแล (CG) ได้ถูกบิดเบือนจาก “การสะท้อนผลลัพธ์ทางคลินิก” กลายเป็น “เครื่องมือเชิงรับเพื่อป้องกันการตรวจสอบและร้องเรียน” (Defensive Documentation) สืบเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างผู้ดูแลกับญาติผู้ป่วย CG จึงถูกบังคับให้ถ่ายภาพ บันทึกพิกัดเวลา และให้ญาติลงลายมือชื่อยืนยันการเยี่ยมทุกครั้งผ่านทั้งแอปพลิเคชันและกระดาษ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนและปกป้องตนเองจากการถูกฟ้องร้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบสารสนเทศถูกใช้งานเพื่อการตรวจสอบมากกว่าการพัฒนาคุณภาพการดูแล

ในขณะเดียวกัน นโยบายที่ผลักดันให้เกิดการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitalization) ทั่วประเทศ มักละเลยการพิจารณา “ข้อจำกัดด้านทักษะทางเทคโนโลยี (Digital Literacy)” ของผู้ปฏิบัติงานระดับชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือผู้ดูแลวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ เมื่อระบบบังคับให้กลุ่มคนเหล่านี้ประเมินและคีย์ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน (เช่น สมาร์ท อสม.) ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อผิดพลาดในการบันทึกจำนวนมหาศาล ทำให้ฐานข้อมูลระดับชาติ (HDC) ขาดความน่าเชื่อถือ (Data Integrity Issue) และในบางพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานขอปฏิเสธการใช้งานระบบดิจิทัลและหันกลับไปใช้ระบบจดบันทึกด้วยกระดาษเช่นเดิม

มุมมองจากพื้นที่:

“ตอนนี้ใช้ app แต่ก่อนต้องใช้เป็นกระดาษ CM เค้ากลัว CG มีปัญหา เพราะบางเคสบางกรณี คนไข้บอก CG ไม่ไปเยี่ยม หรือไปไม่ครบ แล้วตอนนี้มีใบให้เซ็น ผู้มี

ภาวะพึ่งพิงเป็นคนเซ็นว่าวันนี้เราไปเยี่ยมจริงวันที่เท่าไร และต้องตรงกับ App ที่เราลง... อย่างน้อยกัน CG CM และญาติด้วย”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG

“ให้ญาติผู้สูงอายุเซ็นทุกครั้งที่ไปดูแล หลังจากนั้น 1 เดือนพอเยี่ยมครบ CG นำใบเซ็นชื่อส่งมาที่ รพ.สต. เพื่อจะรวบรวมส่งไปทาง อบต. เพื่อที่จะแนบเอกสาร ทาง CG จะลงเยี่ยมใน application CG 4.0... และแนบในการเบิกจ่ายเงินต่อไปค่ะ”

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล CM

“ถ้าโดย sense เราที่เราเป็น CM แล้วเรามอนิเตอร์งานเนี่ย เราแค่เห็นภาพบางคนก็จะรู้แล้วว่าอันเนี้ยภาพเก่า... แต่ถึงกว่าเราจะรู้เนี่ย feedback อีกอย่างนึงก็คือ ญาติ ญาติจะบอกเลยว่าไม่ได้เข้าไปเลย... เค้าก็จะมาฟ้องเราที่ระดับสถานบริการทันที”

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล CM

“ผลของ HDC ปีที่แล้วที่เค้าใช้สมาร์ท อสม. ให้ อสม.เป็นคนประเมินและคีย์ใส่สมาร์ท อสม. ข้อมูลขึ้น HDC พอเรามาดูข้อมูล HDC เราไปย้อนดูทำไมข้อมูลเป็นแบบนี้ เราให้ทำแผ่นกระดาษด้วย และให้คีย์ด้วย พอเรามาเทียบดูกระดาษแบบหนึ่ง คีย์แบบหนึ่ง แบบนี้หมายความว่าอะไร อสม.คีย์ผิด”

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล CM

“เมื่อก่อนนักบริบาลชุมชนของพ่อเคยมี สถาบันการศึกษาพยายามพัฒนา Application นี้ให้ แต่มันใช้ลำบาก และเลิกใช้แล้ว ดูยุ่งยาก ทั้งเรื่องอินเตอร์เน็ต ตอนนี้เขียนมือ”

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล CM

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

กรมอนามัยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าในระดับพื้นที่ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจัง ซึ่งสะท้อนถึงวงจรปัญหาที่ข้อมูลถูกบันทึกเพื่อรายงาน แต่ไม่ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล เมื่อทีมวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า หลายพื้นที่ไม่เคยแม้แต่จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในระดับโรงพยาบาลในฐานะหน่วยที่พึ่งทางเทคนิค หรือแม้แต่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารระดับนโยบายของกรมอนามัยตอบรับว่า

> *"สิ่งที่เราวางแผนไว้คือการสร้างระบบมาตรฐาน (Standard) และระบบการตรวจสอบ (Audit) ส่วนประเด็นที่สองคือการอุดช่องโหว่ (Fill the Gap) ของการทำงาน โดยเราต้องกลับมาตั้งคำถามว่า ศักยภาพและประสิทธิภาพของคนในพื้นที่นั้น เขามีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูล (Analytical Thinking) แล้วหรือยัง"*
>
> — บทสนทนาระหว่างทีมวิจัย – ผู้บริหารระดับนโยบาย
> กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ในด้านปัญหา Digital Literacy ผู้บริหารระดับนโยบาย สปสช. ก็ตระหนักว่าระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับคุณภาพบริการแบบครบวงจรนั้น ยังไม่พร้อมในเชิงปฏิบัติ เพราะจะยิ่งเพิ่มภาระงานในการบันทึก

> *"ระบบข้อมูลมันดี ครอบคลุมคุณภาพได้เลยครับ แต่ว่ามันจะมีความยาก เพราะมันจะต้อง input ข้อมูลหลายเรื่องนะครับเข้ามาในระบบ... ถามว่ามันดีไหม มันดีเพียงแต่ว่าถ้า implement ออกไปมันจะยังไม่พร้อม เพราะว่ามันจะทำให้ภาระงานในการบันทึกข้อมูลอาจจะเพิ่มมากขึ้น"*
>
> — ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 3.5: การบิดเบือนข้อมูล ADL เชิงมนุษยธรรมและข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของตัวชี้วัด (Compassionate ADL Distortion and Structural Limitations of Process-Oriented Indicators)

ระบบการประเมินผลระดับชาติผูกมัดความสำเร็จและการอนุมัติงบประมาณไว้กับความก้าวหน้าของคะแนนความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) ซึ่งย้อนแย้งกับสภาพความเป็นจริงทางคลินิกของการดูแลระยะยาวและการดูแลประคับประคอง (LTC/Palliative Care) ที่เป้าหมายสูงสุดคือการ “ชะลอความเสื่อมถอย” (Maintain function) การรักษาคุณภาพชีวิต และการลดภาวะแทรกซ้อน มิใช่การคาดหวังให้ผู้ป่วยกลับมาฟื้นฟู (Improve)

ความย้อนแย้งนี้นำไปสู่ปรากฏการณ์ “การบิดเบือนข้อมูลด้วยความเมตตา” (Compassionate Data Distortion) ใน 2 รูปแบบ ได้แก่

1. การกดคะแนนแรกเข้า: ผู้ประเมินจงใจให้คะแนนต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อให้ผู้ป่วยที่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างสามารถเข้าสู่ระบบและได้รับสิทธิผ้าอ้อมหรือการดูแลที่จำเป็น
2. การแช่แข็งคะแนนขาออก: เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น พื้นที่มักไม่ปรับคะแนนให้สูงเกินเกณฑ์ขาออก เพื่อรักษาสิทธิการดูแลและป้องกันการถูกร้องเรียนจากญาติว่าทอดทิ้งผู้ป่วย

ปรากฏการณ์นี้ทำให้ข้อมูล ADL ในระบบส่วนกลาง (HDC/3C) ขาดความเที่ยงตรงและไม่สะท้อนผลลัพธ์ทางคลินิกที่แท้จริง ระบบยังขาดตัวชี้วัดด้านคุณภาพที่มีความไวพอจะประเมินผลลัพธ์ที่มีคุณค่า เช่น การไม่เกิดแผลกดทับ การไม่ติดเชื้อซ้ำ หรือระดับความพึงพอใจของครอบครัว

มุมมองจากพื้นที่:

> *“บางครั้งคนไข้ที่ดูเหมือนติดบ้าน คะแนนไม่ได้ต่ำกว่า 12 มันใช้ความรู้สึกของคนประเมินมาช่วย อยากให้เค้าได้รับการช่วยเหลือ ไปกดคะแนนข้อนี้ บางทียังอาบน้ำเองได้อยู่ แต่เราอยากให้เค้าช่วย... เพราะมันมีเรื่องความรู้สึก ลำบากไม่มีเงินซื้อแพมเพิส”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล CM

“บางทีคนไข้ Improve เค้าก็อาจจะไม่อยากเอาคนไข้ออก สมมติคนไข้ ADL 11 ขาออกก็อาจจะ 11 ในเอกสาร แต่ Performance คนไข้จริงๆ อาจจะเป็น 15 ก็ได้ แต่ถ้าเขาเอาคนไข้ 15 ออก เหตุการณ์ที่เกิดตามมาคือ CG ถูกร้องเรียน... ว่าทำไมไม่มาดูแลเค้า”

— แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว / ผู้บริหารระดับโรงพยาบาล

“ใน Long term care เราต้องการ maintain ฟังก์ชันคนไข้ เราไม่ต้องการ improve ฟังก์ชันคนไข้ แต่ด้วยทางปฏิบัติ ถ้ากองทุนไหนทำให้ ADL คนไข้ Improve ได้น้อย อาจจะถูก imply จากกองทุนใหญ่คือ สปสช. ว่าไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างดี เพราะฉะนั้น ADL ที่ถูกประเมิน ถ้าจะไปพล็อตกราฟก็ไม่สะท้อนความเป็นจริงครับ”

— แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว / ผู้บริหารระดับโรงพยาบาล

“ที่ผ่านมาประเมินผ่าน ADL... แต่ในข้อเท็จจริงถ้ามอง long term care มันไม่ควร ADL ดีขึ้น เพราะถ้า ADL ดีขึ้น ก็ไม่ใช่เคส long term care เพราะถ้าเคส long term care มันไม่มีทางที่ ADL ดีขึ้น ขอแค่อยู่ทรงตัวได้ก็โอเคแล้ว”

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล CM

“ถ้าเป็นคนปกติที่ติดเตียงแล้วยังไม่มีแผลกดทับ คุณภาพของคุณที่ไปทำงานเนี่ยถ้าเค้าไม่มีแผล คุณต้องดูแลไม่ให้เกิดแผลให้ได้ เพราะคุณบอกว่าใน care plan คุณไปพลิกตะแคงตัว... ถ้าเราบอกว่าในcare plan ทำกายภาพ คนไข้กล้ามเนื้อต้องไม่ลีบ ไม่ติด... นอกเหนือจากนั้นคือการประเมินภาวะ burnout ความเครียดของญาติและผู้ป่วย”

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล CM

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

สปสช. ชี้แจงว่าข้อกำหนดขั้นต่ำในการจัดเก็บข้อมูลคือ ADL ก่อนเริ่มบริการและเมื่อครบ 12 เดือน เพื่อพิจารณาว่าเคสใดควรได้รับการดูแลต่อในปีถัดไป ซึ่งเป็นการออกแบบที่มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณมากกว่าการวัดผลลัพธ์ทางคลินิก

“Minimal ของข้อมูลที่ สปสช. ร้องขอที่จะได้รับจากพื้นที่คือ ADL ก่อนบริการและเมื่อครบสิบสองเดือน เพื่อดูว่าเคสนั้นจะต้องได้รับดูแลในปีถัดไปหรือไม่ รวมกับเคสใหม่ที่เข้ามา ส่วนที่เหลือก็เป็นข้อมูลสำหรับบริการ พื้นที่แล้วแต่ที่จะออกแบบ”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

กรมอนามัย ยืนยันว่าการวัด ADL แบบง่ายมีข้อดีในเชิงการจัดเก็บ แต่ยอมรับความจำเป็นในการพัฒนาตัวชี้วัดเพิ่มเติม

“ตัวชี้วัดต้องไม่ซับซ้อนเกินไป สองสามารถขับเคลื่อนเชิงระบบที่จะเก็บข้อมูลได้ เพราะว่าการเข้าสู่ระบบเราประเมิน ADL ก่อน แล้วทุกปีแล้วจะมีการประเมิน ADL ซ้ำนะครับ... ไม่ต้องทำซ้ำ เพื่อมาตอบตัวชี้วัด มันต้องเป็นสากลด้วย แล้วก็ไม่ต้องไปรบกวนภาระของผู้จัดทำมากมาย สามารถใช้ข้อมูลจากระบบปกติได้”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสังคม (ระดับนิติบัญญัติ) ก็ตระหนักถึงความตึงเครียดระหว่างตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (Process Indicators) กับผลลัพธ์ที่แท้จริง และมองว่าระบบควรเริ่มขยับจากการวัดเชิงกระบวนการไปสู่การวัดเชิงผลลัพธ์

“ฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเน้นการเน้น process จะเน้น process ว่าทำอะไรบ้าง... การที่เน้น process อันนี้มันก็จะมีข้อดีนะ มันจะนำไปสู่ที่ที่สำเร็จ เราเชื่ออย่างนั้น ฉะนั้นในเบื้องต้นของการทำประเมินเนี้ยก็คือ แต่ตอนนี้มันก็ควรจะต้องขยับไปละ”

— สมาชิกวุฒิสภา /
คณะอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

Theme 3.6: กำแพงสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและเสียงเรียกร้องสู่ตัวชี้วัดที่มีคุณค่า (Data Access Barriers and the Call for Value-Based and Outcome-Oriented KPIs)

แม้เป้าหมายหลักของระบบเทคโนโลยีระดับชาติคือการบูรณาการข้อมูล แต่ในทางปฏิบัติกลับมีอุปสรรคสำคัญคือ “ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล” (Access Rights Barriers) ข้อมูลการดูแลผู้ป่วย เช่น ประวัติทางคลินิก แผนการดูแล และคะแนน ADL ถูกจำกัดสิทธิไว้เฉพาะบุคลากร (CM) ประจำตำบลนั้นๆ ส่งผลให้บุคลากรระดับบริหาร เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอ ไม่สามารถเข้าดูข้อมูลในภาพรวมเพื่อเจาะลึกระดับบุคคล (Drill-down) ได้ การต้องคอยโทรศัพท์ประสานขอข้อมูลจาก CM ทีละแห่ง ทำให้เครือข่ายระดับนโยบายขาดความครบถ้วนของข้อมูลในการทำงาน

ภาวะที่ระบบข้อมูลไม่เอื้ออำนวยนี้ ทำให้สาธารณสุขตกอยู่ในสถานการณ์ “มีข้อมูลมาก แต่นำมาวิเคราะห์ไม่ได้” (Data-Rich, Insight-Poor) กล่าวคือ มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมจำนวนมหาศาล แต่ไม่สามารถแปลงเป็นองค์ความรู้เชิงนโยบายได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานจึงเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ระดับชาติ โดยเปลี่ยนจากการใช้ตัวชี้วัดที่เน้น “การนับปริมาณงาน” (Output-based) ไปสู่ตัวชี้วัดที่สะท้อน “ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิตผู้ป่วย” (Outcome-based) เช่น

- คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (Quality of Life)
- ความพึงพอใจของครอบครัวต่อการดูแลระยะท้าย (Family Satisfaction)
- ดัชนีภาระผู้ดูแล (Caregiver Burden Index)
- ตัวชี้วัดการป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น การไม่เกิดแผลกดทับลุกลาม หรือการไม่ติดเชื้อซ้ำ
- ตัวชี้วัดการตายดี (Good Death) สำหรับกลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย

มุมมองจากพื้นที่:

“เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ ADL ของคนไข้ long term ในพื้นที่เราได้ทุกคน... เพราะว่า CM ของพื้นที่นั้นมีสิทธิ์ดูแลคนไข้ของตัวเองในระบบ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติโรงพยาบาลต้องการข้อมูล เราต้องขอข้อมูลไปยัง CM ในแต่ละตำบลบอกว่า คุณส่งข้อมูล ADL รายบุคคลของคุณให้หน่อยมายังโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์... CM ในระดับอำเภอก็ไม่สามารถเจาะข้อมูลเข้าไปในระดับข้อมูลของแต่ละบุคคลได้”

— แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว / ผู้บริหารระดับโรงพยาบาล

“สมมติว่าเราอยากจะได้ข้อมูลสัก 1 อย่าง นี่ที่เป็นภาพรวมอำเภอ ข้อมูลระดับไม่ได้เชิงลึกด้วยซ้ำไป เราก็จะต้องโทรไปหา สสอ. ว่า ดึงข้อมูลในอันนี้ให้หน่อย แต่บางเรื่องที่เราอยากจะได้ลึกไปกว่านั้น เขาก็จะบอกว่า พี่ยากว่าหนูจะทำให้พี่ได้นี่ หนูต้องโทรหา 18 แห่งเพื่อที่จะสรุปข้อมูลให้พี่”

— แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว / ผู้บริหารระดับโรงพยาบาล

“ปี 65 ผมสามารถเข้าดูระบบได้ทั้งหมด แต่พอปี 65 ประมาณเดือนตุลาคมเขาตัดผมออกจากระบบ... ตอนนี้เคยสมัครเข้าไปใหม่ในระบบมันฟ้องขึ้นไปว่าท่านอยู่กองทุนไหน แต่ไม่สามารถระบุได้เลย”

— ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

“Goal ของ palliative care คือ quality of life ตัวชี้วัดล้อกับ palliative care เช่นการเยี่ยมบ้านสม่ำเสมอ หลัก ๆ หัวใจของ palliative care คือดูแลคนไข้ และญาติคนไข้ว่าเค้ารู้สึกว่าครอบครัวของเค้าสบายดีหรือเปล่า... เอาจริง ๆ ตอนนี้มองในแง่ของความพึงพอใจของครอบครัว อาจจะบ่งบอกได้ว่าทีมประสบความสำเร็จมากกว่า”

— พยาบาลวิชาชีพ งานการดูแลประคับประคอง

“มีตัวหนึ่งน่าวัด caregiver burden index ตัวนี้สะท้อนเรื่องของ... PA เค้ามีหน้าที่ที่จะช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ไม่ใช่ไปช่วย care”

— ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

“การจัดการอาการ คือได้รับยา Opioid แต่ไม่ได้บ่งบอกว่าได้รับยาแล้วเขาจะสุขสบายจริง หรือว่าครอบครัวเขาโอเคจริง ๆ หรือเปล่า เอาจริ ๆ ตอนนี้มองในแง่ของความพึงพอใจของครอบครัว อาจจะบ่งบอกได้ว่าทีมประสบความสำเร็จมากกว่า”

— พยาบาลวิชาชีพ งานการดูแลประคับประคอง

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

ผู้บริหารส่วนกลางจากหลายหน่วยงานสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการเข้าถึงข้อมูลและการขาดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนั้นเป็นที่รับรู้กันดีในระดับนโยบาย แต่กลไกในการแก้ไขยังอยู่ในช่วงพัฒนา กรมอนามัย ยอมรับว่าแม้จะมีสิทธิ์เข้าถึง HDC แต่ข้อมูลนั้นยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพการดูแลระยะยาวอย่างจริงจัง

“แม้แต่ฐานข้อมูล HDC กรมอยู่ในฐานะที่จะเอามาใช้ประโยชน์ไหม ได้ครับ เข้าไปดูได้ แต่ว่ายังไม่เคยเอาข้อมูลส่วนนี้มาวิเคราะห์ครับอาจารย์ HDC เราก็ดูข้อมูลอยู่ครับ เราส่งข้อมูลหลายส่วนเข้าถึง HDC อยู่”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

“ตอนนี้เราสามารถบริหารกำลังคนทั้งประเทศได้ว่าโอเคเรามี CM เท่าไหร่ CG เท่าไหร่นะครับ ซึ่งเน็กซ์สเต็ปของเราเนี่ยเราจะทำภาพรวมของกรมในเรื่องการบริหารจัดการ กระจายตัว กระจุกตัวตรงไหน อันนี้อาจจะต้องเกิดขึ้น แต่สุดท้ายหน้าที่กรมอนามัยมีหน้าที่แค่ชี้เป้า”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.) เป็นหน่วยงานที่เพิ่งเริ่มพัฒนาระบบข้อมูลใหม่ (ระบบ “นิรันดร์”) ร่วมกับ สวทช. เพื่อให้ผู้บริบาลสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานและจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุรายบุคคลได้ แต่ยังจำกัดการเผยแพร่เนื่องจากข้อกำหนด PDPA นอกจากนี้ยังมีแผน MOU บูรณาการข้อมูล 10 กระทรวง ตามมติ ครม. ปี 2568 โดยกำลังเชื่อมโยงข้อมูล 43 รายการจาก 23 หน่วยงาน โดยมอบหมายให้ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) เป็นผู้คัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อบอร์ดชาติผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยอมรับว่า “อุปสรรคสำคัญคือการขาดการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Data Silos)” ซึ่งทำให้ยังไม่เห็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ที่ชัดเจนในระดับชาติ

ผู้บริหาร สอน.บัดดี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ระยะยาวในเรื่องการกำกับคุณภาพผ่านระบบข้อมูล โดยชี้ว่าแนวทางที่พึงประสงค์คือการสร้าง “ศูนย์กลางข้อมูลปฐมภูมิ” (Primary Care Data Hub) ที่ข้อมูลจะไม่เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

> *“ข้อมูลนี้จะไม่ได้เป็นของใครนะคะ แต่มันจะถูกใช้อย่างมีประโยชน์มากขึ้น และมันจะต้องเปลี่ยนจากไซโลเบสเนี่ย เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลมากขึ้น เพื่อลดภาระของพื้นที่ด้วย อันนี้ก็คงเป็นฉากทัศน์สำหรับตัวสอนบัดดี้ด้วยเช่นกันว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้อยากสร้างแอปใหม่เพิ่ม”*
>
> — ผู้บริหารระดับนโยบาย / สอน.บัดดี้ / สป.สธ.

สปสช. ก็มองถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างแม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของการประมาณการจำนวนผู้รับบริการและการตรวจสอบสถานะชีวิตผ่านการเชื่อมต่อกับทะเบียนราษฎร์

> *“ถ้าหมายความว่าเรามีข้อมูลที่แม่นยำมากพอว่า ห้าแสนคนเนี่ยเป็นกลุ่ม LTC กลุ่มที่ 1/2/3/4 เท่าไหร่ อันที่สองคือเราเช็กสถานะได้ว่าเหล่านี้คือเป็นคนไทยสถานะอยู่มีชีวิตนะครับ เพราะว่าเราเชื่อมกับทะเบียนราษฎร์นะครับ”*
>
> — ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

มิติที่ 4 การจัดบริการและรอยต่อการดูแล (Service Delivery & Transition of Care)

เป้าหมายและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้ (Intended system design & expectation)

จากการทบทวนวรรณกรรมระดับชาติ (อ้างอิง: LTC Literature Review) ระบบการดูแลระยะยาว (Long-Term Care: LTC) ของประเทศไทยถูกออกแบบภายใต้กรอบแนวคิด “การดูแลระยะยาวแบบบูรณาการต่อเนื่อง” (Integrated Continuum of Long-Term Care) ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการส่งมอบบริการอย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมป้องกัน การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care: IMC) การดูแลระยะยาวในกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต (Palliative Care) โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสมรรถภาพในการดำรงชีวิต (Functional ability) ให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศรี (Aging in place) ภายใต้การสนับสนุนทางการเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อค้นพบจากพื้นที่

เมื่อนำกรอบโครงสร้างระดับชาติมาวิเคราะห์เทียบเคียงกับสถานการณ์จริงในหลากหลายบริบทพื้นที่ พบว่าระบบเผชิญกับ “คอขวดเชิงโครงสร้าง” ที่ซ้อนทับกันหลายมิติในช่วงรอยต่อของการดูแล ขณะที่พื้นที่ซึ่งมีความพร้อมได้พยายามพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุดช่องโหว่เหล่านั้น ข้อค้นพบสามารถจัดระเบียบเชิงตรรกะออกเป็น 10 แก่นสาระ (theme) ดังนี้

Theme 4.1: รอยต่อที่แยกส่วนจากกลไกการคลังและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน (Fragmented Transition from Siloed Financing and Registration Rules)

ความล้มเหลวในการส่งมอบบริการแบบไร้รอยต่อมีรากฐานมาจากการออกแบบวิธีการจ่ายและบริหารจัดการของ สปสช. ที่แยกตะกร้าเงินตามประเภทบริการอย่างเบ็ดเสร็จ ทำให้เมื่อผู้ป่วยต้องข้ามผ่านจากบริการหนึ่งสู่อีกบริการหนึ่ง กฎเกณฑ์ทางการเงินกลับกลายเป็นอุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 6 เดือนแรกของการฟื้นฟู (IMC) ซึ่งเป็น “นาทีทอง” ที่ผู้ป่วย

ต้องการอุปกรณ์มากที่สุด แต่กลับไม่สามารถเบิกใช้วัสดุสิ้นเปลืองจากกองทุน LTC ได้ ผลักภาระให้ผู้ดูแลต้องดิ้นรนหาทางออกนอกระบบ แม้ในข้อเท็จจริงมีให้สามารถเบิกได้เช่น จากกองทุนฟื้นฟูจังหวัด แต่ผู้ให้บริการต้องทราบเองว่าจะเบิกอะไรได้จากตรงไหนได้บ้าง เนื่องจากมีการบริหารแบบแยกเป็นส่วน ๆ ในทำนองเดียวกัน เมื่อผู้ป่วยกลุ่ม Palliative ครบกำหนด 6 เดือน โดยยังไม่เสียชีวิต กฎเกณฑ์การเบิกจ่ายที่เปลี่ยนไปยิ่งสร้าง “รอยต่อที่แหว่งวิ่น” ซ้ำเติมความต่อเนื่องของการดูแล

จากมุมมองของผู้บริหารระดับนโยบาย สปสช. ตระหนักถึงปัญหานี้และได้ปรับแนวทางการจ่ายเงินจากการจ่ายตาม “จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน” ไปสู่การจ่ายตาม “การอนุมัติแผนการดูแล (Care Plan)” แทน เพื่อสะท้อนการบริการที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้น และยังพยายามขยายนิยามกลุ่มเป้าหมายให้รวมถึงกลุ่มสมองเสื่อมระดับปานกลางขึ้นไปเพื่ออุดช่องว่างการเข้าถึงบริการ

มุมมองจากพื้นที่:

> *“ถ้าใครนำคนไข้เข้าโครงการก่อน อย่างเป็น IMC แล้ว LTC จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ใช่มั้ยคะ ตรงนี้กังวลในอนาคตเหมือนกัน เพราะว่า IMC จะมีกายภาพในการดูแลเพียง 6 เดือน แต่ฟื้นฟูไม่ดีขึ้น แล้วหลังจากนั้นที่อยู่ในชุมชนเราจะไม่มี CG ในการเข้าไปดูแล”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM (รพ.สต.)

> *“พอเป็นช่วงกลาง ๆ (Intermediate) จะไม่สามารถเบิกแพมเพิสหรืออุปกรณ์ให้ได้”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล CM

> *“ช่วง 6 เดือนต้องใช้อุปกรณ์แต่เค้ายังไม่เข้าข่าย long term care... เอาไม้ไผ่หรือบางคนมีความสามารถซื้อได้ก็ซื้อ หรือบางคนเอามาจาก รพ. ที่เค้าบริจาค”*
>
> — ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG

“สสจ.จะให้เบิก Palliative เสร็จสิ้นก่อน เพราะว่าของ Palliative จะเบิกได้ 6 ครั้ง เดือนละ 1,000 หลังจากครบ 6 เดือนแล้ว ถ้าไม่เสียชีวิตก็กลายเป็น Long Term Care เมื่อก่อนเบิกซ้อนกันได้ แต่ตอนนี้คงต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย”

— ผู้อำนวยการสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

“ที่ผ่านมาเราไปจ่ายเงินตาม LTC ที่ register เนอะ ตั้งแต่ปี 59 ถึงประมาณสักปี 66 แล้วเจอข้อจำกัดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของ LTC เนี่ย [มี]แค่ 20 เปอร์เซ็นต์ที่นำไปสู่การทำ Care Plan เราก็เลยปรับระบบใหม่ว่า เราจะไม่ซื้อ registration LTC เราไปซื้อ Care Plan เลยก็แล้วกัน”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“ตอนนี้เราก็ให้คำนิยามเพิ่มเติมว่า LTC ต้องประกอบไปด้วยกลุ่มเดิมคือ ADL ต่ำกว่า 11 กลุ่มสองคือกลุ่ม Palliative ที่มีค่า PPS ต่ำกว่า 50 และกลุ่มสามคือกลุ่มสมองเสื่อมในระดับกลางขึ้นไป มาเป็นเกณฑ์คัดเข้า”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 4.2: ความไม่ยืดหยุ่นของรอบอนุมัติงบประมาณท้องถิ่น และปัญหาความสูญเปล่าของทรัพยากร (Rigidity of Local Budget Approval Cycles and Resource Wastage)

ในขณะที่อาการของผู้ป่วยในระบบดูแลระยะยาวสามารถทรุดลงได้ทุกวัน แต่กระบวนการอนุมัติแผนการดูแล (Care Plan) และงบประมาณกลับขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากต้องรอรอบการประชุมของคณะอนุกรรมการ LTC ซึ่งมักจัดขึ้นเพียงปีละ 1 - 2 ครั้ง หรืออย่างมากก็รายไตรมาส ความล่าช้าในการรอกระบวนการทางเอกสารนี้ ทำให้เกิดช่องโหว่ในการดูแลผู้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่หรือเคสที่มีอาการแทรกซ้อนเฉียบพลัน ที่จะไม่สามารถเบิกใช้อุปกรณ์ทำแผลหรือวัสดุจำเป็นได้ทันท่วงที

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบยังเผชิญกับปัญหา “ความสูญเปล่าของทรัพยากร” จากข้อจำกัดของระเบียบพัสดุ กล่าวคือ เมื่อมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในชื่อผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งไปแล้ว หากผู้ป่วยเสียชีวิตลง สิ่งของเหล่านั้นจะไม่สามารถโอนสิทธิไปให้ผู้ป่วยคนอื่นใช้งานต่อได้ แม้ผู้บริหารระดับนโยบายของ สปสช. จะรับทราบปัญหาและพร้อมสนับสนุนให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดสรรงบระหว่างปี แต่ความท้าทายสำคัญคือ ข้อระเบียบเหล่านี้ผูกพันอยู่กับอำนาจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องมีการบูรณาการแก้ไขระเบียบของ อปท. ไปพร้อม ๆ กัน จึงจะสำเร็จผล

มุมมองจากพื้นที่:

> *“กว่าจะนัดคณะกรรมการที่มีอยู่หลาย ๆ ฟังก์ชัน กว่าจะนัดประชุมมีวาระก็ยาก... บางทีคนไข้มีปัญหา สมมติว่าจากที่ไม่มีแผลแล้วเกิดแผล สรุปแล้วต้องไปขอเบิกที่โรงพยาบาล... อยากจะให้มีโอกาสเบิก 2 ครั้ง (ระหว่างปี)”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ / ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ

> *“เงิน Long Term Care คือไม่อยากจะของบประมาณครั้งเดียว... พอคนนั้นเสียชีวิต วัสดุอุปกรณ์บางอย่างเราใช้กับคนต่อไปไม่ได้ สมมติว่าเดินทางมาครึ่งกลางปีมาเจออีก 10 รายสามารถเรียกประชุมใหม่ทำ Care Plan ใหม่ได้ (แต่ระบบให้จัดสรรรวบยอดครั้งเดียว)”*
>
> — ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข / เทศบาลตำบล

Theme 4.3: ภาระงานเอกสารซ้ำซ้อนและความขัดแย้งระหว่างนวัตกรรมดิจิทัลกับระเบียบราชการ (Redundant Paperwork and the Digital-Bureaucratic Contradiction)

แม้บุคลากรระดับพื้นที่จะพัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันของตนเอง (เช่น App CG 4.0) เพื่อบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ แต่ระเบียบราชการและการเบิกจ่ายของ อปท. ยังคงบังคับให้ต้องส่งหลักฐานในรูปแบบ “แบบฟอร์มกระดาษและลายเซ็นจริง” ควบคู่กันไป ทำให้ CG ต้องแบกภาระทำงานซ้ำซ้อน

จากมุมมองส่วนกลาง ระบบ สอน.บัดดี้ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็น “ระบบปฏิบัติการนอกหน่วยบริการ” ในบริบทของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งต้องการ continuity of data ข้ามหน่วยบริการ แต่ระบบนี้ไม่ได้มีเป้าหมายทดแทน HIS หลัก เพียงแต่ทำหน้าที่เป็น connector/API ระหว่างระบบต่าง ๆ ซึ่งอธิบายว่าเหตุใดจึงยังขาดฟังก์ชันแจ้งเตือนแบบ real-time ที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานต้องการ

มุมมองจากพื้นที่:

> *“Care Plan ของ LTC ที่ทาง รพ.สต. จะผลิต app มา เป็น App CG 4.0 และบันทึกในนั้น เวลาไปส่งงาน อบต. เรามีแบบฟอร์ม สำหรับส่งงาน รพ.สต. เป็น app ค่ะ... เก็บไว้เป็นผลงาน และส่งงาน อบต. มีแบบฟอร์มอีก ต้องทำทั้ง 2 อย่าง”*
>
> — ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG

> *“Care Plan ต่อ 1 คน ต้องมี 4 ใบ... ใบที่ 2 จะมีใบลงเวลาการทำงาน... เพื่อพิสูจน์ว่าไปทำงานดูแลคนนั้นจริง ๆ... ส่งเป็นรูปเล่มรายงานให้เค้า เขียนลายมือตัวเอง”*
>
> — ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

> *“สอน.บัดดี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราวาง positioning ไว้เป็น Anywhere Service คือเป็นบริการนอกหน่วย เราไม่ได้มุ่งหวังให้เขาเป็น HIS เพราะว่า HIS หลักของหน่วยบริการปฐมภูมิอยู่แล้ว เราทำหน้าที่เชื่อมข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่ประชาชนไม่ว่าจะไปรับบริการที่ไหน หน่วยบริการปฐมภูมิจะสามารถเรียกดูได้”*
>
> — ผู้บริหารระดับนโยบาย / สอน.บัดดี้ / สป.สธ.

> *“ในธีมของการ promote สามสิบบาทรักษาทุกที่เนี่ย สิ่งที่สำคัญคือ continuity of data เพราะว่ามันแปลว่าประชาชนเนี่ยจะไปที่ไหนก็ได้ แต่หน่วยที่รับดูแลต่อเนื่องคือหน่วยบริการปฐมภูมิ ถ้าไม่มีการเชื่อมของข้อมูล หน่วยบริการจะดูแลคนไข้ได้อย่างไร นั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราต้องทำ digital transformation”*
>
> — ผู้บริหารระดับนโยบาย / สอน.บัดดี้ / สป.สธ.

Theme 4.4: รอยรั่วในการสื่อสารสหวิชาชีพและช่องว่างแจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยกลับเข้ารับการรักษา (Multidisciplinary Communication Gaps and Re-Admission Notification Blindspots)

แม้ทีมสหวิชาชีพจะใช้ระบบส่งต่อข้อมูลเดียวกัน แต่กระบวนการทำงานที่แยกส่วนตามบทบาทวิชาชีพทำให้เกิดรอยต่อภายในทีมเดียวกัน โดยเฉพาะระหว่างนักกายภาพบำบัดที่เน้นงานฟื้นฟู ADL กับพยาบาลชุมชนที่ดูแลองค์รวม เมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนและต้องกลับไป Re-admit ที่โรงพยาบาล ระบบสารสนเทศไม่มีฟังก์ชันแจ้งเตือนย้อนกลับ (Reverse Notification)

มุมมองจากพื้นที่:

“ถ้าคนไข้กลับมาอยู่ในตึก แล้วถ้านักกายภาพบำบัดไม่ได้มอนิเตอร์ ก็จะไม่ทราบว่าคนไข้มา Admit ถ้าเกิดว่าพยาบาลเจ้าของไข้ได้ติดตามเคส ก็จะรู้... มันอาจจะมีช่องว่างเรื่องของความต่อเนื่อง”

— พยาบาลวิชาชีพงานปฐมภูมิ / โรงพยาบาลชุมชน

“Conference ไม่ค่อยมีเวลา หมอจะไปคิดในกระบวนของท่าน ถ้าเจอเคสผิดปกติแกถึงจะแจ้งกลับมา... มันไม่ได้มา Conference ว่าจะออกอะไรยังไง มันไม่มีเวลา”

— พยาบาลวิชาชีพ / รพ.สต.

“การเยี่ยมอาจจะไม่พร้อมกัน เพราะว่าเคสของนักกายภาพฯก็เยอะ นักกายภาพเขาจะไปดูเน้นเรื่องของการฟื้นฟู ADL เป็นหลัก แต่ของพยาบาลชุมชนที่ดูแลต่อเนื่องดูแบบองค์รวม”

— พยาบาลวิชาชีพ / รพ.สต.

Theme 4.5: สุญญากาศโครงสร้างการบริหารระดับอำเภอ ฐานข้อมูลแบบไซโล และการขาดแคลนศูนย์แบ่งเบาภาระครอบครัว (District Governance Vacuum, Data Silos, and Absence of Respite Care)

สถาปัตยกรรมการอภิบาลระบบกำหนดให้แต่ละ อปท. ระดับตำบลบริหารตนเองอย่างเป็นเอกเทศ ส่งผลให้ขาดกลไก “ผู้จัดการระบบระดับอำเภอ” ที่สามารถบูรณาการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง รพ.สต. และโรงพยาบาลชุมชน ฐานข้อมูลถูกจัดเก็บในระดับตำบลโดยมีสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะ CM ของแต่ละพื้นที่ ทำให้หน่วยงานสนับสนุนระดับอำเภอไม่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มภาพใหญ่ได้ นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานชุมชนยังขาดแคลน “ศูนย์รับฝากดูแลกลางวัน (Social Daycare)” ทำให้ภาระทั้งหมดตกที่ครอบครัว

ผู้บริหารกรมอนามัยชี้ว่าระบบ 3C (LTC Platform) ถูกออกแบบมาเพื่อให้ CM สามารถ “ออกแบบ Care Plan เสนอท้องถิ่น” ไม่ใช่เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมระดับอำเภอหรือประเทศ แต่กรมอนามัยกำลังพัฒนาขั้นต่อไปเพื่อให้ “เห็นภาพรวมกำลังคน (CG/CM) ทั้งประเทศ” ในเชิงการบริหาร

มุมมองจากพื้นที่:

> *“เราต้องเข้า ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ ADL ของคนไข้ long term ในพื้นที่เราได้ทุกคนครับ เพราะว่า CM ของพื้นที่นั้นมีสิทธิ์ดูแลคนไข้ของตัวเองในระบบ... CM ในระดับอำเภอก็ไม่สามารถเจาะข้อมูลเข้าไปในระดับข้อมูลของแต่ละบุคคลได้ เพราะฉะนั้นเราไม่ได้วิเคราะห์ เรายอมรับว่าเข้าถึงฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ลำบาก”*
>
> — ผู้บริหารระดับโรงพยาบาล / โรงพยาบาลชุมชน

> *“เวลาเราจะรวมข้อมูล ADL แค่ ADL ของคนทั้งอำเภอ หนูต้องโทรหา CM 18 รพ.สต. เพื่อที่จะให้เขาดึงข้อมูลในแต่ละพื้นที่มา”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล CM ระดับอำเภอ (โรงพยาบาลชุมชน)

“ภาพฝันอยากจะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอยู่ในชุมชน... จะมี CG เข้าเวร และรับฝากคนไข้ที่ต้องทำกายภาพ หรือไม่มีใครอยู่ด้วยที่บ้าน... ญาติจะเอาคนไข้ใส่รถมาฝากไว้ และตอนเย็นมารับ ทำกับข้าวให้กินด้วย... มันตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแล”

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล CM (สังกัด อปท.)

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

“3C ตอนที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราต้องการให้เขาสามารถดีไซน์ Care Plan เพื่อไปเสนอโครงการที่ท้องถิ่น... next step ของเราเนี่ยเราจะทำภาพรวมของกรม ไม่ใช่เรื่องของการดีไซน์ Care Plan ที่เป็นเชิงคุณภาพมากขึ้น ให้เห็นภาพของ health care / social care ที่มันมากขึ้น สามารถตรวจสอบได้”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

“ตอนนี้เราสามารถบริหารกำลังคนทั้งประเทศได้ว่าโอเค เรามี CM เท่าไหร่ CG เท่าไหร่นะครับ”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Theme 4.6: การนำทุนทางสังคมและเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้อุดช่องโหว่ของบริการภาครัฐ (Bridging Service Gaps through Social Capital and Circular Economy)

เมื่อกลไกการให้บริการของรัฐมีความล่าช้าและไม่ทันต่อสถานการณ์ พื้นที่ต่าง ๆ จึงพยายามแก้ปัญหาด้วยการดึง “ทุนทางสังคม” (Social Capital) มาสร้างนวัตกรรมเพื่ออุดช่องโหว่ดังกล่าว เราจึงได้เห็นการบริหารจัดการตนเองในหลายรูปแบบ เช่น การระดมทุนผ่านการทอดผ้าป่า การนำอุปกรณ์การแพทย์ที่ถูกแทงจำหน่ายมาหมุนเวียนใช้ใหม่ การจัดทำรถไรเดอร์ชุมชนเพื่อช่วยเดินทาง การเปิด Social Daycare รับฝากผู้ป่วยช่วงกลางวัน ไปจนถึงการยกระดับโรงเรียนผู้สูงอายุให้เป็นศูนย์ Drop-in Center แบบถาวร นอกจากนี้ยังมีการดึงอาสาสมัครเข้ามาทำงานควบคู่กับทีมสาธารณสุข เพื่ออุดช่องว่างการดูแลในมิติสังคมและเศรษฐกิจ

ผู้บริหารระดับนโยบายจากกระทรวง พม. รับทราบถึงบทบาทและความเข้มแข็งของกลไกเหล่านี้ และมีแผนที่จะผลักดันระบบ Daycare ให้เป็นนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญที่พบในปัจจุบันคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังขาดทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นที่ ทำให้ยากต่อการนำนวัตกรรมชุมชนเหล่านี้ไปต่อยอดเป็นการวางแผนเชิงนโยบายที่ยั่งยืนได้

มุมมองจากพื้นที่:

“อสม.จะมีประชุมกันว่าปีใหม่เราจัดทำผ้าป่า เพื่อซื้ออุปกรณ์พวกนี้ เราทำผ้าป่าได้ 2 แสนกว่า ก็สามารถไปซื้อได้หลายตัว เราทำมาเรื่อย ๆ เก็บสะสมอุปกรณ์พวกนี้ได้เยอะขึ้น พอมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ก็จะประสาน รพ.สต. ก่อน”

— อาสาสมัครบริบาล / แกนนำชุมชน

“รับผู้ป่วยที่หมอนัด ถ้าลูกหลานไม่ว่างบอก มีจิตอาสากับรถทำหน้าที่เป็นญาติไปซื้อบัตร ไปรอรับยาให้หมด”

— ผู้บริหาร / อปท.

“เพราะโรงเรียนพอจบแล้วคือจบไป... ถ้าคนที่จบไปแล้วไม่ได้มาอยู่ที่วัดเฉย ๆ เขาก็กลับไปภาวะที่ซึมเศร้า แล้วก็เป็นภาระของลูกหลานอีก ก็เลยเปิดเป็นศูนย์สร้างสุขสูงวัย มาทำกิจกรรมร่วมกันได้ตลอดที่ศูนย์”

— ผู้บริหารท้องถิ่น / เทศบาล

“เรามีอาสาผู้พิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ... เค้ามีสิทธิสอบเคสเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ฉุกเฉิน ส่งตรงผ่าน พมจ. เคสหนึ่งช่วยเหลือสูงสุดได้ 3,000 บาท นอกจากนี้สามารถส่งเคสซ่อมแซมบ้านกับผู้สูงอายุได้เช่นกัน หลังไม่เกิน 40,000 บาท/คน”

— ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข / อบต.

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

“กรมฯ มีนโยบายใช้ศูนย์สวัสดิการฯ 12 แห่งเป็นต้นแบบในการเปิดพื้นที่ Daycare เพื่อให้ครอบครัวนำผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมระหว่างวัน”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“แม้ อปท. จะมีงบประมาณและอยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด แต่ยังขาดทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนเชิงนโยบาย กรมฯ จึงมุ่งหวังใช้กลไกบอร์ดชาติในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลในระดับพื้นที่”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Theme 4.7: การบูรณาการการดูแลระยะประคับประคอง (Palliative Care) และระยะท้าย (End of Life Care) และการวางแผนดูแลล่วงหน้า ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและบทบาทของแพทย์ (Integrating Palliative Care and ACP via Digital Innovation and Medical Support)

พื้นที่ที่มีความก้าวหน้าได้เชื่อมต่อการดูแลระยะยาวเข้ากับ Palliative Care โดยนำ “เกมไพ่ทายชีวิต” มาใช้อบรม CG เพื่อเปิดบทสนทนา ACP กับครอบครัวล่วงหน้า และใช้ระบบ Line OA กับ Telemedicine เพื่อติดตามอาการ ปรับยา และสนับสนุนการตัดสินใจของญาติ บทบาทของ “แพทย์” ใน Video call มีน้ำหนักทางจิตวิทยาสูง ช่วยให้ญาติยอมรับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน ผู้บริหารระดับนโยบาย สปสช. ยืนยันว่า Palliative Care เริ่มเชื่อมต่อกับ LTC แล้วบางส่วน และมีแผนขยายการเชื่อมโยงนี้ต่อไป

มุมมองจากพื้นที่:

“เราจะเริ่มพูดคุยเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan) ในกลุ่มผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมาก หรือมีคะแนน ADL ต่ำกว่า 5 ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยสูงอายุและกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)... ถ้าครอบครัวและ

คนไข้ยินยอม ก็สามารถเข้ามานอนพักรักษาในโรงพยาบาลได้ แต่ถ้าเขามีความประสงค์ที่จะเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้าน (Home death) และคนไข้เข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต (Active dying) แล้ว ทีมเราก็พร้อมจะลงไปดูแลประคับประคองให้ถึงที่บ้านครับ"

— แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว / โรงพยาบาลชุมชน

"คนไข้ที่เป็น LTC และมีการคุย ACP ทุกรายจะเข้ากลุ่ม Line OA มีการคุยต่อเนื่อง มีการส่งอาการของผู้ป่วย update ทั้งหมอ tele และรับอุปกรณ์ต่างๆ ส่งเข้า Line OA ในแต่ละคน รวมถึงเคสที่เป็น palliative care ทุกครั้งที่มีการจัดการอาการอยู่ที่บ้าน"

— พยาบาลวิชาชีพงานการดูแลประคับประคอง

"พี่มักจะใช้วิธีต่อสายตรงหรือวิดีโอคอลหาคุณหมอ เพื่อให้ญาติได้รับฟังความเห็นจากแพทย์โดยตรงค่ะ เพราะคำแนะนำจากหมอจะมีน้ำหนักและช่วยประกอบการตัดสินใจของครอบครัวได้ดีที่สุด... แต่ถึงอย่างนั้น ท้ายที่สุดแล้ว เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของญาติเป็นสำคัญ"

— พยาบาลวิชาชีพ / CM

"เป้าหมายสูงสุดของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) คือเรื่องคุณภาพชีวิตค่ะ... หัวใจสำคัญไม่ใช่แค่การดูแลตัวคนไข้ แต่คือการดูแลความรู้สึกของญาติด้วย ต้องทำให้เขารู้สึกว่าคนในครอบครัวได้รับการดูแลให้สุขสบายที่สุด... ดังนั้น ถ้ามองในมุมของการทำงาน ความพึงพอใจและความสงบใจของครอบครัวนี่แหละค่ะ ที่เป็นตัวบ่งบอกความสำเร็จของทีมเราได้ดีที่สุด"

— พยาบาลวิชาชีพงานการดูแลประคับประคอง

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

“ถามว่าก่อนหน้านี้ สปสช. จ่ายบริการ Palliative Care ไหม ก็ต้องบอกว่าจ่ายนะครับ จ่ายผ่านโรงพยาบาล เพราะว่าเคสเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัย professional ในการให้ยา ให้อะไรบางอย่างเพื่อ relief มารับการตรวจ ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จ่ายเป็นรายไอเทมของบริการ LTC ผ่านฐานของโรงพยาบาลอยู่”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 4.8: ความท้าทายจากความเชื่อทางวัฒนธรรมและบริบทศาสนาในการดูแลวาระสุดท้าย (Challenges from Cultural Beliefs and Religious Contexts in End-of-Life Care)

การให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่ชุมชน มักต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีบทบาทเสมือนดาบสองคม ในด้านที่เกื้อหนุนการทำงาน พบว่าวิถีชีวิตแบบมุสลิมมีแนวคิดที่สนับสนุน “การตายดี (Good Death)” ที่บ้าน ซึ่งสอดรับกับทิศทางของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) อย่างสมบูรณ์แบบ

แต่อีกด้านหนึ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญคือ การที่ครอบครัวผู้ป่วยบางส่วนยังคงพึ่งพาความเชื่อทางไสยศาสตร์ หรือใช้วิธีการรักษาแบบพื้นบ้านที่ผิดหลักการแพทย์ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นอกจากจะไม่ช่วยให้อาการดีขึ้นแล้ว ยังกลับสร้างภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อตัวผู้ป่วยในระยะท้ายอีกด้วย

มุมมองจากพื้นที่:

“ด้วยบริบทวิถีชีวิตแบบมุสลิมในพื้นที่ ผู้ป่วยระยะท้ายส่วนใหญ่มักมีความประสงค์ที่จะกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน เพื่อเชิญผู้นำศาสนา (โต๊ะอิหม่าม) มาอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน (ซูเราะห์ยาซีน) ให้ฟัง... ทางทีมดูแลจะสอบถามความต้องการของญาติเสมอ หากญาติยืนยันที่จะพาผู้ป่วยกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา แม้ในเชิงการแพทย์อาจยังมีข้อกังวล แต่แพทย์ก็จะเคารพหลักความเชื่อ และอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับไปวาระสุดท้ายที่บ้าน”

— ทีมพยาบาล / ผู้ดูแล ภาคใต้

“เขาเอาคราบของงู... เอามาตำแล้วก็ใส่ในแผลค่ะ... ปรากฏว่าแผลหนักกว่าเดิม”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG

“แม่ของนาย ก ล้มป่วย นาย ก ไปว่า บ้านนาย ข ทำของใส่แม่... ทั้ง ๆ ที่แม่แก อายุ 102 ปีแล้วค่ะ... ทำความเข้าใจก็ไม่ได้”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG

Theme 4.9: กลไกการดูแลคุณภาพ บริหารภาระงาน และเยียวยาภาวะหมดไฟของคนทำงาน (Quality Assurance, Workload Management, Emergency Consultation Networks, and Burnout Relief)

เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลและป้องกันภาวะหมดไฟ (Burnout) ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้สร้างกลไกสนับสนุนกันเองอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพที่ CM จะประเมินจาก “ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่แท้จริงของผู้ป่วย” ควบคู่ไปกับการบริหารภาระงานด้วยการคละเคส (Case Mix) โดยเฉลี่ยให้ผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้านเพื่อรักษาสมดุลภาระงาน นอกจากนี้ ยังมีการตั้งช่องทางปรึกษาฉุกเฉินผ่าน Line และการโทรสายตรงหาแพทย์ ER เพื่อช่วย CG แก้ปัญหาหน้างานแบบเรียลไทม์ ตลอดจนการเยียวยาจิตใจผ่านกลุ่มให้กำลังใจและการมอบใบประกาศเกียรติคุณประจำปี

สำหรับมุมมองระดับนโยบาย สปสช. ตระหนักดีว่าระบบปัจจุบันสร้างภาระให้ CM อย่างหนัก จึงมีแผนที่จะพัฒนาตำแหน่ง “ผู้ประสานงานการดูแล (Care Coordinator)” ในระดับท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อช่วยรับไม้ต่อในการจัดการสวัสดิการแบบองค์รวม ทั้งด้านสุขภาพและสังคม แทนการพึ่งพิง CM เป็นเสาหลักเพียงตำแหน่งเดียวเช่นในอดีต อย่างไรก็ดีหลักสูตรที่ผลิต CM ของท้องถิ่นในปัจจุบันนั้นเน้นไปเป็น CM บริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการสะดวกขึ้นเนื่องจากมีคนของ อปท.ที่เข้าใจระบบมากขึ้น ยังไม่สามารถมาทำ Care plan ได้

มุมมองจากพื้นที่:

“ถ้าเป็นแผลนะ แผลต้องดีขึ้น... ถ้าไปแค่ถ่ายรูป แล้วก็แค่ say hi แล้วแผลเนี่ย ไม่ทำสักวันนึง ชีวิตความเป็นอยู่เค้าไม่ดีขึ้นแน่นอน”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM

“ในการจัดสรรเคส ผู้ดูแล (CG) 1 คน จะรับผิดชอบผู้ป่วย 4 คนค่ะ โดยเราจะกำหนดสัดส่วนให้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงแค่ 2 คน ควบคู่กับผู้ป่วยติดบ้านอีก 2 คน... จะไม่มีการจัดให้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงรวดเดียวทั้ง 4 คนเด็ดขาด เพราะภาระงานมันจะหนักเกินไปสำหรับคน ๆ เดียวค่ะ”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM

“ถ้าเราเจอปัญหาฉุกเฉินหน้างานจริง ๆ ส่วนมากก็จะใช้วิธียกหูโทรศัพท์คุยเลยค่ะ... เช่น โทรไปแจ้งว่า ‘สายยางให้อาหารคนไข้หลุดค่ะ รบกวนเจ้าหน้าที่หรือพี่พยาบาลเข้ามาช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะ’”

— ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ / CG

“ญาติผู้ดูแลมีปัญหาภาวะเครียด และภาวะหมดไฟ เลยทำวิจัยพัฒนารูปแบบการรับมือภาวะหมดไฟ... และกลุ่มนี้ไปให้กำลังใจกัน เช่นบ้านนี้อยู่กับ 2 คน เริ่มหงุดหงิด ทีมนี้เข้าไปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน... ให้ญาติได้ผ่อนคลาย 2 - 3 ชั่วโมงก่อนกลับไปดูแลต่อ”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM

“จะมีการประเมินความพึงพอใจของ CG โดยที่ CM เป็นคนประเมิน... และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ทาง CG ในรอบปี... ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน”

— ผู้บริหาร / ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

“Care manager ทำหน้าที่ในระบบ LTC ได้ดีพอสมควร เพียงแต่ว่าอาจจะต้องพึ่งบุคลากรหนึ่งของท้องถิ่น ก็คือผมเชื่อว่า Care Coordinator ซึ่งคนเหล่านี้จะทำหน้าที่ประสานงาน คล้ายตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ที่เราจะให้เกิดในท้องถิ่นเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ทุกเรื่อง สวัสดิการทุกเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่เป็น LTC ไม่ใช่มีเสียงเฉพาะด้านสุขภาพ อาจจะต้องมองให้รอบด้าน”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“ในระยะสามปีเรามองถึงความอยู่ได้ของ CG ในระบบนะครับ ส่วน Care Manager เอง เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรสำคัญในการที่จะทั้งคัดกรองทั้งยืนยันทั้งทำแผนดูแลรายบุคคล... บทบาทที่มาเป็น Care Manager นี่ พยาบาลที่เพิ่มขึ้นเขาก็จะได้ค่าตอบแทนจากงบของเราเติมแทนอย่างไร อันนี้เราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับ”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 4.10: สุญญากาศการจัดการขยะทางการแพทย์จากบริการดูแลที่บ้าน (Vacuum in Medical Waste Management from Home-Based LTC Services)

การขยายตัวของบริการ LTC ที่บ้านก่อให้เกิดขยะติดเชื้อและวัสดุสิ้นเปลือง (เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สายยาง) ปริมาณมากในครัวเรือน อย่างไรก็ตาม อปท. หลายแห่งยังไม่มีระบบหรือรถเก็บขยะติดเชื้อรองรับเป็นการเฉพาะ ทำให้บุคลากรต้องแนะนำให้ครอบครัวจัดการด้วยวิธีที่อาจขัดต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อม

มุมมองจากพื้นที่:

“ปัญหาของเราเลยคือต้องสอนวิธีเก็บ วิธีทำลาย... เรามีการบริหารจัดการขยะ เรามีการคัดแยกค่ะ แต่ อบต. เรายังไม่มีรถสำหรับขนขยะเพื่อไปกำจัดต่างๆ และด้วยของกฎหมายบ้านเราเค้าไม่ให้เผา แต่จริง ๆ เราแอบสอนให้เผา โดยขุดหลุมและเผากลางคืนหน่อย แค่ 2 - 3 ชิ้นเผาได้ค่ะ”

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ดูแลพื้นที่

“ถ้ารวมไว้เยอะ ๆ ไปทิ้งที่ไม่ใช่ของเรา เงินเราไม่ได้เสียให้เค้า เราไปทำอย่างนั้นไม่ได้... บ้านไหนที่มีแบบนี้เค้าจะไปแอบขุดหลุมเล็ กๆ”

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ดูแลพื้นที่

มิติที่ 5 การอภิบาล และภาวะผู้นำ (Governance & Leadership)

เป้าหมายและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้ (Intended system design & expectation)

ระบบการดูแลระยะยาว (Long-Term Care: LTC) ของประเทศไทยถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นกระบวนทัศน์ “การกระจายอำนาจ (Decentralization)” โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำหน้าที่เป็น “เจ้าภาพหลัก” ในการบริหารจัดการและอภิบาลระบบสุขภาพและสังคมในระดับพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จ ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ LTC ระดับตำบล และบูรณาการบริการทางการแพทย์กับบริการทางสังคมให้เป็นเนื้อเดียวกัน สอดคล้องกับกรอบแนวคิด WHO ที่มุ่งสู่การดูแลระยะยาวแบบต่อเนื่องไร้รอยต่อ (Integrated Continuum of Care) เพื่อให้ผู้สูงอายุ “Aging in Place” ได้อย่างมีคุณภาพ

> *“ระบบถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็น ‘สะพานเชื่อม’ ใน 2 มิติสำคัญ คือ การเชื่อมต่อศักยภาพการใช้ชีวิต (Functional Ability) ของผู้สูงอายุให้ฟื้นคืนมา และการเชื่อมรอยต่อระหว่างระบบบริการสุขภาพกับระบบบริการสังคม ให้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวผ่านกระบวนการที่ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง”*
>
> — เอกสารรายงานการทบทวนวรรณกรรมระดับชาติ

ในระดับนโยบาย สปสช. ได้อธิบายเหตุผลเบื้องหลังของการออกแบบโครงสร้างนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นผลมาจากข้อจำกัดด้านทรัพยากร ดังนี้

> *“สุดท้ายก็ได้คำตอบว่าประเทศไทยควรเดินหน้าใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน เนื่องจากงบของประเทศไทยเราคงมีไม่มากพอที่จะจัดบริการแบบ Hospital-based ด้วยข้อจำกัดหลากหลายประการ โดยเฉพาะกำลังพล”*
>
> — ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์หน้างานจริงมีความซับซ้อนและแตกต่างจากอุดมคติที่ออกแบบไว้อย่างมีนัยสำคัญ ข้อค้นพบเชิงประจักษ์สามารถสังเคราะห์เป็นลำดับตรรกะของปัญหาการอภิบาลออกเป็น 9 แก่นสาระ (theme) ที่เชื่อมโยงกันจากระดับบุคคล สู่ระดับโครงสร้าง และระดับระบบ ดังนี้

Theme 5.1: อำนาจเบ็ดเสร็จของ “ผู้ถือเงิน” และภาวะพึ่งพิงวิสัยทัศน์ผู้นำระดับท้องถิ่น (Absolute Power of Fund Holders and Individual Leadership Dependency)

การออกแบบกลไกที่มอบอำนาจบริหารงบประมาณไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่งผลให้ทิศทางของระบบ LTC ต้องผูกติดกับ “วิสัยทัศน์ ความเข้าใจ และความกล้าตัดสินใจ” ของผู้บริหารท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในพื้นที่ที่ผู้นำมีวิสัยทัศน์ ทรัพยากรต่าง ๆ จะถูกบูรณาการลงสู่พื้นที่ได้อย่างไร้รอยต่อ

แต่ในทางกลับกัน หากพื้นที่นั้นผู้บริหารขาดความเข้าใจ หรืออยู่ในช่วงรอยต่อรอการเลือกตั้งใหม่ ระบบการดูแลผู้ป่วยจะชะงักงันทันที งบประมาณจะถูกแช่แข็ง และแผนการดูแล (Care Plan) จะไม่ได้รับการเซ็นอนุมัติ ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของกลไกการบริหารจัดการในปัจจุบัน ที่ยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยการพึ่งพิง “ตัวบุคคล” มากกว่า “ความเข้มแข็งของตัวระบบเอง” ที่ควรจะทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอการผลัดเปลี่ยนผู้บริหาร

มุมมองจากพื้นที่:

> *“ในแต่ละเทศบาล ผู้ถือเงินก็จะเป็นนักการเมือง หรือว่านักปกครอง... การตัดสินใจ หรือการที่จะใส่ใจกับเรื่องของภาวะพวกอย่างนี้ ก็จะขึ้นกับตัวนักปกครอง... ถ้าเค้าใส่ใจมาก ๆ เค้าก็ให้ประชุมบ่อย... แต่ถ้าผู้ถือเงินเค้าไม่ได้ให้ความสำคัญมาก ก็ต้องตามนั้น เราจะไปทำอะไรกับตรงนั้นมากไม่ได้”*
>
> — ตัวแทนทีมผู้บริหาร / โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

> *“ประเมินความสำเร็จนะครับ ผมว่ามีหลายองค์ประกอบ เริ่มจากผู้บริหาร อปท. ท่านปลัดที่มีวิสัยทัศน์ และเห็นความสำคัญของกองทุน LTC ที่จะเกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุ... ถ้าหัวไม่ขยับ คนที่ทำงานร่วมกันขยับยากครับ”*
>
> — ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ภาคเหนือตอนล่าง

“ตอนนั้นเรามีผู้นำที่เป็นที่ปรึกษาของนายก ท่านเป็นอดีตข้าราชการเกษียณ มาขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แต่ด้วยลุงอายุเยอะ ไม่ได้มาช่วยเรายังหา key person แบบนั้นอีกไม่เจอ”

— พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการการดูแล / CM พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

สปสช. ยืนยันสถานการณ์นี้จากการสำรวจภาพรวมระดับประเทศว่ายังคงมีท้องถิ่นส่วนหนึ่งที่ยังไม่เข้าร่วมระบบ และระบุสาเหตุหลักไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า

“สี่เปอร์เซ็นต์ที่ยังเจอท้องถิ่นที่ยังไม่มีความพร้อม... ส่วนใหญ่ก็จะห่วงกังวลเรื่องระเบียบข้อจำกัด ความไม่มั่นใจในระเบียบการใช้เงิน... อันที่สองก็คือบุคลากรอาจจะขาด Care Manager ขาด Caregiver”

— ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Theme 5.2: ทุนทางการเมืองท้องถิ่นและบทบาทข้าราชการประจำในฐานะผู้จุดประกายนโยบาย (Local Political Capital and Permanent Officials as Policy Catalysts)

ในด้านบวก ระบบ LTC สามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นมองเห็น “ทุนทางการเมือง (Political Capital)” ว่าสวัสดิการด้านสุขภาวะของผู้มีภาวะพึ่งพิงสามารถสร้างผลงานและฐานเสียงได้ ควบคู่กับบทบาทสำคัญของ “ข้าราชการประจำ” (ปลัด อปท. หรือ ผอ.กองสาธารณสุข หรือสาธารณสุขอำเภอ หรือผอ.โรงพยาบาล) ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชงเรื่อง (Policy Catalyst) สร้างความเข้าใจต่อนักการเมือง และผลักดันนโยบายจนได้รับการอนุมัติ กลไกคู่ขนานนี้คือสะพานที่เชื่อมระหว่างวิสัยทัศน์ด้านสาธารณสุขกับอำนาจทางการเมืองในระดับพื้นที่

มุมมองจากพื้นที่:

“ผอ. ไปคุยกับนายก และท่านนายกมีวิสัยทัศน์ ท่านโอเค ท่านสนับสนุน... การบริการก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สามารถที่จะเป็นฐานเสียงให้ท่านนายกได้ ท่านเลยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนเราเต็มที่”

— พยาบาลวิชาชีพผู้ประสานงาน / โรงพยาบาลชุมชน ภาคเหนือ

“อย่างเคสผู้ป่วยรายใหม่หรือเคสเก่า ๆ ทางนายก อปท. จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมด้วยเสมอครับ เพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้... ทางทีมเราก็พยายามผลักดันให้งานดูแลผู้ป่วยเป็นผลงานของนายกไปเลย พูดง่าย ๆ คือคล้ายกับช่วยท่านหาเสียงไปในตัวครับ”

— ตัวแทนทีมบริหารระดับอำเภอ / ภาคใต้

“ส่วนหนึ่งคือพนักงานประจำต้องเห็นความสำคัญด้วย... ถ้าตัวหลักที่เป็นข้าราชการให้ความสำคัญ และเห็นชอบว่าสิ่งที่จะทำในอนาคตจะเกิดประโยชน์และเอาไปนำเสนอว่าทำแล้วเกิดอะไรขึ้น... เป็นท่านปลัด เพราะว่าปลัด อบต. เป็นเลขากองทุน สปสช. มีสิทธิมีอำนาจในการเสนอความคิดเห็น”

— ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ภาคเหนือตอนล่าง

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

ผู้บริหารระดับนิติบัญญัติ (สว.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุและคนพิการ มองว่ากุญแจสำคัญของความยั่งยืนของระบบไม่ใช่การสั่งการจากบนลงล่าง แต่คือการ “สร้างแรงบันดาลใจ” ให้คนในระบบ

“การที่เราจะให้คนคนหนึ่งมีพลังทำอะไรหรือไม่ทำอะไร ต้องมี Emotion... ถ้าเรามีเงินให้เขา เขาก็อาจจะทำ แต่เมื่อหมดแรงจูงใจเขาคงไม่ทำแล้ว แต่ถ้าเราไปจุดใจเขา แล้วให้เขาเกิดอยากทำเนี่ย เขาก็จะทำต่อไป”

— สมาชิกวุฒิสภา / คณะอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

Theme 5.3: ความหวาดกลัวทางกฎหมายและระเบียบราชการที่แช่แข็งการตัดสินใจ (Legal Fears and Bureaucratic Paralysis)

แม้เจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจคือการสร้างความคล่องตัว แต่การกำกับดูแลจากองค์กรตรวจสอบอิสระ (ป.ป.ช. / สตง.) สร้าง “บรรยากาศแห่งความหวาดกลัว” ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ความกังวลต่อการตีความระเบียบการเบิกจ่ายที่ล้าหลังหรือคลุมเครือ ทำให้ นายก อปท. หลายแห่งเลือกปฏิเสธการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชะลอการอนุมัติโครงการ หรือปฏิเสธการเข้าร่วมกองทุน LTC อย่างสิ้นเชิง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมาย ความกลัวนี้กลายเป็นอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่สกัดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้

มุมมองจากพื้นที่:

> *“นายกองค์กรบริหารส่วนปกครองท้องถิ่นบางที่คิดว่าโมเดลแบบ (จัดตั้งศูนย์) ไม่ใช่สิ่งที่ดี... เห็นนายกถูก ป.ป.ช. เรียกเข้าพบอย่างนี้ครับ กว่าจะสู้ขึ้นศาลมา กว่าจะสู้ผ่าน ป.ป.ช. ได้ใช้เวลาเป็นปี 2 ปี... ที่อื่นก็เกรงกลัวครับ ผมคิดว่าอันนี้มีส่วนอย่างมากในการเหนี่ยวนำความคิด”*
>
> — ตัวแทนทีมผู้บริหาร / โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

> *“มีที่หนึ่งพึ่งตั้งกองทุน LTC ไม่เกิน 2 ปี และไม่ยอมตั้งเด็ดขาด เพราะเค้าบอกว่าติดระเบียบการเบิกจ่าย เค้าไปอ้างหนังสือบางฉบับของปี 2559... เค้าบอกไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เค้าเลยไม่สะดวกที่จะทำ เพราะเค้ากลัวโดนตรวจสอบ ในขณะที่ อปท. อื่น ๆ ทำหมดแล้ว”*
>
> — แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว / โรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้

> *“บางทีเราไม่รู้ว่าทำแบบนี้มันผิดระเบียบมั้ย และมีหลายข้อกฎหมาย... ระเบียบเยอะมาก และเงินเบิกจ่ายอย่างไรต่อ เอกสารก็เยอะ และเราไม่แม่นระเบียบด้วย ต้องทบทวนตลอด และไปไม่ถึงฝันสักที”*
>
> — พยาบาลวิชาชีพ / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Theme 5.4: ข้อจำกัดด้านศักยภาพเชิงโครงสร้างและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Structural and Personnel Capacity Constraints of Local Governments)

ความคาดหวังให้ท้องถิ่นเป็น “เจ้าภาพหลัก” เผชิญกับข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่แท้จริง อปท. ขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากไม่มี “กองสาธารณสุข” เป็นของตนเอง มีข้าราชการรักษาการเพียง 1-2 คน และมีอัตราการย้ายตำแหน่งสูง ภาระงานด้าน LTC จึงถูกโอนให้เจ้าหน้าที่สายงานอื่น (เช่น นักพัฒนาชุมชน หรือนักสังคมสงเคราะห์) ซึ่งขาดองค์ความรู้ด้านศัพท์เทคนิคทางคลินิก ส่งผลให้กลไกท้องถิ่นทำหน้าที่ได้เพียง งานธุรการและงานอนุมัติงบประมาณ แต่ไม่สามารถวิเคราะห์แผนการดูแล (Care Plan) หรือประเมินความต้องการทางสุขภาพของผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนได้อย่างแท้จริง

มุมมองจากพื้นที่:

“ท้องถิ่นภาพใหญ่มีปัญหาเรื่องบุคลากร ทุกวันนี้บางท้องถิ่นรักษาการมีข้าราชการอยู่ 1 - 2 คน ต้องรักษาการทุกตำแหน่ง... ไม่มีกองสาธารณสุข ไม่มีกองป้องกันสาธารณภัย พอเรามองเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย มันวนมาที่ รพ.สต.”

— ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ภาคกลาง

“ส่งน้องไปอบรม CM 2 คน คนหนึ่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อีกคนเป็นผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ แต่ถามว่าไปอบรมบางอย่างคือมีเสียงสะท้อนมาว่าสายงานเราไม่ใช่สายงานด้านสาธารณสุข เพราะว่าหลายๆ ตัวชี้วัด หรือหลายๆ ศัพท์เทคนิคมีความเฉพาะและยากที่จะเข้าใจ... เราไม่มีองค์ความรู้ที่จะไปทำได้”

— ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ภาคเหนือตอนล่าง

“ไม่มีกรอบพนักงานจ้างเพิ่ม และข้าราชการย้ายบ่อย ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเราจะตัดสินใจเองไม่ได้... บางทีผู้ที่จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหามันหมุนเวียน อย่างเช่น ปลัดเค้าย้าย ย้ายบ่อย กว่าเราจะต้องไปทำความเข้าใจว่าท่านปลัดต้องเบิกนะครับ พอจะเข้าใจ พอจะเข้ามือกัน ท่านปลัดก็ย้าย”

— เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข / เทศบาลตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

สปสช. ยืนยันปัญหานี้จากการติดตามระดับประเทศว่าแม้การอบรมหลักสูตร CM จะใช้มาตรฐานเดียวกัน แต่กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกันมาก

“พอมาเจอกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีการศึกษาด้านสุขภาพมาก็จะทำให้ลำบากเวลาทำ Care Plan... นี่ก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งที่คิดว่าจะต้องขยับกันดูว่าจะอัปเกรดเป็นยังไง”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.) ก็มีข้อสังเกตในทิศทางเดียวกันว่า ท้องถิ่นยังขาดทักษะที่จำเป็นในการใช้ข้อมูลเชิงนโยบาย

“แม้ อปท. จะมีงบประมาณและอยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด แต่ยังขาดทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนเชิงนโยบาย กรมฯ จึงมุ่งหวังใช้กลไกบอร์ดชาติในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลในระดับพื้นที่”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย /
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Theme 5.5: ช่องว่างการกำกับดูแลทางคลินิกและอุปสรรคสายการบังคับบัญชาหลังการถ่ายโอนภารกิจ (Clinical Governance Gaps and Chain of Command Hurdles Post-Decentralization)

นโยบายการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้สร้างรอยต่อเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างเห็นได้ชัดใน 3 มิติ ประการแรกคือ โรงพยาบาลชุมชนซึ่งเคยมีบทบาทเป็นหน่วยงานแม่ข่ายในการสนับสนุนและประสานการจัดบริการร่วมกับ รพ.สต. ถูกลดบทบาทลงเหลือเพียงฝ่ายสนับสนุนทางวิชาการ ประการต่อมา การประสานงานมีความซับซ้อนและเป็นทางการมากขึ้น จากเดิมที่บุคลากรสามารถโทรศัพท์ประสานงานกันได้โดยตรง ต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบหนังสือราชการที่ต้องส่งผ่านนายก อบจ. และประการสุดท้ายคือ ระบบฐานข้อมูลที่ถูกตัดขาดจากกัน ปัญหาเหล่านี้ล้วนสร้างอุปสรรคต่อการติดตามและดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

มุมมองจากพื้นที่:

“รพ.สต. ที่ตอนนี้เราก็รู้ว่าออกไปอยู่ อบจ. มันจะมีส่วนของโรงพยาบาล... ฟังก์ชันโรงพยาบาล ทำกับ รพ.สต. เนี่ย เป็นเหมือนกับเป็นคลัตช์ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนให้ความรู้... เพราะเราไม่ได้มีบทบาทในเรื่องของการควบคุมกำกับ เราไม่สามารถที่จะไปบังคับอะไรตรงนั้นได้”

— ตัวแทนทีมผู้บริหาร / โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“บางมิติ จะจัดประชุมอะไรต้องทำหนังสือเชิญ ถึง อบจ. ถึงนายก... ติดเรื่องสายบังคับบัญชา... เมื่อก่อนเคยโทรประสานตรงได้ แต่หลัง ๆ ต้องทำเป็นหนังสือหมด”

— พยาบาลวิชาชีพ / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคใต้

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

กรมอนามัยซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการหลักระบุถึงผลกระทบของการถ่ายโอนต่อห่วงโซ่การบังคับบัญชาทางสาธารณสุขอย่างตรงไปตรงมา

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถสั่ง อบจ. หรือสั่ง อบต. ได้ไหม ไม่ได้ครับ ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา อบจ. คือนิติบุคคลครับ”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สปสช. ยืนยันว่าความซับซ้อนของการถ่ายโอนส่งผลต่อค่าตอบแทนบุคลากรในระบบโดยตรง ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

“เราไปเจอหน่วยจัดบริการณ ปัจจุบันที่เป็น รพ.สต. สังกัดกระทรวง เจอข้อจำกัดที่ระเบียบเงิน LTC ท้องถิ่นไปจ่ายค่าตอบแทน CG ได้ไม่เกิน 600 กับ 1,500 บาท... ในขณะที่ถ้าท้องถิ่นรับงบผ่านหน่วยที่ถ่ายโอนไป อบจ. จะทลายข้อจำกัดเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน ราคาก็อยู่ประมาณสักสองพันสามพัน”

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 5.6: ช่องโหว่ด้านอำนาจของหน่วยงานสาธารณสุขในคณะกรรมการท้องถิ่น (Power Vacuum of Clinical Support Units in Local Committees)

โครงสร้างระบบที่แยกส่วนระหว่าง “ผู้จ่ายเงิน (อปท.)” และ “ผู้ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ (โรงพยาบาล)” ออกจากกัน ได้ก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางอำนาจที่กระทบต่อคุณภาพการดูแลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทางปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีสถานะเป็นเพียง “ที่ปรึกษา” ของคณะกรรมการท้องถิ่น ซึ่งปราศจากสิทธิออกเสียงหรืออำนาจอนุมัติงบประมาณ

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพบว่าผู้ดูแล (CG) ปฏิบัติงานบกพร่องหรือไม่ได้มาตรฐาน โรงพยาบาลก็ไม่มีอำนาจสั่งยุติการทำงานได้ สภาพการณ์เช่นนี้ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานทางคลินิก ต้องตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก คือต้อง “แบกรับความเสี่ยงทั้งหมดไว้โดยปราศจากเครื่องมือเชิงอำนาจในการจัดการ” อย่างสิ้นเชิง

มุมมองจากพื้นที่:

> *“ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นที่ปรึกษากองทุนโดยตำแหน่ง ไม่ได้เป็นกรรมการ เพราะฉะนั้นพูดแบบ off record คือว่า เค้าอยากปรึกษาก็ปรึกษา เค้าไม่อยากปรึกษาก็ไม่ปรึกษา เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีเสียงในกรรมการ... ที่ปรึกษาจะเข้าประชุมหรือไม่เข้าประชุมเค้าก็ไม่ได้สนใจ”*
>
> — ตัวแทนทีมผู้บริหาร / โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

> *“เราอาจจะไม่สามารถประเมินคุณภาพของ CG ที่เราอบรมไปได้... เมื่ออายุมากขึ้นหรือว่าเค้ามีภาวะอื่น ๆ เราก็ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะเลือกคนนี้เข้าหรือจะเอาคนนี้ออกไหม คือเราไม่ได้เป็นนายจ้างเขา... อันนี้เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ทำให้ผู้สูงอายุเราในหลาย ๆ พื้นที่มี CG ดู แต่มีชื่อดูแต่อาจจะไม่ได้รับการดูแล”*
>
> — แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว / โรงพยาบาลชุมชน

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

กรมอนามัยซึ่งต้องการยกระดับบทบาทในการกำกับดูแลคุณภาพ แสดงออกถึงความต้องการในการสร้างระบบ Ranking/Audit ที่เป็นมิตร แต่ยอมรับว่ายังมีความท้าทายเรื่องอำนาจในทางปฏิบัติ

> *"อยากทำครับ ผมไม่เอาตัดสินเพราะตัดสินผมตาย ต้องเป็น Friendly Ranking ครับ Friendly เพื่อการพัฒนา... โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโชว์ต่างๆ ว่า Performance ของแต่ละที่ผลงานเป็นอย่างไร"*
>
> — ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สปสช. เสนอแนวทางแก้ปัญหาเรื่องช่องว่างนี้โดยเห็นว่าควรมีตำแหน่ง "Care Coordinator" หรือ "Systems Manager" ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานทุกมิติ ไม่ใช่เฉพาะสุขภาพ

> *"ผมคิดว่าน่าจะมีตำแหน่งผู้ประสานงานในท้องถิ่น ที่ทำหน้าที่คล้ายนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องเชื่อมประสานทุกเรื่องให้กับตัวเคสที่เป็น LTC... คนนี้จะทำหน้าที่บอกแคร์เมเนเจอร์ว่าเคสนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติมนอกจากเรื่องสุขภาพและแคร์ที่ท้องถิ่นให้"*
>
> — ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 5.7: ความซ้ำซ้อนและปัญหาจากนโยบายส่วนกลางที่แยกส่วนกันทำ (Central Policy Fragmentation and Inter-Ministerial Silos)

ปัญหารากฐานสำคัญที่ทำให้ระบบเดินหน้าได้อย่างติดขัด คือโครงสร้างการทำงานที่แยกส่วนกันอย่างชัดเจน (Structural Silos) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง พม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่แต่ละหน่วยงานต่างมีกฎระเบียบ แหล่งงบประมาณ และฐานกำหนดอัตราค่าตอบแทนของตนเองที่แตกต่างกัน (เช่น ความลักลั่นระหว่างค่าตอบแทนของตำแหน่ง Caregiver และตำแหน่งผู้ช่วยคนพิการ หรือ PA ของ พม.) ประเด็นเหล่านี้ท้าทายความสามารถในการบูรณาการของพื้นที่ พื้นที่ใดที่สามารถในการจัดการและบูรณาการได้ก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างราบรื่น แต่ที่ใดที่ขาดศักยภาพก็จะประสบกับปัญหาในการดำเนินงาน

รอยต่อเชิงนโยบายจากส่วนกลางเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ทั้งในแง่ของการแบกรับภาระงานที่ทับซ้อนกัน ความสับสนวุ่นวายในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ตลอดจนลุกลามไปสู่ปัญหาการแย่งชิงบุคลากรหรือคนทำงานในพื้นที่เดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

มุมมองจากพื้นที่:

“สปสช. ใหญ่จะเห็นด้วยในรูปแบบนี้มั้ย เพราะว่า... ในบทบาทของน้องนักบริบาลชุมชนที่ทำอยู่เนี่ย มันไปซ้อนทับกับหลายกองทุนที่มีงบอยู่แล้ว เช่น งบ Long term Care ก็ไปทำซ้ำกับ CG ที่มีอยู่ปกติ... พอจ้างนักบริบาลชุมชนก็จะไม่มีเงินดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่”

— พยาบาลวิชาชีพ / ผู้จัดการการดูแล CM ระดับอำเภอ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“เงินจาก พม. มีการเบิกจ่ายผ่าน อบต. อบต. เพียงยื่นเอกสารประกอบ และ พม. จะโอนตรงให้ CG แต่ถ้าเป็นเงินขา LTC จะทำโครงการขึ้นไป โอนเข้ามา อบต. อบต. โอนเข้า รพ.สต. และต้องทำแผนการใช้เงินของ รพ.สต. ประกอบด้วย ถึงจะใช้จ่ายได้... พม. เขาเป็นคนทำแผนเองในส่วนพื้นที่ไม่ต้องทำแผนเพื่อใช้จ่ายเงินเลย”

— เจ้าหน้าที่ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล ภาคกลาง

“ดีกว่าแน่ มั่นใจได้เลยว่าถ้าเค้าไม่ลาออก อยู่ไปตลอดชีวิต มีงบที่ตั้งทุกปี สาธารณสุขมันจ่ายเอาเปรียบเค้าอะ 5,000 - 6,000 บาท ส่วน PA 6,000+2,000 เท่ากับ 8,000 บาท”

— ตัวแทนระดับพื้นที่ / ภาคใต้

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

การแยกส่วนนี้สะท้อนได้ชัดเจนจากความแตกต่างของโครงสร้างค่าตอบแทนของแต่ละกระทรวง ซึ่ง สปสช. ยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วน

"ระบบ LTC ประเทศไทยเราเนี่ย 80% สาย CG 20% นี่จะสายวิชาชีพอื่นโดยเฉพาะ Care Manager... ค่าตอบแทนที่เป็น Incentive ให้ Caregiver นี่มัน Vary มากนะครับ คำว่า Vary ก็คือแตกต่างกันมากในแต่ละหน่วยบริการ"

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

กรมกิจการผู้สูงอายุ พม. มีโครงการ "ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ" ที่ใช้หลักสูตร 240 ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่า CG ของ สปสช. (70 ชั่วโมง) แต่ต่ำกว่าระดับมืออาชีพ (420 ชั่วโมง) และมีค่าตอบแทนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

"ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน ได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือน ปฏิบัติงานในพื้นที่ตนเอง เพื่อสร้างความไว้วางใจ โดยมีอัตราดูแลผู้สูงอายุ 1 ต่อ 100 คน"

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมอนามัยอธิบายว่าโครงสร้างหลักสูตรการอบรมที่มีถึง 3 ระดับนั้น แต่ละระดับก็ถูกแยกไปอยู่คนละกระทรวงแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงการแยกส่วนที่ฝังลึกในโครงสร้างระบบ

"18 ชั่วโมงก็ไปอยู่ที่ พม. 70 ชั่วโมงก็อยู่ที่กรม [อนามัย] ส่วน 420 ชั่วโมงก็ไปที่ สบส. [กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข]... แต่จุดเริ่มต้นจากคนที่ไม่มีองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุเลย ก็จะถูกปูพื้นฐานด้วยเจ็ดสิบชั่วโมง"

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Theme 5.8: ความเปราะบางของระบบจากการพึ่งพิงตัวบุคคล และภาวะชะงักงันช่วงเปลี่ยนผ่าน (System Fragility from Single Point of Failure and Transition Paralysis)

ปัจจุบัน ระบบ LTC กำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญที่เรียกว่า “การพึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป” (Single Point of Failure) ยกตัวอย่างเช่น ในระดับปฏิบัติการ สิทธิการเข้าระบบถูกผูกติดไว้กับ Care Manager (CM) เพียงคนเดียว หาก CM ลาออกหรือโยกย้าย การเบิกจ่ายและอนุมัติแผนการดูแล (Care Plan) ของพื้นที่นั้นจะชะงักงันทันที

ในทำนองเดียวกัน เมื่อถึงช่วงรอยต่อทางการเมืองระดับท้องถิ่น เช่น นายก อปท. หมดวาระ หรือปลัดเกษียณอายุ กระบวนการอนุมัติงบประมาณก็จะถูกแช่แข็ง ทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรับบริการ ปรากฏการณ์เหล่านี้ตอกย้ำให้เห็นว่า ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ความบกพร่องของคนทำงานหน้างาน แต่เป็น “ความเปราะบางเชิงโครงสร้าง” ของระบบบริหารจัดการ ที่ออกแบบมาให้ยึดติดกับตัวบุคคล มากกว่าการสร้างกลไกที่รองรับการเปลี่ยนผ่านได้อย่างไร้รอยต่อ

การนำนโยบาย LTC ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จึงมีความยากและซับซ้อนกว่านโยบายที่สามารถดำเนินการได้ภายในระบบตนเอง อย่างกรณี นโยบายสามสิบบาทรักษาทุกที่ หรือบัตรประชาชนใบเดียวไปที่ไหนก็ได้ ที่ดำเนินการโดยภาคสาธารณสุขเป็นหลัก ขณะที่เรื่องนี้ต้องอาศัยความร่วมมือและความพร้อมของทั้งฝั่งสาธารณสุขและฝั่งท้องถิ่นจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้พบว่าแม้นโยบายนี้จะมีมาครบหนึ่งทศวรรษแล้ว การดำเนินงานที่แข่งขันเพิ่งจะปรากฏในช่วง 2 - 3 ปีหลังเอง

> *“รอเปิดสภาครั้งนี้ โครงการเขียนไปเรียบร้อยแล้ว แล้วท่านนายกท่านเก่าเกษียณไม่ทันได้เซ็น ต้องรอ 3-4 เดือน... ในช่วงนั้นมีเปลี่ยนผ่านเรื่องของนายก และกองทุน สปสช. LTC... ติดขัดตรงคณะกรรมการ เราไม่สามารถทำต่อได้”*
>
> — เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคกลาง

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

สปสช. ยืนยันว่า CM คือปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของระบบ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

> *"Care Manager เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของระบบ LTC ที่เป็น Community-based เลย...แต่เราไปเจอข้อจำกัดของท้องถิ่นขนาดไม่ใหญ่มาก มันมีการเวียนของคนทำงาน บางท้องถิ่นขนาดเล็กอาจจะให้แค่พนักงานจ้างเหมาโครงการมาเป็นผู้ดูแลงานก็มีนะครับ"*
>
> — ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Theme 5.9: ทบาทของหน่วยงานระดับอำเภอในการอุดช่องว่างระบบ ด้วยกลยุทธ์ "พี่เลี้ยง" และ "แรงกดดัน" (District-Level System Manager: Mentorship and Pressure Strategies)

ในสถานการณ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวนมากยังคงลังเลและไม่กล้ารับบทบาทด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) จึงต้องสวมบทบาทเป็น "ผู้จัดการระบบเชิงรุก" เพื่อเชื่อมการทำงานระหว่างส่วนกลางและพื้นที่ โดยงัดกลยุทธ์ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งมาใช้ควบคู่กัน

ในด้านไม้อ่อน สสอ. จะลงพื้นที่ไปเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยชี้แจงระเบียบและประกบทำเอกสารเพื่อให้ท้องถิ่นทำงานได้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้ไม้แข็ง โดยอาศัยกลไกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) หรือในระดับอำเภออาศัยนายอำเภอ/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยนำมาเป็นประเด็นการขับเคลื่อนของอำเภอลงมากดดัน เพื่อผลักดันให้ อปท. ทุกแห่งเข้าร่วมดำเนินการจัดการดูแลผู้ป่วย ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กลไกการบริหารจัดการใน "ระดับคนกลาง" (ระดับอำเภอ) ยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขาดไม่ได้ ในการอุดช่องโหว่การทำงานที่หน่วยงานระดับกระทรวงไม่สามารถสั่งการได้โดยตรง

มุมมองจากพื้นที่:

"จุดเริ่มต้นของท้องถิ่นที่ได้เข้ามา ยากมากเพราะเขาบอกว่าไม่ใช่บทบาทของท้องถิ่น... ใช้วิธีการพี่เลี้ยงจาก สปสช. เขต จัดอบรมประชุมที่สาธารณสุขอำเภอ... เมื่อ 2 ปีที่แล้วพึ่งครบ 100% ทางสาธารณสุขอำเภอจี้จนคนรับผิดชอบงานของกองสาธารณสุข ใช้ระบบกดดันกองสาธารณสุขให้ดำเนินการให้ได้ 100% ทั้งอำเภอ"

— ผู้แทนระดับอำเภอ / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ภาคใต้

"สาธารณสุขอำเภอจะเป็นคนผลักดันให้มีกองทุน Long Term Care ให้เกิดขึ้นทุกตำบล... สปสช. แจ้งมาโดยตรงเคยเชิญท้องถิ่นเข้าประชุมที่ สสจ. ประชุมในภาพใหญ่ มีนายแพทย์ สสจ. เป็นประธาน เพื่อจะกระตุ้นให้ได้เต็มที่ 100%"

— ผู้แทนระดับอำเภอ / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ภาคกลาง

"พอได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือเห็นพี่น้องในอำเภออื่น ๆ รู้ว่าตัวเองถ้าป่วยติดเตียงจะได้รับการดูแลจาก รพ. อะไรบ้าง จะมีการเข้าไปแจ้งหรือทักท้วงกับท้องถิ่นทำให้บางท้องถิ่น คิดว่าทำให้ชาวบ้านเข้ามาอยากได้รับการดูแล"

— ตัวแทนระดับพื้นที่ / ภาคใต้

มุมมองจากผู้บริหารส่วนกลาง:

สปสช. ยืนยันว่ากลไกกดดันจากบนลงล่างยังคงมีความจำเป็น และได้ใช้กลไกนี้ผ่านระบบคณะกรรมการภายใต้มหาดไทยอย่างต่อเนื่อง

"มันมีกลไก ก็คือชุดคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นมีมหาดไทยเป็นประธาน ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับ... ตัวนี้ก็อาจจะต้องวิเคราะห์เป็นรายพื้นที่ไปนะครับว่าการเข้าไม่ถึง LTC ในบางพื้นที่มีเหตุปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจากอะไร"

— ผู้บริหารระดับนโยบาย / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

บทที่ 7
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการของระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ภายหลังจากการดำเนินนโยบายและการพัฒนาระบบบริการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา โดยการศึกษาได้อาศัยกรอบแนวคิดขององค์ประกอบระบบการดูแลระยะยาวเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและกลไกของระบบในบริบทของประเทศไทย ควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์การเข้าถึงบริการ ผลลัพธ์ของระบบ และประสบการณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานในระดับพื้นที่

ในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจผู้สูงอายุระดับประเทศและฐานข้อมูลการให้บริการของระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่ออธิบายลักษณะของประชากรผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รูปแบบการเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาว ตลอดจนแนวโน้มของการใช้บริการในระบบสุขภาพ ขณะที่การศึกษาเชิงคุณภาพได้มุ่งสำรวจมุมมองและประสบการณ์ของผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารหน่วยบริการ บุคลากรสาธารณสุข และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจกลไกการดำเนินงานของระบบการดูแลระยะยาว ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบ และข้อจำกัดหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานจริง

บทนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ข้อค้นพบจากการศึกษาทั้งหมด เพื่อนำเสนอภาพรวมของพัฒนาการและสถานการณ์ของระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทย รวมทั้งอภิปรายประเด็นสำคัญที่มีนัยต่อการพัฒนาระบบในอนาคต นอกจากนี้ ยังนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากผลการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวให้

สามารถรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ภาพรวมและสถานการณ์ระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

ภาพรวมและสถานการณ์ระบบการดูแลระยะยาว (LTC) ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับบริบทสากล ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด" (Super-Aged Society) ภายในปี พ.ศ. 2574 ซึ่งเร็วกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันระบบ LTC ของไทยยังคงพึ่งพาครอบครัวเป็นเสาหลัก โดยร้อยละ 91 - 94 ของผู้ดูแลคือคนในครอบครัว (ส่วนใหญ่เป็นสตรีหรือคู่สมรสวัย 56-58 ปี) ซึ่งกว่าร้อยละ 83 - 84 ไม่เคยผ่านการอบรมทักษะใด ๆ และประชากรวัยแรงงานร้อยละ 9 - 11 ต้องลาออกจากงานมาดูแลผู้ป่วย (107)

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ OECD ที่มีระบบสวัสดิการก้าวหน้า การดูแลผู้สูงอายุจะผสมผสานระหว่างการดูแลโดยครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และการใช้บุคลากรวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ในขณะที่ประเทศจีนซึ่งเผชิญปัญหาครอบครัวขนาดเล็กลงจากนโยบายลูกคนเดียว กำลังเร่งสร้างสถานดูแลผู้สูงอายุและนำร่องระบบประกันการดูแลระยะยาว (LTC Insurance) ในเขตเมือง ส่วนในภูมิภาคอาเซียนอย่างประเทศสิงคโปร์ มีการใช้กลไกเงินอุดหนุนร่วมกับการจ้างแรงงานต่างชาติมาเป็นผู้ดูแลในครัวเรือน ซึ่งสะท้อนว่ารูปแบบการพึ่งพิง "ความเสียสละของครอบครัว" เพียงอย่างเดียวในไทยกำลังสวนทางกับแนวโน้มสากลที่มุ่งสู่การสร้างระบบดูแลที่เป็นทางการมากขึ้น (107 - 109)

ช่องว่างระหว่างการออกแบบและการดำเนินงาน (Design-Implementation Gap)

ประเด็นสำคัญและข้อจำกัดในปัจจุบัน (Design-Implementation Gap) รายงานชิ้นนี้สะท้อนช่องว่างระหว่างนโยบายและการปฏิบัติจริงใน 5 มิติ ซึ่งสามารถนำไปเทียบเคียงกับบทเรียนสากลได้ดังนี้

1) **กำลังคน (Workforce):** ไทยติด "กับดักระบบอาสาสมัคร" โดยจ่ายค่าตอบแทนผู้ดูแล (CG) เพียง 5,000 - 6,000 บาท/เดือน ทำให้เกิดภาวะหมดไฟและสมองไหล ในขณะที่มาตรฐาน OECD ถือว่าผู้ดูแลเป็น "วิชาชีพ" ที่ต้องได้รับค่าจ้างที่สะท้อน

ค่าครองชีพจริง (Living Wage) มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ และมีสวัสดิการคุ้มครอง

2) **การเงินการคลัง (Financing):** ไทยใช้งบเหมาจ่าย 6,000 บาท/คน/ปี และปรับเป็น 10,442 บาท/คน/ปี แต่การตั้งงบประมาณดังกล่าวถูกจำกัดไว้เฉพาะบริการสาธารณสุข ซึ่งไม่เพียงพอเนื่องจากค่าใช้จ่ายหลักของบริการดูแลระยะยาวคือบริการด้านสังคมและขาดความยืดหยุ่น ต่างจากจีนที่เริ่มนำร่องเก็บเบี้ย “ประกันการดูแลระยะยาวภาคบังคับ” หรือ OECD (เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี) ที่มีกองทุน LTC ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ครอบครัวล้มละลาย

3) **ระบบข้อมูล (Information Systems):** ข้อมูลของไทยกระจัดกระจายและเน้นบันทึกเพื่อเบิกจ่ายเงิน (Process-oriented) ในขณะที่มาตรฐานสากล (เช่น การใช้ระบบ interRAI ที่ใช้ในกลุ่มประเทศ OECD ในแคนาดา สิงคโปร์ หรือฮ่องกง) จะใช้ข้อมูลเพื่อประเมิน “ผลลัพธ์ทางคลินิก” และจัดสรรทรัพยากรตามความหนักเบาของอาการผู้ป่วยอย่างแม่นยำ (Case based payment) (110)

4) **การจัดบริการ (Service Delivery):** บริการของไทยยังแข็งตัว ขาดนวัตกรรมรอยต่อ เช่น ศูนย์รับฝากดูแลกลางวัน (Daycare) หรือบริการดูแลชั่วคราว (Respite care) ซึ่งในสิงคโปร์และกลุ่ม OECD บริการเหล่านี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รัฐอุดหนุนเพื่อประคับประคองไม่ให้ผู้ดูแลในครอบครัวหมดไฟ

5) **การอภิบาล (Governance):** ในส่วนกลางมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่ทำงานเฉพาะของตนแยกส่วนกัน เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ขาดกลไกการอภิบาลระดับชาติที่ดูภาพรวมทั้งหมดของระบบบริการดูแลระยะยาว ขณะที่ในระดับพื้นที่ความสำเร็จในไทยมักยึดติดกับ “ตัวบุคคล” หรือผู้นำท้องถิ่นเป็นรายพื้นที่ ต่างจากสากลที่ขับเคลื่อนด้วยความเข้มแข็งของระบบสถาบันและกฎหมายที่ชัดเจน

แนวทางแก้ไขปัญหาช่องว่างการดำเนินงาน

1) **ทลายกับดักระบบอาสาสมัคร:** เปลี่ยนผ่านสู่ “ความเป็นมืออาชีพ” (Professionalization) โดยจัดจ้างผู้ดูแลแบบเต็มเวลาด้วยค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (Living Wage) ตามมาตรฐานแรงงานสากล และยกระดับพยาบาลผู้จัดการการดูแล (CM) ให้เป็นตำแหน่งเฉพาะทาง

2) **สร้างผู้จัดการระบบระดับอำเภอ (System Manager):** ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และเชื่อมรอยต่อการดูแล คล้ายคลึงกับโมเดล Care Manager ในระบบของญี่ปุ่นที่บูรณาการทรัพยากรระดับชุมชนเข้าด้วยกัน (111)

3) **ปฏิรูประบบสารสนเทศสู่ Data Analytics:** เปลี่ยนการทำเอกสารเบิกจ่ายให้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรตามความจำเป็นที่แท้จริงของผู้ป่วยได้แบบพลวัตร ขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อการใช้ในการกำกับติดตามผลลัพธ์การให้บริการ

4) **พัฒนากลไกการเงินและนวัตกรรมสังคม:** เนื่องจากไทยอาจยังไม่พร้อมจัดทำระบบประกัน LTC ภาคบังคับแบบญี่ปุ่นหรือจีน ดังนั้นหากจะต้องพึ่งพาระบบภาษีงบประมาณภาครัฐก็จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในภาคสังคมเพื่อให้สามารถจัดบริการได้อย่างทั่วถึง (แม้พม.จะมีงบสนับสนุนแต่ยังเป็นลักษณะโครงการนำร่องหรือต้นแบบ) โดยท้องถิ่นควรต้องเป็นคนลงทุนด้านบริการสังคมซึ่งในการนี้ต้องมีการถ่ายโอนภาระกิจของ พม. ให้แก่ท้องถิ่น ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องขยายเพดานเงินสนับสนุนแก่ท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นมีพื้นที่ทางการคลังเพียงพอในการอุดหนุน ขณะเดียวกันข้อเสนอให้มีการสร้าง “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” เช่น การออกพันธบัตรร่วมทุนทางสังคม (Social Impact Bond) ให้ภาคเอกชนมาลงทุนโดยภาครัฐจ่ายให้ตามสัมฤทธิ์ผลตามที่ตกลงกันไว้ และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจัดตั้งศูนย์ Daycare และ Respite Care

5) **มีกลไกการอภิบาลระบบการดูแลระยะยาวระดับชาติ** ในปัจจุบันแต่ละกระทรวงดำเนินการตามภาระกิจของตนแบบแยกส่วนกัน ขาดกลไกในการบูรณาการการจัดระบบการดูแลระยะยาวในระดับชาติ เสนอให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการอยู่แล้วทำหน้าที่เป็นกลไกในการบูรณาการระบบการดูแลระยะยาว

จุดเด่นและข้อจำกัดของรายงาน

จุดเด่นของรายงาน

มีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-methods) ที่นำข้อมูลระดับมหภาคมาตัดกับเสียงสะท้อนจากคนทำงานหน้างานจริง ทำให้เห็นภาพ “Design-Implementation Gap” ได้ทะลุปรุโปร่ง การนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วยกลไกการเงินสมัยใหม่ (เช่น Social Impact Bond) ถือเป็นการปรับตัวที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังของประเทศกำลังพัฒนา

ข้อจำกัดของรายงาน

แม้รายงานจะชี้ให้เห็นว่าการลงทุน LTC ในปัจจุบันยังไม่คุ้มค่า (ไม่ช่วยลดวันนอนโรงพยาบาล) แต่ยังขาดการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Cost-Effectiveness Analysis) เชิงลึก นอกจากนี้ ในส่วนของการพัฒนาระบบข้อมูล รายงานยังไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดการนำเครื่องมือประเมินมาตรฐานสากล (เช่น interRAI) เข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่กลุ่ม OECD และหลายประเทศในอาเซียนใช้เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลและยกระดับคุณภาพการดูแล

การศึกษาในอนาคต

จากข้อค้นพบในรายงานฉบับนี้ นอกเหนือจากข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประเด็นโจทย์การวิจัยในอนาคตที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบ long-term care ของประเทศไทยได้ประมาณ 6 ประเด็นหลัก ดังนี้

1) การออกแบบระบบการเงินการคลังของระบบ long-term care ที่สอดคล้องกับระดับความจำเป็นของผู้มีภาวะพึ่งพิง

การศึกษารูปแบบการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินของระบบ long-term care ให้สอดคล้องกับระดับความจำเป็นของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ปัจจุบันงบประมาณ long-term care ของประเทศไทยใช้กลไกการจัดสรรแบบเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งมีลักษณะ “flat-rate financing” ซึ่งถึงแม้มีการจัดกลุ่มผู้ป่วยตามความรุนแรงของภาวะพึ่งพิง แต่กลไกการจ่าย

เงินกลับไม่สะท้อนความแตกต่างของระดับความต้องการการดูแลระหว่างผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับต่าง ๆ เช่น กลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง ส่งผลให้บางพื้นที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกับวัสดุสิ้นเปลืองพื้นฐาน เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ขณะที่ทรัพยากรสำหรับบริการฟื้นฟูหรือบริการเชิงคุณภาพกลับมีจำกัด

งานวิจัยในอนาคตควรมุ่งวิเคราะห์ รูปแบบการจัดสรรงบประมาณตามระดับความจำเป็น (needs-based financing) หรือ case-mix adjusted payment สำหรับบริการ long-term care โดยศึกษาทั้งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้สูงอายุ งานวิจัยลักษณะนี้จะช่วยให้สามารถออกแบบระบบการเงินที่ตอบสนองต่อความซับซ้อนของภาวะพึ่งพิง และเพิ่มความคุ้มค่าของการลงทุนในระบบ long-term care ในระยะยาว

2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของภาระการดูแลโดยครอบครัว (family care burden)

งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุในระบบ long-term care ของไทยกว่า 90% ยังคงเป็นสมาชิกในครอบครัว และมีสัดส่วนหนึ่งที่ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้ป่วยเป็นเวลาหลายปี ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ

อย่างไรก็ตาม หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคของภาระการดูแลผู้สูงอายุ ยังมีจำกัด งานวิจัยในอนาคตจึงควรมุ่งวิเคราะห์ประเด็นต่อไปนี้ เช่น มูลค่าทางเศรษฐกิจของแรงงานดูแลที่ไม่เป็นทางการ (informal care economy) ผลกระทบของการออกจากตลาดแรงงานของผู้ดูแลต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศ และผลกระทบต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล

องค์ความรู้จากงานวิจัยลักษณะนี้จะช่วยสนับสนุนการออกแบบนโยบาย เช่น caregiver allowance respite care หรือระบบประกันการดูแลระยะยาว เพื่อบรรเทาภาระของครัวเรือนในอนาคต

3) การพัฒนากำลังคนและเส้นทางวิชาชีพของผู้ดูแล (care workforce development)

การศึกษาภาคสนามสะท้อนว่า ระบบ long-term care ของไทยยังพึ่งพา “ทุนทางสังคมเชิงเสียสละ” หรือการทำงานด้วยจิตอาสาของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (CG) เป็นอย่างมาก ขณะที่ค่าตอบแทนและโครงสร้างอาชีพยังไม่สามารถดึงดูดแรงงานเข้าสู่ระบบได้อย่างยั่งยืน ประเด็นวิจัยที่ควรให้ความสำคัญจึงได้แก่ รูปแบบการพัฒนา อาชีพผู้ดูแลระยะยาว (professional care workforce), กลไกการกำหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระงานและค่าครองชีพ, รูปแบบการฝึกอบรมและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้ดูแล โดยคำนึงถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Cloud Technology เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือแนวคิด IoT เป็นต้น งานวิจัยในประเด็นนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา care economy ของประเทศ และช่วยสร้างระบบกำลังคนที่มีความมั่นคงและยั่งยืนสำหรับรองรับสังคมสูงวัย

4) การพัฒนาระบบสารสนเทศและตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการดูแลระยะยาว

ข้อค้นพบหนึ่งที่สำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้คือระบบข้อมูล long-term care ในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกข้อมูลซ้ำในหลายระบบ และข้อมูลจำนวนมากถูกใช้เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่าการประเมินคุณภาพบริการ

งานวิจัยในอนาคตจึงควรมุ่งพัฒนา กรอบตัวชี้วัดผลลัพธ์ของ long-term care (LTC outcome indicators) ที่สะท้อนคุณภาพการดูแล เช่น อัตราการเกิดแผลกดทับ การเสื่อมถอยของ ADL การกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลซ้ำ นอกจากนี้ควรศึกษาการออกแบบระบบข้อมูลบูรณาการ (integrated care information system) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากบริการสุขภาพและบริการสังคมเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรในระบบ long-term care

5. การออกแบบระบบบริการแบบบูรณาการตลอด (continuum of care)

แม้ว่านโยบายจะมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ intermediate care, long-term care จนถึง palliative care แต่การดำเนินงานจริงยังคงมีลักษณะแยกส่วน

ตามโครงการและแหล่งงบประมาณ ทำให้เกิดปัญหาในช่วง “รอยต่อของการดูแล” เช่น การส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน หรือการปรับระดับการดูแลเมื่อผู้ป่วยมีอาการทรุดลง ประเด็นวิจัยที่สำคัญจึงได้แก่ รูปแบบ integrated care model สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลไกการจัดบริการที่เชื่อมโยง IMC, LTC และ palliative care การประเมินผลของนวัตกรรมชุมชน เช่น social daycare หรือ respite care โดยงานวิจัยในประเด็นนี้จะช่วยลดการกลับเข้าโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในระยะยาว

6. การอภิบาลระบบ long-term care ภายใต้การกระจายอำนาจ

แม้ว่าระบบ long-term care ของไทยจะออกแบบให้ท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ แต่ประสิทธิผลของระบบในแต่ละพื้นที่กลับขึ้นอยู่กับศักยภาพและวิสัยทัศน์ของผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาตัวบุคคลมากกว่าความเข้มแข็งของสถาบัน

งานวิจัยในอนาคตควรมุ่งศึกษาประเด็น เช่น การอภิบาลระบบที่ลงรายละเอียดและเหมาะสมสำหรับระบบ long-term care ภายใต้การกระจายอำนาจ การศึกษากลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับชาติและระดับท้องถิ่น การเจาะลึกบทบาทของ “system manager” ในระดับอำเภอหรือจังหวัด

องค์ความรู้จากงานวิจัยนี้จะช่วยพัฒนาระบบจากการพึ่งพาภาวะผู้นำเฉพาะบุคคลไปสู่ institutional governance ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง

1. สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, กนิษฐา บุณธรรมเจริญ, ศริพันธุ์ สาสัตย์, ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ. รูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน. วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว. 2551;22–31.
2. ภาสกร สวนเรือง, อาณัติ วรรณศรี, สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์. การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2561 Sep;12(3):437–51.
3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567.
4. วิพรรณ ประจวบเหมาะ, นภาพร ชโยวรรณ, มาลินี วงศ์สิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, วรเวศม์ สุวรรณระดา, วิราภรณ์ โพธิศิริ, et al. รายงานการศึกษา โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554). กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2013. Report No.
5. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2557-2561. 2556. Report No.
6. สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, วิชช์ เกษมทรัพย์, วิชัย เอกพลากร, บวรศม ลีระพันธ์. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [Technical Report]. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2561 Feb. Available from: https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4850
7. Saloni Dattani, Lucas Rodés-Guirao, Hannah Ritchie, Esteban Ortiz-Ospina, Max Roser. Life Expectancy [Internet]. 2023. Available from: https://ourworldindata.org/life-expectancy
8. World Health Organization. Ageing and health. 2025 Oct 1.
9. World Bank. Approach Paper World Bank Support to Aging Countries. 2019 May.
10. UN, World Population Prospects. Old-age dependency ratio, 1950 to 2100. 2024.
11. Olshansky SJ. From Lifespan to Healthspan. JAMA. 2018 Oct 2;320(13):1323–4. doi:10.1001/jama.2018.12621

12. Garmany A, Terzic A. Global Healthspan-Lifespan Gaps Among 183 World Health Organization Member States. JAMA Netw Open. 2024 Dec 11;7(12):e2450241. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.50241

13. Fries JF. Chapter 19 - On the Compression of Morbidity: From 1980 to 2015 and Beyond. In: Kaeberlein MR, Martin GM, editors. Handbook of the Biology of Aging (Eighth Edition). San Diego: Academic Press; 2016. p. 507–24. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124115965000198 doi:10.1016/B978-0-12-411596-5.00019-8

14. Fu R, Noguchi H. Moral hazard under zero price policy: evidence from Japanese long-term care claims data. Eur J Health Econ. 2019 Aug;20(6):785–99. doi:10.1007/s10198-019-01041-6

15. Sudharsanan N, Bloom DE. The Demography of Aging in Low- and Middle-Income Countries: Chronological versus Functional Perspectives. In: Future Directions for the Demography of Aging: Proceedings of a Workshop. National Academies Press (US); 2018. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513069/

16. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2567. 2024. Report No.

17. กรมกิจการผู้สูงอายุ. สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2565. 2023. Report No.

18. Crowson NJ, Fredrickson J. Almshouses, Old Age and the Welfare State in Modern Britain. Cultural and Social History. 2025 Aug 27. Located at: world. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14780038.2025.2550071

19. Home Care. Available from: https://www.nursing.upenn.edu/nhhc/home-care/

20. The Social Security Act of 1935. 1935.

21. kffmelissam. Long-Term Care in the United States: A Timeline. KFF. 2015 Aug 31. Available from: https://www.kff.org/medicaid/long-term-care-in-the-united-states-a-timeline/

22. Obinger H, Petersen K, Schmitt C, Starke P. War and Welfare States Before and After 1945. Vol. 1. Oxford University Press; 2018. Available from: https://academic.oup.com/book/7379/chapter/152210423 doi:10.1093/oso/9780198779599.003.0015

23. Doty P. Long-term care in international perspective. Health Care Financ Rev. 1988 Dec;1988(Suppl):145–55. PubMed PMID: 10312969; PubMed Central PMCID: PMC4195117.

24. Framework for Countries to Achieve an Integrated Continuum of Long-Term Care. 1st ed. Geneva: World Health Organization; 2021. 1 p.

25. OECD. Long-term care and health care insurance in OECD and other countries. OECD; 2020. Available from: https://www.oecd.org/en/publications/long-term-care-and-health-care-insurance-in-oecd-and-other-countries_3eabc286-en.html doi:10.1787/3eabc286-en

26. Health Labour Market Analysis Guidebook. 1st ed. Geneva: World Health Organization; 2021. 1 p.

27. Salvador-Carulla L, Alvarez-Galvez J, Romero C, Gutiérrez-Colosía MR, Weber G, McDaid D, et al. Evaluation of an integrated system for classification, assessment and comparison of services for long-term care in Europe: the eDESDE-LTC study. BMC Health Serv Res. 2013 Jun 15;13:218. doi:10.1186/1472-6963-13-218 PubMed PMID: 23768163; PubMed Central PMCID: PMC3685525.

28. Mah J, Gallup B. A Short History of Long-Term Care in Nova Scotia*. Canadian Geriatrics Journal. 2021 Feb 18;24(1):77–81. doi:10.5770/cgj.24.464

29. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

30. Blackburn J, Locher JL, Kilgore ML. Comparison of Long-term Care in Nursing Homes Versus Home Health: Costs and Outcomes in Alabama. Gerontologist. 2016 Apr;56(2):215–21. doi:10.1093/geront/gnu021 PubMed PMID: 24688082.

31. Crocker TF, Ensor J, Lam N, Jordão M, Bajpai R, Bond M, et al. Community based complex interventions to sustain independence in older people: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2024 Mar 21;384:e077764. doi:10.1136/bmj-2023-077764 PubMed PMID: 38514079; PubMed Central PMCID: PMC10955723.

32. Boland L, Légaré F, Perez MMB, Menear M, Garvelink MM, McIsaac DI, et al. Impact of home care versus alternative locations of care on elder health outcomes: an overview of systematic reviews. BMC Geriatr. 2017 Jan 14;17:20. doi:10.1186/s12877-016-0395-y PubMed PMID: 28088166; PubMed Central PMCID: PMC5237488.

33. Di Pollina L, Guessous I, Petoud V, Combescure C, Buchs B, Schaller P, et al. Integrated care at home reduces unnecessary hospitalizations of community-dwelling frail older adults: a prospective controlled trial. BMC Geriatr. 2017 Feb 14;17(1):53. doi:10.1186/s12877-017-0449-9 PubMed PMID: 28196486; PubMed Central PMCID: PMC5310012.

34. Llena-Nozal A, Barszczewski J, Rauet-Tejeda J. How do countries compare in their design of long-term care provision?: A typology of long-term care systems [OECD Health Working Papers]. 182nd ed. 2025 Jun. (OECD Health Working Papers). Report No. Available from: https://www.oecd.org/en/publications/how-do-countries-compare-in-their-design-of-long-term-care-provision_44f5453a-en.html doi:10.1787/44f5453a-en

35. Meagher G, Szebehely M. Long-Term Care in Sweden: Trends, Actors, and Consequences. In: Ranci C, Pavolini E, editors. Reforms in Long-Term Care Policies in Europe: Investigating Institutional Change and Social Impacts. New York, NY: Springer; 2013. p. 55–78. Available from: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4502-9_3 doi:10.1007/978-1-4614-4502-9_3

36. Burau V, Dahl HM. Trajectories of Change in Danish Long Term Care Policies—Reproduction by Adaptation through Top-Down and Bottom-Up Reforms. In: Ranci C, Pavolini E, editors. Reforms in Long-Term Care Policies in Europe: Investigating Institutional Change and Social Impacts. New York, NY: Springer; 2013. p. 79–95. Available from: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4502-9_4 doi:10.1007/978-1-4614-4502-9_4

37. Glendinning C. Long Term Care Reform in England: A Long and Unfinished Story. In: Ranci C, Pavolini E, editors. Reforms in Long-Term Care Policies in Europe: Investigating Institutional Change and Social Impacts. New York, NY: Springer; 2013. p. 179–200. Available from: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4502-9_9 doi:10.1007/978-1-4614-4502-9_9

38. Theobald H, Hampel S. Radical Institutional Change and Incremental Transformation: Long-Term Care Insurance in Germany. In: Ranci C, Pavolini E, editors. Reforms in Long-Term Care Policies in Europe: Investigating Institutional Change and Social Impacts. New York, NY: Springer; 2013. p. 117–38. doi:10.1007/978-1-4614-4502-9_6

39. Blümel M, Spranger A, Katharina Achstetter, Hengel P, Eriksen A, Maresso A, et al. Germany: Health System Summary, 2024. Copenhagen: European Observatory on Health Systems and Policies, WHO Regional Office for Europe; 2024. Report No.

40. Leeuwen MHDV. Trade Unions and the Provision of Welfare in the Netherlands, 1910-1960. The Economic History Review. 1997;50(4):764–91.

41. Schut FT, van den Berg B. Long-Term Care Insurance in the Netherlands. In: Costa-Font J, Courbage C, editors. Financing Long-Term Care in Europe: Institutions, Markets and Models. London: Palgrave Macmillan UK; 2012. p. 103–24. Available from: https://doi.org/10.1057/9780230349193_7 doi:10.1057/9780230349193_7

42. Schut FT, Van Den Berg B. Sustainability of Comprehensive Universal Long-term Care Insurance in the Netherlands. Social Policy & Administration. 2010;44(4):411–35. doi:10.1111/j.1467-9515.2010.00721.x

43. Maarse JAM (Hans), Jeurissen PP (Patrick). The policy and politics of the 2015 long-term care reform in the Netherlands. Health Policy. 2016 Mar 1;120(3):241–5. doi:10.1016/j.healthpol.2016.01.014

44. Colombo F, Llena-Nozal A, Mercier J, Tjadens F. Help Wanted?: Providing and Paying for Long-Term Care. OECD Health Policy Studies. 2011 May 18;2011. doi:10.1787/9789264097759-en

45. Bode I. Social care going market: Institutional and cultural change regarding services for the elderly. Journal of Comparative Social Work. 2010 Apr 1;5:39–54. doi:10.31265/jcsw.v5i1.52

46. Feder J, Komisar HL, Niefeld M. Long-Term Care In The United States: An Overview. Health Affairs. 2000 May;19(3):40–56. doi:10.1377/hlthaff.19.3.40

47. Fox PD, Clauser SB. Trends in Nursing Home Expenditures: Implications for Aging Policy. Health Care Financ Rev. 1980;2(2):65–70. PubMed PMID: 10309332; PubMed Central PMCID: PMC4191139.

48. Duckett MJ, Guy MR. Home and Community-Based Services Waivers. Health Care Financ Rev. 2000;22(1):123–5. PubMed PMID: 25372343; PubMed Central PMCID: PMC4194688.

49. Nakamura S. Japan's Welfare for the Elderly—Past, Present, and Future. Asia Health and Wellbeing Initiative. 2018 Dec 1. Available from: https://ahwin.org/japans-welfare-for-the-elderly-past-present-and-future/

50. Iwagami M, Tamiya N. The Long-Term Care Insurance System in Japan: Past, Present, and Future. JMA J. 2019 Mar 4;2(1):67–9. doi:10.31662/jmaj.2018-0015 PubMed PMID: 33681515; PubMed Central PMCID: PMC7930803.

51. Kim H, Kwon S. A decade of public long-term care insurance in South Korea: Policy lessons for aging countries. Health Policy. 2021 Jan 1;125(1):22–6. doi:10.1016/j.healthpol.2020.11.003

52. Song H. Reorganization of Long-Term Care Insurance for End-of-Life Care. J Hosp Palliat Care. 2024 Dec 1;27(4):167–71. doi:10.14475/jhpc.2024.27.4.167

53. Yeh MJ. Long-term care system in Taiwan: the 2017 major reform and its challenges. Ageing & Society. 2020 Jun;40(6):1334–51. doi:10.1017/S0144686X18001745

54. Ministry of Health and Welfar. Long-term Care Plan 2.0. 2024. Available from: https://english.ey.gov.tw/News3/9E5540D592A5FECD/332a78c0-0c8e-4064-bd71-8c22477dae75

55. Hsu HC, Chen CF. LTC 2.0: The 2017 reform of home- and community-based long-term care in Taiwan. Health Policy. 2019 Oct 1;123(10):912–6. doi:10.1016/j.healthpol.2019.08.004

56. Wieczorek E, Kocot E, Evers S, Sowada C, Pavlova M. Development of a tool for assessing the performance of long-term care systems in relation to care transition: Transitional Care Assessment Tool in Long-Term Care (TCAT-LTC). BMC Geriatr. 2023 Nov 20;23(1):760. doi:10.1186/s12877-023-04467-z PubMed PMID: 37986151; PubMed Central PMCID: PMC10662551.

57. Yang W, Forder J, Nizalova O. Measuring the productivity of residential long-term care in England: methods for quality adjustment and regional comparison. Eur J Health Econ. 2017 Jun;18(5):635–47. doi:10.1007/s10198-016-0816-z PubMed PMID: 27422731; PubMed Central PMCID: PMC5438827.

58. Kawase K, Igarashi A, Eltaybani S, Yasaka T, Sumikawa Y, Takaoka M, et al. Assessing the reliability and feasibility of quality indicators used to evaluate long-term care for older adults. Geriatr Gerontol Int. 2025 Mar;25(3):442–8. doi:10.1111/ggi.15074 PubMed PMID: 39876615; PubMed Central PMCID: PMC11911150.

59. Loureiro N, Martin JI. Quality Indicators for Residential Long-Term Care for the Elderly: A Scoping Review. Research on Ageing and Social Policy. 2024 Jul 30;12(2):82–104. doi:10.17583/rasp.13874

60. Kim H, Jeon B. Developing a framework for performance assessment of the public long-term care system in Korea: methodological and policy lessons. Health Res Policy Syst. 2020 Feb 22;18(1):27. doi:10.1186/s12961-020-0529-8 PubMed PMID: 32087709; PubMed Central PMCID: PMC7036169.

61. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546.

62. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570.

63. สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม). 2023.

64. แจ้งประจักษ ส. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของประเทศไทย: มุมมองด้านนโยบาย. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. 2023 May 9;5:23 - 43.

65. กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ยุทธศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580.

66. กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580).

67. กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แผนปฏิบัติราชการแผนการบูรณาการเพื่อการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2566 - 2570).

68. HFocus. 2025. เสียงสะท้อนการดูแล LTC จากผู้ให้ – ผู้รับบริการ เสนอให้สปสช.ดันเป็นนโยบายระดับชาติ. Available from: https://www.hfocus.org/content/2025/05/34138

69. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567. 2024.

70. วรวรรณ ชาญด้วยวิชย์, ยศ วัชระคุปต์. ระบบประกันการดูแลระยะยาว: ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; 2560. Report No.

71. Connor S, Sepulveda C. The Global Atlas of Palliative Care at the End of Life. 2014.

72. Khongboon P, Pongpanich S. Estimating Long-Term Care Costs among Thai Elderly: A Phichit Province Case Study. J Aging Res. 2018 Jan 17;2018:4180565. doi:10.1155/2018/4180565 PubMed PMID: 29593906; PubMed Central PMCID: PMC5822901.

73. กิจธีระวุฒิวงษ์ ก, กิจธีระวุฒิวงษ์ น. ทิศทางของการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน The developing direction for long-term care giver in community. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 2018 Dec 27;36(4):15–24.

74. Kaewsawang S, Chongsuvivatwong V, Vongsirinavarat M. Capacity of Physiotherapy Workforce Production in Thailand: Public-Private Mix, Secular Trend and Geographic Distribution. Physiother Res Int. 2016 Jun;21(2):127–32. doi:10.1002/pri.1629 PubMed PMID: 25891982.

75. กานดา ชัยภิญโญ, สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านกายภาพบำบัด การปฏิบัติหน้าที่แนวทางการแก้ไขปัญหา และประเด็นการปฏิรูป. Report No.

76. Choomplang N, Anantanasuwong D. The Employment Perspectives of Care Providers for Older Persons in Thailand. Human Resource and Organization Development Journal. 2023 Nov 9;15(2):50–80.

77. นงลักษณ์ พะไกยะ, ศิริพันธุ์ สาสัตย์, วาสินี วิเศษฤทธิ์. การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต [Technical Report]. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2563 Sep. Report No. Available from: https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5280

78. ระบบข้อมูลบุคลากรการดูแลระยะยาวและแผนการดูแลรายบุคคล (Long Term Care : 3C).

79. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แนวทางปฏิบัติ เรื่องการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงและค่าบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.

80. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย. หลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม จำนวน 50 ชั่วโมง. Report No.

81. Pagaiya N, Noree T, Hongthong P, Gongkulawat K, Padungson P, Setheetham D. From village health volunteers to paid care givers: the optimal mix for a multidisciplinary home health care workforce in rural Thailand. Hum Resour Health. 2021 Dec;19(1):2. doi:10.1186/s12960-020-00542-3

82. The Coverage. จากองค์ความรู้ต่างประเทศ สู่การออกแบบ 'LTC' ไทย กับภารกิจที่ให้ 'ท้องถิ่น' ร่วมดูแล. Available from: https://www.thecoverage.info/news/content/8876

83. ธัญกมล รงรองรจเรข. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2567.

84. Khongboon P, Wivatvanit S, Wanwacha C, Kespichayawattana J. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจ้างงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย. Journal of Health Systems Research. 2023 Sep 28;17(3):455–72.

85. Watanabe O, Chompikul J. Factors influencing the intention to leave elderly care among village health volunteers in Mueang district in Nakhon Ratchasima province, Thailand. Kokusai Hoken Iryo (Journal of International Health). 2016;31(1):1–11. doi:10.11197/jaih.31.1

86. Netpradit N. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เขต 1. Rajapark Journal. 2023 Jun 30;17(52):193–210.

87. สาริณี แก้วสว่าง, วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์, บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช. สถานะการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของนักกายภาพบำบัดไทยในภาครัฐและภาคเอกชน. 2561 Jun. Available from: https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4910

88. นงลักษณ์ พะไกยะ, ศิริพันธุ์ สาสัตย์, วาสินี วิเศษฤทธิ์. ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอนาคต. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2021;15(2):200–17.

89. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย. ผลการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2567. 2566 Jul 18.

90. Choomplang N, Anantanasuwong D. The Employment Perspectives of Care Providers for Older Persons in Thailand. Human Resource and Organization Development Journal. 2023 Nov 9;15(2):50–80.

91. Chanprasert P. Long-term care policy and Implementation in Thailand. In: Coping with Rapid Population Ageing in Asia. 2021. p. 36–44.

92. Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, Langhorne P, Burke O, Harwood RH, et al. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group, editor. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017 Sep 12;2017(9). doi:10.1002/14651858.CD006211.pub3

93. Kitreerawutiwong N, Mekrungrengwong S, Wongwonsin A, Phetphum C. Assessing the implementation of the family care team in the district health system of health region 2, Thailand. Fam Med Com Health. 2018 Feb 1;6(1). doi:10.15212/FMCH.2017.0139 PubMed PMID: 10.15212/FMCH.2017.0139.

94. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย. คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager). 2023. Report No.

95. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย. คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง. 2024. Report No.

96. Elena E. Glinskaya, Thomas Walker, Thisuri Jinadhi Wanniarachchi. Labor Markets and Social Policy in a Rapidly Transforming : Caring for Thailand's Aging Population. Washington, D.C: World Bank Group; 2021. Report No.

97. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559. 2016.

98. เอกสารหมายเลข 3 แนบท้าย ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2566. 2016.

99. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีผ้าอ้อม แผ่นรองซับการขับถ่าย แผ่นเสริมซึมซับ และผ้าอ้อมทางเลือก พ.ศ.2566. 2023.

100. สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. เรื่อง ตอบข้อหารือการสนับสนุนตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง. 2022. Report No.

101. สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. ตอบข้อหารือการสนับสนุนงบประมาณการจัดบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง. 2019.

102. กระทรวงสาธารณสุข. ผลการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ปีงบประมาณ 2565. 2023.

103. กลุ่มคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ. ตัวชี้วัดที่ 3.15 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan. 2023.

104. สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง. มหาวิทยาลัยมหิดล: ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี; 2019. Report No.

105. สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, วิชช์ เกษมทรัพย์, กนกพร ภักดีสังข์, ณรงค์ศักดิ์ ชื่นกมล. รายงานผลการศึกษาติดตามการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย. นครปฐม: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล; 2021. Report No.

106. ดวงดาว ศรียากูล. การวิจัยประเมินผลและศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนเชิงระบบ (System driver) ที่มีผลต่อโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 2022.

107. Han X, Wang H, Du X. The impact of long-term care insurance on the utilization of inpatient service: Evidence and mechanisms in China. Health Econ. 2024 Dec;33(12):2778–97. doi:10.1002/hec.4896 PubMed PMID: 39267463.

108. Lu B, Mi H, Yan G, Lim JKH, Feng G. Substitutional effect of long-term care to hospital inpatient care? China Economic Review. 2020 Aug 1;62:101466. doi:10.1016/j.chieco.2020.101466

109. Feng J, Wang Z, Yu Y. Does long-term care insurance reduce hospital utilization and medical expenditures? Evidence from China. Social Science & Medicine. 2020 Aug 1;258:113081. doi:10.1016/j.socscimed.2020.113081

110. Kahn JM, Benson NM, Appleby D, Carson SS, Iwashyna TJ. Long-term Acute Care Hospital Utilization After Critical Illness. JAMA. 2010 Jun 9;303(22):2253–9. doi:10.1001/jama.2010.761

111. Ellencweig AY, Stark AJ, Pagliccia N, McCashin B, Tourigny A. The effect of admission to long-term care program on utilization of health services by the elderly in British Columbia. Eur J Epidemiol. 1990 Jun;6(2):175–83. doi:10.1007/BF00145791 PubMed PMID: 2113871.

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการการศึกษาสถานการณ์การจัดบริการดูแลระยะยาวในชุมชนของไทย
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอย่างรอบด้าน

หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

www.ramapolicyhub.com

